BURKE A. CUNHA, MD, MACP

ANTIBIOTIC ESSENTIALS

JAYPEE

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

TẬP 1

BIÊN DỊCH:

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh

Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Trưởng Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

HÀ NỘI - 2016

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các tác giả, ban biên tập và nhà xuất bản đã nỗ lực hết sức mình để cung cấp cho độc giả các thông tin chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sai sót, lỗi sót hoặc bất kỳ hậu quả nào liên quan với sử dụng nội dung của cuốn sách này, cũng như không nhận trách nhiệm liên quan đối với các thuốc và các thủ thuật được mô tả trong sách. Các điều trị và tác dụng không mong muốn được mô tả trong cuốn sách này có thể không phải luôn áp dụng được cho tất cả mọi đối tượng; tương tự như vậy, một số đối tượng có thể cần tới liều dùng hoặc bị các tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc song không được mô tả trong sách. Thuốc và các thiết bị y tế được thảo luận trong sách có thể không có sẵn để sử dụng do được đặt dưới sự kiểm soát của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chỉ cấp phép sử dụng trong nghiên cứu hoặc các thử nghiệm lâm sàng. Nghiên cứu, thực hành lâm sàng và các quy định của nhà nước Hoa Kỳ thường xuyên thay đổi trong các tiêu chuẩn được chấp thuận trong lĩnh vực này. Khi có các cân nhắc trong sử dụng bất kỳ một thuốc nào trên lâm sàng, nhân viên y tế hoặc độc giả có trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng thuốc trên cơ sở cấp phép của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng kẹp trong hộp thuốc và xem lại các thông tin kê đơn để biết rõ các khuyến cáo cập nhật nhất về liều dùng, các thận trọng và các chống chỉ định và quyết định về việc sử dụng hợp lý đối với sản phẩm. Điều này cực kỳ quan trọng trong trường hợp dùng các thuốc là thuốc mới hoặc ít được kê dùng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cuốn **Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm** được dịch nguyên bản từ **"Antibiotic Essentials"** ISBN: 99789351523468 của Nhà xuất bản Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. tác giả Burke A. Cunha theo hợp đồng đã ký giữa Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam - XUNHASABA và Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

Bất kỳ sự sao chép, trích dẫn nào không được sự đồng ý của Công ty XUNHASABA đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật bản quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ Berne.

Sách đã có bản quyền. Mọi hình thức sao chép, cắt xén, dịch thuật cả cuốn sách hay một phần đều bị nghiêm cấm. Nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Một thành viên
Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam - XUNHASABA
Địa chỉ: 32 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 84-4 39343172 | Fax: 84-4 38252860
E-mail: xunhasaba@hn.vnn.vn
Website: www.xunhasaba.com.vn

BURKE A. CUNHA, MD, MACP

ANTIBIOTIC ESSENTIALS

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Fourteenth Edition

BIÊN DỊCH:

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
Trưởng Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

BS.CKII. Nguyễn Hồng Hà
Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam
Nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung
Trưởng Bộ môn Vi sinh trường Đại học Y Hà Nội
Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Nhà xuất bản Y học - 2016

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Burke A. Cunha, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ hàng đầu của Trường môn các thầy thuốc Hoa Kỳ (MACP) là Trưởng khoa- Khoa bệnh nhiễm khuẩn tại Bệnh viện- Đại học Tổng hợp Winthrop, Mineola, New York; Giáo sư Y khoa, Đại học tổng hợp Quốc gia của trường Y New York, Stony Brook, New York và là một trong số các tác giả hàng đầu thế giới về bệnh nhiễm khuẩn. Trong sự nghiệp khoa học của mình, tác giả đã viết và chủ biên 1225 bài báo khoa học, 193 chương sách và 30 cuốn sách về bệnh nhiễm khuẩn. Tác giả cũng đã nhận nhiều giải thưởng về giảng dậy, như Giải thưởng Aesculapius cho Sự nghiệp giảng dậy nổi bật và Giải thưởng Spatz cho thành tích xuất sắc về lâm sàng và thành tích giảng dậy xuất sắc. Giáo sư là thành viên trong ban biên tập của một số tạp chí bệnh nhiễm khuẩn và là Trưởng ban biên tập của tạp chí Bệnh nhiễm khuẩn về các kiến thức Y khoa trực tuyến. Giáo sư Cunha là một Hội viên của Hiệp hội Bệnh Nhiễm khuẩn Hoa Kỳ, Viện Hàn lâm Vi sinh học Hoa Kỳ, Trường môn Dược lý Lâm sàng Hoa Kỳ, Hội nhiễm khuẩn Ngoại khoa và Trường môn các Thầy thuốc Lồng ngực Hoa Kỳ. Tác giả đã quan tâm trong một thời gian dài tới chẩn đoán các hội chứng lâm sàng, lập luận chẩn đoán, điều trị kháng sinh và tình trạng đề kháng lại kháng sinh của vi khuẩn, các viêm phổi không điển hình, nhiễm khuẩn ngoại khoa, các nhiễm khuẩn ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, bệnh lây từ động vật sang người, sốt không rõ căn nguyên, viêm màng não và viêm não, viêm nội tâm mạc và nhiễm khuẩn bệnh viện. Bác sĩ Cunha là một thầy thuốc hàng đầu của Trường môn các Thầy thuốc Hoa Kỳ và là người đã được bầu chọn danh hiệu "Thành tựu suốt đời" như một Thầy thuốc Bậc thầy và Thầy giáo Bậc thầy.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỂM LƯU Ý

Các khuyến cáo điều trị trong cuốn sách này dựa trên kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng của các tác giả tham gia viết sách cũng như các hướng dẫn điều trị lâm sàng và thông tin thu thập từ y văn.

MỤC LỤC

Chương I - Tổng quan về điều trị kháng sinh	3
Chương II - Điều trị theo kinh nghiệm dựa vào hội chứng lâm sàng	29
Chương III - Đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn và điều trị kháng sinh ban đầu trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn được phân lập	321
Chương IV - Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp	407
Chương V - Nhiễm HIV	499
Chương VI - Dự phòng và tiêm chủng	575
Chương VII - Các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em và các tóm tắt về thuốc dùng trong nhi khoa	625
Chương VIII - Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn dựa trên hình ảnh phim Xquang phổi	687
Chương IX - Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn	739
Chương X - Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp khi sử dụng kháng sinh	789
Chương XI- Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh	813
Phụ lục	1087
Atlas màu - (Hình ảnh nhuộm Gram bệnh phẩm dịch não-tủy, đờm và nước tiểu)	1101
Atlas màu - (Nhuộm tìm nấm)	1105
Index	1109

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA BIÊN SOẠN

Burke A. Cunha, MD, MACP

Trưởng khoa, Khoa Bệnh Nhiễm
Bệnh viện Đại học Winthrop
Mineola, New York
Giáo sư Y học
Trường đại học Y bang New York
Trường Y Stony Brook, New York
Tham gia viết tất cả các chương trừ chương nhiễm HIV & bệnh nhiễm trùng ở trẻ em

Edward J. Bottone, PhD

Giáo sư Y học
Giáo sư Vi sinh
Giáo sư Giải phẫu bệnh
Mount Sinai
Trường Y New York, New York
Tham gia viết các chương: Vi sinh y học; Kí sinh trùng, Nấm và một số căn nguyên ít gặp

John L. Brusch, MD

Phó Trưởng khoa Y và Đơn vị Chăm sóc bệnh Nhiễm trùng
Cambridge Health Alliance
Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Somerville
Trợ lý Giáo sư Y khoa trường Y Harvard
Boston, Massachusetts
Tham gia viết chương: Viêm nội tâm mạc: Điều trị *& Dự phòng*

Daniel Caplivski, MD

Khoa Bệnh Nhiễm
Trợ lý Giáo sư Y khoa của trường Y Mt. Sinai bang New York, New York
Tham gia viết chương: Atlas về hình ảnh nhuộm nấm

Cheston B. Cunha, MD

Khoa Bệnh Nhiễm
Bệnh viện Rhode Island và Bệnh viện Miriam
Trường Y Alpert, Đại học tổng hợp Brown
Providence, Rhode Island
Tham gia viết chương: Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm trùng; Điều trị theo kinh nghiệm dựa trên các hội chứng lâm sàng; Tóm tắt các thông tin về thuốc kháng sinh.

Dennis J. Cleri, MD

Trung tâm Y tế St. Francis
Giáo sư Y học tại Đại học tổng hợp Seton Hall
Trường đào tạo sau đại học về Y học tại Trenton, New Jersey
Tham gia viết chương: Khủng bố sinh học

Staci A. Fischer, MD

Giám đốc, Khoa các bệnh Nhiễm liên quan với ghép tạng- Bệnh viện Rhode Island
Phó giáo sư Y học
Trường Y Alpert, Đại học tổng hợp Brown-Providence, Rhode Island
Tham gia viết chương: Các nhiễm trùng liên quan với ghép tạng: Điều trị và Dự phòng

Pierce Gardner, MD

Cố vấn chính, Khoa Đào tạo và Nghiên cứu lâm sàng
Viện nghiên cứu sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ
Trung tâm quốc tế John E. Fogarty về các nghiên cứu cao cấp trong lĩnh vực khoa học Sức khỏe
Bethesda, Maryland
Tham gia viết chương: Dự phòng và tiêm chủng

Arthus Gran, MD

Khoa Bệnh Nhiễm
Bệnh viện trường Đại học Winthrop
Mineola, New York
Trường Đại học tổng hợp bang New York
Trường Y Stony Brook, New York
Tham gia viết chương: Tóm tắt các thông tin về thuốc kháng sinh

Jean E. Hage, MD

Khoa Bệnh Nhiễm
Bệnh viện trường Đại học Winthrop
Mineola, New York
Trường Đại học tổng hợp bang New York
Trường Y Stony Brook, New York

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tham gia viết các chương: Điều trị theo kinh nghiệm dựa trên các hội chứng lâm sàng; Dự phòng và tiêm chủng; Nhiễm kí sinh trùng, Nấm và Các căn nguyên vi sinh vật ít gặp; Tóm tắt các thông tin về thuốc kháng sinh

Mark H. Kaplan, MD

Giáo sư Y học về các bệnh Nhiễm trùng

Đại học tổng hợp Michigan

Trường Y Ann Arbor, Michigan

Tham gia viết chương: Tóm tắt các thông tin về thuốc điều trị HIV

Douglas S. Katz, MD

Phó chủ tịch- Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu lâm sàng

Giám đốc đơn nguyên chụp CT toàn thân

Bệnh viện Đại học tổng hợp Winthrop

Mineola, New York

Giáo sư Điện quang lâm sàng

Đại học Tổng hợp bang New York

Trường Y Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Atlas Xquang ngực

Raymond S. Koff, MD

Giáo sư Y học lâm sàng

Đại học tổng hợp Connecticut

Trường Y Farmington, Connecticut

Tham gia viết chương: Viêm gan do virus: Điều trị và Dự phòng

Leonard R. Krilov, MD

Trưởng khoa, Khoa Bệnh Nhiễm Nhi

Bệnh viện đại học tổng hợp Winthrop, Mineola, New York

Giáo sư Nhi khoa

Trường Đại học Tổng hợp bang New York

Trường Y Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Các bệnh Nhiễm ở Nhi khoa

David W. Kubiak, PharmD

Dược sỹ Lâm sàng các Bệnh Nhiễm

Bệnh viện Brigham and Women

Boston, Massachusetts

Tham gia viết chương: Tóm tắt các thông tin về thuốc chống retrovirus

George H. McCracken, Jr., MD

Giáo sư Ưu tú về các Bệnh Nhiễm ở Nhi Khoa

tại bệnh viện the Sarah M. and Charles E. Seay

Trường khoa bệnh Nhiễm Nhi khoa- Đại học Tổng hợp Texas

Trung tâm Y tế Southwestern Dallas, Texas

Tham gia viết chương: Các Bệnh Nhiễm Nhi khoa

James H. McGuire, MD

Trưởng khoa lâm sàng

Khoa Bệnh Nhiễm tại bệnh viện Brigham and Women

Giáo sư Y học

Trường Y Havard Boston, Massachusetts

Tham gia viết chương: Nhiễm kí sinh trùng, Nấm và các các căn nguyên vi sinh ít gặp

Nardeen Mickail, MD

Khoa Bệnh nhiễm

Bệnh viện đại học Winthrop Mineola, New York

Trường đại học bang New York

Trường Y Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Robert Moore, MD

Trưởng bộ môn Điện quang Bệnh viện đại học Stony Brook

Giáo sư điện quang

Trường đại học bang New York

Trường Y Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Atlas Xquang ngực

Sigridh Munoz-Gomez, MD

Khoa Bệnh Nhiễm- Bệnh viện Đại học tổng hợp Winthrop

Mineola, New York

Đại học Tổng hợp bang New York

Trường Y Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Tóm tắt các thông tin về thuốc kháng sinh

Ronard L. Nichols, MD

Danh hiệu Giáo sư William Henderson về Phẫu thuật

Giáo sư vinh sinh và Miễn dịch học- Đại học tổng hợp Tulane

Trường Y New Orleans, Louisiana

Tham gia viết chương: Dự phòng và điều trị kháng sinh trong phẫu thuật

Genovefa Papanicolaou, MD

Bác sĩ Cao cấp, Khoa Bệnh Nhiễm

Trung tâm bệnh Ung thư Memorial Sloan Kettering

Phó giáo sư Y học

Trường Cao đẳng Y Weill Cornell New York, New York

Tham gia viết chương: Các nhiễm trùng liên quan với ghép tạng: Điều trị và Dự phòng

Michael F. Rein, MD

Giáo sư Y học (Danh dự)

Đại học tổng hợp thuộc Hệ thống Y tế Virginia Charlottesville, Virginia

Tham gia viết chương: Các bệnh lây qua đường tình dục

John H. Rex, MD

Phó giáo sư Y học

Trường Đại học tổng hợp Texas

Trường Y Houston, Texas

Phó chủ tịch và Giám đốc Y khoa về bệnh nhiễm trùng

Công ty dược phẩm AstraZeneca

Macclesfield, UK

Tham gia viết chương: Thuốc điều trị nấm

Paul E. Sax, MD

Trưởng Khoa lâm sàng, Khoa các bệnh Nhiễm trùng và Chương trình phòng chống HIV

Khoa các Bệnh Nhiễm của bệnh viện Brigham and Women

Phó giáo sư Y học

Trường Y khoa Havard Boston, Massachusetts

Tham gia viết chương: Nhiễm HIV

David Schlossberg, MD

Chương trình kiểm soát Lao- Sở Y tế Philadelphia

Giáo sư Y học

Đại học tổng hợp Temple

Trường Y Philadelphia, Pennsylvania

Tham gia viết chương: Bệnh lao

Paul E. Schoch, PhD

Giám đốc, Khoa Xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Bệnh viện trường đại học tổng hợp Winthrop

Mineola, New York

Tham gia viết chương: Vi sinh y học và Atlas về nhuộm Gram

Daniel S. Siegal, MD

Khoa Điện quang - Bện viện Mount Auburn

Trường Y Havard Boston, Massachusetts

Tham gia viết chương: Atlas về hình ảnh chụp Xquang ngực

Stephanie Strollo, MD

Khoa Bệnh Nhiễm

Bệnh viện Đại học tổng hợp Winthrop- Mineola, New York

Trường Đại học tổng hợp bang New York

Trường Y- Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Điều trị khởi đầu đối với các chủng vi khuẩn phân lập được, trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn.

Uzma Syed, DO

Khoa Bệnh Nhiễm

Bệnh viện Đại học tổng hợp Winthrop- Mineola, New York

Trường Đại học tổng hợp bang New York

Trường Y- Stony Brook, New York

Tham gia viết chương: Điều trị khởi đầu đối với các chủng vi khuẩn phân lập được, trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn

Damary C. Torres, PharmD

Chuyên gia Dược lý lâm sàng

Bệnh viện Đại học tổng hợp Winthrop- Mineola, New York

Phó giáo sư Dược lý lâm sàng

Trường Cao đẳng Dược, Đại học tổng hợp St. John

Queens, New York

Tham gia viết chương: Tóm tắt về các thuốc kháng sinh

Kenneth F. Wagner, DO

Bác sĩ tham vấn về bệnh Nhiễm trùng

Trung tâm Y khoa Quốc gia Naval

Phó giáo sư Y khoa

Uniformed Services, trường Đại học tổng hợp về Khoa học sức khỏe

Trường Y F. Edward Hebert

Bethesda, Maryland

Tham gia viết chương: Kí sinh trùng, Nấm và các căn nguyên vi sinh vật ít gặp

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

LỜI GIỚI THIỆU

Năm 1928, Alexander Fleming tìm ra penicillin, đã đánh đấu một bước ngoặt vĩ đại trong thực hành lâm sàng y khoa. Phát minh này đã cứu sống được hầu hết những bệnh nhân nhiễm trùng nặng mà trước đó gần như chắc chắn sẽ tử vong, đó thực sự là những kỳ tích y học. Từ đầu thế kỷ XX đến nay, nhân loại vẫn mải miết kiếm tìm nhiều loại kháng sinh mới, trên 8000 chất kháng khuẩn đã được tìm thấy và trên 100 loại kháng sinh đã được đưa vào sử dụng trong lâm sàng, thuốc kháng sinh đã thực sự trở thành một vũ khí rất quan trọng trong việc chiến đấu với bệnh lý nhiễm trùng. Tuy vậy, với số lượng các loại kháng sinh ngày càng tăng lên, việc điều trị bệnh lý nhiễm trùng có vẻ như lại càng khó khăn hơn, vấn đề kháng kháng sinh đã trở thành một cản trở lớn cho thực hành lâm sàng mà một yếu tố góp phần không nhỏ vào điều này lại là việc sử dụng kháng sinh trong lâm sàng hiện nay còn nhiều thiếu sót, hạn chế, do đó thực tế đặt ra cần phải có những tài liệu chuẩn hóa về sử dụng kháng sinh trong lâm sàng để giúp các thầy thuốc có thêm những công cụ hữu hiệu hơn, chặt chẽ hơn trong việc sử dụng kháng sinh hiệu quả.

Ngay khi có trong tay cuốn sách ***"Antibiotic Essentials"*** của nhà xuất bản JAYPEE BROTHERS do **Burke A. Cunha** chủ biên và các tác giả tham gia biên soạn là những chuyên gia hàng đầu thế giới về kháng sinh và bệnh lý nhiễm khuẩn, chúng tôi hiểu rằng đây là một tài liệu hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong thực hành lâm sàng quý, nó tập hợp đầy đủ các kiến thức rất quan trọng về kháng sinh như phân loại kháng sinh, liều dùng, phổ tác dụng, khả năng kháng khuẩn, dược động học, đào thải, cách điều chỉnh liều dùng, tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn, khả năng dị ứng, mức độ an toàn cho phụ nữ có thai, khả năng thấm vào các cơ quan, phủ tạng, v.v...

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Vấn đề dùng kháng sinh theo kinh nghiệm được trình bày rất cụ thể, rất thực tế, dễ vận dụng. Các vấn đề về tính nhạy cảm của kháng sinh đối với vi khuẩn, các vấn đề về điều trị ký sinh trùng, nấm, HIV, các virus...là những nội dung mà lâm sàng đang đòi hỏi cấp thiết. Phần khủng bố sinh học với các virus nguy hiểm là những vấn đề rất mới và thời sự. Đặc biệt chương 7 đề cập rất chi tiết về sử dụng kháng sinh trong nhi khoa với nhiều kiến thức tiên tiến. Sách được các tác giả cập nhật hàng năm để bổ sung cho độc giả các thông tin mới nhất.

Kháng sinh, nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn vi khuẩn kháng thuốc cũng như sử dụng hợp lý kháng sinh nhất là khi chưa có kết quả phân lập vi khuẩn và kháng sinh đồ là những vấn đề đầy thách thức cho các thầy thuốc lâm sàng, Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ thực sự là một công cụ rất hữu hiệu giúp cho các bác sĩ nhanh chóng tiếp cận được các hướng dẫn chính xác, ngắn gọn về việc chỉ định và lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm ban đầu tối ưu cho người bệnh phù hợp với thực tế của cơ sở điều trị.

Với tham vọng có được một tài liệu tốt về hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong thực hành lâm sàng, Ban biên dịch đã mời được một đội ngũ các nhà biên dịch tài năng là các

Giáo sư, các chuyên gia hàng đầu của các chuyên ngành lâm sàng có nhiều kinh nghiệm về sử dụng kháng sinh tham gia biên dịch sách song trong quá trình biên dịch sách chúng tôi gặp không ít khó khăn do nội dung cuốn sách liên quan đến rất nhiều thuật ngữ chưa thống nhất cần phải chuẩn hóa, do đó trong một số trường hợp chúng tôi đã phải giải thích thêm hoặc giữ kèm từ gốc tiếng Anh, ví dụ từ *Sepsis* được hiểu là hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS) liên quan với nhiễm khuẩn, song hầu hết các tác giả khác thường sử dụng là nhiễm khuẩn huyết; *Bacteremia* theo định nghĩa là có vi khuẩn trong máu, song trong một số bệnh cảnh có thể hiểu được dịch là nhiễm khuẩn huyết hay có tác giả sử dụng là vãng khuẩn huyết, v.v... hoặc các khái niệm về nhiễm khuẩn, nhiễm trùng cũng có những ý kiến chưa thống nhất trong nước.

Trong khi luôn bám sát nguyên bản, chúng tôi đã cố gắng làm cho cuốn sách được trình bày dễ hiểu, dễ đọc và dễ vận dụng vào thực tế lâm sàng. Chúng tôi hy vọng, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo tốt, giúp ích cho các đồng nghiệp trong quá trình thực hành lâm sàng. Tuy vậy, có thể vẫn còn những điểm chưa hoàn chỉnh, chúng tôi mong nhận được ý kiến góp ý để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi trân trọng cám ơn các Giáo sư, các chuyên gia tham gia Ban biên dịch đã làm việc hết mình để có một cuốn sách với chất lượng tốt nhất. Đặc biệt chúng tôi trân trọng gửi lời cám ơn và khen ngợi đến và các bác sĩ trẻ, các sinh viên tài năng của câu lạc bộ tiếng Anh Trường Đại học Y Hà Nội, đó là các bạn: Trần Nam Sơn, Nguyễn Khắc Thái, Nguyễn Thế Hùng, Bùi Phương Linh, Ngô Thị Hải Linh, Vũ Ngọc Hiếu, Đặng Việt Phong, Bùi Linh Chi, Lê Quốc Anh, Trần Anh Thơ, Quản Trọng Hùng, đã tham gia cùng chúng tôi trong công tác biên dịch cuốn sách. Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban Giám hiệu Trường đại học Y Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của cuốn sách. Cuối cùng, chúng tôi xin cám ơn tất cả những người bệnh phải điều trị với kháng sinh, vì chính các bệnh nhân hiện tại và trong tương lai sẽ phải sử dụng kháng sinh để chống lại các vi khuẩn gây bệnh đã và đang là động lực thôi thúc các thầy thuốc không ngừng cố gắng sử dụng kháng sinh thật thông thái vì một môi trường an toàn, hiệu quả.

Thay mặt Ban biên dịch
PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

BIÊN DỊCH

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh

Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Trưởng Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

BS.CKII. Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung

Trưởng Bộ môn Vi sinh trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA DỊCH SÁCH

TS. Nguyễn Văn Chi
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

TS. Lương Quốc Chính
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Nguyễn Đàm Chính
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

ThS. Vũ Quốc Đạt
Bộ môn truyền nhiễm, trường Đại học Y Hà Nội

TS. Hà Trần Hưng
Bộ môn Hồi sức - Cấp cứu Đại học Y Hà Nội

TS.DS. Nguyễn Khoa Diệu Hằng
Công ty Dược phẩm Đông Đô

ThS. Lê Văn Ký
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

TS.DS. Cấn Tuyết Nga
Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai

TS. Ngô Đức Ngọc
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

TS. Nguyễn Hữu Quân
Khoa Cấp cứu Bệnh viện, Bạch Mai

TS. Đỗ Ngọc Sơn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu,
trường Đại học Y Hà Nội

TS. Mai Duy Tôn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

TS. Trần Hữu Thông
Khoa Cấp cứu, Bệnh Viện Bạch Mai

ThS. Nguyễn Quốc Thái
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
Khoa Nội tiết và Đái tháo đường,
Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Nội Tổng hợp,
trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Tường Vân
Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC TỪ TIẾNG ANH VIẾT TẮT

3TC	Lamivudine	Lamivudin
ABC	abacavir	abacavir
ABE	Acute bacterial endocarditis	Viêm nội tâm mạc cấp tính do vi khuẩn
ABM	Acute bacterial meningitis	Viêm màng não cấp do vi khuẩn
AFB	Acid fast bacilli	Trực khuẩn lao hay trực khuẩn kháng cồn-toan
AIH	Autoimmune lupoid hepatitis	Viêm gan tự miễn dạng lupus
AIHA	Autoimmune hemolytic anemia	Thiếu máu tan máu tự miễn
AML	Acute myelogenous leukemia	Bệnh loxêmi cấp dòng tủy
ANA	Antinuclear antibody	Kháng thể kháng nhân
ARDS	Adult respiratory distress syndrome	Hội chứng ARDS hay hội chứng suy hô hấp cấp ở người lớn
ATV	Atazanavir	Atazanavir
A-V	Atrio-ventricular	Nhĩ-Thất
β-lactams	Peinicillins, cephalosporins, cephamycins (not monobactams or carbapenems)	Kháng sinh nhóm β-lactam bao gồm pinicillin, các cephalosporin, cephamycin (song không bao gồm monobactam hoặc carbapenem)
BAL	Bronchoalveolar lavage	(kỹ thuật) rửa phế quản- phế nang
BMT	Bone marrow transplant	Ghép tủy xương
BPH	Benign prostatic hypertrophy	Phì đại tuyến tiền liệt lành tính
CAB	Catheter associated bacteriuria	Có vi khuẩn niệu liên quan với đặt xông tiểu
CABG	Coronary artery bypass grafting	Làm cầu nối mạch vành
CAC	Catheter associated candiduria	Có Candida niệu liên quan với đặt xông tiểu
CAH	Chronic active hepatitis	Viêm gan mãn hoạt động
CA-MRSA	Community-acquired MRSA	Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng
CAP	Community-acquired pneumonia	Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng
CD_4	CD_4 Tcell lymphocyte	Tế bào lympho T CD_4
CE	California encephalitis virus	Virus viêm não California
CFS	Chronic fatigue syndrome	Hội chứng mệt mỏi mạn tính
CGD	Chronic granulomatous disease	Bệnh tạo u hạt mạn tính
CIE	Counter-imunoelectrophoresis	(kỹ thuật) Điện di miễn dịch đối lưu
CLL	Chronic lymphocytic leukemia	Bệnh loxêmi mạn dòng tế bào lympho
CML	Chronic myelogenous leukemia	Bệnh loxêmi mạn dòng tủy
CMV	Cytomegalovirus	Cytomegalovirus
CNS	Central nervous system	Hệ thần kinh trung ương
CO-MRSA	Community-onset MRSA	Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng
CoNS	Coagulase-negative staphlococci	Tụ cầu với coagulase âm tính
CPH	Chronic persistent hepatitis	Viêm gan tiếp diễn mạn tính
CPK	Creatine phosphokinase	Creatine phosphokinase

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CrCl	Creatinine clearance	Độ thanh thải của creatinin
CSD	Cat scratch disease	Bệnh do mèo cào
CSF	Cerebrospinal fluid	Dịch não tủy
CT	Computerised tomography	Chụp cắt lớp vi tính
CVA	Costovertebral angle	Góc sườn-cột sống
CVC	Central venous catheter	(đặt) Catheter tĩnh mạch trung tâm
CVID	Common variable immune deficiency	(tình trạng) thiếu hụt miễn dịch thay đổi thường gặp
CVVH	Continuous veno venous hemofiltration	Lọc máu tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục
CXR	Chest X-ray	Chụp Xquang ngực
d4T	Stavudine	Stavudin
ddC	Zalcitabine	Zalcitabin
DdI	Didanosine	Didanosin
DFA	Direct fluorescent antibody	(kỹ thuật định lượng) Kháng thể huỳnh quang trực tiếp
DI	Diabetes insipidus	Đái nhạt
DIC	Disseminated intravascular coagulation	Đông máu rải rác trong lòng mạch
DLV	Delavirdine	Delavirdin
DM	Diabetes mellitus	Đái tháo đường
DRV	Darunavir	Darunavir
e.g	For example	Ví dụ
EBV	Ebstein-Barr virus	Virus Ebstein-Barr
EEE	Estern equine encephalitis	Viêm não ngựa vùng miền Tây Hoa Kỳ
EEG	Electroencephalogram	Điện não đồ
EFV	Efavirenz	Efavirenz
EIA	Enzyme immunoassay	Thử nghiệm miễn dịch enzym
ELISA	Enzyme-linked immunosorbent assay	Thử nghiệm ELISA hay thử nghiệm miễn dịch hấp thụ gắn kết enzym
EM	Erythema migrans	Ban đỏ di chuyển
EMB	Ethambutol	Ethambutol
ENF	Enfuvirtide	Enfuvirtid
ESBLs	Extended spectrum β-lactamses	β-lactamses phổ mở rộng
esp	Especially	Nhất là, đặc biệt là
ESR	Erythrocyte sedimentation rate	Tốc độ lắng hồng cầu
ESRD	End-stage renal disease	Bệnh thận giai đoạn cuối
ET	Endotracheal	Nội khí quản
ETR	Etavirine	Etavirin
ETA-ABS	Fluorescent treponemal antibody absorption test	Test hấp thụ kháng thể xoắn khuẩn (giang mai) bằng kỹ thuật huỳnh quang
FPV	Fosamprenavir	Fosamprenavir
FTC	Emtricitabine	Emtricitabin
FUO	Fever of unknown origin	Sốt không rõ nguồn gốc

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

G6PD	Glucose-6-phosphate dehydrogenase	Glucose-6-phosphat dehydrogenase
GC	Gonococcus/gonorrhea	Lậu cầu/ bệnh lậu
GCA	Giant cell arteritis	Viêm động mạch tế bào khổng lồ
GI	Gastrointestinal	Dạ dày-ruột hay đường tiêu hóa
Gm	Gram	đơn vị trọng lượng gam
GU	Genitourinary	Sinh dục- tiết niệu
GVHD	Graft versus host disease	Bệnh mảnh ghép chống lại vật chủ
HA-MRSA	Hospital-acquired MRSA	Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện
HAP	Hospital- acquired pneumonia	Viêm phổi mắc phải trong bệnh viện
HAV	Hepatitis A virus	Virus viêm gan A
HbcAb	Hepatitis B core antibody	Kháng thể đối với kháng nguyên lõi của virus viêm gan B
HbsAg	Hepatitis B surface antigen	Kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B
HBV	Hepatitis B virus	Virus viêm gan B
HCV	Hepatitis C virus	Virus viêm gan C
HDV	Hepatitis D virus	Virus viêm gan D
HEV	Hepatitis E virus	Virus viêm gan E
HFV	Hepatitis F virus	Virus viêm gan F
HFHD	High flux hemodialysis	Lọc máu dòng cao
HFM	Hand foot mouth disease	Bệnh chân-tay miệng
HD	Hemodialysis	Thẩm tách máu
HGA	Human granulocytic anaplasmosis	Bệnh do Aplasmosis granulocytic ở người
HGE	Human granulocytic ehrlichiosis	Bệnh do ehrlichiosis granulocytic ở người
HHV-6,7,8	Human Herpes virus 6,7,8	Virus Herpes typ 6,7,8 ở người
HME	Human monocytic ehrlichiosis	Bệnh ehrlichiosis monocytic ở người
HMPV	Human metapneumovirus	Bệnh do metapneurovirrus ở người
HPS	Hanta virus pulmonary syndrome	Hội chứng phổi do Hanta virus
HPV	Human papiloma virus	Virus papiloma người
HTLV-1	Human T-cell leukemia virus	Virus gây bệnh loxêmi tế bào T ở người
HRIG	Human rabies immune globulin	Globulin miễn dịch người chống virus dại
HSV	Herpes simplex virus	Virus Herpes simplex
I&D	Incision and drainage	Trích rạch và dẫn lưu
IDV	Indinavir	Indinavir
IFA	Immunofluorescent antibody	Kháng thể miễn dịch huỳnh quang
IgA	Immunoglobulin A	Globulin miễn dịch A
IgG	Immunoglobulin G	Globulin miễn dịch G
IgM	Immunoglobulin M	Globulin miễn dịch M
INH	Isoniazid	Isoniazid
IP	Intraperitoneal	Trong (khoang) phúc mạc
IT	Intrathecal	Trong màng tủy sống
ITP	Idiopathic thrombocytopenic purpura	Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

IV	Intravenous	(đường) tĩnh mạch
IV/PO	IV or PO	(Đường) Tĩnh mạch hoặc (đường) Uống
IVDA	Intravenous drug abuser	Người lạm dụng thuốc đường tĩnh mạch
JE	Japanese encephalitis	Viêm não Nhật Bản
Kg	Kilogram	Kilo
L	Liter	Lít
LCM	Lymphocytic choriomeningitis	Viêm mạch mạc màng não tăng bạch cầu lympho
LDH	Lactate dehydrogenase	Lactat dehydrogenase
LFTs	Liver function tests	Xét nghiệm chức năng gan
LGV	Lymphogranuloma venereum	Bệnh Nicolas-Favre hay bệnh Viêm hạch do u hạt bạch huyết hoa liễu hay bệnh hột xoài
LPV/r	Lopanavir/ritonavir	Lopanavir/ritonavir
MAI	Mycobacterium avium-intracellulare	Mycobacterium avium nội tế bào
µg	Microgram	Microgam
µL	Microliter	Microlit
MDR	Multidrug resistant	(vi khuẩn) đa kháng
MDRSP	Multidrug-resistant S.pneumoniae	Phế cầu kháng nhiều thuốc (kháng sinh)
mg	Milligram	Miligam
mL	Milliliter	Mililit
MIC	Minimum inhibitory concentration	Nồng độ ức chế tối thiểu
min	Minute	Phút
MMR	Measles, mumps, rubella	Sởi- Quai bị- Rubella
MRI	Magnetic resonance imaging	Hình ảnh cộng hưởng từ
MRSA	Methicillin-resistant S. aureus	Tụ cầu vàng kháng với methicillin
MRSE	Methicillin-resistant S. epidermidis	S. epidermidis kháng với methicillin
MS	Multiple sclerosis	(bệnh) xơ cứng rải rác
MSSA	Methicillin-sensitive S. aureus	Tụ cầu vàng nhạy với methicillin
MSSE	Methicillin-sensitive S. epidermidis	S. epidermidis kháng với methicillin
MTT	Methyltetrathiazole	Methyltetrathiazol
MU	Million units	Triệu đơn vị
MVC	Maraviroc	Maraviroc
MVP	Mitral valve prolapse	Sa van hai lá
NFV	Nelfinavir	Nelfinavir
NHAP	Nursing home acquired pneumonia	Viêm phổi mắc phải tại cơ sở chăm sóc y tế
NNRTI	Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor	(Thuốc) ức chế enzym sao chép ngược không phải là nucleosid
NP	Nosocomial pneumonia	Viêm phổi bệnh viện
NRTI	Nucleoside reverse transcriptase inhibitor	(Thuốc) ức chế enzym sao chép ngược nucleosid
NSAIDS	Nonsteroidal anti-inflammatory drugs	Thuốc chống viêm không steroid
NVP	Nevirapine	Nevirapin
OI	Opportunistic infection	Nhiễm khuẩn cơ hội

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

PAN	Polyarteritis nodosa	Viêm nhiều động mạch nút
PBC	Primary biliary cirrhosis	Xơ gan mật tiên phát
PBS	Protected brush specimen	(Thu) mẫu bệnh phẩm bằng bàn chải được bảo vệ
PCEC	Purified chicken embryo cells	Tế bào bào thai gà được tinh chế
PCN	Penicillin	Penicillin
PCP	Pneumocystis (carinii) jiroveci	Pneumocystis jiroveci hay Pneumocystis carinii
PCR	Polymerase chain reaction	Phản ứng chuỗi polymerase
PD	Peritoneal dialysis	Thẩm phân phúc mạc
PDA	Patent ductus arteriosus	Còn ống động mạch
PEP	Post-exposure prophylaxis	Dự phòng sau phơi nhiễm
PI	Protease inhibitor	(Thuốc) ức chế protease
PID	Pelvic inflammatory disease	Bệnh lý viêm vùng chậu
PML	Progressive multifocal leukoencephalopathy	Bệnh não chất trắng đa ổ tiến triển
PMN	Polymorphonuclear leucocytes	Bạch cầu đa nhân
PO	Oral	(đường) uống
PPD	Tuberculin skin test	Test da với tuberculin
PPIs	Proton pump inhibitors	(thuốc) ức chế bơm proton
PPNG	Penicillinase-producing N.gonorrhoeae	Lậu cầu sản xuất ra enzym penicillinase
PVE	Prosthetic valve endocarditis	Viêm nội tâm mạch trên van tim nhân tạo
PVL	Panton-Valentine leukocidin	Leukocidin Panton-Valentin
PZA	Pyrazinamide	Pyrazinamid
q-d	Every_days	(dùng) hàng ngày
q-h	Every_hours	(dùng) hàng giờ
q month	Once a month	(dùng) một lần mỗi tháng
q week	Once a week	(dùng) một lần mỗi tuần
RA	Rheumatoid arthritis	Viêm khớp dạng thấp
RAL	Raltegravir	Raltegravir
RBC	Red blood cells	(tế bào) hồng cầu
RE	Regional ileitis (Crohn's disease)	Bệnh Crohn
RMSF	Rocky mountain spotted fever	Bệnh sốt phát ban vùng núi đá
RTV	Ritonavir	Ritonavir
RUQ	Right upper quandrant	Phần tư trên phải
RVA	Rabies, vaccine absorbed	Vaccin hoạt thụ chống virus dại
SARS	Severe acute respiratory syndrome	Hội chứng suy hô hấp cấp nặng (hay SARS)
SBE	Subacute bacterial endocarditis	Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn
SCID	Severe combined immune deficiency	Thiếu hụt miễn dịch kết hợp nặng
SGOT/SGPT	Serum transaminases	Transaminase huyết thanh
SLE	Systemic lupus erythematosus	(bệnh) Lupus ban đỏ hệ thống
SOT	Solid organ transplant	Ghép tạng đặc
sp	Species	Chủng (vi khuẩn)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

SPB	Spontaneous bacterial peritonitis	Viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn
SPEP	Serum protein electrophoresis	Điện di protein huyết thanh
SQ	Subcutaneous	(tiêm) dưới da
SQV	Saquinavir	Saquinavir
STD	Sexually transmitted diseases	(các) bệnh lây truyền qua đường tình dục
StLE	Saint Louis encephalitis	Viêm não Saint-Louis
TA	Temporal arteritis	Viêm động mạch thái dương
TAH/BSO	Total abdominal hysterectomy/ bilateral salpingoopherectomy	Phẫu thuật mở bụng cắt toàn bộ tử cung/ phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên buồng trứng -vòi tử cung
TB	M. tuberculosis	(Trực khuẩn) lao
TDF	Tenofovir disoproxil fumarate	Tenofovir disoproxil fumarat
TEE	Transesophageal echocardiogram	Siêu âm tim qua đường thực quản
TEN	Toxic epidermal necrolysis	Hoại tử biểu bì do độc tố
TID	Three time per day	(dùng) 3 lần/ngày
TMP	Trimethoprim	Trimethoprim
TMP-SMX	Trimethoprim-sulfamethoxazole	Trimethoprim-sulfamethoxazol
TPN	Total parenteral nutrition	Nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch
TPV	Tipranavir	Tipranavir
TRNG	Tetracycline-resistant N.gonorrhoeae	Lậu cầu kháng với tetracyclin
TSS	Toxic shock syndrome	Hội chứng sốc nhiễm độc tố
TTE	Transthoracic echocardiogram	Siêu âm tim qua thành ngực
TTP	Thrombotic thrombocytopenic purpura	Ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch
TURP	Transurethral resection of prostate	(phẫu thuật) cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo.
UC	Ulcerative colitis	Viêm đại tràng loét
UTI	Urinary tract infection	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
VA	Ventriculoatrial	(đặt shunt) não thất- nhĩ
VAP	Ventilator-associated pneumonia	Viêm phổi liên quan với máy thở
VCA	Viral capsid antigen	Kháng nguyên capsid của virus
VEE	Venezuelan-equine encephalitis virus	Virus viêm não ngựa Venezuela
VISA	Vancomycin-intermediate S aureus	Tụ cầu vàng kháng vancomycin trung gian
VLM	Visceral larval migrans	Ấu trùng (nang) sán di chuyển trong nội tạng
VP	Ventriculoperitoneal	(đặt shunt) não thất-phúc mạc
VRE	Vancomycin-resistant enterococci	Cầu khuẩn ruột kháng với vancomycin
VRSA	Vancomycin-resistant S.aureus	Tụ cầu vàng kháng với vancomycin
VSE	Vancomycin-sensitive enterococci	Cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin
VZV	Varicella zoster virus	Virus thủy đậu
WBC	White blood cells	Tế bào bạch cầu
WEE	Western equine encephalitis	Viêm não ngựa vùng miền Tây
WNE	West nile encephalitis	Viêm não vùng bờ tây sông Nil
ZDV	Zidovudine	Zidovudin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC TỪ TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT

BN	Bệnh nhân
CT	Chụp cắt lớp vi tính
ĐTĐ	Đái tháo đường
	Điện tâm đồ
H; h (hour)	Giờ
HA	Huyết áp
HSCC	Hồi sức cấp cứu
LS, Ls	Lâm sàng
MRI	Chụp cộng hưởng từ
NMCT	Nhồi máu cơ tim
NTT	Ngoại tâm thu
THA	Tăng huyết áp
Tr/c, tr/c	Triệu chứng
TKTW	Thần kinh trung ương
TM	Tĩnh mạch
TMCB	Thiếu máu cục bộ
XN	Xét nghiệm
VD, Vd, vd	Ví dụ

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương I

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH

Burke A. Cunha, MD
Cheston B. Cunha, MD
Jean E. Hage, MD
Edward J. Bottone, PhD
Paul E. Schoch, PhD
Demary C. Torres, Pharm D

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NGƯỜI DỊCH:

TS. Nguyễn Văn Chi
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

TS.DS. Cấn Tuyết Nga
Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
Bộ môn Nội tổng hợp, trường Đại học Y Hà Nội

Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn kháng sinh	3
Các yếu tố tác động đến liều dùng kháng sinh	6
Xét nghiệm vi sinh và test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh	9
Các xem xét khác khi điều trị kháng sinh	16
Điều trị kháng sinh kinh nghiệm	20
Điều trị kháng sinh bị thất bại	20
Tụ cầu vàng kháng methicillin (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus [MRSA])	23
Các sai lầm có thể gặp khi kê đơn sử dụng kháng sinh	25
Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm	26

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tổng quan về điều trị kháng sinh

Mặc dù điều trị kháng sinh có khả năng dự phòng/kiểm soát nhiễm khuẩn, song các sai lầm trong kê đơn dùng kháng sinh rất thường gặp bao gồm: tiến hành điều trị tình trạng vi khuẩn cư trú (colonization), điều trị theo kinh nghiệm dưới mức tối ưu, điều trị kết hợp không thích hợp, dùng sai liều, khoảng thời gian dùng liều không đúng và không có thái độ ứng phó thỏa đáng trước một thất bại điều trị kháng sinh rõ ràng. Thái độ ứng xử không thích hợp đối với nguy cơ để kháng kháng sinh của vi khuẩn, khả năng thấm vào mô của kháng sinh được sử dụng, các tương tác thuốc và các tác dụng không mong muốn... đã làm hạn chế hiệu quả của điều trị kháng sinh. Cuốn sách **"Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm"** là một hướng dẫn ngắn gọn, thực hành và đáng tin cậy trong điều trị và dự phòng các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp trong thực tế lâm sàng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN KHÁNG SINH

A. Phổ tác dụng: Phổ tác dụng của kháng sinh cung cấp thông tin kháng sinh sử dụng thường có hiệu quả tác dụng với các loại vi sinh vật nào và là cơ sở của điều trị kháng sinh kinh nghiệm (*Chương II*). Các kháng sinh có dược động học "phụ thuộc vào nồng độ" ("concentration-dependent" kinetics), Vd., các quinolon, aminoglycosid sẽ biểu lộ khả năng diệt khuẩn gia tăng khi nồng độ thuốc tăng cao hơn nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) đối với vi khuẩn; các kháng sinh có dược động học "phụ thuộc vào thời gian" ("time-dependent" kinetics), Vd., các β-lactam không có khả năng này.

B. Khả năng thấm vào mô: Các kháng sinh có hiệu quả đối với một vi sinh vật trên in vitro song không có khả năng đi tới vị trí nhiễm khuẩn sẽ có ít hoặc không có lợi ích đối với vật chủ. Khả năng thấm vào mô của kháng sinh phụ thuộc vào các đặc tính lý - hóa của kháng sinh (Vd: khả năng tan

trong lipid, kích thước phân tử) và đặc điểm của mô (Vd: tình trạng cấp máu cho mô có thỏa đáng không, có tình trạng viêm hay không). Khả năng thấm vào mô của kháng sinh hiếm khi là vấn đề cần quan tâm trong các nhiễm khuẩn cấp, do trong tình trạng này thường có tăng tính thấm vi mạch do giải phóng tại chỗ các chất trung gian hóa học gây viêm. Trái lại, trong các nhiễm khuẩn mạn (Vd: viêm thận-bể thận mạn, viêm tuyến tiền liệt mạn, viêm xương-tủy mạn) và các nhiễm khuẩn do tác nhân gây bệnh nội tế bào, khả năng thấm vào mô của thuốc thường chỉ trông chờ vào các đặc tính hóa học của kháng sinh (Vd: khả năng tan trong lipid cao, kích thước phân tử nhỏ để có thể thâm nhập tốt vào mô). Không thể kỳ vọng là kháng sinh sẽ tiêu diệt triệt để được các vi khuẩn ở các vùng thuốc khó thấm vào hoặc vùng kém được cấp máu (như các ổ ápxe), trong trường hợp này thường phải mổ dẫn lưu để điều trị triệt để. Ngoài ra, các nhiễm khuẩn liên quan với các chất ngoại lai được cấy ghép vào cơ thể thường cần phải lấy bỏ dị vật để điều trị tiệt căn, do các vi khuẩn gây ra tình trạng nhiễm khuẩn liên quan với khớp giả, shunt và các đường truyền tĩnh mạch sẽ sản sinh ra màng nhớt/biophim trên các bề mặt chất dẻo/kim loại cho phép vi khuẩn sống sót mặc dù điều trị kháng sinh.

C. Tình trạng kháng kháng sinh: Tình trạng để kháng của vi khuẩn đối với điều trị kháng sinh có thể được phân loại như là kháng tự nhiên (natural)/ nội sinh (intrinsic) hoặc mắc phải và như là kháng tương đối hoặc tuyệt đối. Một vi khuẩn gây bệnh không chịu tác động của phổ tác dụng thường quy của một loại kháng sinh như thường lệ được gọi là có tình trạng để kháng tự nhiên/nội sinh đối với kháng sinh đó (Vd: 25% các phế cầu khuẩn [*S.pneumoniae*] có tình trạng kháng tự nhiên đối với macrolid). Các để kháng mắc phải (acquired resistance) dành để chỉ một vi khuẩn gây bệnh trước đó vẫn nhạy cảm với một thuốc song hiện tại không còn nhạy cảm với kháng sinh này nữa (Vd: *H.influenzae* kháng với ampicillin). Các vi khuẩn có *mức độ kháng trung gian (hay tương đối)* được biểu hiện bằng sự gia tăng nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), song vẫn nhạy cảm với thuốc ở nồng độ thuốc có thể đạt được trong huyết thanh/mô (Vd: phế cầu [*S.pneumoniae*] kháng penicillin). Trái lại, các vi khuẩn có *mức độ kháng cao (tuyệt đối)* được biểu hiện bằng một gia tăng đột ngột nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trong khi điều trị và không thể khắc phục được tình trạng này bằng cách sử dụng các liều kháng sinh cao hơn liều thường dùng (Vd: trực khuẩn mủ xanh [*P. aerruginosa*] kháng với gentamicin). Hầu hết tình trạng kháng kháng sinh mắc phải có tính chất chuyên biệt với tác nhân gây bệnh (agent-specific) mà không có tính chuyên biệt với nhóm vi khuẩn (class specific) và thường chỉ hạn chế đối với một hoặc hai chủng vi khuẩn. Về bản chất, tình trạng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

kháng thuốc không liên quan với thể tích phân bố thuốc trong huyết thanh hoặc thời gian dùng thuốc dài hay ngắn. Một số kháng sinh ít có nguy cơ gây tình trạng kháng kháng sinh (tức là nguy cơ gây "kháng kháng sinh thấp" ["low resistance" potential]) ngay cả khi được dùng rộng rãi, một số kháng sinh khác có thể dễ có nguy cơ gây tình trạng kháng kháng sinh hơn (tức là có nguy cơ gây "kháng kháng sinh cao" ["high resistance" potential]) ngay cả khi ít được sử dụng.

Các chiến lược kiểm soát thành công đối với tình trạng kháng kháng sinh bao gồm loại bỏ sử dụng kháng sinh khỏi các thức ăn cho gia súc, giám sát vi khuẩn học để phát hiện sớm vấn đề kháng kháng sinh, áp dụng các biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn để hạn chế/khoanh vùng sự lan rộng của các chủng vi khuẩn kháng thuốc di truyền theo dòng vô tính (clonal resistant species), thu hẹp sử dụng các loại kháng sinh được ưu tiên dùng trong bệnh viện (tức là, khuyến cáo các thầy thuốc sử dụng có kiểm soát các kháng sinh có nguy cơ "gây kháng kháng sinh cao" và ưu tiên sử dụng các kháng sinh có nguy cơ "gây kháng kháng sinh thấp"). Các chiến lược kiểm soát ít hiệu quả đối với tình trạng kháng kháng sinh bao gồm quay vòng sử dụng một số phác đồ kháng sinh (rotating formularies), sử dụng hạn chế một số nhóm kháng sinh (Vd: các cephalosporin thế hệ ba, fluoroquinolon) và sử dụng các phác đồ điều trị kết hợp. Khi lựa chọn giữa các kháng sinh tương tự nhau, cố gắng thử chọn dùng một kháng sinh có nguy cơ "gây kháng kháng sinh thấp". Một số kháng sinh (Vd: ceftazidim) kết hợp với làm gia tăng tần suất mắc tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA); một số kháng sinh khác (Vd: vancomycin) kết hợp với gia tăng tần suất mắc cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE).

Nguy cơ gây kháng kháng sinh của từng loại kháng sinh được trình bày trong phần "Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh" tương ứng ***(xem Chương XI)***

D. Các thông tin về tính an toàn của thuốc: Một khi có thể, tránh sử dụng các kháng sinh gây các tác dụng phụ nghiêm trọng/ hoặc thường xảy ra.

E. Chi phí điều trị: Chuyển sớm từ dùng kháng sinh đường tĩnh mạch sang đường uống là một chiến lược quan trọng duy nhất giúp tiết kiệm chi phí điều trị ở các bệnh nhân điều trị trong bệnh viện, do chi phí nằm viện khi phải dùng thuốc theo đường tĩnh mạch (~10 đôla/liều) có thể còn tốn kém hơn nhiều so với giá của chính thuốc kháng sinh được sử dụng. Cũng có thể làm giảm thiểu chi phí điều trị kháng sinh bằng cách sử dụng các kháng sinh có nửa đời sống dài và bằng cách chọn điều trị một kháng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

sinh (monotherapy) thay vì chọn điều trị kết hợp kháng sinh (combination therapy). Các yếu tố khác tham gia làm tăng thêm chi phí điều trị kháng sinh bao gồm sự bắt buộc cần phải dùng một thuốc kháng sinh thứ hai, các tác dụng phụ của kháng sinh (Vd: ỉa chảy, phản ứng da, co giật, viêm tắc mạch và bùng phát vi khuẩn kháng kháng sinh, đòi hỏi phải tập trung cách ly người nhiễm và nhập viện dài ngày).

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LIỀU DÙNG KHÁNG SINH

"Liều thường dùng của kháng sinh" được giả định là khi thuốc này được dùng cho đối tượng có chức năng thận và gan bình thường. Các bệnh nhân bị suy thận và/hoặc rối loạn chức năng gan đáng kể có thể cần giảm liều dùng đối với các kháng sinh được các cơ quan này chuyển hóa/thải trừ (Bảng 1.1). Các khuyến cáo liều dùng chuyên biệt dựa trên mức độ suy thận và suy gan sẽ được trình bày chi tiết trong một chương khác (***xem Chương XI***).

A. Suy thận: Do hầu hết các kháng sinh được thận thải trừ có "tỷ số liều độc so với liều điều trị" ("toxic-to-therapeutic ratio") dao động rộng, vì vậy các phác đồ dùng liều thường được dựa trên ước tính độ thanh thải creatinin bằng công thức (***Bảng 1.1***), thay vì dựa trên tính toán chính xác tốc độ lọc cầu thận. Điều chỉnh liều đặc biệt quan trọng đối với các kháng sinh có "tỷ số liều độc so với liều điều trị" hẹp và đối với các bệnh nhân đang dùng đồng thời các thuốc khác có độc tính với thận hoặc ở bệnh nhân có bệnh thận từ trước.

Bảng 1.1. Các phác đồ dùng liều trong suy gan/ suy thận*

Suy gan

- Giảm 50% tổng liều dùng hàng ngày của kháng sinh được thải trừ qua gan khi có bệnh gan nặng trên lâm sàng.

- **Phác đồ thay thế: Sử dụng một kháng sinh được thải trừ/bị bất hoạt qua đường thận khi dùng liều thường dùng.**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Suy thận

- Nếu độ thanh thải creatinin ~ 40-60 mL/phút, giảm liều 50% đối với các kháng sinh được thải trừ qua thận và duy trì khoảng thời gian dùng liều thường dùng.

- Nếu độ thanh thải creatinin ~ 10-40 mL/phút, giảm liều 50% đối với các kháng sinh được thải trừ qua thận và kéo dài gấp đôi khoảng thời gian dùng liều.

- **Phác đồ thay thế: Sử dụng kháng sinh được thải trừ/ bị bất hoạt qua đường gan khi dùng liều thường dùng.**

1. **Liều khởi đầu và liều duy trì trong suy thận:** Đối với các thuốc được thải trừ qua thận, ***liều khởi đầu không thay đổi*** và ***liều duy trì/khoảng thời gian dùng liều*** được điều chỉnh phù hợp với ***mức độ suy thận (độ thanh thải creatinin***). Có thể khắc phục các khó khăn trong điều chỉnh liều khi có suy thận bằng cách lựa chọn một kháng sinh khác có phổ tác dụng tương đương song được thải trừ qua đường gan.

2. **Liều dùng aminoglycosid:** Áp dụng phác đồ dùng liều một lần duy nhất hàng ngày- được điều chỉnh liều theo mức độ suy thận sau khi dùng liều nạp - đã loại bỏ được gần như hoàn toàn nguy cơ gây độc cho thận của các aminoglycosid và được khuyến cáo sử dụng cho tất cả các bệnh nhân, kể cả đối với các bệnh nhân Hồi sức – Cấp cứu (một ngoại lệ có thể gặp là đối với viêm nội tâm mạc do cầu khuẩn ruột, trong trường hợp này phác đồ được ưu tiên áp dụng hơn là liều gentamicin mỗi 8h/lần). Đánh giá tốt nhất đối với tình trạng rối loạn chức năng ống thận do dùng aminoglycosid là đếm số lượng trụ ống thận trong nước tiểu và thông số này phản ánh độc tính của aminoglycosid đối với thận chính xác hơn là nồng độ creatinin huyết thanh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các con đường chính thải trừ thuốc			
Gan mật		**Thận**	
Chloramphenicol	Isoniazid	Hầu hết các β-lactams	Amantadin
Cefoperazon	Ethambutol	Aminoglycosid	Rimantadin
Ceftriaxon†	Rifampin	TMP-SMX	Acyclovir
Doxycyclin	Pyrazinamid	Aztreonam	Valacyclovir
Minocyclin	Linezolid	Carbapenem	Famciclovir
Telithromycin	Itraconazol	Polymycin B	Valganciclovir
Moxifloxacin	Caspofungin	Colistin	Oseltamavir
Macrolid	Micafungin	Ciprofloxacin	Peramavir
Nafcillin	Anidulafungin	Levofloxacin	Zanamavir
Clindamycin	Ketoconazol	Gatifloxacin	Tetracyclin
Metronidazol	Voriconazol	Gemifloxacin	Oxacillin
Tigecyclin	Posaconazol	Flucytosin	Daptomycin
Quinpristin/ dalfopristin		Fluconazol	Telavancin
		Amphotericin	Ceftarolin fosamil
		Vancomycin	Fosfomycin
		Nitrofurantoin	Cycloserin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

** Xem phần "Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh" đối với từng thuốc riêng biệt trong **Chương XI** để biết các khuyến cáo liều dùng đặc hiệu đối với mỗi thuốc. Độ thanh thải creatinin (Creatinine clearance [CrCl] được sử dụng để đánh giá chức năng thận và có thể được ước tính theo công thức sau: CrCl (mL/phút)= [(140- tuổi) x trọng lượng cơ thể (Kg)/ [72 x nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dL)]. Kết quả được nhân với 0,85 nếu là bệnh nhân nữ. Điều quan trọng cần ghi nhận là do có tình trạng suy giảm dần chức năng thận phụ thuộc theo tuổi của bệnh nhân, các bệnh nhân lớn tuổi có nồng độ creatinin huyết thanh trong giới hạn "bình thường" có thể có CrCl đòi hỏi phải điều chỉnh liều dùng của kháng sinh được chỉ định. Vd., một phụ nữ 70 tuổi, nặng 50 kg có nồng độ creatinin huyết thanh là 1,2 mg/dL sẽ có CrCl ước tính là 34 mL/phút.*

† ~ ½ được thải trừ qua thận.

B. Suy gan: Liều dùng kháng sinh cho các bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan là vấn đề còn gây nhiều tranh cãi, do không có một chỉ dấu nào giống như thông số nồng độ creatinin huyết thanh giúp đánh giá chính xác chức năng gan. Trong thực hành, liều dùng kháng sinh được dựa trên đánh giá lâm sàng mức độ nặng của bệnh gan. Để phục vụ mục đích lâm sàng,

thường không cần điều chỉnh liều đối với các trường hợp suy gan nhẹ hoặc vừa. Đối với suy gan nặng, thường cần tiến hành điều chỉnh liều khi dùng các kháng sinh có nguy cơ gây độc cho gan (***Chương IX***). Có tương đối ít kháng sinh phụ thuộc hoàn toàn vào chức năng gây bất hoạt/ thải trừ thuốc của gan và các khó khăn trong điều chỉnh liều đối với các trường hợp này có thể được khắc phục bằng cách chọn một kháng sinh thích hợp được thải trừ qua đường thận.

C. **Kết hợp suy gan và suy thận:** Không có các hướng dẫn tốt để điều chỉnh liều dùng cho các bệnh nhân bị suy cả gan và thận. Nếu tình trạng suy thận nặng hơn tình trạng suy gan, các kháng sinh được thải trừ qua gan thường được dùng với liều bằng một nửa so với tổng liều thường dùng hàng ngày. Nếu tình trạng suy gan nặng hơn tình trạng suy thận, các kháng sinh được thải trừ qua thận thường được dùng và liều dùng được điều chỉnh phù hợp theo chức năng thận.

D. **Kiểu thải trừ của kháng sinh/độc tính trên cơ quan bài xuất:** Kiểu thải trừ/ bài xuất thuốc không dự kiến khuynh hướng gây độc đối với cơ quan bài xuất thuốc kháng sinh được sử dụng, Vd., nafcillin (một thuốc được thải trừ qua gan) không phải là một chất gây độc đối với gan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÉT NGHIỆM VI SINH VÀ TEST ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CỦA VI KHUẨN VỚI KHÁNG SINH

A. **Tổng quan**. Test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh trên in vitro cung cấp các thông tin về độ nhạy vi sinh của một vi khuẩn gây bệnh đối với các kháng sinh khác nhau và hữu ích cho hướng dẫn điều trị. Áp dụng đúng các dữ liệu vi sinh vật và độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận các kết quả trên in vitro để xác định là liệu các kết quả này có phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng không; nếu không nhận định lâm sàng thường được ưu tiên xem xét.

B. **Các hạn chế của test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh**

1. ***Các dữ liệu trên in vitro không thể phân biệt được giữa vi khuẩn ngụ cư (colonizer)*** và ***vi khuẩn gây bệnh (pathogens)***. Trước khi nhận định

kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ phòng xét nghiệm vi sinh, điều quan trọng là cần xác định xem liệu vi khuẩn được trả lời trong kết quả nuôi cấy là vi khuẩn gây bệnh hay chỉ là một vi khuẩn ngụ cư trong bệnh cảnh lâm sàng. Một nguyên tắc là không cần điều trị đối với các vi khuẩn ngụ cư.

2. ***Các dữ liệu trên in vitro không phải lúc nào cũng có thể chuyển tải thành hiệu quả trên invivo***. Kết quả test chỉ dẫn một vi sinh vật "nhạy cảm với" hoặc "đề kháng với" kháng sinh được test trên in vitro không nhất thiết sẽ phản ánh hoạt tính trên in vivo. ***Bảng 1.2*** liệt kê các kết hợp kháng sinh- vi sinh vật khiến test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh thường không đáng tin cậy.

3. ***Test đánh giá*** độ nhạy ***trên in vitro phụ thuộc vào vi khuẩn, phương pháp làm test và nồng độ kháng sinh***. Test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh trên *in vitro* tại các phòng xét nghiệm vi sinh *giả định là* chủng vi khuẩn phân lập được phát hiện từ *bệnh phẩm máu* và được tiếp xúc với *nồng độ trong huyết thanh* của một kháng được test với liều thường dùng. Do một số vị trí trong cơ thể (Vd: bàng quang, nước tiểu chứa một nồng độ kháng sinh cao hơn nồng độ được thấy trong huyết thanh) và ở các vị trí khác (Vd: dịch não tủy chứa nồng độ kháng sinh thấp hơn nồng độ được thấy trong huyết thanh), các dữ liệu trên *in vitro* có thể cho kết quả sai lạc đối với các nhiễm khuẩn không gây nhiễm theo đường máu (non-bloodstream infections). Vd., phân lập được *Klebsiella pneumoniae* từ dịch não tủy có thể được nhận định như là "nhạy cảm" với cefazolin ngay cả khi cefazolin không thấm được vào dịch não tủy. Tương tự như vậy, phân lập được *E. coli* và *Klebsiella* trong nước tiểu thường được báo cáo là "đề kháng" với ampicillin/ sulbactam mặc dù thuốc có hiệu quả điều trị trên *in vivo*, do nồng độ kháng sinh cao trong đường tiết niệu. Cần kê dùng các kháng sinh với liều thường dùng được khuyến cáo. Các nỗ lực làm giảm thiểu chi phí điều trị bằng cách giảm liều dùng có thể làm giảm hiệu quả của kháng sinh (Vd: cefoxitin với liều 2g đường tĩnh mạch ức chế được ~85% các chủng *B. fragilis* được phân lập, trái lại khi dùng với liều 1g đường TM chỉ ức chế được ~20 các chủng vi khuẩn này).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 1.2. Các kết hợp kháng sinh- vi sinh vật khiến test đánh giá độ nhạy **của vi khuẩn với kháng sinh trên *in vitro* không thể dự đoán được hiệu quả trên *in vivo*[1]**

Kháng sinh	Các vi khuẩn có thể "nhạy cảm" với thuốc
Penicillin	*H. influenzae, Yersinia pestis*
TMP-SMX	Klebsiella, Enterococci, Bartonella
Polymycin B	Proteus, Salmonella
Imipenem	*Stenotrophomonas maltophilia* [2]
Gentamicin	Trực khuẩn lao (*Mucobacterium tuberculosis*)
Vancomycin	*Erysipelothrix rhusiopathiae*
Aminoglycosid	Streptococci, Salmonella, Shigella
Clindamycin	Fusobacteria, Clostridia, enterococci, Listeria
Macrolid	*P. multocida*
Cephalosporin thế hệ 1 và 2	Salmonella, Shigella, Bartonella
Cephalosporin thế hệ 3 và 4 [4]	Enterococci, Listeria, Bartonella
Tất cả các kháng sinh	Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)[3]

1: *Test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh trên in vitro không giúp dự kiến hoạt tính của thuốc trên in vivo. Không thể dựa trên các dữ liệu về độ nhạy của vi khuẩn để hướng dẫn điều trị đối với các kết hợp kháng sinh- vi sinh vật được nêu trong bảng này.*

2: *Trước đây được gọi là Pseudomonas.*

3: *Mặc dù tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) nhạy cảm rõ rệt với nhiều loại kháng sinh trên in vitro, chỉ có vancomycin, minocyclin, quinupristin/dalfopristin, linezolid, daptomycin, ceftarolin fosamil (chỉ duy nhất đối với nhiễm khuẩn do và cấu trúc da cấp do vi khuẩn), telavancin và tigecyclin có hiệu quả trên in vivo.*

4: *Cefoperazon là một cephalosporin duy nhất có hoạt tính chống cầu khuẩn khuẩn ruột hữu ích trên lâm sàng đối với E. faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]), song thuốc không có hoạt tính đối với E. faecium (cầu khuẩn ruột kháng vancomycin [VRE]).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

4. **Các kiểu nhạy cảm không thường gặp của vi khuẩn với kháng sinh:** Các vi khuẩn có kiểu nhạy cảm với kháng sinh có thể được dự kiến trước. Khi một chủng vi khuẩn được phân lập có kiểu nhạy cảm không thường gặp (tức là phân lập được các chủng vi khuẩn không phù hợp với kiểu nhạy cảm với kháng sinh thường gặp đối với loại vi khuẩn này) (***Bảng 1.3***), phòng xét nghiệm vi sinh cần tiến hành thêm các xét nghiệm thăm dò. Các test mở rộng đánh giá độ nhạy của vi khuẩn có thể cần được chỉ định.

Bảng 1.3. Các kiểu nhạy cảm không thường gặp của vi khuẩn với kháng sinh đòi hỏi phải chỉ định thêm các test vi sinh

Vi khuẩn	Các kiểu nhạy cảm không thường gặp	Các kiểu nhạy cảm thường gặp
Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)	Kháng với penicillin	Nhạy cảm với penicillin
Tụ cầu (Staphylococci)	Kháng với vancomycin/ clindamycin; nhạy cảm với erythromycin	Nhạy cảm với vancomycin
Liên cầu viridans (*Viridans streptococci*)	Kháng/ đáp ứng trung gian với vancomycin	Nhạy cảm với vancomycin
Phế cầu (*S.pneumoniae*)	Kháng với/ đáp ứng trung gian với vancomycin	Nhạy cảm với vancomycin
Liên cầu tan máu β (*β-hemolytic* streptococci)	Kháng/ đáp ứng trung gian với penicillin	Nhạy cảm với penicillin
Trực khuẩn ruột (Enterobacteriaceae)	Kháng với imipenem	Nhạy cảm với imipenem
E.Coli, *P.mirabilis*, Klebsiella	Kháng với cefoxitin/cefotetan	Nhạy cảm với cephalosporin thế hệ hai
Enterobacter, Serratia	Nhạy cảm với ampicillin/ cefazolin	Kháng với ampicillin/ cefazolin
Morganella, Providencia	Nhạy cảm với ampicillin/ cefazolin	Kháng với ampicillin/ cefazolin
Klebsiella	Nhạy cảm với cefotetam; Kháng với ceftazidim	Kháng với cefotetam; Nhạy cảm với ceftazidim

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

P. aeruginosa	Kháng với amikacin; nhạy cảm với gentamicin /tobramycin	Nhạy cảm với amikacin; Kháng với gentamicin / tobramycin
Stenotrophomonas maltophilia (*S.maltophilia*)	Kháng với TMP-SMX; Nhạy cảm với imipenem	Nhạy cảm với TMP-SMX

Các chủng vi khuẩn phân lập được có kiểu nhạy cảm với kháng sinh không thường gặp đòi hỏi phòng xét nghiệm vi sinh thực hiện các test vi sinh thêm để xác nhận chủng vi khuẩn được phân lập và cụ thể hóa cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn. Các test mở rộng để đánh giá độ nhạy của vi khuẩn đối với kháng sinh được chỉ định.

Bảng 1.4. Các kiểu nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn kháng lại với nhiều thuốc kháng sinh (Multi-Drug Resistant Organisms [MDROs]) và của vi khuẩn sinh enzym β-Lactamase phổ mở rộng (Extended-Spectrum β-Lactamase [**ESBL**]) *

Các đặc điểm kháng kháng sinh của vi khuẩn kháng lại nhiều thuốc kháng sinh (MDROs) & vi khuẩn sinh enzym β-Lactamase phổ mở rộng (ESBL)

Các đặc điểm kháng kháng sinh

- *Acinebacter sp* thuộc chủng vi khuẩn kháng lại nhiều thuốc kháng sinh (MDRO) ***kháng lại với ciprofloxacin, amikacin và ceftazidim***
- *Pseudomonas aeruginosa* thuộc chủng vi khuẩn kháng lại nhiều thuốc kháng sinh (MDRO) ***kháng lại với amikacin và meropenem***
- *Klebsiella oxytoca* sinh enzym β-lactamase phổ mở rộng (ESBL) ***kháng lại với ceftazidim***
- *Klebsiella pneumoniae* sinh enzym β-lactamase phổ mở rộng (ESBL) ***kháng lại với ceftazidim***
- *Enterobacter .sp* sinh enzym β-lactamase phổ mở rộng (ESBL) ***khánglại với ceftazidim***
- *Escherichia coli* sinh enzym β-lactamase phổ mở rộng (ESBL) ***khánglại với ceftazidim***
- *Proteus mirabilis* sinh enzym β-lactamase phổ mở rộng (ESBL) ***kháng lại với ceftazidim***

* ***Hầu hết các vi khuẩn sinh enzym ESBL*** **là Klebsiella, Enterobacter, E. coli**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điểm gẫy đánh giá độ nhạy **của vi khuẩn với kháng sinh (susceptibility Breakpoints) đối với phế cầu (*Streptococcus pneumoniae*):** Do độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh một phần có liên quan với nồng độ thuốc, Viện tiêu chuẩn hóa đối với các phòng xét nghiệm và lâm sàng (the Clinical and Laboratory Standards Institute [CLSI]), trước đây có tên gọi là Ủy ban Quốc gia về các tiêu chuẩn phòng xét nghiệm lâm sàng (the National Committee for Clinical Laboratory Standards [NCCLS]), đã sửa đổi lại giá trị điểm gẫy đối với test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của *S.pneumoniae*, giá trị này phân biệt giữa vị trí nhiễm khuẩn phế cầu tại màng não và ngoài màng não (***Bảng 1.5***).

Bảng 1.5. Điểm gẫy đánh giá độ nhạy với kháng sinh đối với phế cầu của Viện tiêu chuẩn hóa đối với các phòng xét nghiệm và lâm sàng (CLSI)*

Kháng sinh	Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/mL)		
	Nhạy	Trung gian	Kháng
Amoxicillin (không phải trong điều trị viêm màng não)	≤ 2	4	≤ 8
Amoxicillin-clavulanic acid (không phải trong điều trị viêm màng não)	≤ 2/1	4/2	≤ 8/4
Penicillin (trong điều trị viêm màng não)	≤ 0,06	-	≤ 0,12
Penicillin (không phải trong điều trị viêm màng não)	≤ 2	4	≤ 8
Azithromycin	≤ 0,5	1	≤ 2
Clarithromycin/erythromycin	≤ 0,25	0,5	≤ 1
Doxycyclin/tetracyclin	≤ 2	4	≤ 8
Telithromycin	≤ 1	2	≤ 4
Cefaclor	≤ 1	2	≤ 4
Cefdinir/cefpodoxim	≤ 0,5	1	≤ 2
Cefprozil	≤ 2	4	≤ 8
Cefuroxime axetil (đường uống)	≤ 1	2	≤ 4
Loracarbef	≤ 2	4	≤ 8
Cefepim (không phải trong điều trị viêm màng não)	≤ 1	2	≤ 4
Cefepim (trong điều trị viêm màng não)	≤ 0,5	1	≤ 2

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cefotaxim (không phải trong điều trị viêm màng não)	≤ 1	2	≤ 4
Cefotaxim (trong điều trị viêm màng não)	≤ 0,5	1	≤ 2
Ceftriaxon (không phải trong điều trị viêm màng não)	≤ 1	2	≤ 4
Ceftriaxon (trong điều trị viêm màng não)	≤ 0,5	1	≤ 2
Imipenem	≤ 0,12	0,25-0,5	≤ 1
Meropenem	≤ 0,25	0,5	≤ 1
Ertapenem	≤ 1	2	≤ 4
Vancomycin	≤ 1	-	-
Moxifloxacin	≤ 1	2	≤ 4
Levofloxacin	≤ 2	4	≤ 8
TMP-SMX	≤ 0,5/9,5	1/19-2/38	≤4/78
Chloramphenicol	≤ 4	-	≤ 8
Clindamycin	≤ 0,25	0,5	≤ 1
Linezolid	≤ 2	-	-
Rifampin	≤ 1	2	≥ 4

Từ viết tắt: *CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): Viện tiêu chuẩn hóa đối với các phòng xét nghiệm và lâm sàng- trước đây có tên gọi là NCCLS (National Committee for Clinical laboratory Standards): Ủy ban Quốc gia về các tiêu chuẩn phòng xét nghiệm lâm sàng; M100-S20 (2010).*

*Điều kiện làm test: *Môi trường: Canh thang Mueller-Hinton với 2,5% máu ngựa được ly giải (cation-được điều chỉnh). Chất cấy là cụm khuẩn lạc ngưng kết được ủ ở nhiệt độ 35°C (20-24 giờ).*

C. Tóm tắt: Test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn đối với kháng sinh trên in vitro hữu ích trong hầu hết các trường hợp, song không được theo đuổi một cách mù quáng. Nhiều yếu tố cần được xem xét khi giải thích các dữ liệu vi sinh vật trên in vitro, hội chẩn bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm được khuyến cáo cho tất cả các trường hợp nhất là khi gặp khó khăn trong giải thích kết quả test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh. Các thay đổi chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống bằng cách sử dụng cùng kháng sinh hoặc bằng nhóm kháng sinh khác được thực hiện tốt nhất khi kháng sinh dùng đường uống có thể đạt được nồng độ trong máu/mô tương đương như kháng sinh dùng đường tĩnh mạch. Vd., chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống khi đang dùng cefazolin 1g (TM) thành

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

cephalexin 500mg (uống) có thể không hiệu quả đối với tất cả các vi khuẩn gây bệnh tại tất cả các vị trí nhiễm khuẩn, do cephalexin 500mg (uống) đạt được nồng độ huyết thanh thấp hơn nhiều so với cefazolin 1g (TM) (16 µg/mL so với 200µg/mL).

CÁC XEM XÉT KHÁC KHI ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH

A. Điều trị kháng sinh diệt khuẩn **(bactericidal therapy) so sánh với** điều trị kháng sinh cản khuẩn **(bacteriostatic therapy):** Đối với hầu hết các nhiễm khuẩn, kháng sinh cản khuẩn và kháng sinh diệt khuẩn đều ức chế/ tiêu diệt vi khuẩn với cùng tốc độ và ***hầu không phải là yếu tố được tính tới trong lựa chọn kháng sinh***. Các kháng sinh diệt khuẩn có ưu điểm đối với một số nhiễm khuẩn, như viêm nội tâm mạc, viêm màng não và giảm bạch cầu có sốt, song có các ngoại lệ ngay cả đối với các trường hợp này.

B. Điều trị bằng một kháng sinh **(monotherapy) so sánh với điều trị kết hợp (combination therapy):** Điều trị bằng một kháng sinh được ưa dùng hơn so với điều trị kết hợp ***đối với gần như tất cả các nhiễm khuẩn***. Ngoài giúp tiết kiệm chi phí, điều trị bằng một kháng sinh sẽ làm giảm cơ may bị các sai sót về dùng thuốc và nguy cơ bỏ liều/tương tác thuốc ít xảy ra hơn. Điều trị kết hợp kháng sinh có thể hữu ích để có được tác dụng hiệp đồng của thuốc hoặc để mở rộng phổ tác dụng so với phổ tác dụng có được khi dùng một thuốc đơn độc.Tuy nhiên, do khó đánh giá tác dụng hiệp đồng thuốc và luôn có khả năng bị đối lập tác dụng, chỉ nên phối hợp kháng sinh với mục đích có được tác dụng hiệp đồng nếu tác dụng hiệp đồng này được dựa trên test đánh giá thực tế. Điều trị kết hợp kháng sinh không có hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng kháng kháng sinh, ngoại trừ trong một số tình huống hãn hữu (***Bảng 1.6***).

C. Điều trị bằng đường tĩnh mạch so sánh với chuyển sang điều trị bằng đường uống**:** Bệnh nhân nhập viện thường được bắt đầu bằng điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, sau đó chuyển sang điều trị bằng đường uống với liều tương đương sau khi có cải thiện lâm sàng/ giảm sốt (thường trong vòng 72 giờ). ***Các ưu điểm của chương trình chuyển sớm từ đường tĩnh mạch sang đường uống bao gồm giảm chi phí điều trị, bệnh nhân có thể được xuất viện sớm, làm giảm thiểu nhu cầu điều trị đường tĩnh mạch tại nhà và giúp loại bỏ thực sự các nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch***. Các thuốc rất phù hợp để chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống hoặc

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

để điều trị hoàn toàn bằng đường uống bao gồm doxycyclin, minocyclin, clindamycin, metronidazol, chloramphenicol, amoxicillin, trimethoprim-sulfamethoxazol, quinolon và linezolid.

Hầu hết các bệnh nhiễm khuẩn nên được điều trị bằng đường uống trừ khi bệnh nhân trong tình trạng bệnh nặng cần hồi sức, không thể dùng kháng sinh bằng đường uống hoặc không có kháng sinh uống tương đương. Nếu bệnh nhân có thể uống được/hấp thu được kháng sinh dùng đường uống, không có khác biệt trong kết cục lâm sàng khi sử dụng các kháng sinh với liều tương đương theo đường tĩnh mạch hoặc đường uống. Điều quan trọng hơn cần nghĩ tới chỉ xem xét về phổ tác dụng của kháng sinh, sinh khả dụng và khả năng thâm nhập vào mô của thuốc hơn là con đường dùng thuốc.

Bảng 1.6. Điều trị kết hợp kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh

Các ví dụ về điều trị kết hợp kháng sinh giúp dự phòng tình trạng kháng kháng sinh:

Penicillin kháng pseudomonas (carbenicillin)+ aminoglycosid (gentamicin , tobramycin, amikacin).

Rifampin + các thuốc chống lao khác (INH, ethambutol, pyrazinamid)

5-flucytosin + Amphotericin B.

***Các ví dụ về điều trị kết hợp kháng sinh không giúp dự phòng được tình trạng kháng kháng sinh*:**

TMP-SMX

Aztreonam + ceftazidim

Cefepim + ciprofloxacin

Aminoglycosid + imipenem

Hầu hết các kết hợp kháng sinh khác

* *Các kết hợp kháng sinh này thường được kê dùng cho bệnh nhân để dự phòng tình trạng kháng kháng sinh, song thực tế sự kết hợp này lại không đạt được mục tiêu này.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Gần như tất cả các bệnh nhân không trong tình trạng bệnh lý nặng cần hồi sức nên được điều trị một phần hoặc toàn bộ bằng kháng sinh ***uống.*** Khi chuyển từ điều trị đường tĩnh mạch sang đường uống, ***kháng sinh uống được chọn dùng cần có cùng phổ tác dụng/mức độ hoạt tính đối với mầm bệnh được biết/***được giả định và ***phải*** đạt được ***cùng nồng độ trong máu và mô như kháng sinh tương đương dùng đường tĩnh mạch*** (***Bảng 1.7***).

Bảng 1.7. Sinh khả dụng của các kháng sinh uống

Sinh khả dụng	Kháng sinh		
Cực kỳ tốt[1] (>90%)	Amoxicllin	TMP	Linezolid
	Cephalexin	TMP-SMX	Fluconazol
	Cefprozil	Doxycyclin	Voriconazol
	Cefadroxil	Minoxyclin	Rifampin
	Clindamycin	Chloramphenicol	Isoniazid
	Quinolon	Metronidazol	Pyrazinamid
			Cycloserin
Tốt [2] (60-90%)	Cefixim	Valaciclovir	Ethambutol
	Cefpodoxim	Famciclovir	5-Flucytosin
	Ceftibuten	Valganciclovir	Posaconazol
	Cefurroxim	Macrolid	Itraconazol (dung dịch)
		Cefaclor	Nitazoxanid (với thức ăn)
		Nitrofurantoin	
Kém [3] (< 60%)	Vancomycin	Cefdinir	Nitazoxanid (ngoài bữa ăn)
	Acyclovir	Cefditoren	Fosfomycin

1: *Dùng theo đường uống tạo ra* ***nồng độ thuốc trong máu/mô tương đương*** *như* cùng liều thuốc được dùng theo đường tĩnh mạch (đường uống= đường tĩnh mạch).

2: *Dùng theo đường uống tạo ra* ***nồng độ thuốc trong máu/mô thấp hơn song vẫn có hiệu quả điều trị như*** *cùng liều thuốc được dùng theo đường tĩnh mạch (đường uống* < đường tĩnh mạch).

3: *Dùng theo đường uống tạo ra* ***nồng độ thuốc trong máu/mô dưới mức hiệu quả.***

D. Thời gian điều trị. Hầu hết các nhiễm khuẩn do vi khuẩn ở đối tượng là người bình thường cần được điều trị kháng sinh trong vòng 1-2 tuần. Có thể cần kéo dài hơn thời gian điều trị ở các bệnh nhân bị suy giảm khả năng miễn dịch (Vd: đái tháo đường, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh gan do rượu,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

giảm bạch cầu đa nhân trung tính, giảm chức năng lách, v.v...), nhiễm khuẩn mạn tính do vi khuẩn (Vd: viêm nội tâm mạc, viêm xương-tủy), nhiễm khuẩn mạn do virus và nấm hoặc khi nhiễm một số tác nhân gây bệnh là vi khuẩn nội tế bào (***Bảng 1.8***). Các nhiễm khuẩn như nhiễm HIV có thể cần điều trị suốt đời. Thông thường, điều trị kháng sinh không nên dùng kéo dài liên tục quá 2 tuần, ngay cả khi bệnh nhân vẫn tiếp tục còn tình trạng sốt nhẹ (***Bảng 1.8***). Điều trị dài ngày không mang lại lợi ích gì và làm tăng nguy cơ bị các tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc và bội nhiễm.

Bảng 1.8. Các bệnh nhiễm khuẩn cần điều trị kháng sinh dài ngày

Điều trị	**Bệnh nhiễm khuẩn**
3 tuần	Bệnh hạ cam hay bệnh Nicolas-Favre (Lymphogranuloma venereum), giang mai (giang mai giai đoạn hai), nhiễm *H.pylori*, viêm tuyến tiền liệt mạn tính.
4 tuần	Viêm tai giữa mạn tính, viêm xoang mạn, viêm xương-tủy cấp, viêm thận-bể thận mạn, ápxe não, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn.
4-6 tuần	Viêm nội tâm mạc cấp tính do vi khuẩn (do tụ cầu vàng, listeria, cầu khuẩn ruột), viêm xương-tủy xương mạn tính [4]
3 tháng	Ápxe phổi [1], bệnh nhiễm khuẩn malleomyces pseudomallei (vi khuẩn whitmore), nhiễm khuẩn do bartonella.
6 tháng	Lao phổi, lao ngoài phổi, bệnh do nấm actinomyces[2], nocardia[3], các nhiễm khuẩn liên quan với đặt bộ phận giả trong cơ thể [5].
12 tháng	Bệnh Whipple.
>12 tháng	Phong thể u phong (Lepromatous leprosy), nhiễm HIV, sốt Q (viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn/viêm nội tâm mạc xảy ra trên van nhân tạo).

1: Điều trị tới *khi khỏi bệnh hoặc tới khi phim chụp Xquang phổi trở lại bình thường/gần bình thường và không thay đổi ổn định.*

2: *Có thể cần điều trị dài hơn; điều trị tới khi khỏi bệnh.*

3: *Có thể cần điều trị dài hơn ở các cơ địa bị suy giảm miễn dịch.*

4: *Cần tiến hành cắt bỏ mô bị hoại tử bằng phẫu thuật một cách thỏa đáng để điều trị triệt để.*

5: *Các chất liệu ngoại lai được cấy ghép trong cơ thể kết hợp với nhiễm khuẩn (van tim nhân tạo,* đoạn mạch máu nhân tạo được cấy ghép, *khớp nhân tạo, shunt lọc máu) cần được lấy bỏ* càng sớm càng tốt sau chẩn đoán. Nếu *không thể lấy bỏ được bộ phận giả khỏi cơ thể, khi đó có thể thử áp dụng* điều trị ức chế nhiễm khuẩn dài ngày, *mặc dù thất bại lâm sàng nhiều khả năng xảy ra.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Các dữ liệu về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn thường không có sẵn để áp dụng trước khi bắt đầu tiến hành điều trị bằng kháng sinh. Điều trị theo kinh nghiệm dựa trên việc hướng điều trị bao phủ đối với vi khuẩn gây bệnh bị nghi vấn nhất và có xem xét tới tiền sử dị ứng thuốc, chức năng gan/thận, các tác dụng phụ của kháng sinh có thể gặp, nguy cơ gây kháng thuốc và chi phí điều trị. Nếu một bệnh nhân có tình trạng bệnh ở mức độ vừa hoặc nặng, thường khởi đầu điều trị theo kinh nghiệm bằng đường tĩnh mạch. Các bệnh nhân có tình trạng bệnh nhẹ, bất kể được nhập viện hay điều trị ngoại trú, có thể được bắt đầu bằng kháng sinh uống có tính sinh khả dụng cao. Nên thực hiện nuôi cấy các bệnh phẩm lâm sàng thích hợp (*Vd*: máu, đờm, nước tiểu) trước khi bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm để có được các phân lập vi khuẩn giúp làm test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn trên in vitro. Điều trị theo kinh nghiệm đối với các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp được trình bày trong ***Chương II***.

THẤT BẠI KHÁNG SINH

Có nhiều nguyên nhân rõ ràng có thể gây ra tình trạng thất bại điều trị kháng sinh, bao gồm sốt do thuốc, các nhiễm khuẩn không đáp ứng với kháng sinh và các bệnh lý gây sốt song không phải là nhiễm khuẩn. Sai lầm thường gặp nhất trong xử trí đối với tình trạng thất bại kháng sinh hiển nhiên này là thay đổi/phối hợp thêm kháng sinh thay vì tìm kiếm và xác định nguyên nhân (***Bảng 1.9, 1.10***).

Bảng 1.9 Các nguyên nhân gây thất bại kháng sinh hiển nhiên/thực tại

Các yếu tố liên quan với vi sinh vật

- Vi khuẩn nhạy cảm với thuốc trên in vitro song không có hiệu quả trên *in vivo*.
- Dung nạp kháng sinh của cầu khuẩn Gram dương.
- Điều trị tình trạng vi khuẩn cư trú (không phải là nhiễm khuẩn).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các yếu tố liên quan với kháng sinh

- Phổ tác dụng/ diện bao phủ của kháng sinh không thỏa đáng.
- Nồng độ kháng sinh trong máu không thỏa đáng.
- Nồng độ kháng sinh trong mô không thỏa đáng.
- Giảm hoạt tính kháng sinh trong mô.
- Các tương tác thuốc-thuốc:

  Bất hoạt kháng sinh.

  Đối kháng tác dụng của kháng sinh.

Các vấn đề liên quan với khả năng thấm của kháng sinh vào mô

- Ổ ápxe không được dẫn lưu.
- Nhiễm khuẩn liên quan với dị vật.
- Ổ nhiễm khuẩn được che chắn (protected focus) Vd., dịch não tủy.
- Giảm tưới máu/giảm cấp máu cho cơ quan bị nhiễm khuẩn:

  Viêm xương-tủy xương mạn tính.

  Viêm thận-bể thận mạn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Không phải là bệnh nhiễm khuẩn

- Các bệnh lý nội khoa giống như nhiễm khuẩn (Vd: bệnh lupus ban đỏ hệ thống).
- Sốt do thuốc.

Bệnh nhiễm khuẩn không đáp ứng với kháng sinh

- Nhiễm khuẩn do virus.
- Nhiễm khuẩn do nấm.

Bảng 1.10. Các đặc điểm lâm sàng của sốt do thuốc

Tiền sử

Nhiều song không phải tất cả các đối tượng này có cơ địa dị ứng.

Bệnh nhân mẫn cảm với thuốc trong nhiều ngày tới nhiều năm mà không có "bất kỳ biểu hiện gì".

Khám thực thể

Nhịp tim chậm tương đối (***xem trang 23***).

Sốt có thể thấp hoặc cao, song thường dao động trong khoảng 39°C-39,5°C và có thể cao hơn 40°C.

Bệnh nhân dường như "dung nạp rất tốt" với các mức độ sốt.

Các xét nghiệm cận lâm sàng

Tăng số lượng bạch cầu (thường với chuyển dịch sang trái).

Tăng số lượng bạch cầu ưa acid gần như luôn gặp song ít gặp tình trạng tăng bạch cầu ưa acid (eosinophilia).

Tăng tốc độ lắng hồng cầu được gặp trong hầu hết các trường hợp.

Tăng nhẹ các enzym transaminase huyết thanh xảy ra sớm và thoáng qua (thường gặp).

Cấy máu âm tính (loại trừ tình trạng nhiễm bẩn).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhịp tim chậm tương đối *

Mối tương quan giữa nhiệt độ cơ thể và nhịp tim hay mạch đập

Nhiệt độ	Đáp ứng mạch đập thích hợp (nhịp/phút)	Mạch chậm tương đối (nhịp/phút)
41°C	150	<140
40,5°C	140	<130
40°C	130	<120
39,5°C	120	<110
39°C	110	<100

* *Nhịp tim chậm tương đối (relative bradycardia)* dành để chỉ tình trạng *tần số tim chậm một cách không thích hợp so với thân nhiệt (phải tiến hành lấy mạch một cách đồng thời với lấy thân nhiệt khi có tăng thân nhiệt). Áp dụng cho các bệnh nhân người lớn có thân nhiệt ≥ 39°C, không áp dụng cho các bệnh nhân bị block tim độ 2/3, nhịp do* máy tạo nhịp tạo ra hoặc các đối tượng đang dùng *thuốc chẹn beta, diltiazem hoặc verapamil.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TỤ CẦU VÀNG KHÁNG METHICILLIN (MRSA)

Nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) rất thường xảy ra tại các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc y tế (Vd: tại các an dưỡng đường, trung tâm lọc máu) song cũng có thể xảy ra tại cộng đồng. Nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin được phân loại thành nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (hospital-acquired [HA-MRSA]), nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát ở cộng đồng (community-onset [CO-MRSA]) hoặc nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (community-acquired [CA-MRSA]), mỗi loại vi khuẩn gây bệnh này có thể giúp những gợi ý trong điều trị theo kinh nghiệm (***Bảng 11.1***).

Bảng 1.11. Phân loại các nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)

Chủng tụ cầu vàng kháng methicillin	Dịch tế học & Vi khuẩn học	Điều trị
Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (Hospital acquired MRSA [HA-MRSA])*	Các chủng vi khuẩn có nguồn gốc trong bệnh viện, các vi khuẩn này mang các gen SCC mec I, II,III, PVL (+) (hiếm gặp) và sản xuất ra một số độc tố của tụ cầu vàng.	Kháng với hầu hết các kháng sinh. Chỉ có vancomycin, quinupristin/dalfopristin, minocyclin, linezolid, tigecyclin hoặc daptomycin là có hiệu quả đáng tin cậy.
Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát ở cộng đồng (Community onset MRSA [CO-MRSA])*	Các chủng vi khuẩn có nguồn gốc trong bệnh viện và sau này có mặt trong cộng đồng, các vi khuẩn này mang các gen SCC mec I, II,III genes, PVL (+) (hiếm gặp) và sản xuất ra một số độc tố của tụ cầu vàng.	Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin gây nhiễm khuẩn khởi phát ở cộng đồng (CO-MRSA) có cùng độ nhạy cảm với kháng sinh như các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA) và cần được điều trị như nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện
Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (Community acquired MRSA [CA-MRSA])	*Chỉ* các nhiễm khuẩn MRSA" mắc phải từ cộng đồng" được biểu hiện như *một viêm mủ cơ (pyomyositis) nặng hoặc viêm phổi nặng/ hoại tử do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (kèm với cúm)* cần được xem xét như là có nguy cơ do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA). *Tất cả các nhiễm khuẩn khác do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) từ cộng đồng cần được xem xét về phương diện lâm sàng như là do tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát ở cộng đồng (CO-MRSA).* Vi khuẩn mang các gen SCC mec IV,V. PVL+(thường gặp). Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng với PVL– (CA-MRSA PVL-Strains) về phương diện lâm sàng không thể phân biệt được với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) hoặc tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA). Vi khuẩn sản xuất các độc tố thường gặp của tụ cầu vàng cộng với 18 độc tố khác.	Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) nhạy cảm với clindamycin, TMP-SMX và doxycyclin. Kháng sinh được dùng để điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin gây nhiễm khuẩn khởi phát ở cộng đồng (CO-MRSA)/tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA) cũng có hiệu quả đối với nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA), song không phải điều ngược lại lúc nào cũng đúng.

Từ viết tắt: PVL (Panton-Valentine Leukocidin).

** Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát ở cộng đồng (CO-MRSA)= Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA).*

Phỏng theo: **Cunha BA**. *Clinical Manifestations and Antimicrobial Therapy of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Clin Microbiol Infect 11:33-42, 2005 và* **Cunha BA**. *Simplified Clinical Approach to Community acquired MRSA (CA-MRSA) Infections. Journal of Hospital Infections 68: 271-273, 2008.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC SAI LẦM CÓ THỂ GẶP KHI KÊ ĐƠN SỬ DỤNG KHÁNG SINH

- ***Sử dụng kháng sinh để điều trị tình trạng vi khuẩn cư trú hoặc các bệnh không phải nhiễm khuẩn/ bệnh nhiễm khuẩn không đáp ứng với kháng sinh.***

- ***Lạm dụng sử dụng điều trị kết hợp kháng sinh***. Điều trị bằng một kháng sinh *(monotherapy)* được ưa chuộng hơn điều trị kết hợp kháng sinh trừ khi có các lý do bắt buộc đủ sức thuyết phục cho chỉ định này, như cần tới hiệp đồng thuốc hoặc cần mở rộng phổ tác dụng ra ngoài phổ tác dụng có thể đạt được khi dùng một thuốc đơn độc. Điều trị bằng một kháng sinh làm giảm nguy cơ tương tác thuốc và *các tác dụng phụ và thường đỡ tốn kém hơn.*

- ***Sử dụng kháng sinh*** đối với các trường hợp sốt kéo dài. Đối với các bệnh nhân có tình trạng sốt dai dẳng khi đang được điều trị kháng sinh có vẻ như phác đồ điều trị này thất bại, điều quan trọng là phải đánh giá lại bệnh nhân thay vì dùng thêm kháng sinh bổ sung. Các nguyên nhân gây sốt kéo dài bao gồm các ổ nhiễm khuẩn không được dẫn lưu, các bệnh lý nội khoa khác không do nhiễm khuẩn và sốt do thuốc. *Các nguyên nhân gây* tăng bạch cầu/ sốt mức độ thấp *không có chẩn đoán không nên được điều trị bằng liều trình kháng sinh dài ngày.*

- ***Điều trị ngoại khoa không thỏa đáng***. Các nhiễm khuẩn có liên quan với vật liệu của bộ phận giả đặt trong cơ thể bị nhiễm khuẩn hoặc các ổ đọng dịch (Vd: ổ ápxe) thường cần được điều trị ngoại khoa để điều trị triệt để. Đối với các nhiễm khuẩn như viêm xương-tủy xương mạn tính, phẫu thuật *được coi là cách duy nhất để điều trị triệt để nhiễm khuẩn.* Kháng sinh chỉ hữu ích để ức chế hoặc dự phòng các biến chứng nhiễm khuẩn cục bộ.

- ***Điều trị tại nhà bằng đường tĩnh mạch***. Hiện tại, ít có nhu cầu cần tới *sử dụng điều trị tại nhà bằng* đường tĩnh mạch *khi có rất nhiều kháng sinh uống cực kỳ tốt sẵn có để sử dụng (Vd: doxycyclin, minocyclin, quinolon, TMP-SMX, linezolid).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC BÀI GỢI Ý ĐỘC GIẢ ĐỌC THÊM

Bosso JA, Mauldin PD, Salgado CD. The association between antibiotic use and resistance: the role of secondary antibiotics. Eur J Clin Microbiol. Infect Dis. 29: 1125–1192, 2010.

Cunha BA. Oral Antibiotic Therapy of Serious Systemic Infections. Med Clin N Am 90: 1197–1222, 2006.

Cunha BA. Pseudomonas aeruginosa: Resistance and therapy. Semin Respir Infect 17: 231–9, 2002.

Cunha BA. Clinical relevance of penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae. Semin Respir Infect 17: 204–14, 2002.

Cunha BA. Effective antibiotic resistance and control strategies. Lancet 357: 1307–1308, 2001.

Cunha BA. The significance of antibiotic false sensitivity testing with in vitro testing. J Chemother 9: 25–33, 1997.

Cunha BA, Ortega A. Antibiotic failure. Medical Clinics of North America 79: 663–672, 1995.

Empey KM, Rapp RP, Evans ME. The effect of an antimicrobial formulary change on hospital resistance patterns. Pharmacotherapy 22: 81–7, 2002.

Endimiani A, Perez F, Bajaksouzian S, et al. Evaluation of updated interpretive criteria for categorizing Klebsiella pneumoniae with reduced carbapenem susceptibility. J Clin Microbiol. 48: 4417–4425, 2010.

Hicks LA, Monnet DL, Roberts RM. Increase in pneumococcus macrolide resistance, USA. Emerg. Infect. Dis. 16: 896–897, 2010.

Johnson DH, Cunha BA. Drug fever. Infectious Disease Clinics of North America 10: 85–91, 1996.

Jorgensen JH , Ferraro MJ . Antimicrobial susceptibility testing: a review of general principles and contemporary practices . Clin Infect Dis 49: 1749–1755, 2009.

Leekha S, Terrell CL, Edson RS. General principles of antimicrobial therapy. Mayo Clin. Proc. 86:156–167, 2011.

Patel SM, Saravolatz LD. Monotherapy versus combination therapy. Med Clin N Am 90: 1183–95, 2006.

Riou M, Carbonnelle S, Avrain L, et al. In vivo development of an antimicrobial resistance in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from the lower respiratory tract of intensive care unit patients with nosocomial pneumonia and receiving antipseudomonal therapy. Int J. Antimicrobial Agents. 36: 513–522, 2010.

Schlossberg D. Clinical approach to antibiotic failure. Med Clin N Am 90: 1265–77, 2006.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tenover FC, Moellering RC. The rationale for revising the clinical and laboratory standards institute vancomycin minimal inhibitory concentration interpretive criteria for Staphylococcus aureus. Clinical Infect Dis 44: 1208–1215, 2007.

Weinstein MP, Klugman KP, Jones RN. Rationale for revised penicillin susceptibility breakpoints versus Streptococcus pneumoniae: coping with antimicrobial susceptibility in an era of resistance. Clin Infect Dis 48: 1596–1600, 2009.

TEXTBOOKS

Anaissie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA (eds). Clinical Mycology. Churchill Livingstone, New York, 2003.

Baddour L, Gorbach SL (eds). Therapy of Infectious Diseases. Saunders, Philadelphia, Pennsylvania, 2003.

Bryskier A (ed). Antimicrobial Agents . ASM Press, Washington, D.C., 2005.

Chadwick DJ, Goode J (eds). Antibiotic Resistance: Origins, Evolution, Selection and Spread. John Wiley &Sons, New York, 1997.

Cohen J, Powderly WG. Infectious Diseases (2nd ed.). Philadelphia: Elsevier, 2004.

Finch RG, Greenwood D, Norrby SR, Whitley RJ (eds). Antibiotic and Chemotherapy, 8th Edition. Churchill Livingstone, Edinburgh, Scotland, 2003.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases, 3rdEdition. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.

Grayson ML (ed). Kucers' The Use of Antibiotics, 6th Edition, ASM Press, Washington, DC, 2010.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of infectious Diseases, 7th Edition. Philadelphia Elsevier Churchill Livingstone, 2010.

O'Grady F, Lambert HP, Finch RG, Greenwood D (eds). Antibiotic and Chemotherapy, 2nd Edition. Churchill, Livingston, New York, 1997.

Ristuccia AM, Cunha BA (eds). Antimicrobial Therapy. Raven Press, New York , 1984.

Scholar EM Pratt WB (eds). The Antimicrobial Drugs, 2nd Edition, Oxford University Press, New York, 2000.

Schlossberg D (ed). Clinical Infectious Disease. Cambridge:Cambridge University Press, 2008.

Yoshikawa TT, Rajagopalan S (eds). Antibiotic Therapy for Geriatric Patients. Taylor & Francis Group, New York, 2006.

Yu V, Edwards G, McKinnon PS, Peloquin C, Morse G (eds). Antimicrobial Therapy and Vaccines, Volume II: Antimicrobial Agents, 2nd Edition.Esun,Technologies, Pittsburgh, Pennsylvania, 2005.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương II

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM DỰA VÀO HỘI CHỨNG LÂM SÀNG

Burke A. Cunha, MD
John L. Brusch, MD
Ronald L. Nichols, MD
Genovefa Papanicolaou, MD
Jean E.Hage, MD
Raymond S. Koff, MD
John H. Rex, MD
Dennis J. Cleri, MD
Cheston B. Cunha, MD
Staci A. Fischer, MD
David Schlossberg, MD

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NGƯỜI DỊCH:

TS. Lương Quốc Chính
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Vũ Quốc Đạt
Bộ môn truyền nhiễm, trường Đại học Y Hà Nội

TS. Mai Duy Tôn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

TS. Trần Hữu Thông
Khoa Cấp cứu, Bệnh Viện Bạch Mai

TS. Ngô Đức Ngọc
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

TS. Nguyễn Hữu Quân
Khoa Cấp cứu Bệnh viện, Bạch Mai

Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương	32
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đầu – mắt – tai – mũi – họng	55
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới	87
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn tim mạch	129
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa	151
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn đường tiết niệu – sinh dục	183
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục	204
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn xương khớp	217
Điều trị theo kinh nghiệm cho các nhiễm khuẩn da và mô mềm	236
Nhiễm khuẩn huyết/Shock nhiễm khuẩn	268
Sốt giảm bạch cầu	280
Các bệnh nhiễm trùng sau cấy ghép tạng	283
Các bệnh nhiễm trùng qua trung gian độc tố	297
Các tác nhân trong khủng bố sinh học	303
Tài liệu tham khảo và bài độc giả nên đọc thêm.	311

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương này được sắp theo các hội chứng lâm sàng, phân loại bệnh nhân và trong một số trường hợp, theo các chủng vi sinh vật đặc hiệu. Tóm tắt lâm sàng được trình bày ngay sau mỗi bảng điều trị. ***Chương này chủ yếu trình bày các bệnh nhiễm khuẩn và kháng sinh điều trị cho người lớn. Đối với các bệnh nhiễm khuẩn và điều trị kháng sinh ở trẻ em xin xem Chương VII.*** Các khuyến cáo điều trị được dựa trên hiệu quả kháng khuẩn, độ tin cậy, chi phí, độ an toàn và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. Liều dùng của các kháng sinh trong chương này là liều thường dùng cho người lớn có chức năng gan và thận bình thường. Với bất kỳ loại điều trị nào (Vd: điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn, điều trị đường TM thay thế, điều trị đường uống), ***các thuốc được khuyến cáo có hiệu quả tương đương như nhau và không xếp hạng theo thứ tự ưu tiên.*** Điều chỉnh liều, tác dụng phụ, các tương tác thuốc và các thông tin kê đơn quan trọng khác được mô tả trong phần ***Tóm tắt thông tin đối với từng loại thuốc*** trong ***Chương XI***. Khi sử dụng bất kỳ thuốc nào cần đọc kĩ tờ thông tin hướng dẫn dùng thuốc cài trong hộp thuốc, về các chỉ định và liều dùng được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and Drug Administration) phê chuẩn. Cột cuối cùng trong thanh tiêu đề các phương pháp điều trị, "***Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống***" ("*IV-to-PO switch*") chỉ dẫn hội chứng lâm sàng này nên được điều trị bằng đường TM đơn độc hoặc điều trị bằng đường TM sau đó chuyển sang đường uống nhưng không được điều trị bằng đường uống đơn độc. Cột "***Điều trị theo đường uống hoặc Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống***" ("*PO Therapy or IV-to-PO switch*" chỉ dẫn hội chứng lâm sàng này có thể được điều trị bằng đường uống đơn độc, đường TM đơn độc, hay điều trị bằng đường TM sau đó chuyển sang điều trị bằng đường uống (trừ khi có các chỉ định khác được ghi chú trong phần chú thích ở dưới mỗi bảng điều trị). Hầu hết bệnh nhân đang được điều trị theo đường TM nên được chuyển sang điều trị theo đường uống tương đương khi tình trạng lâm sàng có cải thiện.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Viêm màng não cấp tính do vi khuẩn (Xem Atlas màu tiêu bản nhuộm Gram dịch não tủy)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Đối tượng là người khỏe mạnh bình thường	Não mô cầu *(N.meningitidis)* *H. influenzae* Phế cầu (*S. pneumoniae)*	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 3g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 3g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần	Chloramphenicol 500 mg (đường uống) mỗi 6h/lần x 2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Người già hoặc bệnh nhân bị bệnh lý ác tính	*Listeria monocytogenes* cộng với các tác nhân gây bệnh màng não thường gặp ở đối tượng là người bình thường	*Trước khi có kết qủa nuôi cấy*: Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12h/lần x 3 tuần ***kết hợp với*** Ampicillin 2g (TM) mỗi 4h/lần x 3 tuần *Sau khi có kết quả nuôi cấy có Listeria* Ampicillin 2g (TM) mỗi 4h/lần x 3 tuần *Không thấy Listeria* Điều trị như đối với đối tượng là người bình thường	*Sau khi có kết quả nuôi cấy mọc Listeria* TMP-SMX 5 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (TM) mỗi 6h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 tuần *Không thấy Listeria* Điều trị như đối với đối tượng là người bình thường	*Chỉ đối với viêm màng não do Listeria* TMP-SMX 5mg/kg (uống) mỗi 6h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 tuần *Đối với các tác nhân gây bệnh màng não thường gặp*: Chloramphenicol 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 3 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm khuẩn shunt thần kinh trung ương (shunt dẫn lưu não thất-nhĩ [AV shunts]) (điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được MRSA, MSSE hoặc MRSE, điều trị một cách phù hợp)	Tụ cầu vàng *(S.aureus)* *S.epidermidis* (*staphylococci* không có men coagulase[CoNS])	MSSA/MSSE Cefotaxim 3g (TM) mỗi 6h/lần * ***hoặc*** Ceftizoxim 3g (TM) mỗi 6h/lần * MRSA/MRSE Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần*	MSSA/MSSE Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần * ***hoặc*** Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần * MRSA/MRSE Vancomycin 2g (TM) mỗi 12h/lần* ***cộng với*** 20mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 24h/lần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu não thất	MSSE/MRSE Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần* MSSA/MRSA Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm khuẩn shunt thần kinh trung ương (dẫn lưu não thất- ổ bụng [VP shunts])	*E. Coli* *K. pneumoniae* *Enterobacter* *S. marcescens*	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12 giờ x 2 tuần sau khi rút bỏ shunt dẫn lưu	TMP-SMX 5 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu	TMP-SMX 5 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần x 2 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu não thất
	Trực khuẩn mủ xanh *(P. aeruginosa)* đa kháng thuốc	Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần ± Colistin 1,7 mg/kg (TM) mỗi 8h ***cộng với*** Colistin 10 mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 24h/lần x 2 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu não thất	Meropenem 2g (TM) mỗi 8 giờ ± Amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Amikacin 10 mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 24h/lần x 2 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu não thất	
	Acinetobacter baumanii đa kháng thuốc	Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Ampicillin/sulbactam 4,5 g (TM) mỗi 6h/lần ± Colistin 1,7 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ***cộng với*** Colistin 10 mg (tiêm nội tủy sống) mỗi 12h/lần x 2 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu não thất	Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần ***cộng với*** Ampicillin/sulbactam 4,5 g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu não thất	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (Methicillin-sensitive/Resistant S. aureus): Tụ cầu vàng nhạy/kháng với methicillin; MSSE/MRSE (methicillin-sensitive/resistant S.epidermidis): S.epidermidis nhạy/kháng với methicillin. MDR (multidrug-resistant): đa kháng thuốc. CoNS(Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu với coagulase âm tính.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc theo đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72h).

** Điều trị trong vòng 1 tuần sau khi rút bỏ ống dẫn lưu.*

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát đột ngột tình trạng sốt, đau đầu, cổ cứng.

Chẩn đoán: Nhuộm và nuôi cấy Gram dịch não tủy.

Viêm màng não cấp do vi khuẩn (ở đối tượng khỏe mạnh bình thường)

Xem xét chẩn đoán: Nhuộm Gram cặn dịch não tủy đã được phân ly vẫn là xét nghiệm chẩn đoán tốt nhất. Kỹ thuật miễn dịch điện di đối lưu (CIE)/tìm kháng nguyên vi khuẩn trong dịch não tủy không giúp ích gì trong xác nhận chẩn đoán (có thể cho kết quả âm tính giả). Cấy máu cho kết quả dương tính đối với các tác nhân gây bệnh viêm màng não cấp tính do vi khuẩn (viêm màng não mủ) ở 80-90% các trường hợp. Các thay đổi dịch não tủy điển hình trong viêm màng não do vi khuẩn bao gồm một số lượng bạch cầu 100-5.000 tế bào/mm^3, áp lực dịch não tủy mở tăng cao, tăng nồng độ protein và acid lactic (>4-6 mmol/L) và nhuộm Gram dịch não tủy dương tính. Nếu số lượng bạch cầu trong dịch não tủy cực kỳ cao (>20.000 tế bào/mm^3), cần đặt nghi vấn có tình trạng ápxe não bị vỡ vào hệ thống não thất và cần tiến hành chụp CT/MRI để khẳng định chẩn đoán. Viêm màng não do phế cầu (*S. pneumoniae*) thường đi kèm với những bất thường thần kinh sọ, thay đổi tình trạng ý thức và các di chứng thần kinh. Với viêm màng não do *H. influenzae* hoặc phế cầu (*S. pneumoniae*), cần tiến hành chụp CT/MRI não để loại trừ các bệnh lý khác của hệ thần kinh trung ương.

Lưu ý: Nếu nghĩ tới viêm màng não cấp do vi khuẩn (viêm màng não mủ), cần tiến hành chọc dịch não tủy trước khi chỉ định cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính não, do điều trị kháng sinh sớm cho bệnh nhân có tính chất quyết định đối với tiên lượng. Chỉ nên thực hiện chụp CT/ MRI trước khi chọc dịch não tủy khi nghi ngờ tổn thương choán chỗ/quá trình viêm mủ nội sọ, sau khi đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm máu để nuôi cấy. Dấu hiệu cứng gáy phát hiện được khi khám thực thể có giá trị chẩn đoán hạn chế ở bệnh nhân cao tuổi, do tình trạng cứng gáy có thể xảy ra ngay cả khi không có viêm màng não (Vd: viêm khớp cột sống cổ) và viêm màng não có thể xảy ra ngay cả khi không có dấu hiệu cứng gáy. Sốt tái phát trong tuần lễ đầu của viêm màng não do *H. influenzae* thường xảy ra do tràn dịch dưới màng cứng và tình trạng này thường thuyên giảm một cách tự phát sau vài ngày. Viêm màng não do não mô cầu có thể xảy ra kèm với hoặc không kèm với nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu (meningococcemia). Trên tiêu bản nhuộm Gram, phế cầu (*S.pneumoniae*) có thể bị nhầm với *H. influenzae* và Listeria có thể bị nhầm với phế cầu (*S. pneumoniae*). Viêm màng não do não mô cầu có thể xảy ra ở các đối tượng đã được tiêm vaccin phòng não mô cầu nhất là nhóm huyết thanh B (là chủng vi khuẩn không có trong vaccin phòng não mô cầu).

Xem xét điều trị: Không được giảm liều kháng sinh tác dụng trên màng não (liều màng não) khi tình trạng bệnh nhân cải thiện. Chọc lại dịch não tủy nếu bệnh nhân không đáp ứng với kháng sinh sau 48 giờ điều trị; không thấy đáp

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ứng với điều trị có thể do điều trị kháng sinh thất bại, bệnh tái phát hoặc đó là một bệnh lý của hệ thần kinh trung ương không phải nhiễm khuẩn. Đối với viêm màng não do phế cầu (*S. pneumoniae*), cần thu thập nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Penicillin đối với tất cả các chủng vi khuẩn phân lập được từ dịch não tủy. Các chủng phế cầu kháng penicillin nhạy cảm với liều tác dụng trên màng não của kháng sinh nhóm beta-lactam (Vd: ceftriaxon). Hầu hết các chủng phế cầu kháng penicillin ở mức độ cao (highly penicillin-resistant pneumococcal strains) vẫn có thể được điều trị một cách hữu hiệu bằng liều có tác dụng trên màng não của beta-lactam. Các chủng phế cầu kháng penicillin ở mức độ cao (hiếm gặp trong dịch não tủy) có thể được điều trị trong vòng 2 tuần bằng meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần hoặc bằng linezolid 600mg (TM) mỗi 12 giờ/lần. Dexamethason 0,15 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần x 4 ngày có thể dùng cho trẻ em bị viêm màng não cấp do vi khuẩn để làm giảm tỷ lệ mắc/ mức độ nặng của các di chứng thần kinh, mặc dù giá trị của steroid ở người lớn bị viêm màng não cấp tính do vi khuẩn không rõ ràng. Khi sử dụng cho bệnh nhân, cho dexamethason 30 phút trước khi bắt đầu dùng liều kháng sinh.

Tiên lượng: Thường gây tử vong nếu bệnh nhân không được điều trị. Tỷ lệ tử vong ở nhưng ca bệnh người lớn được điều trị là 10-20%. Các khiếm khuyết thần kinh biểu hiện khi bệnh nhân tới khám cấp cứu thường liên quan với một tiên lượng xấu. Khiếm khuyết thần kinh vĩnh viễn thường xẩy ra hơn trong viêm màng não mủ do phế cầu (*S.pneumoniae)* so với viêm màng não mủ do *H. influenzae*, ngay cả khi bệnh nhân được điều trị tức thì. Trong viêm màng não do não mô cầu có nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu, tiên lượng có liên quan với số lượng đốm xuất huyết, có ít hoặc không có khiếm khuyết thần kinh ở các đối tượng sống sót.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng não cấp tính do vi khuẩn (ở người cao tuổi có bệnh lý ác tính)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/ nuôi cấy dịch não tủy. Các tác nhân gây bệnh gây viêm màng não mủ cấp bao gồm các tác nhân gây bệnh thường gặp ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường cộng với *Listeria monocytogenes* (một trực khuẩn Gram dương ái khí). Listeria là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất gây viêm màng não cấp do vi khuẩn ở bệnh nhân có bệnh lý ác tính và là một vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Với viêm màng não do *Listeria*, nuôi cấy dịch não tủy đạt tỷ lệ dương tính 100%, song nhuộm Gram dịch não tủy âm tính ở 50% các trường hợp. Ung thư biểu mô di căn màng não (meningeal carcinomatosis) được gợi ý bằng bất thường của nhiều dây thần kinh sọ não.

Lưu ý: Phân lập được "vi khuẩn dạng bạch hầu" ("diphtheroids") từ dịch não tủy cần được định danh để loại trừ *Listeria*. *Listeria* di động và gây tan máu trên môi trường thạch máu, còn "vi khuẩn dạng bạch hầu" thì không di động và không gây tan máu.

Xem xét điều trị: Bệnh nhân lớn tuổi và bệnh nhân ung thư bị viêm màng não cấp do vi khuẩn cần được điều trị kháng sinh kinh nghiệm bao phủ đối với *Listeria* cộng với các tác nhân gây bệnh thường gặp khác ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường (Vd: não mô cầu [*N. meningitidis*], *H. influenzae*, *phế cầu [S.pneumoniae]*). Các kháng sinh cephalosporin thế hệ ba không có hoạt tính đối với *Listeria*.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe nền của người bệnh.

Viêm màng não cấp do vi khuẩn (Nhiễm khuẩn ở đối tượng được đặt shunt hệ thần kinh trung ương)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/nuôi cấy dịch não tủy. Viêm màng não do *S.epidermidis* thường chỉ xảy ra với vật liệu cấy ghép bộ phận giả bị nhiễm trùng (Vd: đặt shunt ở hệ thần kinh trung ương)

Lưu ý: Cấy máu thường âm tính đối với vi khuẩn gây bệnh ở bệnh nhân đặt shunt não thất-ổ bụng. Nuôi cấy dịch não tủy mọc *P.acnes* thường thể hiện tình trạng tạp nhiễm từ da. *P. acnes* hiếm khi là tác nhân gây bệnh trong nhiễm trùng shunt não thất- ổ bụng.

Xem xét điều trị: Khoảng 15% các chủng *S.epidermidis* kháng với nafcillin/clindamycin. Ngoài kháng sinh đường toàn thân với liều có tác dụng trên màng não, các kháng sinh dùng bổ sung thêm tiêm vào trong não thất/nội tủy sống đôi khi được áp dụng để khống chế tình trạng nhiễm khuẩn shunt trước khi rút bỏ shunt dẫn lưu não thất. Nếu vancomycin được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn thần kinh trung ương do tụ cầu vàng (tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin [MSSA/MRSA]), ngoài điều trị đường tĩnh mạch, nên dùng thêm liều nội tủy sống nếu cần thiết.

Tiên lượng: Tốt nếu các vật liệu cấy ghép được rút bỏ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng não cấp tính không do vi khuẩn/Viêm màng não mạn tính

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Virus (Viêm màng não vô khuẩn)	EBV, viêm mạch mạc màng não tăng bạch cầu lympho (LCM), *Parvo B19*, quai bị, *Enterovirus*, virus gây viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE). Không có điều trị hữu hiệu nào đối với hầu hết các virus này Đối với người nhiễm HIV (***xem Chương V***)			
	HSV-1 HSV-2 VZV	Điều trị đường TM: Acyclovir 10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x10 ngày Điều trị đường TM chuyển sang đường uống hoặc điều trị theo đường uống: Acyclovir 800 mg (uống) 5 lần/ngày x 10 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 2g (uống) mỗi 6h/lần x 10 ngày		
	HHV-6	Gancyclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Foscarnet 90 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần.		
Viêm não – màng não tiên phát do amip	*Naegleria fowleri*	Amphotericin B deoxycholat 1mg/kg (TM) mỗi 24h/ lần tới khi chữa khỏi bệnh ***kết hợp với*** Amphotericin B deoxycholat 1mg tiêm vào não thất qua bóng dẫn lưu não thất trực tiếp (Ommaya reservoirs) mỗi 24h/lần tới khi chưa khỏi bệnh		
Bệnh Lyme do xoắn khuẩn Borrelia	*Borrelia burgdorferi*	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 12h/ lần x 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần (TM) 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần x 11 ngày	Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/ lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x11 ngày (không cần dùng liều nạp đường uống nếu cùng thuốc được cho theo đường tĩnh mạch).	
Viêm não – màng não do amip thể u hạt	*Acanthamoeba*	Không có điều trị nào được chứng minh có hiệu quả (Amphoterricin B, fluconazol, ketoconazol, itraconazol, flucytosin, rifampin, isoniazid, aminoglycosid, sulfonamid, pentamidin đa phần chỉ mang lại đôi chút thành công. Một số trường hợp thành công đã được báo cáo ở người nhận tạng ghép được điều trị bằng pentamidin TM và được điều trị tiếp theo bằng itraconazol và ở bệnh nhân bị bệnh AIDS được điều trị bằng ketoconazol phối hợp với flucytosin		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh lao	*M. tuberculosis*	Điều trị đường TM /đường uống Isoniazid (INH) 300mg (TM/uống) mỗi 24h/lần x 6 tháng ***kết hợp với*** Rifampin 600mg (TM/uống) mỗi 24h/lần x 6 tháng ***kết hợp với*** Pyrazinamid 25 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tháng ***kết hợp với*** Ethambutol (EMB) 15 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần (trừ khi biết rõ độ nhạy cảm của vi khuẩn với các thuốc điều trị)		
		Bắt đầu bằng 4 thuốc như đối với lao phổi, song kéo dài thời gian điều trị từ 9 đến 12 tháng. Giảm liều corticosteroid trong vòng 1-2 tháng. Nếu chứng minh được hoặc nghi ngờ có tình trạng kháng thuốc, cần hội chẩn bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm.		
Nấm Đối tượng không nhiễm HIV	*Cryptococcus neoformans*	Amphetericin B deoxycholat 0,7-1mg (TM) mỗi 24h/lần x 2-6 tuần* ***kết hợp với*** Flucytosin 25mg/kg (uống) mỗi 6h/lần x 6 tuần* ***Tiếp sau đó bằng*** Fluconazol 800mg (TM hoặc uống) x 1 liều, sau đó 400mg (uống) mỗi 24h x 10 tuần*	Amphotericin B Liposomal (AmBisome) 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 6-10 tuần** ***Hoặc*** Fluconazol 800mg (TM hoặc uống) x 1 liều, sau đó 400mg (uống) mỗi 24h x 10 tuần *	Điều trị đường uống đơn độc Fluconazol có thể được dùng theo đường uống*
Đối tượng nhiễm HIV	*Cryptococcus neoformans* (***xem trang 541***). *Blastomyces dematitidis* (***xem trang 470***).			
Viêm màng não mạn tính	*Trực khuẩn lao (M. tuberculosis), bệnh Brucella, bệnh do xoắn khuẩn gây vàng da chảy máu (Leptospirosis), bệnh do xoắn khuẩn giang mai (T.pallidum), bệnh nấm cryptococcus, bệnh nấm coccidiodes (Coccidioidomycosis), Bệnh nấm Histoplasma (Histoplasmosis), bệnh do toxoplasma (Toxoplasmosis), bệnh nhiễm giun đũa chó-mèo (Toxocariasis), CMV, bệnh nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở não (Neurocysticercosis), bệnh Lyme thần kinh do xoắn khuẩn Borrelia (Neuroborreliosis), Enterovirus.*			Điều trị vi khuẩn gây bệnh sau khi chẩn đoán xác định. Không điều trị theo kinh nghiệm

Từ viết tắt : EBV: Epstein-Barr virus ; CMV: Cytomegalovirus; HSV-1 (Herpes simplex virus 1): Virus Herpes simplex typ 1; HSV-2 (Herpes simplex virus 2): Virus Herpes simplex typ 2 ; VZV (Varicella zoster virus): Virus thủy đậu-zona; HHV-6 (Human Herpes virus-6): Virus Herpes người typ 6.

Thời gian điều trị biểu diễn tổng thời gian dùng thuốc theo đường uống (đối với điều trị lao), đường TM hoặc đường TM + đường uống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

** Phác đồ dùng 6 tuần amphotericin B deoxycholat kết hợp với flucytosin là phác đồ điều trị kinh điển để đạt được khả năng chữa khỏi lâu dài. Những số liệu không chính thống gợi ý một liệu trình điều trị ngắn hơn được tiếp theo bằng Fluconazol x 10 tuần (hoặc dài hơn) có thể thành công. Hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm được khuyến cáo.*

*** Các chế phẩm Amphotericin B kết hợp với lipid khác với liều 3-5 mg/kg (TM) cũng có thể được dùng cho bệnh nhân* (***trang 514***).

Viêm màng não do virus (viêm màng não vô khuẩn)

Biểu hiện lâm sàng: Đau đầu, sốt nhẹ, dấu hiệu kích thích màng não nhẹ, sợ ánh sáng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng test huyết thanh đặc hiệu/nuôi cấy virus. Nhiễm khuẩn sinh dục do virus Herpes simplex typ 2 (HSV-2) thường đi kèm với các triệu chứng thần kinh trung ương nhẹ và thường không cần phải điều trị bằng thuốc kháng virus đối với các triệu chứng này. Nhiễm virus Hepes simplex typ 1 (HSV-1) gây một loạt các nhiễm trùng thần kinh trung ương, bao gồm viêm màng não, viêm não-màng não và viêm não (***xem trang 47***). Về phương diện lâm sàng, không thể phân biệt được viêm màng não do virus Herpes simplex (HSV), virus Herpes người typ 6 (HHV-6) và virus gây viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE) với các nguyên nhân gây viêm màng não do virus khác. Viêm màng não do virus Epstein-Barr (EBV) thường được kết hợp với các đặc điểm lâm sàng/cận lâm sàng của bệnh tăng bạch cầu đơn nhân do nhiễm EBV. Cần đặt nghi vấn chẩn đoán này ở bệnh nhân có test monospot (+) và bị viêm não-màng não không rõ nguyên nhân. Viêm màng não do virus thủy đậu-zona (VZV) điển hình được kết hợp với các tổn thương bọng nước ở da (bệnh zona do *H. zoster*) và thường không cần phải điều trị thêm ngoài điều trị như bệnh Zona. Viêm mạch mạc màng não tăng bạch cầu lympho (LCM) được khởi đầu như một tình trạng "giả cúm" thường xảy ra vào mùa thu sau khi tiếp xúc với chuột đồng và bệnh nhân có thể có nồng độ glucose dịch não tủy thấp. Viêm màng não do Enterovirus thường được kết hợp với ban dát sần, viêm thanh quản không xuất tiết, ỉa chảy, song nồng độ glucose trong dịch não tủy thấp hiếm gặp. Viêm màng não vô khuẩn do quai bị có thể được biểu hiện không đi kèm với sưng tuyến mang tai ± giảm thính lực cấp. Viêm màng não vô khuẩn do thuốc gây ra có thể đi kèm với tăng bạch cầu ái toan trong dịch não tủy song bệnh nhân không sốt/sốt nhẹ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Xem xét về khả năng thuốc chống viêm không steroid, TMP-SMX và globulin miễn dịch dùng đường tĩnh mạch là nguyên nhân gây viêm màng não vô khuẩn do thuốc.

Xem xét điều trị: Điều trị tác nhân gây bệnh đặc hiệu.

Tiên lượng: Khi không có tình trạng tổn thương thần kinh khu trú, bệnh nhân thường sẽ phục hồi hoàn toàn

Viêm não - màng não tiên phát do amip (Primary Amebic Meningoencephalitis [PAM]) (*Naegleria fowleri)*

Biểu hiện lâm sàng: Thường mắc phải khi phơi nhiễm với nước ngọt chứa ký sinh trùng, thường do hoạt động nhảy xuống bơi hay tắm ở hồ ao/bể bơi. Đối tượng thường mắc bệnh là trẻ em và người lớn trẻ tuổi khỏe mạnh. Vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể qua lá sàng của xương sàng và đi vào dịch não tủy. Các triệu chứng xảy ra trong vòng 7 ngày sau phơi nhiễm và có thể hoàn toàn giống như viêm màng não bùng phát do vi khuẩn, bao gồm đau đầu, sốt, chán ăn, nôn, các dấu hiệu của viêm màng não, biến đổi tình trạng tinh thần, hôn mê. Bệnh nhân có thể than phiền về một mùi bất thường/cảm giác vị giác khác thường vào giai đoạn sớm của nhiễm trùng. Dịch não tủy có hồng cầu và có nồng độ glucose rất thấp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trong dịch não tủy. Tình trạng phân bố bệnh trên toàn thế giới. Amip sống tự do trong nước ngọt hồ ao và phát triển mạnh ở các vùng khí hậu ấm áp. Chẩn đoán chính vẫn là dựa trên nghi vấn lâm sàng qua khai thác tiền sử có phơi nhiễm với nước ao hồ (chưa được xử lý) trong vòng 1-2 tuần trước đó.

Lưu ý: Các dấu hiệu dịch não tủy giống với viêm màng não do vi khuẩn, song thấy có hồng cầu trong dịch não tủy.

Xem xét điều trị: Thường gây tử vong trừ khi được điều trị sớm.

Tiên lượng: Thường gây tử vong.

Viêm não dạng u hạt do amip (*Acanthamoeba sp.*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát âm ỉ với các khiếm khuyết thần kinh khu trú ± thay đổi tình trạng tinh thần, co giật, sốt, đau đầu, liệt nửa người, dấu hiệu kích thích màng não, mất điều hòa động tác (ataxia), rối loạn thị lực. Có thể kết hợp với viêm loét giác mạc do Acanthamoeba, loét da hoặc bệnh lan tỏa. Thường chỉ được gặp ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch/ốm nằm liệt giường.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trong bệnh phẩm sinh thiết não. Chụp CT/MRI cho thấy tổn thương khối choán chỗ. Các "nang hình sao" ("Stellate cysts") đặc trưng cho Acanthamoeba. Bệnh được phân bố trên toàn thế giới. Có liên quan chặt chẽ với việc sử dụng liên tục kính áp tròng. Chẩn đoán phân biệt với *N. fowleri* bằng nuôi cấy.

Lưu ý: Khác với viêm não-màng não tiên phát do amip (do *Naegleria fowleri*), viêm não dạng u hạt do amip không liên quan với tình trạng phơi nhiễm với nước ngọt (chưa được xử lý). Bệnh cảnh lâm sàng giống với viêm màng não bán cấp/mạn tính. Không tìm thấy thể tư dưỡng của ký sinh trùng (trophozoites) trong dịch não tủy. Các tổn thương da có thể được biểu hiện nhiều tháng trước khi khởi phát triệu chứng thần kinh trung ương.

Xem xét điều trị: Không điều trị nào chứng minh có hiệu quả. Bệnh nhân thường bị tử vong mặc dù được điều trị sớm.

Tiên lượng: Thường tử vong.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Lyme thần kinh do xoắn khuẩn Borrelia (Neuroborreliosis)

Biểu hiện lâm sàng: Có thể có cứng gáy nhẹ, sốt nhẹ dưới 39°C (thường từ 38-38,5°C). Có tiền sử phơi nhiễm gần đây với ve/mò. Thường không thấy có nổi ban. Tình trạng đau họng gặp ở một số bệnh nhân. Số lượng bạch cầu trong giới hạn bình thường, AST/ALT tăng nhẹ trong một số trường hợp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tình trạng sinh kháng thể kháng xoắn khuẩn *B. burgdorferi* trong hệ thần kinh trung ương. Một tỉ số hiệu giá kháng thể IgM đối với xoắn khuẩn gây bệnh trong dịch não tủy so với trong huyết thanh >1 giúp chẩn đoán xác định.

Lưu ý: Nếu các triệu chứng thần kinh trung ương được biểu hiện ở giai đoạn cấp của bệnh Lyme, có thể không thấy có ban trên da và test huyết thanh chẩn đoán có thể âm tính ở giai đoạn sớm của bệnh. Không thể chẩn đoán được một cách đáng tin cậy bệnh Lyme thần kinh khi sử dụng tỉ số hiệu giá kháng thể IgM đối với xoắn khuẩn gây bệnh trong dịch não tủy so với trong huyết thanh nếu

bệnh nhân đã được dùng kháng sinh trước khi tiến hành chọc dịch não tủy (do kháng sinh làm thay đổi tỉ số này và khiến thông số này trở nên vô dụng).

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe nền của người bệnh. Bệnh Lyme thần kinh có tiên lượng tốt ngay cả khi điều trị muộn.

Viêm màng não do lao (*Mycobacterium tuberculosis*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát bán cấp với các triệu chứng không đặc hiệu. Sốt thường gặp ± đau đầu, buồn nôn, nôn. Biểu hiện cấp tính và liệt các dây thần kinh sọ thường ít gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng phết lam kính/nuôi cấy tìm trực khuẩn kháng cồn-toan (AFB) dịch não tủy. Xét nghiệm PCR dịch não tủy tìm trực khuẩn kháng cồn-toan tuy đặc hiệu song không quá nhạy. Dịch não tủy có thể bình thường song thường cho thấy có tăng ưu thế bạch cầu lympho nhẹ, giảm nồng độ glucose, tăng protein và có một vài hồng cầu. Nồng độ Adenosine deaminase (ADA) tăng song nồng độ này cũng tăng trong viêm màng não cấp do vi khuẩn, nhiễm khuẩn do listeria, bệnh do Brucella thể thần kinh.

Lưu ý: Dịch não tủy có thể có tình trạng tăng ưu thế bạch cầu đa nhân trung tính ở giai đoạn sớm, trước khi xuất hiện tình trạng tăng ưu thế bạch cầu lympho điển hình. Tăng bạch cầu ưa acid trong dịch não tủy không phải là một điểm đặc trưng của lao màng não và cần đặt nghi vấn chẩn đoán khác. Chụp Xquang ngực, test da với tuberculin (PPD) và phết lam kính/nuôi cấy dịch não tủy tìm trực khuẩn lao có thể âm tính.

Xem xét điều trị: Dexamethason 4 mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần x 4-8 tuần hữu ích để làm giảm tình trạng viêm nhiễm thần kinh trung ương nếu được cho dùng sớm. Dịch tiết chứa nhiều protein của lao màng não có thể gây tắc nghẽn não thất và gây tràn dịch não tủy và biến chứng này được chẩn đoán bằng chụp CT/ MRI và có thể cần phải đặt shunt dẫn lưu não thất.

Tiên lượng: Các yếu tố tiên lượng xấu bao gồm chậm trễ điều trị, có khiếm khuyết thần kinh hoặc tràn dịch não tủy gây giãn não thất.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng não do nấm crytococcus (*Cryptococcus neoformans*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát âm ỉ với các triệu chứng không đặc hiệu. Đau đầu là triệu chứng thường gặp nhất. Các trường hợp mạn tính có thể có các triệu chứng thần kinh trung ương trong nhiều tuần tới nhiều tháng xen với các giai đoạn không triệu chứng. Các biểu hiện cấp tính thường gặp hơn ở bệnh nhân bị AIDS, điều trị steroid dài ngày, bị bệnh lý ác tính của mô lưới-hạch bạch huyết (lymphoreticular malignancies). 50-80% bệnh nhân có chức năng miễn dịch bất thường.

Xem xét chẩn đoán: *C. neoformans* là nguyên nhân thường gặp nhất của viêm màng não do nấm và chỉ các nấm men được bọc trong nang (encapsulated yeasts) trong dịch não tủy mới gây ra được viêm màng não. Chẩn đoán bằng nhuộm mực tàu tiêu bản dịch não tủy phát hiện được các nấm men được bọc trong nang/ phản ứng huyết thanh với kháng nguyên của Cryptococcus được gắn latex (ngưng kết latex)/nuôi cấy phát hiện được nấm. Cần loại trừ tình trạng nhiễm HIV và các bệnh lý nền gây ức chế miễn dịch khác.

Lưu ý: Kết quả dương tính giả với kháng nguyên Cryptococcus có thể xảy ra khi sử dụng ống vận chuyển bệnh phẩm "BBL Port-A-Cul transort vials". Hiệu giá kháng nguyên gắn latex trong dịch não tủy khi test bằng kỹ thuật ngưng kết latex có thể không trở lại mức giá trị zero. Tiếp tục điều trị tới khi hiệu giá kháng thể giảm xuống/không thể giảm được xuống thấp hơn và tới khi nuôi cấy dịch não tủy âm tính đối với nấm Cryptococcus. Nhuộm mực tàu tiêu bản đã được xử lý cho thấy có các nấm men được bọc trong nang trong dịch não tủy hữu ích đối với nhiễm trùng khởi phát, song không nên dựa vào tiêu chuẩn này để chẩn đoán các đợt bệnh tái phát, do các phết nhuộm lam kính có thể dương tính mặc dù nuôi cấy dịch não tủy âm tính (các nấm Cryptococcus đã chết có thể vẫn nằm lại trong dịch não tủy qua nhiều năm). Chẩn đoán đợt bệnh tái phát dựa trên kết quả nuôi cấy dịch não tủy.

Xem xét điều trị: Điều trị tới khi dịch não tủy trở nên vô khuẩn hoặc hiệu giá với kháng nguyên gắn latex trong dịch não tủy trở về giá trị zero hoặc liên tục gần bằng không qua các lần chọc dịch não tủy liên tiếp. Sau khi bệnh nhân hết sốt với điều trị bằng amphotericin B/5FC, chuyển sang điều trị bằng fluconazol theo đường uống × 10 tuần. Dạng bào chế kết hợp với lipid của Amphotericin B có thể hữu ích nếu bệnh nhân không thể dung nạp được với amphotericin B deoxycholat. Bệnh nhân nhiễm HIV cần phải được điều trị ức chế nấm kéo dài suốt cuộc đời còn lại của họ bằng fluconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần. Luôn cần tham khảo tư vấn từ các chuyên gia.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Tốt. Các yếu tố tiên lượng xấu bao gồm không có tăng tế bào dịch não tủy, có nhiều tế bào nấm trong dịch não tủy và có rối loạn ý thức khi nhập viện.

Viêm màng não mạn tính

Biểu hiện lâm sàng: Cũng giống như viêm màng não cấp tính, song các dấu hiệu thực thể/triệu chứng kém nổi trội và biểu hiện lâm sàng có tính chất bán cấp (> 1 tháng). Bệnh Lyme thể thần kinh mạn tính do xoắn khuẩn Borrelia cực kỳ hiếm gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán phân biệt quá rộng để quyết định điều trị theo kinh nghiệm. Biểu hiện lâm sàng bán cấp/mạn tính cho phép có thời gian để hoàn thiện các quy trình thăm dò tìm kiếm chẩn đoán. Nuôi cấy dịch não tủy và thực hiện các xét nghiệm trên dịch não tủy/huyết thanh để phát hiện được tác nhân gây bệnh đặc hiệu, sau đó điều trị cho bệnh nhân. Bệnh Lyme ở hệ thần kinh trung ương được chẩn đoán bằng cách chứng minh có tình trạng sinh kháng thể kháng xoắn khuẩn *B.burgdorferi* trong hệ thần kinh trung ương. Một tỉ số hiệu giá kháng thể IgM đối với xoắn khuẩn gây bệnh trong dịch não tủy so với trong huyết thanh >1 giúp chẩn đoán xác định tình trạng bệnh lý này.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy căn nguyên nhiễm khuẩn, xem xét khả năng do dùng thuốc chống viêm không steroid, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, ung thư biểu mô di căn màng não (meningeal carcinomatosis), bệnh sarcoidose .... Viêm màng não mạn tính do Cytomegalovirus hoặc do cầu khuẩn ruột cần yêu cầu tìm kiếm tức khắc tình trạng ức chế miễn dịch/có khiếm khuyết cơ chế để kháng nền của vật chủ. Không thể chẩn đoán được một cách đáng tin cậy bệnh Lyme thần kinh khi sử dụng tỉ số hiệu giá kháng thể IgM đối với xoắn khuẩn gây bệnh trong dịch não tủy so với trong huyết thanh nếu bệnh nhân đã được dùng kháng sinh trước khi tiến hành chọc dịch não tủy (do kháng sinh làm thay đổi tỉ số này và khiến chỉ số này trở nên kém hữu dụng).

Xem xét điều trị: Nếu nghi ngờ viêm màng não do lao ở mức độ cao, điều trị chống lao theo kinh nghiệm được khuyến cáo áp dụng. Đối với các trường hợp khác, chỉ điều trị sau khi đã chẩn đoán được chính xác nhiễm khuẩn đặc hiệu.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân. Tiên lượng đối với bệnh Lyme thần kinh do xoắn khuẩn Borrelia tốt ngay cả khi bệnh nhân được điều trị muộn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm não

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Herpes	HSV-1 HSV-2 VZV	*Điều trị đường tĩnh mạch:* Acyclovir 10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x 10 ngày ***hoặc*** ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 10 ngày *Chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống hoặc điều trị theo đường uống:* Acyclovir 800 mg (uống) 5 lần mỗi ngày x 10 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 2g (uống) mỗi 6h/lần x10 ngày
	HHV-6	Ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12h x 2 tuần ***hoặc*** Foscarnet 90 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần
Arbovirus	*Các tác nhân gây bệnh thường gặp:* Virus gây viêm não California (CE); Virus gây viêm não ngựa miền Tây (WEE); Virus gây viêm não ngựa Venezuela (VEE); Virus gây viêm não ngựa miền Đông (EEE); Virus gây viêm não St. Louis (St. LE), Virus gây viêm não Nhật Bản (), Virus gây viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE) *Chuyển điều trị từ đường tĩnh mạch sang đường uống:* Không được áp dụng	
Mycoplasma	*M.pneumoniae*	Doxycyclin 20 mg (TM) mỗi 12 giờ x 3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần* ***Hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần
Listeria	*Lmonocytogenes*	Điều trị như đối với viêm màng não do Listeria ***(trang 12)*** song cần điều trị 6-8 tuần
HIV	***Xem Chương V (trang 499)***	
Ghép tạng, HIV/AIDS	CMV HHV-6 *Toxoplasma gondii*	Ghép tạng ***(xem trang 285)*** HIV/AIDS ***(xem trang 499)***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: HSV1 (Herpes simplex virus 1): Virus Herpes simplex typ 1; HSV 2 (Herpes simplex virus 2): Virus Herpes simplex typ 2 ; VZV (Varicella zoster virus): Virus thủy đậu-zoster; HHV-6 (Human Herpes virus 6): Virus Herpes người typ 6; CMV: Cytomegalovirus; CE (California encephalitis virus): Virus gây viêm não California; WEE (Western equine encephalitis): Virus gây viêm não ngựa miền tây; VEE (Venezuelan equine encephalitis virus): Virus gây viêm não ngựa Venezuela; EEE (Eastern equine encephalitis): Virus gây viêm não ngựa miền Đông; St.LE (Sant Louis encephalitis): Virus gây viêm não St. Louis; JE (Japanese encephalitis): Viêm não Nhật Bản; WNE (West Nile encephalitis): Virus gây viêm não vùng bờ tây sông Nil;

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc theo đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang điều trị theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

Viêm não do Herpes (HSV-1)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt và thay đổi tình trạng tinh thần song không có biểu hiện cứng gáy.

Xem xét chẩn đoán: Ghi điện não đồ sớm (<72 giờ) là xét nghiệm sơ bộ tốt nhất, cho thấy có các sóng bất thường ở một bên thùy thái dương. Chụp cộng hưởng từ não cho hình ảnh bất thường trước khi thấy trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính do chỉ có thể phát hiện được các bất thường trên hình ảnh chụp CT não sau vài ngày so với thời điểm quan sát được sóng bất thường khu trú ở thùy thái thái dương. Chẩn đoán khẳng định bằng PCR dịch não tủy phát hiện được DNA của HSV-1. Viêm não do Herpes thường biểu hiện như một viêm não hoặc viêm não-màng não, biểu hiện như một viêm màng não đơn độc không thường gặp. Giảm sâu chức năng cảm giác là dấu hiệu đặc trưng đối với viêm não-màng não do HSV. Dịch não tủy có thể có tình trạng tăng ưu thế bạch cầu đa nhân trung tính và nồng độ glucose thấp, không giống với các nguyên nhân gây viêm màng não do virus khác.

Lưu ý: Ở bệnh nhân là đối tương có chức năng miễn dịch bình thường, viêm não do HHV-6 có thể giống với viêm não do HSV-1 với ổ sóng điện não bất thường ở thùy trán/thái dương trên đường ghi điện não đồ.

Xem xét điều trị: HSV là một trong số các nguyên nhân gây viêm màng não do virus có thể điều trị được ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường. Điều trị càng sớm càng tốt, do các khiếm khuyết thần kinh có thể nhẹ và phục

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hồi nếu tiến hành điều trị sớm, song các biến chứng này sẽ nặng và không phục hồi nếu bệnh nhân được điều trị muộn.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rộng của tổn thương não và điều trị sớm hay muộn cho bệnh nhân bằng thuốc kháng HSV.

Viêm não do Arbovirus (*Arboviral encephalitis*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính bằng sốt, đau đầu, thay đổi tình trạng tinh thần từ nhiều ngày tới nhiều tuần sau khi virus xâm nhập qua vết cắn/đốt của côn trùng nhiễm virus (Vd: muỗi/ve). Viêm não do nhiễm virus gây viêm não vùng bờ tây sông Nil (WNE) được gợi bằng khi có biểu hiện viêm não kèm theo hoặc không kèm theo tăng cao nồng độ ferritin, kèm theo hoặc không kèm theo tình trạng run cơ hoặc liệt mềm mới xuất hiện. Điện não đồ cho thấy có các sóng chậm lan tỏa, kèm theo hoặc không tăng hoạt tính hạch nền/ vùng đồi thị. Tiên lượng- mức độ nặng của khiếm khuyết thần kinh và mức độ/thời gian bị giảm bạch cầu lympho tương đối/ nồng độ ferritin.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh học đặc hiệu đối với arbovirus.

Lưu ý: Bệnh thường xảy ra vào mùa xuân/thu. Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp điển hình có thể xảy ra.

Xem xét điều trị: Hiện tại chỉ có các biện pháp điều trị hỗ trợ có thể được áp dụng cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Các khiếm khuyết thần kinh vĩnh viễn thường gặp, song không thể dự đoán trước được. Bệnh có thể gây tử vong cho bệnh nhân.

Viêm não do Mycoplasma

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt và thay đổi tình trạng tinh thần song không có biểu hiện cứng gáy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được gợi ý bằng tình trạng viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với đau họng, viêm tai giữa, hồng ban nút đa dạng (*E.multiforme*), phân nát/lỏa chảy đi kèm với tăng hiệu giá kháng thể IgM đối với mycoplasma và hiệu giá ngưng kết lạnh (cold agglutinin) rất cao (≥1:1024). Dịch não tủy cho thấy có tăng nhẹ bạch cầu đơn nhân/bạch cầu lympho với nồng độ glucose

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bình thường/thấp.

Lưu ý: Dấu hiệu thần kinh trung ương có thể làm lu mờ các dấu hiệu phổi.

Xem xét điều trị: Macrolid không có hiệu quả điều trị đối với nhiễm khuẩn thần kinh trung ương. Doxycyclin làm giảm nhanh việc lan truyền mycoplasma trong dịch tiết hầu-họng (trái lại macrolid gây lan truyền mycoplasma trong dịch tiết hầu-họng kéo dài).

Tiên lượng: Nếu được điều trị sớm, tiên lượng tốt và không để lại các di chứng thần kinh.

Viêm não do Listeria

Biểu hiện lâm sàng: Sốt/tinh thần lú lẫn (viêm não) ± cứng gáy (viêm não-màng não).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chọc dịch não tủy. Cần nghĩ tới viêm não do Listeria nếu dịch não tủy có các "đặc điểm của viêm màng não mủ" cộng với có hồng cầu trong dịch não tủy. Listeria được thấy khi nhuộm Gram dịch não tủy ở 50% các trường hợp, song nuôi cấy dương tính đạt tỷ lệ 100%.

Lưu ý: Tránh nhầm lẫn với các trực khuẩn Gram dương khác (tạp nhiễm từ da) được phân lập từ dịch não tủy (vi khuẩn thường trú trên da dạng bạch hầu [diphtheroid]). Listeria di động và gây tan máu trên môi trường thạch máu.

Xem xét điều trị: Cephalosporin thế hệ ba không có hoạt tính đối với Listeria. Ở bệnh nhân bị dung nạp với penicillin, cho bệnh nhân dùng ampicillin (mà không phải là penicillin) liều tác dụng trên màng não.

Tiên lượng: Tốt khi điều trị sớm/thích hợp. Tiên lượng có liên quan với mức độ rối loạn chức năng tế bào lympho T của bệnh nhân.

Viêm não do Cytomegalovirus (CMV) (*xem trang 539*)

Viêm não do Toxoplasma (*xem trang 544*)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe não/Viêm mủ dưới màng cứng/Huyết khối tĩnh mạch hang/ Viêm tắc tĩnh mạch mủ trong sọ

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Ápxe não (Tổn thương một khối đơn độc)				
Chấn thương hở	Tụ cầu vàng (MSSA) Enterobacteriaceae *P.aeruginosa*	Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần		Không áp dụng
Tiến hành thủ thuật ngoại thần kinh (Điều trị khởi đầu như đối với MSSA; nếu sau đó xác định là MRSA, MSSE hoặc MRSE, điều trị phù hợp)	*S. aureus* *S. epidermidis* (CoNS)	*(MSSA)* Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần x 2 tuần ***hoặc*** *(MRSA)/MSSE/MRSE* Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (TM) mỗi 12 h/lần x 2 tuần		*MSSA/MRSA/ MSSE/MRSE* Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần
Nguồn gốc từ tai/ xương chũm	Enterobacter Proteus	Điều trị giống như trong chấn thương hở (***Xem ở trên***)		
Nguồn gốc từ răng	Các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng Actinomyces	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***kết hợp với*** Metronidazol 500mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần		Ceftizoxim 3g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần
Nguồn gốc từ xoang/ viêm mủ dưới màng cứng	Các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng *H. influenzae*	Điều trị giống như trong nhiễm khuẩn nguồn gốc từ răng (***Xem ở trên***)		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguồn gốc từ tim (viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn; shunt tim từ phải sang trái)	Tụ cầu vàng (MSSA) Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influezae*	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	
	Tụ cầu vàng (MRSA)	Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Vancomycin 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12 giờ x 2 tuần	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12 giờ x 2 tuần
Nguồn gốc từ phổi	Các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng Actinomyces	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***kết hợp với*** Metronidazol 500mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Ceftizoxim 3g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (Methicillin-sensitive/resistant *S.aureus*): Tụ cầu vàng nhạy/kháng Methicillin; MSSE/MRSE (Methicillin-sensitive/reisistant *S. epidermidis*): *S.epidermidis* nhạy/kháng Methicillin. CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu không sinh coagulase hay coagulase (-).

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường TM + điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc theo đường uống, nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện lâm sàng thay đổi, với sốt, thay đổi tình trạng tinh thần, liệt một hoặc nhiều dây thần kinh sọ ± đau đầu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/nuôi cấy dịch não tủy. Nếu nghi vấn bệnh nhân bị ápxe não, cần tiến hành chụp CT/MRI não. Chọc dịch não tủy có thể gây tình trạng thoát vị não.

Lưu ý: Phân tích dịch não tủy cho kết quả âm tính với viêm màng não do vi khuẩn trừ khi ápxe vỡ vào hệ thống não thất.

Xem xét điều trị: Điều trị bằng kháng sinh với liều có tác dụng với màng não. Các ápxe não chỉ có một ổ duy nhất với kích thước lớn có thể được dẫn lưu bằng phẫu thuật; Xử trí tốt nhất đối với ápxe não gồm nhiều ổ ápxe nhỏ là điều trị nội khoa

Tiên lượng. Liên quan với nguồn gốc nhiễm khuẩn nền và tình trạng sức khỏe của người bị bệnh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe não (nguồn gốc do viêm tai giữa/xương chũm)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI đầu chứng minh có ổ nhiễm khuẩn ở xương chũm.

Lưu ý: Cần loại trừ tình trạng viêm mủ dưới màng cứng kết hợp.

Xem xét điều trị: Xem xét tư vấn bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi- Họng về khả năng chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô xương chũm hoại tử .

Tiên lượng: Tốt. Có thể cần cắt lọc xương chũm hoại tử để điều trị triệt để.

Ápxe não (nguồn gốc răng)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp Xquang Panorex/ chụp xạ hình gallium xương hàm để chứng minh có ổ nhiễm khuẩn ở xương hàm/ăn mòn vào các xoang.

Lưu ý: Áp xe vùng ngọn chân răng (apical root abscess) có thể không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt.

Xem xét điều trị: Một ổ ápxe lớn duy nhất có thể được mổ dẫn lưu. Nhiều ổ ápxe nhỏ tốt nhất là được điều trị nội khoa. Điều trị tới khi các tổn thương trên phim chụp CT/MRI thoái triển hoặc không thể thu nhỏ được hơn khi điều trị.

Tiên lượng: Tốt nếu loại bỏ được ổ nhiễm trùng tại răng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe não (Nguồn gốc xoang /viêm mủ dưới màng cứng)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng phim chụp xoang/chụp CT/ MRI xoang để khẳng định có tình trạng viêm xoang/ăn mòn xương (viêm xương-tủy xương của xương sọ/ápxe ngoài màng cứng). Thường từ viêm xoang cạnh mũi (paranasal sinusitis).

Lưu ý: Không được bỏ sót nhiễm khuẩn xoang nền, do tình trạng này có thể cần phẫu thuật dẫn lưu.

Xem xét điều trị: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi- Họng về khả năng chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô xoang bị hoại tử.

Tiên lượng: Tiên lượng tốt nếu xoang được dẫn lưu.

Ápxe não (Nguồn gốc tim; viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn)

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu thường dương tính nếu ápxe não do tác nhân gây bệnh trong viêm nội tâm mạc cấp là do vi khuẩn. Chụp CT/ MRI não cho thấy tổn thương dạng khối thành nhiều ổ.

Lưu ý: Không được bỏ sót các shunt tim phải sang trái (Vd: còn lỗ bầu dục, dị tật vách nhĩ) như nguồn gây ápxe não. Thuyên tắc mạch não gây viêm màng não vô khuẩn trong viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn, song tình trạng này sẽ gây viêm màng não nhiễm khuẩn/ápxe não trong viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn (do các vi khuẩn gây bệnh có độc tính cao).

Xem xét điều trị: Tổn thương thành nhiều ổ gợi ý tình trạng gieo bệnh tới não theo đường máu. Sử dụng test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được khi cấy máu để quyết định sử dụng kháng sinh bao phủ đối với các vi khuẩn gây bệnh này. Liều có tác dụng trên màng não cũng giống như liều điều trị viêm nội tâm mạc

Tiên lượng: Liên quan với vị trí/kích thước của tổn thương thần kinh trung ương và mức độ tác động tới van tim.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe não (nguồn gốc phổi)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được gợi ý khi bệnh nhân có các bệnh lý phổi nền kèm theo như giãn phế quản, viêm mủ màng phổi, xơ hóa nang hoặc ápxe phổi ở một bệnh nhân bị ápxe não.

Lưu ý: Ápxe não rất thường gặp do bệnh phổi làm mủ mạn tính (chronic suppurative lung disease) (Vd: giãn phế quản, ápxe phổi/viêm mủ màng phổi), song không thường gặp trong viêm phế quản mạn/đợt tiến triển nặng của bệnh phế quản- phổi mạn (AECB). Nếu bệnh nhân không có một bệnh lý tim phổi dễ có khuynh hướng gây ápxe não, cần tìm kiếm một ápxe răng (vùng ngọn chân răng) không có biểu hiện lâm sàng bằng chụp xạ hình gallium xương hàm/chụp Xquang răng Panorex.

Xem xét điều trị: Có thể cần dẫn lưu bằng phẫu thuật đối với ápxe phổi.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ/vị trí của tổn thương thần kinh trung ương, dẫn lưu ổ ápxe/viêm mủ màng phổi và kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn phổi.

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN VÙNG ĐẦU VÀ TAI-MŨI- HỌNG

Viêm mô tế bào vùng mặt/quanh ổ mắt

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm mô tế bào ở mặt	Liên cầu nhóm A *H. influenzae*	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Quinolon hô hấp* (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Bất kỳ cephalosporin uống thế hệ 2 hoặc 3 x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon * (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường TM + điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống, nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

** Levofloxacin 500 mg hoặc Moxifloxacin 400 mg.*

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với phát ban da ở mặt, đau và nóng song không có kèm xuất tiết dịch, sưng, ngứa.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên biểu hiện lâm sàng. Có thể lan nhanh khắp khuôn mặt. Màu sắc ban đỏ tía gợi ý nhiễm khuẩn do *H.influenzae*.

Lưu ý: Nếu viêm mô tế bào vùng quanh hốc mắt, cần tiến hành chụp CT/MRI vùng đầu để loại trừ tình trạng viêm xoang nền/tác động thần kinh trung ương. Nếu thứ phát do trầy da sau khi tiếp xúc với một bề mặt bị nhiễm bẩn nước bọt, cần xem xét khả năng bị nhiễm trùng do *Herpes gladiatorum*; tổn thương gây đau/phù và không đáp ứng với kháng sinh thường được chỉ định để điều trị viêm mô tế bào.

Xem xét điều trị: Có thể cần điều trị trong vòng 3 tuần ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (người dùng steroid mạn tính, đái tháo đường, lupus ban đỏ hệ thống...).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm; xấu nếu có viêm xoang nền hoặc có xâm lấn thần kinh trung ương.

Viêm xoang do vi khuẩn

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM (Bệnh nhân nằm viện)	Điều trị đường uống *hoặc* Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cấp tính	*S.pneumoniae* *H.influenzae* *M. catarrhalis*	Quinolon tác dụng trên hô hấp† (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần x 11 ngày	Quinolon tác dụng trên hô hấp †(uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Amoxicillin/acid clavulanic XR 2 viên (uống) mỗi 12h/lần x 10 ngày ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 11 ngày* ***hoặc*** Cephalosporin‡ (uống) x 2 tuần ***hoặc*** Clarithromycin XL 1g (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần
Mạn tính	Giống như khi điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn kị khí cấp tính/đường miệng.	Đòi hỏi phải điều trị kháng sinh dài ngày (2-4 tuần)	

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc theo đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ). ***Xem Chương VII*** *để biết điều trị cho trẻ em.*

* *Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

† *Moxifloxacin 400mg x 7 ngày hoặc Levofloxacin 750mg x 5 ngày.*

‡ *Cefdinir 300mg mỗi 12h/lần hoặc Cefixim 400mg mỗi 12h/lần hoặc Cefpodoxim 200mg mỗi 12h/lần.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn

Biểu hiện lâm sàng: Thường gặp chảy dịch mũi và ho kèm với đau đầu, đau vùng mặt và sốt mức độ nhẹ kéo dài > 10-14 ngày. Cũng có thể biểu hiện cấp tính với sốt cao (≥ 39°C) và chảy mủ mũi có kèm hoặc không kèm với đau đầu dữ dội kéo dài ≥ 3 ngày. Các biểu hiện khác phụ thuộc vào xoang bị tác động: *Xoang hàm*: căng đau khi gõ vào răng hàm; đau răng hàm trên; viêm nhiễm tại chỗ lan rộng có thể gây viêm tủy xương của xương vùng mặt gây các biểu hiện lồi mắt, viêm mô tế bào sau hố mắt, liệt vận nhãn, lan rộng viêm nhiễm trực tiếp tới nội sọ hiếm gặp; *Xoang trán*: đau đầu nổi trội, lan rộng tình trạng viêm tới nội sọ có thể gây ápxe ngoài màng cứng/ápxe não, viêm màng não, huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên/xoang hang; Lan rộng tình trạng viêm tới vùng hố mắt có thể gây viêm mô tế bào quanh mắt; *Xoang sàng*: phù mi mắt và chảy nhiều nước mắt; Lan rộng tình trạng viêm có thể gây đau sau hố mắt/viêm mô tế bào quanh hố mắt và/hoặc huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên /xoang hang; *Xoang bướm*: đau đầu dữ dội; Lan rông viêm tới xoang hang có thể gây viêm màng não, liệt các dây thần kinh sọ (III, IV, VI), ápxe thùy thái dương, huyết khối xoang hang. Ho và chảy mũi là các biểu hiện nội trội ở trẻ em.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp Xquang xoang hoặc chụp CT/MRI cho thấy mờ hoàn toàn xoang, mức nước-khí, dày niêm mạc. Xem xét chọc hút xoang ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch hoặc thất bại điều trị. Ở trẻ em, viêm xoang cấp là một chẩn đoán lâm sàng; các thăm dò hình ảnh học không nên áp dụng thường quy.

Lưu ý: Viêm xoang có thể được biểu hiện như một tình trạng viêm mô tế bào quanh hốc mắt (cần tiến hành chụp CT/MRI để loại trừ tình trạng viêm xoang nền). Nếu kết quả CT/MRI cho thấy có tác động tới "vách sau", cần điều trị như một viêm màng não mủ cấp. Ở trẻ em, soi xoang (transillumination), căng đau vùng xoang khi gõ và màu sắc của dịch tiết của mũi không phải là các chỉ dẫn tin cậy được để chẩn đoán viêm xoang.

Xem xét điều trị: Điều trị đủ liệu trình để dự phòng tái phát/biến chứng. Kháng sinh nhóm macrolid và TMP-SMX có thể dễ dẫn đến phế cầu kháng thuốc (DRSP) và ≥30% các chủng *S. pneumonia* có tình trạng kháng tự nhiên với macrolid. Cần xem xét tỷ lệ kháng thuốc tại địa phương trước khi lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị đủ liệu trình. Tái phát có thể xảy ra khi điều trị không đạt mức tối ưu. Đối với các trường hợp bị tái phát thường xuyên, xem xét chỉ định thăm dò hình ảnh học và hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xoang mạn do vi khuẩn

Biểu hiện lâm sàng: Đau đầu lan tỏa, mệt mỏi, xung huyết mũi, chảy dịch mũi sau kéo dài > 3 tháng với ít đau /không căng đau xoang khi gõ. Các triệu chứng tại chỗ thường kín đáo. Sốt ít gặp.

Xem xét chẩn đoán: Phim chụp xoang và chụp CT/MRI đầu thường ít hữu ích hơn so với khi chẩn đoán viêm xoang cấp (bất thường niêm mạc mạn tính có thể tiếp tục tồn tại sau khi tình trạng nhiễm khuẩn đã được điều trị). Nhiều trường hợp viêm xoang hàm trên mạn tính do nguyên nhân từ răng; tiến hành chụp Xquang răng nếu có nghi vấn.

Lưu ý: Các biểu hiện lâm sàng có thể thay đổi/không đặc hiệu. Mệt mỏi và dễ bị kích ứng có thể nổi bật hơn so với các triệu chứng tại chỗ. Có thể bị chẩn đoán nhầm là viêm mũi dị ứng. Chụp CT/MRI đầu có thể giúp loại trừ các khối u xoang.

Xem xét điều trị: Thất bại điều trị/tái phát thường do liệu trình kháng sinh không đủ thời gian, liều hoặc khả năng thâm nhập của kháng sinh vào mô viêm chưa thỏa đáng. Cần điều trị đủ liệu trình. Nếu triệu chứng tiếp diễn sau 4 tuần điều trị, cần tư vấn bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng để xem xét chỉ định mổ dẫn lưu xoang.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị đủ liệu trình. Tái phát có thể xảy ra nếu điều trị không đạt mức tối ưu. Đối với những trường hợp bị tái phát thường xuyên, xem xét chỉ định thăm dò hình ảnh học và hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm giác mạc

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị tại chỗ
Do vi khuẩn	Tụ cầu vàng *(S.aureus)* Phế cầu *(S.pneumoniae)* *Bacillus cereus* *M. catarrhalis* *P.aeruginosa*	Thuốc nhỏ mắt kháng khuẩn (ciprofloxacin, ofloxacin hoặc tobramycin/bacitracin/polymyxin B) dùng hàng giờ khi bệnh nhân thức x 2 tuần
Do virus	HSV-1	Dung dịch Trifluridin 1% nhỏ 1giọt hàng giờ khi bệnh nhân thức x 2 ngày, sau đó 1 giọt mỗi 6h/lần x 14-21 ngày ***hoặc*** thuốc mỡ bôi mắt virus (Vd: vidarabin) trước khi đi ngủ x 14-21 ngày
Do amip	Acanthamoeba	Thuốc nhỏ mắt propamidin (0,1%), neomycin, gramicidin hoặc polymycin B dùng hàng giờ khi bệnh nhân thức x 1-2 tuần ***hoặc*** thuốc nhỏ mắt polyhexamethylen biguanid (0,02%) dùng hàng giờ khi bệnh nhân thức x 1-2 tuần ***hoặc*** thuốc nhỏ mắt chlorhexidin (0,02%) dùng hàng giờ khi bệnh nhân thức x 1-2 tuần.

Biểu hiện lâm sàng: Mờ đục, thâm nhiễm hoặc loét giác mạc.

Chẩn đoán: Dựa trên biểu hiện của các tổn thương giác mạc /kết quả nuôi cấy.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm giác mạc do vi khuẩn

Xem xét chẩn đoán: Thường thứ phát sau chấn thương mắt. Luôn cần hội chẩn bác sĩ nhãn khoa.

Lưu ý: Để chắc chắn cần nuôi cấy bệnh phẩm lấy từ ổ loét. Vi khuẩn gây bệnh ít gặp thường gặp trong chấn thương mắt.

Xem xét điều trị: Điều trị tới khi tổn thương thoái triển hoàn toàn. Thuốc mỡ tra mắt dễ sử dụng hơn/tác dùng kéo dài hơn các loại dung dịch nhỏ mắt. Tránh dùng steroid tại chỗ.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rộng của chấn thương/vi khuẩn gây bệnh. Nhiễm trùng do *S. aureus, B. cereus, P.aeruginosa* có tiên lượng xấu đối với bệnh nhân.

Viêm giác mạc do virus (HSV-1)

Xem xét chẩn đoán: Đặc trưng bằng tình trạng loét giác mạc "dạng nhánh cây" ("dendritic" corneal ulcers). Luôn cần hội chẩn bác sĩ nhãn khoa.

Lưu ý: Các loét giác mạc nhỏ có thể bị bỏ sót nếu không nhuộm huỳnh quang khi khám mắt.

Xem xét điều trị: Điều trị tới khi tổn thương thoái triển hoàn toàn. Không cần dùng acyclovir uống. Tránh dùng thuốc mỡ tra mắt chứa steroids.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm (trước khi tổn thương mắt lan rộng).

Viêm giác mạc do amip (Acanthamoeba)

Xem xét chẩn đoán: Thường liên quan với sử dụng kính áp tròng mềm kéo dài nhiều giờ trong ngày. Bệnh phẩm cạo giác mạc dương tính với nhuộm calcofluor. Viêm giác mạc do Acanthamoeba gây đau với các thâm nhiễm giác mạc điển hình có hình vòng nhẫn, mờ đục. Luôn cần hội chẩn với bác sĩ nhãn khoa.

Lưu ý: Không được nhầm với loét giác mạc "dạng nhánh cây" do HSV-1. Tránh dùng steroid tại chỗ.

Xem xét điều trị: Nếu bị nhiễm khuẩn thứ phát, điều trị như đối với viêm giác mạc do vi khuẩn.

Tiên lượng: Không có điều trị có hiệu quả. Tiên lượng tồi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm kết mạc

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị bằng đường uống/tại chỗ
Do vi khuẩn	*M. catarrhalis* *H. influenzae* Phế cầu *(S.pneumoniae)* Não mô cầu *(N.meningitidis)* Lậu cầu *(N. gonorrhea)*	Các thuốc nhỏ mắt kháng khuẩn (ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin hoặc tobramycin/ bacitracin/ polymyxin B) dùng mỗi 12h/lần x 1 tuần kết hợp với thuốc mỡ kháng khuẩn (cùng loại kháng sinh) vào giờ đi ngủ x 1 tuần.
Do virus	Adenovirus	Không áp dụng
	Virus thủy đậu-zona (VZV)	Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần x 10-14 ngày ***hoặc*** Famciclovir 500mg (uống) mỗi 8h/lần x10-14 ngày.
Do Chlamydia	*C.trachomatis* (bệnh mắt hột)	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Azithromycin 1g (uống) x 1 liều.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm kết mạc do vi khuẩn

Biểu hiện lâm sàng: Dịch tiết mủ từ kết mạc, với số lượng nhiều.

Xem xét chẩn đoán: Kết mạc đỏ; Tiến hành nuôi cấy để tìm vi khuẩn gây bệnh đặc hiệu.

Lưu ý: Không được nhầm với viêm kết mạc dị ứng, tình trạng này gây ngứa và có dịch tiết trong.

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn bác sĩ nhãn khoa. Dùng thuốc mỡ bôi mắt sẽ có tác dụng kéo dài hơn so với dùng dung dịch nhỏ mắt. Không được sử dụng steroid tại chỗ khi không dùng thuốc kháng khuẩn.

Tiên lượng: Tốt khi được điều trị sớm và không để lại di chứng suy giảm thị lực.

Viêm kết mạc do virus

Do Adenovirus

Biểu hiện lâm sàng: Kết mạc đỏ, chảy nước mắt nhiều, nuôi cấy vi khuẩn âm tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên biểu hiện giác mạc đục dạng vẩn mây/hơi nước song nuôi cấy vi khuẩn âm tính. Dấu hiệu chỉ điểm là các thâm nhiễm lấm chấm với giác mạc đục dạng vẩn mây. Bệnh lây nhiễm cao; Điều cần tihiết là cần rửa tay cẩn thận sau khi tiếp xúc với bệnh nhân để làm giảm lây nhiễm. Tiến hành nuôi cấy virus từ kết mạc để chẩn đoán.

Lưu ý: Viêm thanh quản là một bằng chứng gợi ý cho căn nguyên nhiễm adenovirus (sốt viêm họng – kết mạc).

Xem xét điều trị: Hiện không có biện pháp điều trị hữu hiệu. Thường thuyên giảm trong vòng 1-2 tuần.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ đục mờ giác mạc. Các trường hợp nặng có thể cần tới nhiều tuần giác mạc mới trở lại bình thường.

Bệnh zona mắt do VZV (VZV Ophthalmicus)

Xem xét chẩn đoán: Mụn phỏng nước ở đầu mũi dự đoán bệnh sẽ gây tác động tới mắt.

Lưu ý: Không được bỏ sót các tổn thương bọng nước ở ống tai ngoài ở bệnh nhân bị liệt mặt (hội chứng Ramsey-Hunt).

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn với bác sĩ nhãn khoa. Có thể dùng steroid tại chỗ nếu thuốc được cho cùng với điều trị kháng virus thủy đậu (VZV).

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm bằng thuốc chống virus đường toàn thân.

Viêm kết mạc do trachoma hay bệnh mắt hột (*C. trachomatis*)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng kỹ thuật định lượng kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA)/nuôi cấy bệnh phẩm kết mạc.

Lưu ý: Không được nhầm giữa viêm kết mạc tạo hạt hai bên và thường ở mi trên do Chlamydia (bệnh đau mắt hột) với viêm kết mạc do virus/vi khuẩn là bệnh lý viêm kết mạc tác động tới cả mi mắt trên và dưới.

Xem xét điều trị: Điều trị bằng thuốc tra mắt có erythromycin hữu ích đối với trẻ sơ sinh. Azithromycin liều đơn có thể gây tình trạng tái phát.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng mạch-võng mạc (Chorioretinitis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị theo đường uống hoặc Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Do virus	CMV	***Xem trang 539***		
Do nấm †	*Candida albicans*	Fluconazol 800mg (TM) x 1 liều, sau đó 400mg (TM) mỗi 24 h/lần x 2 tuần‡ ***hoặc*** Voriconazol 6mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 1 ngày, sau đó 4 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần‡	Amphotericin B deoxycholat 0,6mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần tới tổng liều 1g ***hoặc*** dạng bào chế kết hợp với lipid của Amphotericin B (***trang 821***) (TM) mỗi 24h/lần x 3 tuần ‡	Fluconazol 800mg (uống) x 1 liều, sau đó 400 mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần *‡
Do động vật đơn bào	*Toxoplasma gondii*	Điều trị TM Không được áp dụng	Điều trị theo đường uống: Pyrimethamin 75mg (uống) x 1 liều, sau đó 25 mg (uống) mỗi 24h/lần x 6 tuần ***kết hợp với hoặc*** Sulfadiazin 1g (uống) mỗi 6h/lần x 6 tuần ***hoặc*** Clindamycin 300 mg (uống) mỗi 8h/lần x 6 tuần.	

Từ viết tắt: CMV: Cytomegalovirus

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc theo đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

† Điều trị TM hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống.

** Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

‡ Thời gian điều trị tương đối và nên được tiếp tục dùng tới khi giải quyết được nhiễm trùng. Yêu cầu được bác sĩ nhãn khoa theo dõi sát.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng mạch-võng mạc do CMV (*xem trang 539*)

Viêm màng mạch-võng mạc do Candida

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương nhỏ, dạng vòng tròn, màu trắng, lồi lên khỏi bề mặt võng mạc.

Xem xét chẩn đoán: Dấu hiệu khi soi đáy mắt tương tự như các khuẩn lạc màu trắng, lồi lên khỏi bề mặt đĩa thạch máu.

Lưu ý: Viêm nội nhãn do Candida báo hiệu là bệnh nấm Candida xâm lấn tạng/ lan tràn.

Xem xét điều trị: Điều trị như đối với nhiễm nấm Candida lan tràn toàn thân.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm.

Viêm màng mạch-võng mạc do Toxoplasma

Biểu hiện lâm sàng: Các nhiễm sắc tố màu xám/đen trên điểm vàng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng định lượng hiệu giá IgM đối với Toxoplasma bằng kỹ thuật kháng thể miễn dịch huỳnh quang (IFA).

Lưu ý: Viêm nội nhãn một bên thường chỉ dẫn một nhiễm Toxoplasma mắc phải, nhiễm Toxoplasma bẩm sinh thường tác động tới cả hai mắt.

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn với bác sĩ nhãn khoa. Chỉ điều trị đối với nhiễm Toxoplasma cấp/hoạt động với các triệu chứng thị giác; Không cần điều trị đối với viêm màng mạch-võng mạc mạn tính. Bổ sung thêm acid folic 10mg (uống) mỗi 24h/lần để dự phòng tình trạng thiếu acid folic.

Tiên lượng: Tùy thuộc vào mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội nhãn

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Do vi khuẩn (Điều trị khởi đầu như đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA hoặc S. epidermidis, tiến hành điều trị một cách phù hợp)	Liên cầu (Streptococci) *H.influenzae* Tụ cầu vàng (MSSA)	**Tiêm vào trong dịch kính**: Cefepim 2,25mg/0,1 mL dịch muối sinh lý vô khuẩn x 1 liều; dùng nhắc lại x 1 lần nếu cần trong 2-3 ngày ***cộng với*** **Tiêm dưới kết mạc**: Cefepim 100mg/0,5 mL dịch muối sinh lý vô khuẩn mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***cộng với*** Levofloxacin 500mg (TM/uống) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần.		
	Tụ cầu vàng (MRSA) *S. epidermidis* (CoNS)	**Tiêm vào trong dịch kính**: Cefepim 2,25mg/0,1 mL dịch muối sinh lý vô khuẩn x 1liều; dùng nhắc lại x 1 lần nếu cần trong 2-3 ngày ***cộng với*** **Tiêm dưới kết mạc**: Cefepim 100 mg/0,5 mL dịch muối sinh lý vô khuẩn mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***cộng với*** Levofloxacin 500 mg (TM/uống) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần.		
Do nấm ‡	*C. albicans*	Fluconazol 800mg (TM) x 1 liều, sau đó 400 mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tháng	Voriconazol (***xem "liều thường dùng" trang 1080***) x 2 tháng	Fluconazol (như liều TM) ***hoặc*** Voriconazol (***xem trang 1080***) x 2 tháng
	A.fumigatus *A.flavus*	Amphoterricin B (trong dịch kính) 10µg (trong 0,1mL dịch muối sinh lý) mỗi 2-3 ngày/lần	Voriconazol (***xem "liều thường dùng" trang 1080***) x 2 tháng	Voriconazol (***xem "liều thường dùng", trang 1080***) x 2 tháng
Lao	*M. tuberculosis*	Điều trị giống như viêm phổi do lao (***xem trang 94***)		
Thủy tinh thể cấy ghép bị nhiễm khuẩn* (Điều trị khởi đầu như đối với MSSA nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA hoặc S. epidermidis, tiến hành điều trị một cách phù hợp)	Entero-bacteriaceae Tụ cầu vàng (MSSA)	Meropenem 1g (TM) mỗi 8 h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Chloramphenicol 500mg (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần	Chloramphenicol 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 2 tuần
	Tụ cầu vàng (MRSA)	Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Minocyclin 100 mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/ lần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (Methicillin-sensitive/resistant *S. aureus*): Tụ cầu nhạy/kháng Methicillin. CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu không sinh coagulase hay coagulase (-).

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc theo đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

** Chỉ điều trị theo đường tĩnh mạch hoặc chuyển điều trị từ đường tĩnh mạch sang đường uống.*

‡ Thời gian điều trị mang tính tương đối và nên được tiếp tục tới khi bệnh thoái triển hoàn toàn. Cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi sát.

Viêm nội nhãn do vi khuẩn

Biểu hiện lâm sàng: Đau nhức mắt/mất thị lực đột ngột.

Xem xét chẩn đoán: Viêm nội nhãn sau mổ xảy ra sau phẫu thuật1 – 7 ngày. Có thể nhìn thấy mủ ở tiền phòng (hypopyon).

Lưu ý: Viêm nội nhãn khởi phát muộn có thể xảy ra ở tới tuần thứ 6 sau mổ. Mảng trắng trong bao (white intracapsular plaque) là dấu hiệu đặc trưng.

Xem xét điều trị: Sử dụng steroid (dexamethason 0,4 mg/0,1 mL tiêm vào trong dịch kính và 10mg/1mL tiêm dưới kết mạc) cùng với kháng sinh đối với viêm nội nhãn sau mổ. Cũng cần sử dụng kháng sinh toàn thân đối với các trường hợp nặng. Thường cần phải tiến hành lấy bỏ dịch kính

Tiên lượng: Liên quan với độc lực của vi sinh vật gây bệnh.

Viêm nội nhãn do nấm

Biểu hiện lâm sàng: Suy giảm chậm thị lực ± đau ở mắt. Bệnh nhân không bị sốt. Tiền sử/ hiện tại bệnh nhân đang được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, được đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, điều trị kháng sinh dài ngày/ dùng thuốc ức chế miễn dịch, dùng steroid, người nghiện trích đường tĩnh mạch hoặc sau mổ đục thủy tinh thể.

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu thường dương tính trong viêm nội nhãn do Candida. Các tổn thương màu trắng tròn/nhỏ gần các mạch võng mạc. Chẩn đoán bằng nuôi cấy dịch kính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Các triệu chứng xuất hiện âm thầm với đau ít hoặc không đau ở mắt hoặc sốt. Cấy máu âm tính với viêm nội nhãn do nấm Aspergillus.

Xem xét điều trị: Sự thâm nhập của kháng sinh vào dịch kính đòi hỏi thuốc phải có độ hòa tan trong lipid cao và bệnh nhân có tình trạng viêm nặng. Lựa chọn đường dùng kháng sinh bằng đường TM/tiêm trong dịch kính/dưới kết mạc tùy thuộc vào các đặc tính lý-hóa của thuốc được chọn dùng cho bệnh nhân. Phẫu thuật lấy bỏ dịch kính được một số tác giả ưa thích áp dụng.

Nếu sử dụng amphotericin B tiêm vào dịch kính, bổ sung thêm điều trị toàn thân theo đường tĩnh mạch không mang lại lợi ích gì. Voriconazol có thể thâm nhập vào dịch não tủy/mắt, song kinh nghiệm lâm sàng về điều trị này còn hạn chế. Dựa trên các dữ liệu hiện có, dường như, caspofungin kém thâm nhập vào trong dịch kính và không nên sử dụng thuốc này để điều trị viêm nội nhãn do nấm.

Tiên lượng: Kết quả tốt khi tiến hành phẫu thuật lấy bỏ dịch kính phối hợp với điều trị kháng sinh chống nấm tiêm vào trong dịch kính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội nhãn do lao

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương dạng lấm chấm ở võng mạc nổi lồi lên ± suy giảm thị lực.

Xem xét chẩn đoán: Thường có biểu hiện các dấu hiệu thực thể lao ngoài mắt. Khẳng định chẩn đoán lao kê bằng sinh thiết gan/xương.

Lưu ý: Viêm nội nhãn do lao là một dấu hiệu của lao toàn thể .

Xem xét điều trị: Điều trị như đối với lao toàn thể. Có thể dùng steroid toàn thân nếu thuốc được sử dụng cùng với thuốc điều trị lao.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Thủy tinh thể cấy ghép bị nhiễm trùng

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng và nuôi cấy dịch tiền phòng. Cần hội chẩn với bác sĩ nhãn khoa.

Lưu ý: Nuôi cấy dịch lấy từ bề mặt không phù hợp. Có thể cần phải hút dịch ở tiền phòng để tiến hành nuôi cấy.

Xem xét điều trị: Thủy tinh thể bị nhiễm khuẩn phải được tháo bỏ để điều trị triệt để.

Tiên lượng: Tốt khi lấy bỏ thủy tinh thể nhân tạo sớm và có khuyến cáo cần dùng kháng sinh cho bệnh nhân .

Viêm tai ngoài

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Lành tính	*P.aeruginosa*	Chỉ dùng dung dịch thuốc nhỏ mắt (ofloxacin 0,3%, tobramycin, polymycin B); áp dụng nhỏ tai mỗi 6h/lần x 1 tuần.		
Ác tính	*P.aeruginosa*	**Một thuốc "A" ± một thuốc "B":** **Các" thuốc A" bao gồm:** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8/lần ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 8 giờ x 4-6 tuần **Các" thuốc B" bao gồm:** Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/ lần x 4-6 tuần ***hoặc*** Amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần x 4-6 tuần		Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (uống) mỗi 24h/ lần x 4-6 tuần

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian dùng thuốc đường tại chỗ (đối với thể lành tính) hoặc theo đường TM + đường uống (đối với thể ác tính). Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị đường TM có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tai ngoài lành tính (do *Pseudomonas aeruginosa*)

Biểu hiện lâm sàng: Chảy dịch ống tai ngoài cấp tính song không có thủng màng nhĩ hoặc tổn thương xương đi kèm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được gợi ý dựa trên biểu hiện chảy dịch ống tai ngoài sau khi tiếp xúc với nước. Thường mắc phải từ hồ bơi *"bệnh tai của người đi bơi"*. Đây không phải là một tình trạng nhiễm trùng xâm lấn.

Lưu ý: Phải đảm bảo chắc chắn là viêm tai ngoài không đi kèm với thủng màng nhĩ là tình trạng đòi hỏi phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng và điều trị kháng sinh toàn thân.

Xem xét điều trị: Điều trị tại chỗ tới khi triệu chứng/tình trạng nhiễm khuẩn thoái triển.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt với điều trị tại chỗ.

Viêm tai ngoài ác tính (do Pseudomonas aeruginosa)

Biểu hiện lâm sàng: Chảy dịch ống tai ngoài cộng với tác động tới xương.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có *P. aeruginosa* trong nuôi cấy mô mềm lấy từ ống tai kết hợp tổn thương xương/sụn trên phim chụp Xquang. Thường tác động tới bệnh nhân đái tháo đường. Chụp CT/MRI đầu cho thấy có tác động tới xương của ống tai ngoài.

Lưu ý: Hiếm gặp ở người không bị đái tháo đường.

Xem xét điều trị: Đòi hỏi phải phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử kết hợp với điều trị kháng sinh để điều trị triệt để.

Tiên lượng: Liên quan với kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Viêm tai giữa cấp

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tiêm bắp	Điều trị theo đường uống
Nhiễm trùng do vi khuẩn không biến chứng nguyên phát	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Ceftriaxon 50mg/kg (Tiêm bắp) x 1 liều	Amoxicillin 1g hoặc 10 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần x 10 ngày ***hoặc*** Clarithromycin 7,5mg/kg (uống) mỗi 12h/lần x 10 ngày ***hoặc*** Azithromycin 10 mg/kg (uống) x 1 liều, sau đó 5 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x 4 ngày
Thất bại điều trị hoặc vi sinh vật kháng thuốc *	Phế cầu đa kháng thuốc (MDRSP) *H. influenzae* sinh men β-lactamase	Ceftriaxon 50mg/kg (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần x 3 liều	Amoxicillin/acid clavulanic ES-600/90 mg/ kg/ngày (uống) chia 2 liều nhỏ x 10 ngày† ***hoặc*** Cephalosporin† (uống) x 10 ngày

Từ viết tắt: MDRSP (multidrug-resistant *S. pneumonia*): Phế cầu đa kháng thuốc.

Liều dùng cho trẻ em được cung cấp; Viêm tai giữa cấp ít gặp ở người lớn. Đối với viêm tai giữa mạn tính, cần điều trị kháng sinh kéo dài.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* *Điều trị thất bại: Triệu chứng tiếp tục kéo dài và vẫn còn thấy các bất thường khi soi tai sau khi bắt đầu điều trị kháng sinh ban đầu 48-72 giờ. Khi có các yếu tố nguy cơ nhiễm phế cầu đa kháng thuốc (MDRSP), xem phần* ***Xem xét điều trị****.*

† *ES-600= 600mg amoxicilin/5mL. Cephalosporins: Cefuroxim axetil 15 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần hoặc Cefdinir 7 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần hoặc 14mg/kg (uống) mỗi 24h/lần hoặc Cefpodoxim 5mg/kg (uống) mỗi 12h/lần có thể được dùng.*

Viêm tai giữa cấp tính

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, đau tai, giảm thính lực. Các biểu hiện không đặc hiệu thường gặp hơn ở trẻ nhỏ tuổi (trẻ quấy khóc, sốt). Điểm mấu chốt để chẩn đoán là khám màng nhĩ. Bệnh không phổ biến ở người lớn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên dấu hiệu màng nhĩ mờ đục, xung huyết, phồng lên, đi kèm với mất các điểm mốc và giảm di động khi soi tai bằng ống nội soi tai khí (pneumatic otoscopy).

Lưu ý: Việc không lấy sạch ráy tai (dẫn tới không thể quan sát đầy đủ màng nhĩ) khi thăm khám và chỉ dựa vào tiền sử bị đau tai/ đau khi kéo tai là các yếu tố chính dẫn đến chẩn đoán qua mức viêm tai giữa. Viêm tai giữa ứ dịch (otitis media with effusion) (tức là màng nhĩ bị co kéo hoặc ở vị trí bình thường nhưng bị giảm di động hoặc di động với áp lực âm, có dịch đọng lại ở đằng sau màng nhĩ song vẫn có mầu sắc bình thường) thường tự khỏi và không cần điều trị bằng kháng sinh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Các yếu tố nguy cơ bị nhiễm khuẩn do phế cầu đa kháng thuốc kháng sinh bao gồm đã điều trị kháng sinh trong vòng 30 ngày trước, không đáp ứng điều trị sau 48-72 giờ, trẻ được gửi nhà trẻ và dùng kháng sinh dự phòng. Macrolid và TMP-SMX có thể dễ dẫn đến phế cầu đa kháng thuốc kháng sinh và 25% các chủng phế cầu (*S.pneumoniae)* có tình trạng kháng tự nhiên với macrolid.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt, song bệnh có xu hướng tái phát. Viêm tai mạn tính, viêm tai mạn tính có cholesteatoma, viêm xương chũm là các biến chứng hiếm gặp. Đối với các trường hợp viêm tai giữa tái phát thường xuyên, phẫu thuật nạo VA/ thủ thuật chích màng nhĩ và đặt ống thông khí (tympanostomy tubes) là các thủ thuật ngoại khoa hàng đầu được áp dụng cho trẻ em.

Viêm xương chũm

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cấp tính	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* Tụ cầu vàng (MSSA)	Ceftriaxon 1-2g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần
Mạn tính	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* *P. aeruginosa* Tụ cầu vàng (MSSA) Các vi khuẩn kị khí trong khoang miệng	Meronem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 4 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 4 tuần	Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x 4-6 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/lần x 4-6 tuần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần x 4-6 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

Viêm xương chũm cấp tính

Biểu hiện lâm sàng: Đau/sưng và ấn đau trên xương chũm kèm sốt.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI cho thấy xương chũm bị tác động.

Lưu ý: Cần tiến hành chụp CT/MRI đầu để loại trừ tình trạng nhiễm khuẩn lan tới thần kinh trung ương được biểu hiện như viêm màng não mủ cấp.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xương chũm mạn tính

Biểu hiện lâm sàng: Sưng/đau bán cấp ở vùng xương chũm kèm sốt nhẹ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI cho thấy xương chũm bị tác động. Hiếm gặp viêm tai xương chũm mạn tính thứ phát do lao (chẩn đoán bằng nhuộm phết kính tìm trực khuẩn lao/ nuôi cấy bệnh phẩm sinh thiết xương hoặc mô xương hoại tử được cắt lọc).

Lưu ý: Tiến hành chụp CT/MRI đầu để loại trừ tình trạng nhiễm khuẩn lan tới thần kinh trung ương

Xem xét điều trị: Thường cần phải phẫu thuật cắt lọc xương hoại tử để điều trị triệt để. Nên được xem xét như một tình trạng viêm tủy xương mạn tính. Nếu thứ phát do lao, điều trị như lao xương.

Tiên lượng: Tiến triển nặng dần nếu không được phẫu thuật. Tiên lượng tối khi có kết hợp với viêm màng não/ápxe não.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tuyến mang tai mưng mủ

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm tuyến mang tai (do vi khuẩn)	Tụ cầu vàng (MSSA) *Enterobacteriaceae* Các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon * (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Quinolon * (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

** Levofloxacin 500 mg hoặc Moxifloxacin 400 mg.*

Biểu hiện lâm sàng: Đau/ sưng một bên tuyến mang tai kèm chảy dịch từ ống Stenon có kèm theo hoặc không kèm theo sốt.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng, tăng amylase, chụp CT/MRI chứng minh có sỏi trong ống dẫn/trong tuyến mang tai.

Lưu ý: Cần phân biệt với quai bị một bên bằng triệu chứng chảy mủ từ ống Stenon.

Xem xét điều trị: Nếu ống dẫn nước bọt bị tắc nghẽn, cần loại bỏ sỏi.

Tiên lượng: Tốt nếu điều trị sớm.

Viêm hầu họng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường uống
Do vi khuẩn	Liên cầu nhóm A	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 7-10 ngày ***hoặc*** Cefprozil 500mg (Uống) mỗi 12h/lần x 7-10 ngày ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 7-10 ngày ***hoặc*** Clarithromycin XL 1g (uống) mỗi 24h/lần x 7-10 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) x 1 liều, sau đó 250mg (uống) mỗi 24h/lần x 4 ngày.
Viêm họng có giả mạc	*Arcanobacterium (Corynebacterium) hemolyticum*	Doxycyclin 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12 giờ x 1-2 tuần ***hoặc*** ClarithromycinXL 1g (uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Azithromycin 500mg (TM hoặc uống) x 1 liều sau đó 250mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Cephalosporin (TM hoặc uống) x 12 tuần.
	C. diphtheriae *C. ulcerans*	Kháng độc tố bạch hầu (***xem trang 301***) ± penicillin hoặc macrolid.
Do virus	Các virus hô hấp, EBV, CMV, HHV-6	Không áp dụng. Epstein-Barr virus (EBV)/ Cytomegalovirus (CMV) không gây viêm họng tiên phát, song viêm họng là một phần của hội chứng tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, cùng với viêm gan và viêm hạch bạch huyết. Đối với viêm gan do virus (***xem trang 174-175***).
Khác	*M. pneumoniae* *C. pneumoniae*	Quinolon hô hấp*(uống) mỗi 24h/lần x 1 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 1tuần ***hoặc*** ClarithromycinXL 1g (uống) mỗi 24h/lần x 1 tuần ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) x 1 liều sau đó 250mg (uống) mỗi 24h/lần x 4 ngày.

Hội chứng mệt mỏi mạn tính †

Từ viết tắt: EBV: Epstein-Barr virus; CMV: Cytomegalovirus; HHV6 (Human Herpes virus 6): Virus

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Herpes người typ 6.

* *Levofloxacin 500 mg hoặc Moxifloxacin 400 mg.*

† *Không phải là nguyên nhân của viêm hầu họng, tác nhân gây bệnh không được biết (không phải EBV) song có thể gây ra bởi một loại virus gây bệnh laxemi ở chuột có tên là Xenotropic Murine Leukemia Related virus (XMRV).* ***Xem phần Xem xét điều trị (trang 77).***

Viêm họng do vi khuẩn (*Bacterial Pharyngitis*)

Biểu hiện lâm sàng: Đau họng cấp với sốt, sưng hạch vùng trước cổ cả hai bên và tăng hiệu giá ASO. Không có nói khàn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán viêm họng do liên cầu nhóm A dựa trên tiêu chuẩn có tăng hiệu giá kháng thể kháng liên cầu (ASO) sau khởi phát đau họng và cấy dịch họng dương tính. Test nhanh tìm liên cầu không cần thiết do chậm trễ chờ kết quả nuôi cấy (~ 1 tuần) vẫn cho phép có được một khoảng thời gian thích hợp để bắt đầu điều trị và dự phòng thấp tim cấp. Viêm họng do liên cầu nhóm A hiếm gặp ở người lớn sau tuổi 30.

Lưu ý: Nhuộm Gram dịch xuất tiết họng giúp phân biệt tình trạng liên cầu nhóm A thuộc các vi khuẩn cư trú trong họng (có ít hoặc không có bạch cầu đa nhân trung tính) với tình trạng nhiễm trùng do liên cầu nhóm A (có nhiều bạch cầu đa nhân trung tính) ở bệnh nhân có kết quả cấy họng hoặc test nhanh tìm liên cầu dương tính. Không được đơn thuần dựa trên kết quả cấy que ngoáy họng hoặc làm test nhanh tìm liên cầu để chẩn đoán phân biệt giữa người lành mang vi khuẩn với nhiễm trùng do liên cầu.

Xem xét điều trị: Benzathin penicillin 1,2 triệu đơn vị (tiêm bắp) x 1 liều có thể được dùng như một điều trị thay thế cho điều trị bằng đường uống. Sử dụng penicillin, erythromycin và ampicillin bị thất bại ở 15% các trường hợp do khả năng thâm nhập kém của các thuốc này vào chất tiết ở miệng hoặc do vi khuẩn ở miệng sản xuất enzym beta-lactamase.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt. Điều trị trong vòng 10 ngày để dự phòng thấp khớp cấp.

Viêm họng giả mạc

Biểu hiện lâm sàng: Viêm học có giả mạc do *A. hemolyticum* được biểu hiện bằng phát ban dạng tinh hồng nhiệt và viêm họng có giả mạc. Viêm họng bạch hầu *do C. diphtheriae* không có sốt/phát ban.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy dịch ngoáy họng/phân lập vi khuẩn

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

gây bệnh ở các bệnh nhân có phát ban dạng tinh hồng nhiệt.

Lưu ý: Phải phân biệt liên cầu tan máu nhóm A (*A.hemolyticum*) với trực khuẩn bạch hầu (*C.diphtheriae*) khi nuôi cấy.

Xem xét điều trị: Đối với liên cầu tan máu nhóm A (*A.hemolyticum*), doxycyclin hoặc erythromycin có hiệu quả hơn beta-lactam. Penicillin hoặc macrolid thường được sử dụng để điều trị trực khuẩn bạch hầu (*C. diphtheriae*). Nhiễm trùng do *C. diphtheriae* cần được điều trị bằng giải độc tố càng sớm càng tốt do điều trị kháng sinh chỉ là điều trị bổ trợ thêm .

Tiên lượng: Phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn đường thở. Tiên lượng tốt nếu được điều trị sớm đối với *A. hemolyticum*. Tiên lượng đối với bạch hầu thanh quản phụ thuộc vào điều trị sớm bằng giải độc tố và có hay không có và mức độ nặng của viêm cơ tim do độc tố vi khuẩn.

Viêm họng do virus

Biểu hiện lâm sàng: Đau họng cấp. Các đặc điểm khác phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh đặc hiệu.

Xem xét chẩn đoán: Hầu hết các trường hợp viêm họng virus là do virus hô hấp gây nên và thường đi kèm với khàn tiếng, song không có sốt cao, xuất tiết dịch họng, xuất huyết vòm họng hoặc hạch viêm ở vùng sau cổ. Các nguyên nhân gây viêm họng virus khác (EBV, CMV, HHV-6) thường được kết hợp với nổi hạch vùng sau cổ và tăng SGOT/SGPT. Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng do EBV có thể được biểu hiện bằng viêm họng xuất tiết hoặc không xuất tiết và được chẩn đoán dựa trên hiệu giá kháng thể kháng liên cầu (ASO) âm tính + test Monospot dương tính hoặc tăng hiệu giá IgM đối với kháng nguyên vỏ của virus (VCA). Trước khi test Monospot trở nên dương tính (có thể cần chờ tới 8 tuần), chẩn đoán sơ bộ bị tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng do nhiễm EBV có thể được đặt ra dựa trên tốc độ lắng hồng cầu và SGOT là các xét nghiệm bị gia tăng trong nhiễm EBV và bình thường trong viêm họng do liên cầu nhóm A. Nếu test EBV Monospot âm tính, làm lại test sau 8 tuần; nếu vẫn âm tính, tiến hành định lượng hiệu giá IgM đối với cytomegalovirus (CMV)/Toxoplasma để chẩn đoán nguyên nhân của viêm họng với test "Monospot âm tính".

Lưu ý: 30% các bệnh nhân bị viêm họng do virus là người mang liên cầu nhóm A (vi khuẩn ngụ cư ở họng hầu). Tìm kiếm các đặc điểm nhiễm virus để gợi ý chẩn đoán chính xác (giảm bạch cầu, tăng bạch cầu lympho, có tế bào lympho không điển hình).

Xem xét điều trị: Chỉ điều trị triệu chứng. Dùng steroid ngắn ngày chỉ áp dụng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

đối với nhiễm trung do EBV nếu có biểu hiện hoặc có nguy cơ rõ rệt bị tắc nghẽn đường thở. Do 30% bệnh nhân bị viêm họng do virus có mang liên cầu nhóm A nên không cần điều trị dù kết quả nuôi cấy họng dương tính với liên cầu nhóm A nếu không thấy có các đặc điểm viêm họng do liên cầu (Vd: nổi hạch sau cổ hai bên).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nhiễm khuẩn toàn thân. Tình trạng mệt mỏi sau nhiễm virus thường gặp. CMV có thể vẫn tiếp tục hoạt động trong gan trong vòng 6-12 tháng và gây tình trạng tăng nhẹ transaminase huyết thanh.

Viêm họng do Mycoplasma/Chlamydophilia (Chlamydia)

Biểu hiện lâm sàng: Đau họng cấp ± viêm thanh quản. Thường không xuất tiết.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên có tăng hiệu giá IgM đối với *M. pneumoniae* hoặc *C. pneumoniae*. Xem xét chẩn đoán này ở các bệnh nhân bị viêm họng không có xuất tiết song không phải là viêm họng do virus hoặc liên cầu. Viêm họng do Mycoplasma thường đi kèm với viêm tai giữa/viêm màng nhĩ bọng nước (bullous myringitis) .

Lưu ý: Các bệnh nhân bị nhiễm trùng do *C.pneumoniae* thường bị viêm thanh quản nhưng viêm họng do Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), liên cầu nhóm A hoặc *M. pneumoniae* không có đặc điểm này.

Xem xét điều trị: Điều trị viêm thanh quản do *C.pneumoniae* cho kết quả lấy lại nhanh được giọng nói bình thường (~ 3 ngày), song điều này không xảy ra với viêm họng do virus.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Hội chứng mệt mỏi mạn tính (CFS)

Biểu hiện lâm sàng: Mệt mỏi > 1 năm với suy giảm nhận thức và không kèm viêm họng.

Xem xét chẩn đoán: Loại trừ các nguyên nhân khác gây mệt mỏi mạn tính (ung thư, bệnh lý tuyến thượng thận/tuyến giáp...) trước khi chẩn đoán hội chứng mệt mỏi mạn tính. Hiệu giá kháng thể đối với HHV-6/Coxsackie B thường tăng cao. Một số bệnh nhân có giảm số lượng/hoạt tính của tế bào diệt tự nhiên (NK). Tốc độ lắng hồng cầu ~ 0. Thường gặp biểu hiện hình trăng lưỡi liềm đỏ tía ở thành sau họng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Tăng hiệu giá IgG với kháng nguyên vỏ virus (VCA) của EBV thường gặp trong hội chứng mệt mỏi mạn tính, song EBV không gây ra hội chứng mệt mỏi mạn tính. Không được nhầm giữa hội chứng mệt mỏi mạn tính với hội chứng đau xơ cơ là bệnh lý có các "điểm kích hoạt đau " ở cơ và không có suy giảm nhận thức. Hội chứng mệt mỏi mạn tính với đau xơ cơ có thể cùng tồn tại ở một bệnh nhân. Khi nghi vấn bệnh nhân có hội chứng mệt mỏi mạn tính, song nếu họ có tình trạng viêm họng hoặc nếu tốc độ lắng hồng cầu tăng cao, cần xem xét tới một chẩn đoán thay thế khác.

Xem xét điều trị: Hiện không có biện pháp điều trị đặc hiệu nào. Các bệnh nhân bị giảm số lượng tế bào diệt tự nhiên (NK) có thể nhận được lợi ích nhờ điều trị bằng β-caroten 50.000 đơn vị (uống) mỗi 24h/lần x 3 tuần. Bệnh nhân có tăng hiệu giá IgG với *C.pneumoniae* có thể có được lợi ích khi điều trị bằng doxycyclin 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 3 tuần.

Tiên lượng: Bệnh có tính chất chu kì với từng đợt thuyên giảm (được thúc đẩy bởi tình trạng gắng sức, stress hoặc thiếu ngủ). Tránh gắng sức đối với bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh tưa miệng (bệnh nhiễm Candida họng miệng)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị bằng đường uống
Nấm	*C.albicans*	Fluconazol 200mg (uống) x 1 liều, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần x nhiều tuần† ***hoặc*** Posaconazol 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 1 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 13 ngày ***hoặc*** Clotrimazol 10mg viên ngậm (uống) x 5 lần/ngày trong nhiều tuần† ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần x† nhiều tuần.
	Các loài Candida kháng fluco-nazol	Posaconazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần x† nhiều tuần* ***hoặc*** Voriconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần x† nhiều tuần* ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) x 1, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần x† nhiều tuần* ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần x† nhiều tuần*

** Thời gian điều trị phụ thuộc vào bệnh lý nền và đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân.*

† Xem Phần viêm thực quản không đáp ứng với Fluconazol (***trang 612***).

Tưa miệng (bệnh nhiễm nấm Candida họng-miệng)

Biểu hiện lâm sàng: Lưỡi hoặc hầu họng phủ một lớp mầu trắng. Những mảng trắng bám dính có thể xuất hiện ở bất kỳ phần nào của hầu họng.

Xem xét chẩn đoán: Nhuộm Gram/nuôi cấy các mảng trắng chứng minh có nấm men (Candida). Nuôi cấy và làm test đánh giá độ nhạy với kháng sinh đối với nấm gây bệnh rất hữu ích trong phân tích các trường hợp không đáp ứng điều trị.

Lưu ý: Các tổn thương mặt bên của lưỡi, trắng, dạng sọc, có thể giống tưa miệng song thật ra là biểu hiện của chứng bạch sản dạng lông (hairy Leukoplakia). Bạch sản dạng lông sẽ gợi ý cho tình trạng nhiễm HIV. Tưa miệng có thể xẩy ra ở trẻ em, người nghiện rượu, đái tháo đường và các đối tượng dùng steroid/điều trị kháng sinh hoặc người nhiễm HIV.

Xem xét điều trị: Gần như toàn bộ nhiễm khuẩn là do *C. albicans* gây nên, đây là loài nấm thường nhạy cảm với fluconazol. Các nhiễm trùng không đáp ứng với fluconazol có thể là do nhiễm trùng *C.albicans* kháng với fluconazol gây nên (lý do thường gặp nhất), trái lại các nhiễm trùng do một loài nấm không phải albicans kháng fluconazol (hiếm gặp), việc không tuân thủ điều trị (thường gặp) hoặc tương tác thuốc (Vd: dùng đồng thời với rifampin làm giảm rõ rệt nồng độ azole trong máu). Đối với các trường hợp nghi vấn có tình trạng kháng fluconazol, thử điều trị bằng một azole khác là hợp lý do thường không xẩy ra tình trạng kháng chéo.

Tiên lượng: Các bệnh nhân không bị nhiễm HIV thường đáp ứng tốt với điều trị, nhất là khi làm giảm/loại bỏ yếu tố thúc đẩy bệnh (Vd: ngừng dùng kháng sinh, giảm liều steroid...). Bệnh nhân HIV có thể cần tới một liệu trình điều trị dài hơn và nên điều trị đến khi chữa khỏi hẳn bệnh. Tái phát thường gặp ở bệnh nhân HIV và tiến hành điều trị thuốc chống retrovirus hữu hiệu là chiến lược chung có hiệu quả nhất.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Loét miệng/ Tổn thương dạng bọng nước trong miệng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Bệnh viêm họng Vincent	Borrelia Fusobacterium	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Một beta-lactam bất kỳ (TM) x 2 tuần	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic 500/125 mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần
Bệnh viêm họng Ludwig	Liên cầu nhóm A	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Một beta-lactam bất kỳ (TM) x 2 tuần	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic 500/125 mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần
Viêm niêm mạc miệng	Hệ vi khuẩn chí thông thường ở miệng	Không áp dụng		
Bệnh viêm họng mụn nước	*Virus Coxsackie A*	Không áp dụng		
Bệnh viêm lợi miệng do Herpes	HSV-1	<u>*Điều trị theo đường uống:*</u> Valacyclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần x 1 tuần ***hoặc*** Famciclovir 500 mg (uống) mỗi 12h/lần x 1 tuần ***hoặc*** Acyclovir 400 mg (uống) 5 lần/ngày x 1 tuần		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Herpes ở môi (loét lạnh/ sốt và mọc mụn nước)	HSV-1 (tái phát)	*Điều trị theo đường uống:* Valacyclovir 2g (uống) mỗi 12h/lần x 1 ngày (2 liều) bắt đầu dùng khi khởi phát triệu chứng (ngứa/rát) ***hoặc*** Acyclovir 400 mg (uống)5 lần/ngày x 1 tuần ***hoặc*** Famciclovir 500 mg (uống) mỗi 12h/lần x 1 tuần *Điều trị tại chỗ* Kem bôi Penciclovir 1% mỗi 2h/lần khi thức x 4 ngày ***hoặc*** Kem bôi Acyclovir 5% 5 lần/ngày x 4 ngày. (*không dùng khi đang ngủ*)
Loét miệng Áp-tơ	Hệ vi khuẩn thông thường ở miệng	Không áp dụng

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh viêm họng Vincent (Borrelia/Fusobacterium)

Biểu hiện lâm sàng: Đau/chảy máu lợi song không có sốt.

Xem xét chẩn đoán: Hởi thở hôi, vệ sinh răng miệng kém /viêm mủ răng lợi.

Lưu ý: Không thể quy kết hơi thở hôi cho tình trạng vệ sinh răng miệng kém mà không xem xét và tìm kiếm các nguyên nhân nghiêm trọng khác (Vd: ápxe phổi, suy thận).

Xem xét điều trị: Sau khi kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn cấp, cần hội chẩn với bác sĩ nha khoa

Tiên lượng: Rất tốt nếu được điều trị sớm.

Bệnh viêm họng Ludwig (liên cầu nhóm A)

Biểu hiện lâm sàng: Đau ở sàn miệng kèm với sốt.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên biểu hiện sàn miệng sưng và nhô cao. Có thể gặp sưng to vùng cổ.

Lưu ý: Thiếu hụt C1α cũng gây sưng quanh miệng/lưỡi, song không có sốt hoặc sàn miệng sưng và nhô cao. Hiếm gặp hơn, bệnh viêm họng Ludwig có thể do *F. necrophorum* gây ra.

Xem xét điều trị: Không cần thiết phải phẫu thuật dẫn lưu. Có thể cần cấp cứu đường thở, vì vậy nên đặt cạnh giường bệnh bộ mở khí quản cấp cứu.

Tiên lượng: Tắc nghẽn đường thở xảy ra sớm có tác động bất lợi đối với tiên lượng của bệnh nhân.

Viêm miệng (hệ vi khuẩn thông thường ở miệng)

Biểu hiện lâm sàng: Vết loét đau ở miệng và sốt

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được dựa trên biểu hiện lâm sàng.

Lưu ý: Không được bỏ sót nguyên nhân bệnh toàn thân (Vd: bệnh lơxêmi cấp).

Xem xét điều trị: Điều trị triệu chứng đối với tình trạng đau.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của bệnh lý hệ nền toàn thân.

Bệnh viêm miệng-họng có mụn nước do virus Coxsackie A (Herpangina)

Biểu hiện lâm sàng: Bọng nước /vết loét đau ở miệng kèm với sốt.

Xem xét chẩn đoán: Các vết loét nằm ở phía sau thành họng. Không có tổn thương lợi hoặc hơi thở hôi.

Lưu ý: Không được nhầm với tổn thương mụn nước do virus Herpes-simplex.

Xem xét điều trị: Hiện không có biện pháp điều trị hiệu quả nào đối với tình trạng này. Bệnh thường thuyên giảm tự nhiên trong vòng 2 tuần.

Tiên lượng: Tốt, song có thể tái phát.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh viêm miệng – lợi do Herpes (HSV-1)

Biểu hiện lâm sàng: Đau lợi và sốt.

Xem xét chẩn đoán: Các vết loét nằm ở phía trước của họng, kết hợp với chảy máu lợi, không có hơi thở hôi.

Lưu ý: Không được bỏ sót một bệnh toàn thân hay đi kèm với chảy máu lợi (Vd: bệnh loxêmi cấp dòng tủy). Bệnh lý quanh răng thường không đi kèm với loét miệng.

Xem xét điều trị: Thuốc giảm đau dạng dung dịch dùng đường uống có thể giúp giảm đau khi nuốt.

Tiên lượng: Rất tốt nếu được điều trị sớm.

Bệnh lở môi do Herpes (vết loét lạnh/sốt và mọc phỏng nước) (HSV-1)

Biểu hiện lâm sàng: Các mụn nước gây đau dọc theo ranh giới của môi trên hoặc môi dưới, kèm theo sốt.

Xem xét chẩn đoán: Gây ra bởi nhiễm HSV-1 tái phát, được biểu hiện bằng có các tổn thương dạng phỏng nước đau ở trên/gần ranh giới viền môi. Các đợt bệnh bùng phát có thể do stress, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, kinh nguyệt kích hoạt và thường được bắt đầu bằng đau hoặc ngứa trước khi xuất hiện các mụn nước. Mụn nước có vẩy ở trên và các đợt bệnh bùng phát thường thuyên giảm trong vòng 1tuần. "Sốt và mọc phỏng nước" ("Fever blisters") không bị riêng tình trạng tăng nhiệt độ gây ra, mà tình trạng này có thể đi kèm với sốt rét, viêm màng não do phế cầu/ não mô cầu. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.

Lưu ý: Không được nhầm với bệnh chốc lở quanh miệng. Tổn thương chốc lở có vẩy khô ở trên (song không có phỏng nước), thương tổn gây ngứa (song không đau), không tác động tới bờ viền môi.

Xem xét điều trị: Không phải lúc nào cũng cần điều trị. Nếu chỉ định dùng valacyclovir, chỉ nên bắt đầu sử dụng thuốc khi xuất hiện đau/ngứa để làm giảm triệu chứng/phỏng nước/ giảm khoảng thời tồn tại của thương tổn trong đợt bệnh bùng phát. Valacyclovir không còn hiệu quả khi phỏng nước đã xuất hiện. Những thuốc dùng tại chỗ không kê đơn (docosanol 10%, kem tetracain) có thể làm giảm đau/ngứa. Có thể xem xét điều trị ức chế dùng một lần/ngày đối với các trường hợp tái phát thường xuyên hoặc trong khoảng thời gian có gia tăng nguy cơ bị đợt bệnh bùng phát (Vd: tiếp xúc với ánh sáng mặt trời). Các biện pháp chống nắng có thể hữu ích.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Bệnh có xu hướng tái phát ở các đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường. Có thể nặng ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

Loét miệng Áp-tơ (hệ vi khuẩn thông thường ở miệng)

Biểu hiện lâm sàng: Các loét đau /phỏng nước ở miệng song không có sốt.

Xem xét chẩn đoán: Thường là một dấu hiệu đơn độc. Các loét gây đau.

Lưu ý: Có thể là bằng chứng của một bệnh lý toàn thân (Vd: hội chứng Behçet). Các loét ở miệng trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống không gây đau.

Xem xét điều trị: Thường không đáp ứng với tất cả các điều trị thường quy và thường bị tái phát. Kem bôi Steroid (Kenalog) có thể hữu ích.

Tiên lượng: Tốt, song có xu hướng tái phát.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm trùng vùng sâu của cổ, hội chứng Lemierre, các nhiễm khuẩn nặng răng miệng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Các nhiễm trùng vùng sâu của cổ (thành họng bên, khoang sau hầu họng)	Vi khuẩn kị khí trong khoang miệng Liên cầu trong khoang miệng	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 100mg (TM) x 1 liều, sau đó 10 mg (TM) mỗi 24h/lần hoặc 50mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Clindamycin 300 mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 11 ngày *
Hội chứng Lemierre	· *Fusobacterrium necrophorum*	Điều trị như đối với nhiễm trùng vùng sâu của cổ, ***xem ở trên***		

Nhiễm khuẩn nặng răng miệng	Vi khuẩn kị khí trong khoang miệng Liên cầu trong khoang miệng	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g(TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/ lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 11 ngày*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nhiễm trùng vùng sâu của cổ (thành họng bên, khoang sau hầu họng)

Xem xét chẩn đoán: Nhiễm trùng khoang bên của hầu họng: Khoang họng phía trước: có thể gây biểu hiện sốt/ rét run, cứng hàm, nuốt khó, sưng vùng góc hàm ± sưng tuyến mang tai và thành bên của họng phồng to. Nhiễm trùng khoang họng phía sau: có thể gây biểu hiện nhiễm khuẩn huyết sepsis, không có khít hàm/đau và không sưng họng. Nhiễm trùng khoang hầu họng phía sau: có thể gặp sốt/ rét run, rối loạn nuốt, khó thở ± niêm mạc cứng đờ, trào ngược thực quản và thành họng sau phồng to.

Lưu ý: Nhiễm trùng các "vùng nguy hiểm" ở khoang sau hầu họng có thể lan tới trung thất và biểu hiện như viêm trung thất.

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng về chỉ định mổ dẫn lưu.

Tiên lượng: Tiên lượng xấu nhất với các nhiễm trùng khoang họng sau bên và khoang sau của họng.

Hội chứng Lemierre

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng đau họng nặng với sốt, biểu hiện nhiễm độc và sưng đau trên vùng tĩnh mạch cảnh. Viêm tắc tĩnh mạch nhiễm khuẩn huyết của tĩnh mạch cảnh (jugular vein septic thrombophlebitis) và thuyên tắc mạch phổi nhiễm khuẩn huyết (septic pulmonary emboli) .

Xem xét chẩn đoán: Có thể biểu hiện như một thuyên tắc nhiều mạch phổi nhiễm khuẩn huyết. Thường xảy ra sau khi bị nhiễm khuẩn răng gần đây. Chẩn đoán dựa trên biểu hiện đau trên vùng tĩnh mạch cảnh. Cấy máu dương tính đối với *F. necrophorum* hoặc *F. nucleatum*; hiếm gặp với tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA).

Lưu ý: Nên nghi vấn bị hội chứng Lemierre ở bệnh nhân hiện đang bị nhiễm trùng răng hoặc trong tiền sử/nhiễm trùng hầu họng kèm với biểu hiện đau họng nặng và sưng đau vùng tĩnh mạch cảnh.

Xem xét điều trị: Nếu không đáp ứng với điều trị kháng sinh, có thể cần phẫu thuật mở tĩnh mạch lấy huyết khối.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị ngay. Có thể nặng nề hơn với viêm họng do *M. pneumoniae* hoặc do EBV xảy ra đồng thời.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nhiễm trùng nặng răng miệng

Xem xét chẩn đoán: Tiến hành chụp CT/MRI xương hàm để loại trừ tình trạng ápxe hoặc viêm tủy xương.

Lưu ý: Rò dịch mạn tính ở một bệnh nhân được cấy ghép răng nên được chẩn đoán là viêm tủy xương/ápxe mạn tính cho tới khi chứng minh được một chẩn đoán khác.

Xem xét điều trị: Ổ ápxe cần được dẫn lưu để điều trị triệt để.

Tiên lượng: Tiên lượng tồi và dễ tái phát nếu không được mổ dẫn lưu thỏa đáng.

Viêm nắp thanh quản (Epiglottitis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm nắp thanh quản	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* Các virus đường hô hấp	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefprozil 500mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Tiếng thở rít kèm với nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.

Xem xét chẩn đoán: Chụp phim cổ nghiêng cho thấy có phù nắp thanh quản. Chụp CT/MRI vùng cổ có thể giúp ích nếu phim chụp Xquang cổ không chẩn đoán được tình trạng này.

Lưu ý: Không cố gắng tiến hành lấy bệnh phẩm để nuôi cấy trong viêm nắp thanh quản (do nỗ lực này có thể thúc đẩy tình trạng tắc nghẽn đường hô hấp trên).

Xem xét điều trị: Điều trị theo kinh nghiệm càng nhanh càng tốt. Cần hội chẩn bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng.

Tiên lượng: Xảy ra sớm tình trạng tắc nghẽn đường thở là yếu tố tiên lượng xấu.

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI

Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính (AECB)

Phân loại	Mầm bệnh	Điều trị đường uống
Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn (AECB)	*S.pneumoniae* *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Quinolon đường hô hấp* (uống) mỗi 24h/lần x 5 ngày ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic 500mg/125mg (uống) mỗi 12h/lần x 5 ngày ***hoặc*** Clarithromycin XL 1g (uống) mỗi 24/lần x 5 ngày ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 5 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) x 3 ngày

** Moxifloxacin 400 mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Ho có đờm và phim chụp Xquang ngực bình thường ở một bệnh nhân bị viêm phế quản mạn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên ho có đờm, đờm mủ và phim chụp Xquang ngực không có dấu hiệu viêm phổi. *H. influenzae* thường gặp hơn so với các tác nhân gây bệnh khác.

Lưu ý: Không lấy mẫu đờm để tiến hành nuôi cấy trong viêm phế quản mạn. Kết quả nuôi cấy thường cho thấy hệ vi khuẩn chí bình thường/hỗn hợp và không được sử dụng để hướng dẫn điều trị.

Các xem xét điều trị: Điều trị với cùng các kháng sinh như đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng, do các tác nhân gây bệnh tương tự nhau (mặc dù *H. influenza* tương đối hay gặp hơn). Các virus hô hấp/*C. pneumonia* có thể khởi phát đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn, song sau đó thường dẫn đến nhiễm khuẩn thứ phát gây ra các triệu chứng của bệnh nhân và là mục tiêu của điều trị. Thuốc giãn phế quản hữu ích để điều trị tình trạng co thắt phế quản. Phế cầu kháng macrolid

(Macrolide-resistant *S. pneumoniae*) đặt ra một quan tâm lâm sàng quan trọng (tần suất gặp ≥ 30%).

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng tim - phổi nền của bệnh nhân.

Viêm trung thất

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Xẩy ra sau thủng thực quản hoặc phẫu thuật lồng ngực	Các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng	***Điều trị được ưu tiên lựa chọn:*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/ lần x 2 tuần ***hoặc*** Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần ***Điều trị thay thế:*** Meronem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần.	Amoxicillin/ acid clavulanic 500mg/125mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp * (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Moxifloxacin 400 mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Phim chụp Xquang ngực thường cho thấy có thâm nhiễm quanh rốn phổi trong trường hợp bị viêm trung thất. Tràn dịch màng phổi do thủng thực quản có tăng nồng độ amylase trong dịch tràn.

Lưu ý: Không được bỏ sót tình trạng thủng thực quản trong các viêm trung thất có tràn dịch màng phổi.

Các xem xét điều trị: Cần tiến hành hội chẩn ngoại khoa nếu nghi vấn bệnh nhân bị thủng thực quản.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ, vị trí và thời gian bị thủng thực quản/nhiễm khuẩn trung thất.

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) (*Xem Atlas màu về tiêu bản nhuộm Gram đờm và Chương VIII cho chẩn đoán phân biệt trên hình ảnh Xquang*)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp *	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Không biết rõ tác nhân gây bệnh	Phế cầu *(S.pneumoniae)*[¶] *H. influenzae* Não mô cầu *(N.meningitides)* *M. catarrhalis* *B. pertussis* *Legionella sp.* *Mycoplasma pneumonia* *Chlamydophilia (Chlamydia) pneumoniae*	Quinolon hô hấp[†] (TM) mỗi 24h/lần ***hoặc điều trị kết hợp với*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***kết hợp với với hoặc*** Doxycyclin[‡] (TM) x 1-2 tuần ***hoặc*** Azithromycin 500 mg (TM) mỗi 24h/lần x1- 2 tuần (dùng tối thiểu 2 liều trước khi chuyển sang điều trị theo đường uống)	Quinolon hô hấp[†] (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Doxycyclin [‡] (uống) x 1-2 tuần ***hoặc*** Macrolid [††¶] (uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

* *Các đối tượng bị suy giảm chức năng miễn dịch có thể cần liệu trình điều trị kéo dài hơn.*

† *Moxifloxacin 400mg x 1-2 tuần hoặc Levofloxacin 750mg x 5 ngày (hoặc 500 mg x 1-2 tuần).*

†† *Azithromycin 500mg hoặc Clarithromycin XL 1g.*

¶ *Nên tránh điều trị bằng Macrolid đơn độc ở các vùng có tình trạng phế cầu kháng Macrolid (MRSP) hoặc có phổ biến các chủng phế cầu (S.pneumoniae) đa kháng thuốc (MDRSP).*

‡ *Doxycyclin 200mg (TM hoặc uống) mỗi 12 giờ x 3 ngày, sau đó 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12 giờ x 4-11 ngày.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp*	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị đường uống *hoặc* chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn điển hình	Phế cầu *(S.pneumoniae)*[¶] *H. influenzae* *M. catarrhalis* *B. pertussis*	Doxycylin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg tĩnh mạch mỗi 12h/lần x 11 ngày ***hoặc*** Quinolon hô hấp[†] (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần	Doxycyclin[‡] (TM) x 1-2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Tigecylin** 200mg (TM) x 1liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần	Xem phần (không biết rõ tác nhân gây bệnh) ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic XR 2 viên (uống) mỗi 12h/lần x 7-10 ngày ***hoặc*** Cefprozil 500mg (uống) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần
	*K. pneumoniae**	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ertapenem1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp[§] (TM) mỗi 24 h/lần x 2 tuần	Ceftarolin fosamil *** 600mg (TM) mỗi 12h/lần x 5-7 ngày ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doripenem1g (TM) mỗi 8h/lần[¶¶]	Quinolon hô hấp[§] (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần
	K. pneumonia đa kháng thuốc	Cenftazidin/avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 200 mg[¶] (TM) x 1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần **	Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần[¶] ***hoặc*** Polymycin B 1-1,25 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần[¶¶¥]	Không có phác đồ

* *Các đối tượng bị suy giảm chức năng miễn dịch có thể cần liệu trình điều trị kéo dài hơn.*

† *Moxifloxacin 400 mg x 1-2 tuần hoặc Levofloxacin 750 mg x 5 ngày (hoặc 500 mg x 1-2 tuần).*

§ *Moxifloxacin 400mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

¥ *1mg Colistin =12.500 IU; 1mg Polymycin B = 10.000 IU.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

‡ *Doxycyclin 200mg (TM hoặc uống) mỗi 12 giờ x 3 ngày, sau đó 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần x 4-11 ngày.*

** *Tigecyclin được chỉ định để điều trị các viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do phế cầu (S. pneumonia), H. influenzae và Legionella.*

¶ *Có thể cần dùng liều tigecyclin cao hơn liều thường dùng đối với các trường hợp nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm kháng nhiều thuốc kháng sinh còn nhạy với thuốc.*

¶¶ *Điều trị tới khi chữa khỏi hẳn bệnh.*

*** *Ceftarolin fosamil được chỉ định để điều trị các viêm phổi do vi khuẩn mắc phải từ cộng đồng (CABP) do phế cầu (S. pneumoniae), tụ cầu vàng (chỉ với các chủng tụ cầu phân lập nhạy với methicillin), H. influenzae, K.pneumoniae, K. oxytoca và E. coli gây nên.*

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) (Tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp *	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị đường uống *hoặc* Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn không điển hình *Bệnh lây truyền từ động vật sang người*	*C. psittaci* (bệnh sốt vẹt) *Coxiella burnetii* (bệnh sốt Q) *Francisella tularensis* (bệnh sốt thỏ hay tularemia)	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Quinolon hô hấp† (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12 giờ x 11 ngày ***hoặc*** Quinolon hô hấp† (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Không phải bệnh lây truyền từ động vật sang người	*Legionella sp*‡ Mycoplasma ÷ pneumoniae ‡ *C.pneumoniae* ‡	Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 100mg (TM) x 1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần **	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần x4-11 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần (dùng tối thiểu 2 liều trước khi chuyển sang điều trị theo đường uống)	Quinolon hô hấp† (uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 11 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x 1- 2 tuần ***hoặc*** Clarithromycin XL 1g (uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần
	CMV	Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh		
Cúm (nhẹ hoặc vừa song không có bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do căn nguyên vi khuẩn)	Cúm A *Cúm người* *Cúm mùa* *Cúm lợn* (H_1N_1)	Oseltamivir(Tamiflu) 75mg (uống) mỗi 24h/lần x 5 ngày	Zanamivir (Relenza) 10mg (2 nhát xịt qua đường miệng) mỗi 12h/lần x 5 ngày	Oseltamivir có thể không có hiệu quả điều trị đối với cúm mùa ở người/ cúm gia cầm (H5N1), song dường như thuốc có hiệu quả với cúm lợn (H_1N_1)

* *Các đối tượng bị suy giảm chức năng miễn dịch có thể cần liệu trình điều trị kéo dài hơn.*

† *Moxifloxacin 400mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

‡ *Có thể cần điều trị kéo dài: Đối với nhiễm trung do Legionella (2-3 tuần), Mycoplasma (2 tuần); Chlamydia (2 tuần).*

** *Tigecyclin được chỉ định để điều trị các viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do Legionella.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) (Tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp *	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị đường uống *hoặc* Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cúm (nặng đi kèm đồng thời với viêm phổi cộng đồng) §	Cúm A *Cúm người* *Cúm mùa* *Cúm lợn (H_1N_1)*	Oseltamivir (Tamiflu) 75mg (uống) mỗi 12h/lần x 5 ngày¶ ***kết hợp với hoặc*** Rimantadin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 7-10 ngày¶¶ ***hoặc*** Amantadin 200mg (uống) mỗi 24h/lần x 7-10 ngày ¶¶		Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt nếu có thể được sau khi triệu chứng khởi phát, tốt hơn là trong vòng 2 ngày. Rimantadin/Amantadin không có hoạt tính đối với virus cúm B
Cúm (với viêm phổi do vi khuẩn mắc phải từ cộng đồng xảy ra kế tiếp sau đó)	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae*	Quinolon‡ (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***kết hợp với hoặc*** Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần x 2 tuần **ho**ặc Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***kết hợp với hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Quinolon‡ (uống) mỗi 24/lần x 2 tuần
		Kết hợp với điều trị cúm (***xem trang trước để biết chi tiết***)		
Viêm phổi do thủy đậu	Virus thủy đậu-zona (VZV)	Acyclovir 5-10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x 10 ngày		Valacyclovir 1-2g (uống) mỗi 8h/lần x 10 ngày

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc đường TM+ đường uống.

** Các đối tượng suy giảm chức năng miễn dịch dễ có khuynh hướng bị nhiễm các vi khuẩn như được liệt kê ở trên, song cũng có thể bị nhiễm trùng do các tác nhân gây bệnh thường gặp như ở đối tượng không có bất thường chức năng miễn dịch.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

[¶] *Mặc dù tình trạng đề kháng thường gặp, các thuốc này có thể cải thiện tình trạng oxy hóa máu trong các trường hợp bị nhiễm cúm A nặng khi bệnh nhân cần được hỗ trợ thông khí.*

[‡] *Có thể cần điều trị kéo dài: Đối với nhiễm trùng do Legionella (2-3 tuần), Mycoplasma (2 tuần); Chlamydia (2 tuần).*

[§] *Nếu phim Xquang phổi cho thấy có hình ảnh thâm nhiễm tạo tổn thương hang nhiều và nhanh chóng < 72 giờ, cần bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm kháng sinh đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/ Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) bằng vancomycin, linezolid, ceftarolin hoặc tigecyclin, cùng với điều trị chống cúm.*

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp *	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị đường uống *hoặc* Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Hít vào phổi	Các vi khuẩn kị khí trong khoang miệng Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/ lần x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon [‡] (TM) mỗi 24h/lần x 2tuần	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần x 11 ngày	Quinolon hô hấp[‡] (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12 giờ x 11 ngày** ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic XR 2 viên nén (uống) mỗi 12h/ lần x 2 tuần
Bệnh lao phổi	*M. tuberculosis*	INH 300 mg (uống) mỗi 24 h/lần (và pyridoxin 50 mg (uống) mỗi 24 h/lần) x 6 tháng ***cộng với*** rifampicin 600 mg (uống) mỗi 24 h/lần x 6 tháng ***cộng với*** pyrazinamid 25 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần x 2 tháng ***cộng với*** ethambutol 15 mg/kg (uống) (tới khi biết được tình trạng nhạy của trực khuẩn lao với thuốc được dùng) [††]		
Trực khuẩn lao đa kháng thuốc	*M. tuberculosis*	Bedaquiline (Sirturo) 400 mg (uống) mỗi 24 h/lần (điều trị thuốc cần được giám sát trực tiếp) x 2 tuần, sau đó 200 mg (uống) 3 lần mỗi tuần x 22 tuần *		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Myco-bacteria không phải trực khuẩn lao (lao không điển hình)	*Mycobacterium avium* nội bào *(MAI)*	*Điều trị trong 12 tháng sau khi đờm âm tính với MAI*; Etham-butol 15 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần ***cộng với hoặc*** Clari-thromycin 500 mg (uống) mỗi 12 h/lần ***hoặc*** Azithromycin 500 mg (uống) mỗi 24 h/lần ***cộng với hoặc*** (Rifampin hoặc Rifabutin). Có thể thay rifamycin bằng một quinolon (uống) ‡ mỗi 24 h/lần
	M.kansasii	*Điều trị được ưu tiên chọn dùng*: Rifampicin 600mg (uống) mỗi 24 h/lần ***cộng với*** INH 300 mg (uống) mỗi 24 h/lần ***cộng với*** pyridoxin 50 mg (uống) mỗi 24 h/lần ***cộng với*** Ethambutol 15 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần. Điều trị x 12 tháng sau khi xét nghiệm đờm âm tính. *Điều trị thay thế*: Rifampicin 600mg (uống) x 3 lần/tuần ***hoặc*** hàng ngày ***cộng với*** Ethambutol 15mg/kg (uống) x 3 lần/tuần ***hoặc*** hàng ngày ***cộng với*** clarithromycin 500-1000mg (uống) x 3 lần/tuần ***hoặc*** hàng ngày. Điều trị x 12 tháng sau khi xét nghiệm đờm âm tính.

* *Có thể được sử dụng như một phần của phác đồ điều trị lao bằng nhiều thuốc (> 3 thuốc). Uống thuốc trong bữa ăn. Các tác dụng không mong muốn bao gồm buồn nôn, đau đầu, đau khớp, kéo dài khoảng QTc.*

‡ *Moxifloxacin 400 mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

†† *Nếu phân lập ra nhạy cảm với thuốc, ngừng dùng Ethambutol và tiếp tục dùng các thuốc còn lại như nêu ở trên tới khi hoàn thành 6 tháng điều trị. Nếu vi khuẩn kháng INH, tiếp tục dùng Ethambutol, Rifampicin và Pyrazinamid tới khi hoàn thành 6 tháng điều trị. Nếu thấy có bất kỳ một tình trạng vi khuẩn lao kháng thuốc nào khác, cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc chuyên khoa truyền nhiễm và hô hấp.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp *	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị đường uống *hoặc* Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Người nghiện rượu mạn	*K. pneumoniae* Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Meropenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 200mg (TM) x 1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp‡ (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Quinolon hô hấp (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần
	K.pneumoniae đa kháng thuốc kháng sinh	Ceftazidim/avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 200mg (TM) x 1 liều, sau đó 100 mg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần **	Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x 1-2 tuần¥ ***hoặc*** Polymycin B 1-1,25 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 1-2 tuần¥	Không có
Giãn phế quản, xơ hóa nang	*S.maltophilia* *B.cepacia* *Alcaligenes xyloxidans*	<u>Điều trị được ưu tiên chọn dùng:</u> TMP-SMX 2,5 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần¶ ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần¶ <u>Điều trị thay thế</u>: Doxycyclin100mg (TM) mỗi 12h/lần¶		TMP-SMX viên nén hàm lượng 1SS (uống) mỗi 6h/lần¶ ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần¶ ***hoặc*** quinolon hô hấp‡ (uống) mỗi 24h/lần.
	P. aeruginosa	Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần ¶	Levofloxacin750mg (TM) mỗi 24h/lần¶ ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần¶ ± Amikacin 1g (TM) mỗi 12h/lần¶	Levofloxacin 750 mg (uống) mỗi 24h/lần¶ ***hoặc*** Ciprofloxacin 750 mg (uống) mỗi 12h/lần
	P.aeruginosa đa kháng thuốc	Ceftazidim/avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần¶	Polymycin B 1-1,25 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần¶¥	Không có

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: CO/CA-MRSA (Community-onset/ community- acquired methicillin-resistant *S.aureus*) (***xem trang 23-24***). Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát/mắc phải ở cộng đồng.

Thời gian điều trị biểu diễn tổng thời gian dùng thuốc đường TM, dùng thuốc theo đường uống hoặc thời gian dùng thuốc đường TM + thời gian dùng thuốc đường uống.

* *Các đối tượng bị suy giảm chức năng miễn dịch dễ có khuynh hướng mắc các vi khuẩn gây bệnh như được liệt kê song có thể bị nhiễm khuẩn do các tác nhân gây bệnh thường gặp ở đối tượng là người bình thường.*

[¶] *Điều trị tới khi chữa khỏi bệnh.*

[‡] *Moxifloxacin 400mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

[**] *Tigecyclin được chỉ định để điều trị đối với viêm phổi mắc phải trong công đồng do phế cầu (S.pneumoniae) (còn nhạy cảm với penicillin), H. influenzae (không sinh β -lactamase) và Legionella.*

[¥] *Colistin 1mg = 12.500 đơn vị quốc tế; Polymyxin B 1mg = 10.000 đơn vi quốc tế.*

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) (Tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp *	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Điều trị đường uống *hoặc* Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Điều trị dài ngày bằng steroid [†]	*Aspergillus sp*	Voriconazol (***xem "liều thường dùng" trang 1080***)[¶]	Các dạng bào chế kết hợp với lipid của amphotericin (***trang 821***)[¶] ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) x1 sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần[¶] ***hoặc*** amphotericin B 1-1,5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần[¶] (***trang 437-439***)	Voriconazol (***xem "liều thường dùng" trang 1080***)[¶] ***hoặc*** Posaconazol 200mg mỗi 6h/lần khởi đầu, sau đó 400 mg mỗi 12h/lần khi ổn định[¶] ***hoặc*** Itraconazol 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 ngày sau đó 200mg (uống) mỗi 12h/lần[**¶]
	P. (carinii) jiroveci (viêm phổi do *Pneumocystis carinii*)	TMP-SMX 5mg/kg (TM) mỗi 6 giờ/lần x 3 tuần[‡]	Pentamidin 4mh/kg (TM) mỗi 24h/lần x 3 tuần [‡]	TMP-SMX 5mg/kg (uống) mỗi 6h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Atovaquon 750mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Dapson 100mg (uống) mỗi 24h/lần
	CMV	Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh		
HIV	Các tác nhân gây bệnh đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng điển hình/không điển hình		***Xem trang 89-90***	
	P. (carinii) jiroveci (PCP)		***Xem trang 534***	
Các tác nhân gây bệnh khác	Đối với *Cryptococcus neoformans, Blastomyces, Histoplasma, Coccidiodes, Paracoccidioides, Actinomyces, Nocardia, Pseudallescheria boydii, Sporothrix, Mucor* (***xem trang 438-439***)			

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

¶ *Điều trị tới khi chữa khỏi bệnh.*

† *Điều trị theo đường TM hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống.*

* *Các đối tượng bị suy giảm chức năng miễn dịch dễ có khuynh hướng mắc các vi khuẩn gây bệnh như được liệt kê, song có thể bị nhiễm khuẩn do các tác nhân gây bệnh thường gặp ở đối tượng là người bình thường.*

** *Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

‡ *Liều steroid: prednisolon 40 mg (uống) mỗi 12 h/lần vào ngày 1-5, sau đó 40mg (uống) mỗi 24 h/lần vào ngày 6 -10, sau đó 20 mg (uống) mỗi 24 h/lần vào ngày 11-21. Methylprednisolon (TM) có thể được dùng thay cho prednisolin với liều TM bằng 75% liều prednisolon.*

‡ *Moxifloxacin 400 mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, ho, các triệu chứng hô hấp, phim chụp Xquang phổi phù hợp với viêm phổi. Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng điển hình được biểu hiện chỉ bằng tình trạng viêm phổi mà không có các dấu hiệu ngoài phổi.

Xem xét chẩn đoán: Phân lập được vi sinh vật khi nhuộm Gram đờm/cấy đờm. Cùng vi khuẩn được tìm thấy trong máu nếu kết quả cấy máu dương tính. Xem ***Chương VIII*** cho các hình ảnh Xquang ngực điển hình.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (căn nguyên vi khuẩn điển hình)

Xem xét chẩn đoán: Xét nghiệm đờm sẽ hữu ích nếu chỉ có ưu thế một vi sinh vật duy nhất và bệnh phẩm không bị nhiễm bẩn nước bọt. Đờm mủ, đau ngực kiểu màng phổi, tràn dịch màng phổi là các bằng chứng giúp định hướng ưu tiên tới các tác nhân gây bệnh điển hình.

Lưu ý: Tiến hành chụp Xquang ngực để khẳng định chẩn đoán và loại trừ các tình trạng bệnh lý tương tự không do nhiễm khuẩn gây nên (Vd: suy tim).

Xem xét điều trị: Không được chuyển sang dùng kháng sinh phổ hẹp sau khi phân lập được vi sinh vật trên bệnh phẩm nhuộm Gram/cấy máu. Phát hiện được tác nhân gây bệnh có vai trò quan trọng đối với tiên lượng bệnh và các vấn đề sức khỏe cộng đồng, song không có vai trò trong điều trị. Mức độ nặng của viêm phổi mắc phải từ cộng đồng có liên quan với mức độ rối loạn chức năng tim phổi/miễn dịch và có tác động tới số ngày bệnh nhân cần nằm viện, mà không có ảnh hưởng tới biện pháp điều trị hoặc lựa chọn kháng sinh cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng tim phổi và chức năng của lách.

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (bệnh ho gà)

Biểu hiện lâm sàng: Chảy nước mũi trong vòng 1-2 tuần (giai đoạn viêm xuất tiết) tiến triển sang tình trạng ho kịch phát (giai đoạn kịch phát) kéo dài 2-4 tuần, thường không có tiếng rít đặc trưng khi hít vào (inspiratory whoop), được tiếp theo bằng giai đoạn hồi phục kéo dài 1-2 tuần mà trong giai đoạn này cơn ho kịch phát giảm về tần suất/mức độ nặng. Sốt ở mức độ thấp hoặc không có sốt. Ở trẻ < 6 tháng tuổi, thường không thấy có tiếng rít đặc trưng trong thì hít vào nhưng có thể xảy ra tình trạng ngừng thở. Trẻ lớn hoặc người lớn có thể biểu hiện bằng tình trạng ho dai dẳng (không có tiếng rít đặc trưng khi hít vào) kéo dài 2- 6 tuần.

Xem xét chẩn đoán: Kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (PCR) hoặc kỹ thuật định lượng kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) dương tính với *Bordetella pertussis* từ bệnh phẩm dịch tỵ-hầu. Có thể tiến hành nuôi cấy dịch quết tỵ-hầu trên môi trường Bordet-Gengou bằng cách cố định bệnh phẩm ngay tại giường. Hình "tim xù xì" ("shaggy heart") trên phim chụp Xquang phổi là dấu hiệu đặc trưng. Đây là viêm phổi mắc phải từ cộng đồng duy nhất có tăng bạch cầu lympho > 60%.

Lưu ý: Cần xem xét khả năng bị ho gà ở các trẻ lớn tuổi và người lớn có tình trạng ho kéo dài. Khàn tiếng không thường gặp, song có thể bị chẩn đoán nhầm với viêm thanh quản do virus hoặc do *C.pneumoniae*.

Xem xét điều trị: Ở giai đoạn kịch phát, kháng sinh có tác dụng khiêm tốn trên tiến triển của bệnh, song được chỉ định để làm giảm lây truyền bệnh.

Tiên lượng: Tốt, mặc dù diễn biến bệnh kéo dài.

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (căn nguyên vi khuẩn không điển hình)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với các triệu chứng, dấu hiệu thực thể ngoài phổi hoặc các bất thường cận lâm sàng.

Xem xét chẩn đoán: Được khẳng định bằng các test huyết thanh chẩn đoán đặc hiệu.

Lưu ý: Không thấy có đáp ứng với điều trị bằng beta-lactams gợi ý chẩn đoán

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do căn nguyên gây bệnh không điển hình.

Bệnh Legionnaire hay bệnh của lính Lê Dương (*Legionnaire sp.*)

Vi khuẩn Legionella sống trong môi trường nước ngọt và tồn tại cộng sinh với amip nước ngọt. Nhiễm khuẩn do Legionella có thể được lây truyền vào cơ thể con người qua các giọt nhỏ khí dung (droplet aerosolization) từ các nguồn cấp nước bị nhiễm Legionella (Vd: hệ thống làm mát, hệ thống cấp nước, whirlpools, vòi hoa sen, máy điều hòa nhiệt độ, các thiết bị trị liệu hô hấp). Bệnh của lính Lê-Dương hay bệnh do Legionella có thể xảy ra thành các trường hợp đơn lẻ hoặc trong thành các vụ dịch nhỏ (nhiễm khuẩn mắc phải từ cộng đồng hoặc nhiễm khuẩn bệnh viện). Bệnh do Legionella có khuynh hướng xảy ra theo mùa và rất thường gặp vào mùa thu/đông. Nhiễm khuẩn do Legionella hiếm gặp ở các trẻ nhỏ tuổi, ít thường gặp ở người lớn trẻ tuổi, song thường gặp nhất ở bệnh nhân người lớn/ người cao tuổi. Các đối tượng bị suy giảm miễn dịch trung gian qua tế bào (giảm chức năng tế bào lympho T) là đối tượng dễ bị nhiễm nhất, song các đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường cũng có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn này.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Ở các đối tượng bình thường, viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do Legionella thường biểu hiện nặng nề hơn so với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do *M. pneumoniae* hoặc *C.pneumoniae*. Khởi phát bệnh thường cấp tính, với sốt cao(≥ 39°C) và nhịp tim chậm tương đối. Đau cơ và rét run không phải ít gặp. Cũng giống như các viêm phổi không điển hình khác, bệnh do Legionella được đặc trưng bằng các biểu hiện ngoài phổi của bệnh (***Bảng 2.1***) và đây là chìa khóa để chẩn đoán sơ bộ trên lâm sàng. Trên hình ảnh chụp Xquang phổi, bệnh do Legionella được gợi ý không chỉ bởi hình ảnh của thâm nhiễm phổi có thể biến đổi, mà còn bởi sự tiến triển nhanh và không đối xứng của tổn thương thâm nhiễm này. Trong viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do Legionella, tác động tới cả hai bên phổi thường gặp, tình trạng đông đặc/tràn dịch màng phổi không phải là quá hiếm gặp, nhưng hiếm gặp tổn thương tạo hang. Cần chỉ định làm xét nghiệm tìm Legionella cho các bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng có sốt ≥ 39°C kết hợp với nhịp tim chậm tương đối (nếu họ không dùng verapamil, diltiazem hoặc thuốc chẹn beta hoặc có tình trạng loạn nhịp/block tim), lú lẫn tinh thần, ỉa chảy tóe nước, đau bụng, giảm tương đối bạch cầu lympho, tăng tốc độ lắng hồng cầu/protein phản ứng, tăng nhẹ/tạm thời SGOT/SGPT, giảm sớm/tạm thời nồng độ phospho huyết thanh, tăng nồng độ ferritin (>2 lần giá trị bình thường), tăng CPK và đái máu vi thể.

Xem xét chẩn đoán: Không thấy có đáp ứng với điều trị bằng beta-lactam ở bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng cũng gợi ý cho khả năng bị nhiễm Legionella và cần chỉ định làm xét nghiệm đặc hiệu tìm vi khuẩn ngay

tức khắc. Chẩn đoán được khẳng định bằng kỹ thuật định lượng kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) tìm Legionella trong đờm/chất tiết hô hấp. Hiệu giá IgA đối với Legionella (hiệu giá làm một lần ≥1:256 hoặc tăng ≥4 lần giữa hiệu giá giai đoạn cấp và giai đoạn hồi phục) giúp khẳng định chẩn đoán. Legionella cũng có thể được nuôi cấy trên môi trường thạch agar BCYE từ bệnh phẩm đờm/chất tiết hô hấp, dịch màng phổi hoặc tổ chức phổi. Cũng có thể chẩn đoán được *Legionella pneumophila* (type huyết thanh 01-06) bằng test tìm kháng nguyên trong nước tiểu.

Lưu ý: Do không có dấu hiệu đặc biệt nào đặc trưng cho bệnh, tập hợp các dấu hiệu/triệu chứng của viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do Legionella thường bị bỏ sót và dạng các tác động cơ quan ngoài phổi giúp phân biệt nhiễm khuẩn do Legionella với các nguyên nhân gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng khác. Giảm nồng độ natri máu thường gặp nhưng không đặc hiệu. Giảm nồng độ phospho huyết thanh là một dấu hiệu ít gặp hơn song đặc hiệu hơn trong nhiễm khuẩn do Legionella. Các dấu hiệu gợi ý cho một nguyên nhân gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng khác (không phải do Legionella) bao gồm tăng hiệu giá ngưng kết lạnh, SGOT/SGPT bình thường, nồng độ phospho huyết thanh bình thường, nồng độ CPK bình thường, tác động tới đường hô hấp trên (viêm họng không xuất tiết, viêm thanh quản, viêm tai). Định lượng kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) tìm Legionella trong đờm/chất tiết hô hấp dương tính ở giai đoạn sớm và nhanh chóng trở nên âm tính nhờ điều trị. Xét nghiệm định lượng kháng thể miễn dịch huỳnh quang (IFA), như đối với các vi sinh vật gây bệnh khác, có thể âm tính nếu được chỉ định làm quá sớm (thường vào thời điểm biểu hiện bệnh) và điều trị kháng sinh có thể làm mất/giảm hiệu giá IFA khiến cho việc khẳng định chẩn đoán (bằng huyết thanh học) trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Xét nghiệm tìm kháng nguyên *Legionella* trong nước tiểu rất hữu ích song có các hạn chế, vì test này không phải lúc nào cũng dương tính khi bệnh nhân đến viện cấp cứu và chỉ phát hiện được *Legionella pneumophila* (typ huyết thanh 01-06) mà không phát hiện được các chủng Legionella khác.

Xem xét điều trị: Các thuốc kháng sinh điều trị Legionella có hoạt tính cao là quinolon, doxycyclin và macrolid. Rifampin có hoạt tính chống lại Legionella trên in-vitro, song khi được sử dụng trong điều trị kết hợp (erythromycin + rifampin) lại không chứng minh được là mang lại bất kỳ ưu điểm vượt trội hơn so với khi áp dụng phác đồ điều trị bằng một thuốc (quinolon, doxycyclin). Legionella không đáp ứng với điều trị bằng beta-lactams và chỉ đáp ứng phần nào với erythromycin. Các bệnh nhân được điều trị bằng quinolon, tigecyclin hoặc doxycyclin thường hạ sốt chậm (5–7 ngày). Thường cần điều trị liên tục trong 2–3 tuần tùy thuộc vào mức độ nặng trên lâm sàng/các yếu tố miễn dịch của vật chủ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Ở đối tượng không bị suy giảm miễn dịch với chức năng tim – phổi tốt, tiên lượng thường tốt. Tiên lượng dè dặt ở các đối tượng là người có tuổi bị suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào (nhiễm HIV, ghép tạng, điều trị corticosteroid) và các đối tượng có bệnh tim – phổi nặng (bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản mạn tính).

Viêm phổi do *Mycoplasma pneumoniae*

Dịch tễ học: *M. pneumoniae* tác động chủ yếu đến các đối tượng người lớn trẻ tuổi và người cao tuổi. *M. pneumoniae* được lây truyền từ người sang người qua các giọt nhỏ đường hô hấp.

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh khởi phát bán cấp bằng tình trạng ho không xuất tiết/ho khan đặc trưng kéo dài trong nhiều tuần, sốt mức độ thấp (< 39°C) / ớn lạnh và đau cơ nhẹ. Như với các viêm phổi mắc phải từ cộng đồng viêm phổi mắc phải từ cộng đồng không điển hình khác, *M. pneumoniae* được đặc trưng bằng biểu hiện tác động tới các cơ quan ngoài phổi, có thể bao gồm đau họng (viêm họng không xuất tiết), viêm màng nhĩ căng phồng, viêm phồng màng nhĩ, viêm tai giữa và/hoặc đi ngoài phân lỏng/ỉa chảy (***Bảng 2.1***). Các đặc điểm không ủng hộ cho chẩn đoán bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do *M. pneumoniae* bao gồm sốt cao (> 39°C), nhịp tim chậm tương đối, viêm thanh quản, đau bụng, tăng SGOT/SGPT, nồng độ phospho huyết thanh giảm thấp hoặc có các bất thường thận. Chụp Xquang ngực điển hình cho thấy hình ảnh thâm nhiễm một bên không có ranh giới rõ rệt, không có tràn dịch màng phổi, đông đặc phổi hoặc tổn thương tạo hang ở nhu mô phổi. *M.pneumoniae* có thể biểu hiện như một tình trạng viêm phổi nặng mắc phải từ cộng đồng ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch, người có tuổi và các đối tượng bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn giai đoạn muộn.

Xem xét chẩn đoán: Xét nghiệm chẩn đoán *M. pneumoniae* được khuyến cáo cho các bệnh nhân có biểu hiện ho khan kéo dài không giải thích được bằng nguyên nhân khác, sốt mức độ nhẹ, phân lỏng/đi ngoài phân nước và hình ảnh thâm nhiễm phổi với ranh giới không rõ rệt trên phim Xquang phổi. Hiệu giá ngưng kết lạnh bị tăng lên sớm/và thoáng qua (75%) và cung cấp một chẩn đoán sơ bộ nhanh; Hiệu giá ≥ 1:64 giúp xác định tác nhân gây bệnh là do *M. pneumoniae*. Gia tăng hiệu giá IgM đối với *M. pneumoniae* khi làm theo kỹ thuật ELISA gợi ý tình trạng nhiễm khuẩn cấp, song một gia tăng hiệu giá IgG chỉ dẫn bệnh nhân có phơi nhiễm trong tiền sử; Cũng có thể nuôi cấy được *M.pneumoniae* từ chất tiết đường hô hấp trên môi trường nuôi cấy virus (cần tới 1–2 tuần để virus mọc).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Tình trạng ho khan, không xuất tiết cũng gợi ý một bệnh lý liên quan với bệnh lý liên quan với cúm (ILI) hoặc một nhiễm khuẩn do *C. pneumoniae*. Trước khi gán cho căn nguyên hồng ban đa dạng (*E. multiforme)* do nhiễm trùng *M. pneumoniae* gây ra, cần bảo đảm chắc chắn là tình trạng này không do các nguyên nhân khác gây ra (Vd: do dùng thuốc gây nên). Các đặc điểm không ủng hộ cho chẩn đoán nhiễm khuẩn do *M. pneumoniae* bao gồm nhiệt độ > 39°C, nhịp tim chậm tương đối, tràn dịch màng phổi mức độ vừa/nhiều, đông đặc/tổn thương tạo hang ở nhu mô phổi, đau bụng không giải thích được bằng nguyên nhân khác, tăng SGOT/SGPT hoặc nồng độ phospho huyết thanh thấp. Cần đặt nghi vấn bị nhiễm khuẩn do *M. pneumoniae* ở các bệnh nhân ho mạn tính/hen phế quản mới khởi phát.

Xem xét điều trị: Doxycyclin, macrolid, quinolon hoặc tigecyclin cho đáp ứng lâm sàng nhanh (thường <72 giờ), song tình trạng ho khan của bệnh nhân thường tiếp diễn trong nhiều tuần. Do vi khuẩn Mycoplasma cư trú trên/trong tế bào biểu mô phế quản, cần tiến hành điều trị kháng sinh liên tục trong vòng 2 tuần để loại bỏ tình trạng mang vi khuẩn từ chất tiết dịch họng hầu và làm giảm nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh qua các giọt tiết nhỏ đường hô hấp.

Tiên lượng: Nhiễm khuẩn do *M. pneumoniae* thường là một bệnh nhẹ và tự khỏi ở các đối tượng người lớn trưởng thành có chức năng miễn dịch bình thường. Nhiễm khuẩn do *M. pneumoniae* có thể nặng ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, người lớn tuổi và người có bệnh phổi giai đoạn nặng. Các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn và viêm não-màng não do M.pneumoniae (đau đầu/cứng gáy, rối loạn tâm thần, hiệu giá ngưng kết lạnh rất cao [thường ≥1:1024]) có tiên lượng tốt. *M. pneumoniae* có thể gây biến chứng viêm tủy cắt ngang, mất điều hòa động tác thân não/tiểu não hoặc hội chứng Guillain-Barré. Sau nhiễm khuẩn *M. pneumoniae* một số bệnh nhân xuất hiện tình trạng hen dai dẳng.

Nhiễm khuẩn do Chlamydophilia pneumoniae (bệnh do Chlamydia)

Dịch tễ học: Nhiễm khuẩn *C. pneumoniae* có thể xảy ra như các trường hợp tản phát hoặc như một phần của một vụ dịch bùng phát viêm phổi mắc phải tại một viện dưỡng lão. Nhiễm khuẩn do *C.pneumoniae* được lây truyền từ người này sang người khác qua các giọt nhỏ chất tiết hô hấp. *C.pneumoniae* không có khuynh hướng xảy ra theo mùa. Một số bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do *C. pneumoniae* xuất hiện tình trạng hen kéo dài.

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm khuẩn do *C. pneumoniae* được biểu hiện như

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

một tình trạng bệnh "giống nhiễm khuẩn do mycoplasma" ("mycoplasma-like" illness). Khác với các viêm phổi mắc phải từ cộng đồng không điển hình khác, viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do *C. pneumoniae* được đặc trưng bằng các dấu hiệu ngoài phổi, đặc biệt là chảy nước mũi, đau họng và khàn tiếng (***Bảng 2.1***). Nhiệt độ của bệnh nhân thường ≤ 39°C. Dấu hiệu Xquang ngực điển hình cho thấy có tổn thương thâm nhiễm một bên song không có đông đặc, tổn thương tạo hang hoặc tràn dịch màng phổi. Có khuyến cao chỉ định làm xét nghiệm tìm *C. pneumoniae* cho các bệnh nhân có tình trạng bệnh "giống nhiễm khuẩn do mycoplasma" và có khàn tiếng.

Xem xét chẩn đoán: Để chẩn đoán viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do *C. pneumoniae* đòi hỏi có hiệu giá làm một lần với IgM ≥1:16 hoặc với IgG >1:512 (ELISA hoặc MIF). *C. pneumoniae* có thể nuôi cấy được từ chất tiết hô hấp bằng cách sử dụng môi trường nuôi cấy virus.

Lưu ý: Hiệu giá IgG chỉ dẫn tiền sử phơi nhiễm trước đó mà không phải là tình trạng nhiễm khuẩn mới. Tăng hiệu giá IgM có thể bị chậm lại tới trên 3 tuần sau đó và tăng hiệu giá IgG có thể bị chậm lại tới trên 6 tuần sau đó. Kết quả âm tính giả có thể xảy ra nếu tiến hành xét nghiệm hiệu giá IgM quá sớm. Phát hiện được *C. pneumoniae* từ chất tiết đường hô hấp không giúp phân biệt được người mang với người bị nhiễm khuẩn. Ở một bệnh nhân bị viêm phổi cộng đồng mắc phải có tình trạng khò khè không giải thích được bằng bất kỳ một nguyên nhân nào sẽ là dấu hiệu gợi ý cho khả năng bị nhiễm khuẩn do *C. Pneumoniae.*

Xem xét điều trị: Doxycyclin hoặc quinolon là các thuốc có hiệu quả điều trị. *C. pneumoniae* nhạy cảm với erythromycin trên in-vitro, song thuốc này thường không có hiệu quả với vi khuẩn trên in-vivo. *C. pneumoniae* cũng đáp ứng với các macrolid thế hệ mới hơn.

Tiên lượng: Viêm phổi cộng đồng mắc phải do *C. pneumonia* thường là một viêm phổi mức độ từ nhẹ/vừa với tiên lượng cực kỳ tốt. Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng nặng có thể xảy ra ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch , người cao tuổi hoặc các bệnh nhân bị bệnh phổi giai đoạn nặng, một số trường hợp xuất hiện tình trạng hen vĩnh viễn sau nhiễm khuẩn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 2.1. Các đặc điểm chẩn đoán đối với các viêm phổi không điển hình không thuộc loại bệnh lây truyền từ động vật sang người

Các đặc điểm quan trọng	*Mycoplasma pneumoniae*	Bệnh Legionnaire	*C. pneumoniae*
Triệu chứng			
Rối loạn tâm thần	–[†]	+	–
Đau đầu dữ dội	–	±	–
Hội chứng kích thích màng não	–	–	–
Đau cơ	±	±	±
Đau tai	–	–	±
Đau ngực kiểu màng phổi	–	±	–
Đau bụng	–	±	–
Đi ngoài phân lỏng/ la chảy phân nước	±	±	–
Dấu hiệu thực thể			
Phát ban	±[a]	–	–
Viêm họng không xuất tiết	+	–	+
Ho ra máu	–	+	–
Thở rít	–	–	+
Đông đặc thùy phổi	–	+	–
Tác động tới tim mạch	±[b]	–[c]	–
Lách to	–	–	–
Nhịp tim chậm tương đối	–	+	–

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bất thường cận lâm sàng			
Số lượng bạch cầu	↑ /bình thường	↑	Bình thường
Tăng tiểu cầu cấp tính	±	–	–
Giảm natri máu	–	+	–
Giảm phosphat máu	–	+	–
Tăng AST/ALT (SGOT/SGPT)	–	+	–
Tăng CPK	–		–
Tăng CRP (>30)	–	+	–
Tăng Ferritin (> 2x giá trị bình thường)	–	+	–
Tăng ngưng kết lạnh (≥ 1:64)	+	–	–
Đái máu vi thể	–	±	

Phim Xquang ngực			
Thâm nhiễm phổi	Rải rác thành đám	Rả rác thành đám hoặc đông đặc	Các tổn thương có giới hạn
Hạch rốn phổi hai bên	–	–	–
Tràn dịch màng phổi	± (nhỏ)	±	–

Từ viết tắt- Ký hiệu: ALT= alanine aminotransferase; AST= aspartate aminotransferase; += thường biểu hiện; ±= đôi khi biểu hiện; –= thường không biểu hiện; ↑= tăng; ↓= giảm; ↑↑↑= tăng rõ rệt hay tăng mạnh.

[a]: hồng ban đa dạng; [b]: viêm cơ tim, block tim hoặc viêm màng ngoài tim; [c]: trừ khi viêm nội tâm mạc.

[†]: *rối loạn tâm thần khi có viêm não-màng não.*

[††]: *Thường không (+) sớm, song kháng nguyên trong nước tiểu tồn tại kéo dài nhiều tuần; Hữu ích chỉ đối với chẩn đoán L. pneumophila (nhóm huyết thanh 01-06), song không có giá trị đối với các chủng/ nhóm huyết thanh chẩn đoán khác.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi không điển hình thuộc loại bệnh lây truyền từ động vật sang người (*xem Chương VIII về chẩn đoán phân biệt dựa trên dạng hình ảnh Xquang phổi*)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Các tác nhân gây bệnh lâytruyền từ động vật sang người (vectơ của loại bệnh lây truyền từ động vật sang người)	*C. psittaci* (bệnh sốt vẹt *[Psitacosis]*) *Coxiella burnetii* (bệnh sốt Q) *Francisella tularensis* (bệnh sốt thỏ hay bệnh tularemia)	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần x 11 ngày	Levofloxacin 500mg (TM) x 2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) x 2 tuần	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 11 ngày† ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) x 2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (uống) x 2 tuần

Thời gian điều trị biểu diễn tổng thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch, điều trị theo đường uống hoặc điều trị theo đường tĩnh mạch + điều trị theo đường uống.

**Các đối tượng bị suy giảm chức năng miễn dịch có thể cần liệu trình điều trị kéo dài hơn.*

†*Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với các dấu hiệu và triệu chứng ngoài phổi hoặc các bất thường cận lâm sàng (***Bảng 2.2***).

Xem xét chẩn đoán: Tiền sử tiếp xúc với các động vật chim-thú là thông tin quan trọng trong định hướng chẩn đoán: Bệnh sốt vẹt (psittacosis) (vẹt và các loại chim họ vẹt); bệnh sốt Q (Q-fever) (cừu, mèo chửa); bệnh Tularemia hay bệnh sốt thỏ (thỏ, hươu nai). Chẩn đoán được khẳng định bằng test huyết thanh học đặc hiệu. Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng thuộc loại bệnh lây truyền từ động vật sang người với lách to/nhịp tim chậm tương đối gợi ý sốt Q hoặc bệnh sốt vẹt.

Lưu ý: Vi sinh vật gây bệnh khó/nguy hiểm để nuôi cấy trong phòng xét nghiệm. Không tiến hành nuôi cấy tác nhân gây bệnh. Sử dụng test huyết thanh học để chẩn đoán. Chẩn đoán bệnh sốt Q cấp tính bằng cách chứng minh có gia tăng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hiệu giá IgG đối với *C. burnetii* (phase II). Hầu hết các bệnh nhân bị sốt Q cấp tính không tiến triển thành bệnh mạn tính, Vd: viêm nội tâm mạc bán cấp do sốt Q. Chẩn đoán sốt Q mạn tính đặt ra khi chứng minh được có tình trạng gia tăng hiệu giá IgG (phase I) ≥1:1024 vào tháng thứ 6 sau khi bị sốt Q cấp tính.

Xem xét điều trị: Viêm nội tâm mạc do sốt Q đòi hỏi phải được điều trị dài ngày.

Tiên lượng: Tốt, ngoại trừ đối với sốt Q có biến chứng, Vd: viêm cơ tim, viêm nội tâm mạc bán cấp.

Bảng 2.2. Các đặc điểm chẩn đoán đối với các viêm phổi không điển hình thuộc loại bệnh lây truyền từ động vật sang người

Các đặc điểm quan trọng	Bệnh sốt vẹt (Psittacosis)	Bệnh sốt Q	Bệnh Tularemia
Triệu chứng			
Rối loạn tâm thần	–	±	–
Đau đầu dữ dội	+	+	+
Hội chứng kích thích màng não	–	–	–
Đau cơ	+	+	+
Đau tai	–	–	–
Đau kiểu màng phổi	±	±	+
Đau bụng	–	–	–
Ỉa chảy	–	–	–

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dấu hiệu thực thể			
Phát ban	±[a]	–	–
Viêm họng không xuất tiết	–	–	±
Ho ra máu	–	–	±
Đông đặc thùy	+	+	+
Biểu hiện tim	±[b]	±[c]	–
Lách to	±	+	–
Nhịp tim chậm tương đối	±	±	–
Phim Xquang ngực			
Tổn thương thâm nhiễm phổi	Đông đặc phổi rải rác mảng	Thâm nhiễm "tròn" hoặc đông đặc phổi	Các "thâm nhiễm phổi hình trứng"
Hạch rốn phổi hai bên	–	–	±
Tràn dịch màng phổi	–	–	Máu
Bất thường cận lâm sàng			
Số lượng bạch cầu	↓	↑/bình thường	↑/bình thường
Tăng tiểu cầu cấp tính	–	+	–
Giảm natri máu	±	±	±
Giảm phosphat máu	–	–	–
Tăng AST/ALT (SGOT/ SGPT)	+	+	–
Tăng ngưng kết lạnh	–	±	–
Kháng thể kháng cơ trơn	–	±	–
Đái máu vi thể	–	–	–

Từ viết tắt-Ký hiệu: ALT = alanine aminotransferase; AST = aspartate aminotransferase; += thường biểu hiện; ± =đôi khi biểu hiện; –= thường không biểu hiện; ↑= tăng; ↓= giảm; ↑↑↑ = tăng rõ rệt hay tăng mạnh.

[a]: Các đốm Horder (Horder's spots) là các đốm trên mặt, gần giống với hồng ban ở bụng của sốt thương hàn (rose spots); [b]: viêm cơ tim; [c]: viêm nội tâm mạc.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nhiễm trùng thuộc loại bệnh lây nhiễm từ động vật sang người (hội chứng viêm đường hô hấp cấp nặng [SARS])

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, ho khan, đau cơ, ỉa chảy ở một số bệnh nhân. Nghe phổi giống như cúm do virus (tức là phổi im lặng, không có rale). Nhiễm khuẩn hai pha (biphasic infection): sốt giảm xuống sau vài ngày, bệnh nhân cải thiện, sau đó sốt tái phát trong một vài ngày và bệnh nhân trở nên có tình trạng thở nhanh-nông/giảm nồng độ oxy máu. Phim chụp Xquang phổi cho thấy có tình trạng thâm nhiễm kẽ (lan tỏa) hai bên phổi. Số lượng bạch cầu và tiểu cầu thường bình thường hoặc giảm nhẹ. Giảm bạch cầu lympho tương đối xuất hiện sớm. Thường gặp tăng nhẹ SGOT/ SGPT, LDH, CPK.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phân lập được virus hoặc test huyết thanh học đặc hiệu với SARS dương tính. Điều quan trọng là cần loại trừ nhiễm cúm A, bệnh do Legionella và viêm phổi tularemia (tularemic pneumonia).

Lưu ý: Không được lẫn với nhiễm cúm do virus (tình trạng bệnh lý kéo dài 3 ngày). Các bệnh nhân bị SARS diễn biến nặng lên vào tuần thứ 2 là thời gian mà bệnh nhân cúm đang trong giai đoạn hồi phục. Vào giai đoạn sớm, phim chụp Xquang phổi của bệnh nhân SARS có các thâm nhiễm rải rác và thâm nhiễm phổi có thể có hình oval (khác với cúm trừ khi bệnhnhân có tình trạng viêm phổi mắc phải từ cộng đồng thêm vào). Ở giai đoạn muộn, phim chụp Xquang phổi có biểu hiện hình ảnh ARDS.

Xem xét điều trị: Hầu hết các bệnh nhân có tình trạng giảm oxy hóa máu nặng và cần được thở oxy /hỗ trợ thông khí. Trong một nghiên cứu bộ, một số bệnh nhân có diễn biến tốt hơn khi được chỉ định dùng corticosteroid (methylprednisolon liều tấn công 500mg (TM) mỗi 24/lần ×3 ngày sau đó giảm dần liều/chuyển sang dùng prednison (uống) tới tổng thời gian điều trị 20 ngày) kết hợp với Interferon alfacon-1 (9 µg (tiêm dưới da) mỗi 24h/lần × tối thiểu 2 ngày, tăng liều tới 15 µg/ngày nếu không đáp ứng) ×8 đến 13 ngày. Ribavirin không cho thấy có hiệu quả điều trị.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng miễn dịch/chức năng tim phổi nền và tình trạng ARDS. Tử vong thường gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hội chứng hô hấp Trung Đông (Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện như một tình trạng bệnh lý giống cúm (ILI) với khởi phát cấp tính bằng sốt, rét run, ho khan/thở nhanh nông, đau cơ ± buồn nôn/nôn/tiêu chảy. Thường gặp đau đầu/ đau họng. Ho ra máu gặp trong một số trường hợp. Tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh /ARDS là bệnh cảnh lâm sàng điển hình (~ 1 tuần). Số lượng tế bào bạch cầu đa nhân trung tính thường bình thường, giảm số lượng tiểu cầu, tăng men gan (SGOT/SGPT), tăng LDH, giảm tương đối số lượng bạch cầu, song có thể gặp tăng bạch cầu lympho ở một số trường hợp khác. Phim chụp Xquang ngực: tổn thương thâm nhiễm ở vùng đáy phổi một bên (giai đoạn khởi đầu) hoặc các tổn thương thâm nhiễm dạng nốt/kẽ phổi đậm đặc cả hai bên (giai đoạn muộn hơn). Hình ảnh động đặc phổi thường gặp ± tràn dịch màng phổi.

Xem xét chẩn đoán: Về mặt lâm sàng, MERS giống như tình trạng bệnh lý giống cúm (ILI) (khác với bệnh SARS do Coronavirus [SARS-CoA]). Tiếp xúc với lạc đà một bướu (ổ chứa tự nhiên MERS). Chẩn đoán bằng kỹ thuật PCR thời gian thực (RT-PCR) tìm virus CoA gây MERS (MERS-CoA virus) trong chất tiết đường hô hấp (đường hô hấp dưới > đường hô hấp trên), song không thấy virus trong phân/ nước tiểu (khác với coronavirus gây bệnh SARS [SARS-CoA]).

Lưu ý: Biểu hiện lâm sàng giống như nhiễm cúm A nặng. Bệnh không diễn biến 2 pha (như đối với SARS-CoA).

Xem xét điều trị: Thông khí hỗ trợ cho bệnh nhân, song hiện chưa có biện pháp điều trị hữu hiệu nào. Không có tình trạng đồng nhiễm trùng do vi khuẩn, tức là không cần dùng kháng sinh để điều trị các viêm phổi mắc phải từ cộng đồng chồng thêm vào hội chứng MERS-CoV. Các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng đóng vai trò quan trọng để dự phòng lan truyền bệnh trong bệnh viện/ lây từ người sang người.

Tiên lượng: Tỷ lệ tử vong cao với tình trạng ARDS/ suy hô hấp tiến triển nhanh nhất là khi bệnh nhân có các bệnh lý nội khoa đi kèm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cúm gia cầm (Cúm A [H5N1, H7N9])

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm cúm sau khi tiếp xúc gần với gia cầm bị nhiễm bệnh. Tại châu Á gần đây có các vụ dịch bùng phát ở người. Lây truyền bệnh từ người sang người đã được báo cáo. Thường gặp, tình trạng bệnh lý bệnh hô hấp bùng phát tiếp theo nhanh bằng ARDS/tử vong.

Xem xét chẩn đoán: Thường khởi phát cấp tính với tình trạng bệnh lý cúm nặng ± la chảy/xung huyết kết mạc với giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, tăng nhẹ transaminase huyết thanh và tăng LDH. Chẩn đoán bằng kỹ thuật PCR thời gian thực đặc hiệu hemagglutin (hemagglutin-specific RT-PCR) với cúm gia cầm hoặc nuôi cấy chất tiết đường hô hấp.

Lưu ý: Mặc dù cúm gia cầm do virus cúm A gây nên, test huyết thanh học ức chế hemagglutinin (the hemagglutinin inhibition serological test) được sử dụng để chẩn đoán nhiễm cúm A không nhạy đối với hemagglutinin gia cầm, cho kết quả test âm tính.

Xem xét điều trị: Phải cho thuốc kháng virus sớm mới có hiệu quả. Các chủng cúm gia cầm có thể kháng lại với oseltamivir và amantadin/rimantadin. Liều oseltamivir 150mg có thể hiệu quả hơn liều 75mg. Ngay cả khi bị kháng nên cho bệnh nhân dùng amantadin/rimantadin để làm tăng tình trạng giãn đường dẫn khí ngoại biên/ cải thiện tình trạng oxy hóa máu của bệnh nhân.

Tiên lượng: Bệnh thường bùng phát với tình trạng ARDS/tử vong. Khác với bệnh cúm mùa ở người/cúm lợn, cúm gia cầm thường gây tử vong nhanh với tỷ lệ tử vong cao, song không có biến chứng viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cúm mùa/cúm người (virus cúm typ A/B)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt, đau đầu, đau cơ/ đau khớp, đau họng, mệt lả, ho khan. Đau cơ được thấy rõ nhất ở vùng thắt lưng thấp/ hai chân. Đau mắt thường gặp. Sốt cao, nhanh lúc khởi đầu, sau đó sốt giảm đi trong vòng 2-3 ngày. Mức độ nặng của bệnh biến đổi từ tình trạng cúm nhẹ tới viêm phổi nặng đe dọa tính mạng bệnh nhân. Phim Xquang phổi trong giai đoạn sớm của cúm hoàn toàn bình thường/gần như bình thường mà không có thâm nhiễm thùy/ phân thùy phổi hoặc tràn dịch màng phổi.

Xem xét chẩn đoán: Các trường hợp nhẹ với đau đầu, đau họng và chảy nước mũi giống như cảm lạnh thông thường/nhiễm virus đường hô hấp (tình trạng

bệnh giống cúm) và có thể do virus cúm các typ A hoặc B gây nên. Tình trạng cúm nặng thường do virus cum typ A gây nên. Chẩn đoán nhanh bằng kỹ thuật định lượng kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) chất tiết đường hô hấp (bệnh phẩm dịch quết tỵ-hầu). Virus cúm có thể được nuôi cấy trên môi trường nuôi cấy virus từ các chất tiết hô hấp và định typ virus.

Lưu ý: Viêm phổi do cúm không có biểu hiện dấu hiệu gì khi nghe phổi và hình ảnh Xquang phổi bình thường/gần bình thường. Viêm phổi nặng do cúm đi kèm với tình trạng rối loạn khuếch tán oxy (tăng chênh lệch nồng độ oxy máu động mạch-phế nang) và bệnh nhân trong tình trạng giảm oxy máu/xanh tím. Bệnh nhân có thể bị đau ngực kiểu màng phổi. Cúm có thể tấn công tới các cơ liên sườn gây nhầm lẫn với đau ngực kiểu màng phổi. Các thâm nhiễm trên phim Xquang phổi trong viêm phổi do virus chỉ dẫn có viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do vi khuẩn xảy ra đồng thời /tiếp sau khi bị cúm. Nếu viêm phổi mắc phải từ cộng đồng biểu hiện như một viêm phổi hoại tử nặng/bùng phát ở một đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường cần khai thác tiền sử bị viêm phổi do cúm trước đó hoặc xảy đồng thời.

Xem xét điều trị: Cúm nhẹ vừa có thể được điều trị bằng thuốc ức chế neuraminidase (Tamiflu/Relenza) và thuốc giúp làm thuyên giảm triệu chứng sau 1-2 ngày. Bắt đầu điều trị trong vòng 2 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Giảm liều Tamiflu xuống 75 mg (uống) mỗi 48h/lần khi độ thanh thải creatinin của bệnh nhân là 10–30 mL/phút. Nói chung, không khuyến cáo sử dụng Relenza cho các bệnh nhân có bệnh hen/bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (do thuốc làm gia tăng nguy cơ co thắt phế quản) và nên ngừng dùng thuốc nếu xảy ra co thắt phế quản hoặc chức năng hô hấp của bệnh nhân bị suy giảm nhanh. Đối với viêm phổi/cúm nặng, điều trị bằng rimantadin hoặc amantadin do các thuốc này có thể làm tăng khả năng oxy hóa máu/giãn đường dẫn khí ngoại biên. Giảm liều rimantadin xuống 100mg (uống) mỗi 24h/lần ở các bệnh nhân có tuổi, rối loạn chức năng gan nặng hoặc CrCl < 10 mL/phút. Cúm đi kèm đồng thời với viêm phổi do vi khuẩn mắc phải từ cộng đồng thường do tụ cầu vàngnhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA), trong khi viêm phổi mắc phải từ cộng đồng xảy ra kế tiếp sau cúm thường do phế cầu (*S. pneumoniae)* hoặc *H. influenzae* gây ra (***xem trang 120***).

Tiên lượng: Tốt đối với các trường hợp cúm nhẹ/vừa. Cúm nặng có thể gây tử vong do viêm phổi bởi virus cúm (*Influenza pneumonia*) với giảm nồng độ oxy máu trầm trọng. Tiên lượng xấu nếu có biểu hiện nhiễm khuẩn đồng thời do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA). Cúm kết hợp với viêm phổi hoại tử mắc phải từ cộng đồng do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) thường gây tử vong. Tiên lượng rất tồi đối với các trường hợp viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do tụ cầu vàng kháng methicillin

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thuộc chủng (+) với Panton-Valentine Leukocidin (PVL). Ho khan/mệt mỏi có thể tiếp diễn kéo dài nhiều tuần lễ sau khi hết cúm.

Bảng 2.3. Ba bệnh cảnh lâm sàng của viêm phổi do cúm A ở người lớn

Đặc trưng lâm sàng vào thời điểm khởi phát viêm phổi	Mức độ nặng	Tác nhân gây bệnh thường gặp
• Viêm phổi do cúm (***không có tổn thương thâm nhiễm thùy/ thành ổ***)	Nhẹ → hiếm khi tử vong	Cúm (người, lợn†)
• Viêm phổi do cúm ***cộng với*** viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do vi khuẩn (***với các tổn thương thâm nhiễm nhanh chóng tạo nhiều hang***)	Nặng → thường tử vong nhanh	Cúm (người, lợn song không phải là cúm gia cầm) kết hợp với nhiễm khuẩn tụ cầu nhạy với methicillin /viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do tụ cầu vàng kháng methicillin (MSSA/ CA-MRSA)*
• Viêm phổi do cúm ***cộng với*** viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do vi khuẩn (***xảy ra tiếp theo những tổn thương thâm nhiễm thùy phổi/thành ổ không tạo hang*** (*sau ~một tuần cải thiện*)	Nhẹ/vừa → Hiếm khi tử vong (trừ khi có bệnh lý tim-phổi nền/suy giảm miễn dịch)	Phế cầu (*S. pneumoniae*), *H. influenzae*

† *Cúm gia cầm (H5N1) thường gây tử vong nhanh ở người lớn trẻ tuổi/khỏe mạnh.*

* *Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng có PLV (+) (CA-MRSA PVL + strains) thường có độc tính / dễ gây tử vong.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi do cúm lợn (H1N1)

Biểu hiện lâm sàng: Cúm lợn (H1N1) có thể có biểu hiện thay đổi từ tình trạng bệnh nhẹ với sốt, ho và phân lỏng/ỉa chảy tới viêm phổi nặng do virus đòi hỏi phải được hỗ trợ thông khí và tình trạng suy hô hấp này có thể tiến triển nhanh thành hội chứng ARDS/tử vong. Do biểu hiện lâm sàng giống như cúm mùa ở người, các bệnh nhân bị viêm phổi do cúm lợn (H1N1) , cũng như các viêm phổi do virus khác thường có biểu hiện bệnh lý giống cúm. Khác với cúm mùa ở người, viêm phổi do cúm lợn tác động chủ yếu đến người lớn khỏe mạnh trẻ

tuổi. Cũng như cúm mùa ở người, virus H1N1 có thể tác động tới trẻ em, phụ nữ có thai và người có tuổi có kèm các bệnh lý nội khoa. Ở người lớn được nhập viện, viêm phổi do cúm lợn điển hình sẽ được biểu hiện bằng sốt cao >39°C thường có kèm với rét run và đau cơ. Bệnh nhân cũng có thể than phiền bị đau đầu hoặc đau họng. Ho khan là biểu hiện đặc trưng song tình trạng ho xuất tiết nhẹ với đờm nhầy cũng thường gặp. Bệnh nhân có tình trạng thở nhanh-nông. Viêm xung huyết đỏ kết mạc hiếm gặp. Phổi nghe không có rales. Bệnh nhân thường đi ngoài phân lỏng/ỉa chảy song không bị đau bụng. Viêm phổi do cúm lợn (H1N1) có biểu hiện lâm sàng giống như tình trạng cúm mùa ở người, cúm gia cầm, viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do CMV hoặc Adenovirus. Chụp Xquang phổi ở giai đoạn sớm (< 48 giờ) thường cho thấy hình ảnh phổi bình thường hoặc có thể hình ảnh mờ đậm hai đáy phổi giống như xẹp phổi vùng đáy phổi. Chụp Xquang phổi ở giai đoạn muộn hơn (> 48 giờ) điển hình sẽ cho thấy thâm nhiễm kẽ rải rác hai bên. Tình trạng đông đặc phổi có thể xảy ra ở giai đoạn muộn hơn, song các tổn thương tạo hang hoặc tràn dịch màng phổi mức độ vừa/nhiều không phải dấu hiệu đặc trưng thường gặp. Mức độ giảm nồng độ oxy máu có liên quan với mức độ nặng của viêm phổi. Ở người lớn, các bằng chứng cận lâm sàng không đặc hiệu bao gồm giảm tương đối số lượng bạch cầu lympho không giải thích được bằng các nguyên nhân khác, giảm tiểu cầu, tăng CPK hoặc tăng nhẹ transaminase huyết thanh(SGOT/SGPT). Ở bệnh nhân người lớn không gặp các tế bào bạch cầu lympho không điển hình. Khác với cúm mùa ở người và cúm gia cầm (H_5N_1), giảm bạch cầu không thường gặp trong viêm phổi do cúm lợn (H1N1) ở người lớn. Nồng độ LDH huyết thanh lúc tăng lúc không. Hiệu giá ngưng kết lạnh không tăng. Lây nhiễm trong bệnh viện có thể xảy ra.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán xác định bằng kỹ thuật PCR thời gian thực đối với chất tiết đường hô hấp/phổi/chất tiết họng hầu. Test sàng lọc chẩn đoán nhanh cúm (Rapid influenza diagnostic screening tests [RIDTs]), nếu dương tính, có mối tương quan tốt với kết quả dương tính khi sử dụng kỹ thuật PCR thời gian thực. Tuy vậy, khoảng 30% test sàng lọc chẩn đoán nhanh cúm này có kết quả âm tính giả. Vì vậy, kết quả RIDTs âm tính không loại trừ nhiễm cúm lợn (H1N1). Test tìm virus hô hấp kháng thể huỳnh quang có thể dương tính hoặc âm tính. Các kết quả test trái ngược nhau khi sử dụng test chẩn đoán nhanh cúm A, bộ test tìm virus hô hấp kháng thể huỳnh quang (respiratory FA viral panel) và kỹ thuật RT-PCR có thể do tính thay đổi giữa các mẫu bệnh phẩm hơn là do sự khác biệt về độ nhạy/độ đặc hiệu của test được áp dụng. Tất cả các test chẩn đoán có thể âm tính ở một số trường hợp viêm phổi do cúm lợn (H1N1) được xác nhận khi mổ tử thi, song phổi của các bệnh nhân này có kết quả RT-PCR dương tính với H1N1.

Lưu ý: Do viêm phổi do cúm lợn (H1N1) được biểu hiện như một bệnh lý liên

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

quan với cúm, cần thận trọng để loại trừ các viêm phổi do virus khác cũng như các tình trạng có bệnh cảnh lâm sàng gần giống với viêm phổi do virus. Trong các vụ dịch do cúm lợn (H1N1), sai lầm chẩn đoán thường gặp nhất là thừa nhận rằng một kết quả test sàng lọc chẩn đoán nhanh cúm (RIDT) âm tính cũng dự đoán là kết quả xét nghiệm RT-PCR với H1N1 cũng âm tính. Ở người lớn mắc có tình trạng bệnh lý giống cúm và test sàng lọc chẩn đoán nhanh cúm (RIDTs) âm tính, các tiêu chuẩn lâm sàng hữu ích giúp để nhận biết viêm phổi do cúm lợn (H1N1) (***Bảng 2.3***). Chụp Xquang phổi rất quan trọng để phát hiện các trường hợp có thể nhầm lẫn với cúm lợn. Trong khi cúm mùa ở người có thể được biểu hiện đồng thời với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) hoặc kế tiếp sau một khoảng thời gian (5–7 ngày) cải thiện triệu chứng đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do phế cầu (*S. pneumoniae)* hoặc *H. influenzae*, thì điều này không thường gặp đối với viêm phổi do cúm lợn (H1N1) và không phải là một biến chứng của viêm phổi do cúm gia cầm (H5N1). Hình ảnh của viêm phổi do cúm lợn (H1N1) trên phim chụp Xquang ngực được biểu hiện lúc đầu bằng hai trường phổi sáng, được tiếp theo bằng các tổn thương thâm nhiễm rải rác hai bên phổi. Ngưng kết tố lạnh và các bạch cầu lympho không điển hình có thể gặp ở bệnh nhân nhi song ở người lớn các dấu hiệu này sẽ gợi ý cho chẩn đoán khác, Vd: viêm phổi do adenovirus hoặc CMV. Tất cả các test chẩn đoán đối với viêm phổi do cúm lợn (H1N1) có thể âm tính. Ở một số trường hợp viêm phổi do cúm lợn (H1N1) được xác nhận khi mổ tử thi có các test chẩn đoán âm tính, song các trường hợp này có kết quả RT-PCR dương tính với H1N1 trong phổi.

Xem xét điều trị: Cúm lợn (H1N1) dường như đáp ứng với oseltamivir. Steroid không mang lại lợi ích gì cho bệnh nhân. Mặc dù amantadin hoặc rimantadin không có hiệu quả điều trị đối với cúm lợn (H1N1), các bệnh nhân có tình trạng giảm oxy hóa máu nặng có thể có được lợi ích khi điều trị bằng amantadin hoặc rimantadin do thuốc làm tăng tình trạng giãn đường thở ngoại biên/oxy hóa máu. Nếu hình ảnh chụp Xquang phổi trong viêm phổi do cúm lợn (H1N1) không thấy có tổn thương thâm nhiễm thùy/ổ khu trú, không cần phải điều trị bằng kháng sinh theo kinh nghiệm. Viêm phổi do cúm lợn (H1N1) với nhiều thâm nhiễm thùy/ổ khu trú và nhanh chóng tạo tổn thương hang (< 72 giờ) nên tiến hành điều trị theo kinh nghiệm kháng sinh chống tụ cầu vàng nhạy với methicillin/ tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (MSSA/ CA-MRSA) cùng với oseltamivir. Đối với các bệnh nhân bị viêm phổi do cúm lợn (H1N1) đã có cải thiện và lại vào viện cấp cứu sau 5–7 ngày với tổn thương thâm nhiễm ở thùy phổi/phân thùy phổi khu trú (không tạo hang), cần được điều trị như đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do vi khuẩn điển hình bao phủ cả tác nhân gây bệnh là phế cầu (*S. pneumoniae)* hoặc *H. influenzae.*

Ở các bệnh nhân không thể sử dụng oseltamivir bằng đường uống, có thể cho

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

dùng peramivir tĩnh mạch. (***Xem trang 1016 để biết khuyến cáo liều dùng***).

Tiên lượng: Ở bệnh nhân người lớn có chức năng miễn dịch bình thường, tiên lượng có liên quan với mức độ nặng của viêm phổi do cúm lợn. Với cúm lợn (H1N1), tiên lượng có liên quan trực tiếp với mức độ nặng của viêm phổi (có liên quan với tình trạng rối loạn khuếch tán oxy) tức là với mức độ/thời gian bị giảm nồng độ oxy máu nặng. Tiên lượng xấu nhất khi bệnh nhân đồng thời bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin, song không quá tồi đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng xảy ra kế tiếp do *S. pneumoniae* hoặc *H. influenzae*.

Bảng 2.4. Chẩn đoán lâm sàng nhanh viêm phổi do cúm lợn (H1N1) ở bệnh nhân người lớn nhập viện với test chẩn đoán nhanh cúm(RIDTs) âm tính: Bộ ba chẩn đoán cúm lợn.

Chẩn đoán viêm phổi do cúm lợn (H1N1) có thể đặt ra (các tiêu chuẩn lâm sàng)	
Tình trạng bệnh lý giống cúm (ILIs) với ho khan, nhiệt độ >39°C + đau cơ với phim Xquang phổi không có thâm nhiễm thành ô khu trú/ thâm nhiễm phân thùy phổi với test sàng lọc chẩn đoán nhanh cúm (RIDTs*) âm tính *kết hợp với* bất kỳ 3 trong số các dấu hiệu sau[§] :	
• Giảm tương đối số lượng bạch cầu lympho [†] • Giảm số lượng tiểu cầu [†]	• Tăng SGOT/SGPT [†] • Tăng CPK [†]

* *Test chẩn đoán(-) đối với các tác nhân gây bệnh là các virus khác gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CMV, SARS, hội chứng phổi do Hanta virus (HPS), virus hợp bào hô hấp (RSV), metapneumoviruses, parainfluenza viruses, adenoviruses).*

§ *Biểu hiện trong vòng 3 ngày đầu nhập viện.*

† *Không có một nguyên nhân khác giải thích.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi do hít vào phổi (Aspiration Pneumonia)

Xem xét chẩn đoán: Đờm không giúp chẩn đoán. Không cần nuôi cấy dịch hút xuyên khí quản.

Lưu ý: Vị trí thùy phổi tổn thương thay đổi tùy theo tư thế của bệnh nhân trong khi hít các chất tiết vào phổi.

Xem xét điều trị: Các vi khuẩn kị khí trong khoang miệng nhạy cảm với tất cả các beta-lactam và hầu hết các khác sinh được sử dụng để điều trị. Không cần thiết bao phủ thêm kháng sinh điều trị vi khuẩn kị khí (*B. fragilis*).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của bệnh lý thần kinh trung ương/thực quản.

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở bệnh nhân nhiễm HIV (trực khuẩn lao trong đờm âm tính) (đối với viêm phổi do PCP *xem trang 534*)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do căn nguyên vi khuẩn ở bệnh nhân nhiễm HIV với các tổn thương thâm nhiễm khu trú + CD_4 bình thường/giảm nhẹ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/nuôi cấy đờm ± cấy máu dương tính (tác nhân gây bệnh là vi khuẩn) hoặc test huyết thanh học chẩn đoán đối với Legionella/Chlamydia (tác nhân gây bệnh là vi khuẩn không điển hình). Phế cầu (*S. pneumoniae)* và *H. influenzae* đặc biệt thường gặp.

Lưu ý: Biểu hiện Xquang phổi không điển hình không phải là quá hiếm gặp. Điều trị hội chứng chứng viêm phổi mà không phải điều trị dấu hiệu Xquang ngực . Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do vi khuẩn (thâm nhiễm khu trú/phân thùy phổi) ở bệnh nhân HIV không giống với nhiễm khuẩn do PCP (thâm nhiễm kẽ rải rác hai bên phổi). Viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* được biểu hiện bằng tình trạng giảm nồng độ oxy máu nặng và tăng LDH/tăng β-glucan.

Xem xét điều trị: Cần loại trừ viêm phổi do trực khuẩn lao /do Mycobacterium avium nội bào (MAI) bằng nhuộm đờm tìm trực khuẩn kháng cồn-toan (AFB) âm tính. Nếu AFB âm tính, điều trị như đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do căn nguyên vi khuẩn ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường.

Tiên lượng: Giống như đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do căn nguyên vi khuẩn ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi do trực khuẩn lao (Tuberculous pneumonia)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với một tổn thương thâm nhiễm duy nhất/ nhiều tổn thương thâm nhiễm ở phổi.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy/phết lam kính nhuộm tìm trực khuẩn kháng cồn-toan trong đờm. Phân lập được trực khuẩn lao từ chất tiết hô hấp rất quan trọng. Nhiễm lao tiên phát thường xảy ra ở thùy dưới của phổi và thường kết hợp với tràn dịch màng phổi. Tái hoạt động của trực khuẩn lao thường xảy ra ở hai bên/đỉnh phổi ± các tổn thương cũ, phức hợp Ghon đã lành sẹo; tổn thương hang/xơ hóa thường gặp, song hạch to hoặc tràn dịch màng phổi không thường gặp. Tình trạng tái hoạt động của trực khuẩn lao tăng lên ở các đối tượng dùng steroid, dùng thuốc ức chế miễn dịch, nhiễm HIV, sau cắt dạ dày, nối tắt hỗng-hồi tràng, bị bệnh bụi phổi, đái tháo đường, suy thận mạn, người cao tuổi.

Lưu ý: Nhiễm lao tiên phát có thể được biểu hiện như viêm phổi mắc phải từ cộng đồng và cải thiện tạm thời khi điều trị bằng quinolon. Các bệnh nhân bị lao tiên phát có tràn dịch màng phổi nhiều thường bị mất hoặc giảm đáp ứng miễn dịch với tuberculin (anergy). Lao tái hoạt động được biểu hiện như một viêm phổi mạn.

Xem xét điều trị: Thường cần 1–2 tuần điều trị để làm hết trực khuẩn lao trong đờm.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi do *Mycobacterium avium* nội bào (MAI Pneumonia)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở đối tượng là người bình thường hoặc ở bệnh nhân bị ức chế miễn dịch/bệnh nhân nhiễm HIV với tổn thương thâm nhiễm một ổ duy nhất/ nhiều ổ thâm nhiễm không thể phân biệt được với lao phổi.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy tìm trực khuẩn kháng cồn-toan. Ở bệnh nhân HIV, nhiễm khuẩn do Mycobacterium avium nội bào (MAI) có thể lan tràn khắp hai phổi, giống như hình ảnh lao kê. Nhiễm khuẩn do MAI điển hình gặp ở thùy lưỡi phổi trái (lingular) với hình ảnh "cây nảy chồi" (" tree in bud" appearance) trên phim CT ngực. Nổi hạch rốn phổi hai bên thường gặp hơn so với khi bị lao phổi.

Lưu ý: Bệnh cảnh lâm sàng có thể gần giống với lao tái hoạt động. Cần phải chẩn đoán phân biệt lao phổi với nhiễm khuẩn *Mycobacterium avium* nội bào (MAI) bằng nuôi cấy trực khuẩn lao, do điều trị đối với MAI khác với điều trị lao.

Xem xét điều trị: Cần được điều trị tới khi nuôi cấy đờm âm tính × 1 năm.

Tiên lượng: Tốt ở các đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường. Ở bệnh nhân HIV tiên lượng có liên quan với mức độ ức chế miễn dịch/số lượng tế bào CD_4.

Viêm phổi do *Mycobacterium kansasii*

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng bán cấp giống như lao phổi tái hoạt động.

Xem xét chẩn đoán: Bệnh phổi/tổn thương thâm nhiễm phổi trên phim Xquang ngực cộng với phân lập được *M. kansasii* ở một mẫu bệnh phẩm đờm chỉ có duy nhất vi khuẩn này. *M. kansasii* có thể gây nhiễm khuẩn lan tỏa, giống như lao phổi và được chẩn đoán bằng cách nuôi cấy được *M.kansasii* từ đờm, máu, gan hoặc tủy xương.

Lưu ý: Phân lập được *M. kansasii* trong đờm ở một đối tượng có phim Xquang ngực bình thường và không có biểu hiện triệu chứng không xác định được là nhiễm khuẩn do *M. kansasii*.

Xem xét điều trị: Cần được điều trị tới khi nuôi cấy đờm âm tính x 1 năm.

Tiên lượng: Tốt ở các đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường. Có thể tiến triển nhanh/tử vong khi không được điều trị ở bệnh nhân nhiễm HIV.

Viêm phổi ở người nghiện rượu mạn tính

Xem xét chẩn đoán: Viêm phổi do *Klebsiella pneumoniae* thường xảy ra chỉ ở bệnh nhân bị nghiện rượu mạn và được đặc trưng bằng đờm đốm máu màu "thạch nho tím" và tổn thương tạo hang (điển hình trong vòng 3–5 ngày).

Lưu ý: Nghi vấn nhiễm khuẩn do Klebsiella đối với các viêm phổi do "phế cầu khuẩn" tạo hang. Viêm mủ màng phổi phổ biến hơn tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Đơn trị liệu bằng một thuốc kháng sinh với các thuốc kháng thế hệ mới có tác dụng diệt Klebsiella, Vd: cephalosporin thế hệ 3, carbapenem, colistin, tigecyclin, sẽ có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn so với điều trị kết hợp "hai thuốc" kháng sinh thế hệ cũ.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rối loạn chức năng của gan/lách.

Viêm phổi do cúm

Xem xét chẩn đoán: Viêm phổi do tụ cầu vàng (*S. aureus)* hoặc bệnh Legionnaire có thể được biểu hiện đồng thời với viêm phổi do cúm. Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) được đặc trưng bằng tình trạng tím tái và tổn thương tạo hang nhanh <72 giờ. Không được chẩn đoán viêm phổi do tụ cầu khi không có các dấu hiệu này.

Lưu ý: Tiếp sau cải thiện lâm sàng ~1 tuần ở một bệnh nhân viêm phổi do virus cúm, có thể xảy ra viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do phế cầu (*S. pneumoniae)* hoặc *H. influenzae.*

Xem xét điều trị: Không cần điều trị bao phủ chống tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) đối với các viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do vi khuẩn sau nhiễm virus cúm. Điều trị như đối với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do căn nguyên vi khuẩn điển hình.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của viêm phổi do cúm và các yếu tố liên quan với vật chủ, Vd: bệnh tim phổi đi kèm.

Giãn phế quản/xơ hóa nang

Xem xét chẩn đoán: Xơ hóa nang/giãn phế quản được đặc trưng bằng tình trạng tiết đờm nhầy ± sốt mức độ thấp. Mặc dù ít gặp hơn, tình trạng này có thể được biểu hiện như một ápxe phổi. Khởi phát viêm/ápxe phổi được báo trước bằng ho/giảm chức năng hô hấp.

Lưu ý: Các chủng vi khuẩn cư trú trong đờm thường gặp (Vd: *S. maltophilia, B. cepacia, P.aeruginosa*). Các vi sinh vật này có thể không phản ánh tác nhân gây bệnh.

Xem xét điều trị: Quan trọng là cần lựa chọn kháng sinh có khả năng kháng thuốc thấp và thâm nhập tốt vào chất tiết đường hô hấp (Vd: quinolon, meropenem) .

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của bệnh phổi nền/mức độ nặng của nhiễm khuẩn.

Viêm phổi ở bệnh nhân ghép tạng

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với tổn thương thâm nhiễm quanh rốn phổi và giảm nồng độ oxy máu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán nhiễm CMV bằng nhuộm/nuôi cấy bệnh phẩm sinh thiết phổi.

Xem xét điều trị: Điều trị như đối với viêm phổi do Cytomegalovirus nếu CMV là tác nhân gây bệnh chủ yếu trên tiêu bản bệnh phẩm sinh thiết phổi. Nhiễm trùng do CMV có thể tiến triển mặc dù bệnh nhân được điều trị bằng ganciclovir.

Tiên lượng: Có liên quan với mức độ ức chế miễn dịch.

Viêm phổi ở bệnh nhân điều trị steroid dài ngày

Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn do nấm, tiến hành sinh thiết phổi để khẳng định chẩn đoán/phát hiện vi sinh vật gây bệnh. Không thấy đáp ứng với điều trị kháng sinh thích hợp thường gợi ý nhiễm khuẩn do nấm. Tránh điều trị nấm theo kinh nghiệm; do điều trị này đòi hỏi phải đảm bảo đủ thời gian điều trị, vì vậy trước hết phải khẳng định chẩn đoán bằng sinh thiết phổi là điều hợp lý. Tiên lượng có liên quan với mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Viêm phổi cấp do Aspergillus

Biểu hiện lâm sàng: Phim Xquang phổi cho thấy có tình trạng viêm phổi hoại tử tiến triển (cả hai bên ở 50% các trường hợp) không đáp ứng với điều trị kháng sinh. Các điểm đặc trưng của viêm phổi do Apsergillus ở giai đoạn sớm là "dấu hiệu quầng sáng" ("halo sign"). Vài ngày sau đó, quầng sáng giảm dần kích thước. Sau một tuần kể từ khi xuất hiện dấu hiệu quầng sáng, "dấu hiệu liềm khí" ("air crescent sign") được biểu hiện điển hình. Bệnh thường được gặp ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng sinh thiết phổi (mà không phải là dịch rửa phế quản – phế nang) chứng minh có sợi nấm xâm nhập nhu mô/mạch máu phổi. Thường chỉ xẩy ra ở các bệnh nhân được dùng steroid dài ngày, dùng hóa chất điều trị ung thư, sau ghép tạng, các đối tượng bị suy giảm chức năng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

miễn dịch với giảm bạch cầu hạt hoặc có bệnh tạo u hạt mạn tính (chronic granulomatous disease [CGD]). Apsergillus galactomannan (GM) có thể XR với Geotrichum, Blastomyces, Penicillium hoặc Alternaria. Tăng nồng độ GM khi dùng Cyclophosphamid và nếu bị viêm ruột/viêm đại tràng sẽ làm tăng hấp thu GM.

Lưu ý: Viêm phổi do Aspergillus thể xâm lấn không xảy ra ở các đối tượng là người bình thường/ không bị suy giảm miễn dịch. Tăng nồng độ β-glucan giống khi khi bị viêm phổi do Pneumocystis carinii (PCP), song khác với nhiễm khuẩn do PCP bệnh nhân không bị tăng nồng độ LDH.

Tiên lượng: Tổn thương hang là một dấu hiệu tiên lượng tốt. Tiên lượng có liên quan với mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Áp xe phổi/ Mủ màng phổi

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Ápxe phổi/ mủ màng phổi	Các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng Tụ cầu vàng *(S. aureus)* *K. pneumoniae* Phế cầu *(S. pneumoniae)*	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 8h/lần *	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/ lần*	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần* Quinolon† (uống) mỗi 24h/ lần *
Giãn phế quản, xơ hóa nang (*P. aeruginosa*): ***Xem trang 121***				

** Điều trị tới khi lui bệnh hoàn toàn. Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).*

† Moxifloxacin 400mg hoặc Levofloxacin 500 mg.

Biểu hiện lâm sàng: Ápxe phổi được biểu hiện như tổn thương phổi tạo một hang duy nhất/nhiều hang với sốt. Tràn mủ màng phổi được biểu hiện như một tràn dịch màng phổi kèm sốt dai dẳng song không có mức nước-khí trên phim chụp Xquang ngực tư thế nằm nghiêng sang bên.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Trong ápxe phổi, phim phổi thẳng hoặc phim CT ngực cho thấy có các tổn thương phổi thành hang xuất hiện sau khi bị viêm phổi trên 1 tuần. Hầu hết các trường hợp viêm phổi mắc phải từ cộng đồng không đi kèm với với tràn dịch màng phổi và rất ít khi tiến triển thành tràn mủ màng phổi. Trong tràn mủ màng phổi, pH dịch màng phổi ≤7,2; nuôi cấy dịch tiết mủ để phân lập tác nhân gây bệnh.

Lưu ý: Tràn dịch màng phổi thứ phát do viêm phổi mắc phải từ cộng đồng thường thuyên giảm nhanh nhờ điều trị. Cần đặt nghi vấn bị tràn mủ màng phổi ở các bệnh nhân có tình trạng tràn dịch màng phổi tiếp diễn dai dẳng kèm với sốt.

Xem xét điều trị: Cần mở màng phổi/mổ dẫn lưu để điều trị tràn mủ màng phổi. Điều trị ápxe phổi tới khi chữa khỏi hẳn tình trạng này (thường kéo dài 3–12 tháng).

Tiên lượng: Tốt, nếu mủ được dẫn lưu thỏa đáng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải tại cơ sở dưỡng lão (Nursing Home-Acquired Pneumonia [NHAP])

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm phổi mắc phải tại cơ sở dưỡng lão (NHAP)	*H. influenzae* Phế cầu *(S. pneumoniae)* *M.catarrhalis*	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** quinolon hô hấp †† (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày; sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần.	Ertapenem 1g(TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần	Quinolon hô hấp†† (uống) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 11 ngày

Xem xét chẩn đoán: Khó lấy được bệnh phẩm đờm ở bệnh nhân cao tuổi/bệnh nhân nằm liệt giường. Thường gặp *H. influenzae*; Không thường gặp *K. pneumonia* ở các bệnh nhân không nghiện rượu và thậm chí cả ở quần thể các bệnh nhân nghiện rượu.

Lưu ý: Giống như viêm phổi mắc phải từ cộng đồng về cả tác nhân gây bệnh và thời gian cần nằm điều trị trong bệnh viện, song không giống với viêm phổi bệnh viện.

Xem xét điều trị: Điều trị như đối với viêm phổi cộng đồng, song khác với viêm phổi bệnh viện. Không cần điều trị bao phủ đối với tác nhân gây bệnh là *P. aeruginosa* hoặc trực khuẩn Gram âm.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng tim – phổi nền của bệnh nhân.

Viêm phổi bệnh viện (Nosocomial Pneumonia [NP])/ Viêm phổi mắc phải từ bệnh viện (Hospital –Acquired Pneumonia [HAP])/ Viêm phổi liên quan với máy thở (Ventilator-Associated Pneumonia [VAP])[§]

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Điều trị theo kinh nghiệm	*P.aeruginosa** *E.coli* *K.pneumoniae* *S.marcescens* *(S.aureus)* [†]	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/ lần×1–2 tuần ***hoặc*** Piperacillin/tazobactam 4,5 mg (TM) mỗi 6h/lần ***kết hợp với*** amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần × 1–2 tuần		Levofloxacin-750mg (uống) mỗi 24h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** Ciprofloxacin-750mg (uống) mỗi 12h/ lần × 1–2tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* *Đối với viêm phổi bệnh viện(NP)/viêm phổi liên quan với máy thở (VAP) do P. aeruginosa đã được khẳng định, điều trị kết hợp kháng sinh thường được ưu tiên áp dụng.*

† *Tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) là các vi khuẩn cư trú thường gặp của dịch tiết đường hô hấp. Ở các bệnh nhân đang được thông khí nhân tạo có biểu hiện sốt, tăng bạch cầu và xuất hiện tổn thương thâm nhiễm trên phim chụp Xquang ngực không đủ để khẳng định chẩn đoán Viêm phổi bệnh viện (NP)/Viêm phổi mắc phải từ bệnh viện (HAP)/Viêm phổi liên quan với máy thở do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA). MSSA/ MRSA NP/HAP/VAP được phân biện dựa vào lâm sàng.*

§ *Điều trị viêm phổi bệnh viện do hít phải chất tiết vào phổi cũng giống như điều trị đối với viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở. Các vi khuẩn kị khí không phải là tác nhân gây bệnh thường gặp trong viêm phổi bệnh viện do hít phải chất tiết vào phổi.*

Viêm phổi bệnh viện (NP)/Viêm phổi mắc phải tại bệnh viện (HAP)/ Viêm phổi liên quan đến máy thở (VAP)§

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Điều trị đặc hiệu	*P.aeruginosa**†	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***Cộng với hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 8h/lần × 2tuần ***hoặc*** Amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần		Levofloxacin 750mg (uống) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần
	Klebsialla hoặc Acinetobacter kháng nhiều thuốc	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần¶ ***hoặc*** Ceftolozen/tazobactam 1,5g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần		
	P.aeruginosa kháng nhiều thuốc	Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần† ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần§ ***hoặc*** Ceftolozen/tazobactam 1,5g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần		
	Enterobacteriaceae kháng carbapenem (CRE)	Ceftolozen/avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần		
	HSV-1 **	Acyclovir 10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 10 ngày		Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần × 10 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* ***Để với điều trị bao phủ P. aeruginosa theo kinh nghiệm, chỉ cần dùng một loại thuốc kháng sinh là đủ.*** *Đối với viêm phổi bệnh viện (NP)/viêm phổi liên quan với máy thở (VAP) do P. aeruginosa đã được khẳng định, điều trị kết hợp kháng sinh thường được ưu tiên áp dụng.*

‡ *Viêm phổi bệnh viện (NP)/viêm phổi liên quan với máy thở (VAP) do P. aeruginosa được biểu hiện bằng tổn thương thâm nhiễm nhiều ổ và tạo hang nhanh trong vòng <72 giờ trên phim Xquang ngực ± cấy máu mọc P. aeruginosa không thể giải thích được bằng một nguyên nhân khác (cấy máu âm tính đối với viêm phổi liên quan với máy thở do P. aeruginosa mắc phải do hít các chất tiết vào phổi và cấy máu dương tính đối với viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở do P.aeruginosa mắc phải do lây truyền theo đường máu).*

† *Dùng thuốc bằng cách truyền trong 4 giờ.*

‴ *Biểu hiện muộn trong tiến trình của viêm phổi liên quan với máy thở bằng tình trạng "cai máy thở thất bại", không biểu hiện như một viêm phổi liên quan với máy thở ở giai đoạn sớm.*

§ *Nếu còn nhạy cảm với thuốc.*

¶ *Có thể cần dùng tigecyclin với liều cao hơn liều thường dùng để điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm kháng nhiều thuốc kháng sinh song vẫn còn nhạy cảm với tigecyclin.*

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương thâm nhiễm phổi phù hợp với viêm phổi do vi khuẩn xảy ra ≥ 1 tuần trong khi nằm viện ± sốt/ tăng bạch cầu.

Xem xét chẩn đoán: Tổn thương thâm nhiễm trên phim Xquang phổi với tăng bạch cầu và sốt là không đặc hiệu/không đủ để chẩn đoán viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở. Chẩn đoán xác định bằng sinh thiết phổi. *P. aeruginosa* là một vi khuẩn cư trú thường gặp ở các bệnh nhân đang được thở máy. Viêm phổi liên quan với máy thở do *P. aeruginosa* được biểu hiện như một viêm phổi hoại tử và tổn thương tạo hang nhanh (< 72 giờ), các micro ápxe và xâm lấn vào mạch máu. Viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở do *S. aureus* (tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin [MSSA/MRSA]) rất hiếm gặp mặc dù vi khuẩn này có thể mọc khi nuôi cấy dịch hút từ ống nội khí quản sau khi rửa phế quản hoặc chất tiết hô hấp ở 25% trường hợp. Viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở do Acinetobacter/Legionella thường xảy ra trong các vụ dịch xảy ra trong bệnh viện.

Lưu ý: Không có cơ sở để tiến hành điều trị bao phủ đối với các tác nhân gây bệnh ngoài phổi cư trú trong chất tiết đường hô hấp ở bệnh nhân đang được thở máy (Enterobacter, *B. cepacia, S. maltophilia,* Citrobacter, Flavobacterium, cầu khuẩn ruột). Các vi sinh vật này hiếm khi hoặc thậm chí là không bao giờ gây viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở. Mẫu bệnh phẩm bán định lượng được lấy bằng phương pháp rửa phế quản-phế nang (BAL)/bàn chải được bảo vệ có thể phản ánh các vi khuẩn cư trú ở đường dẫn khí. Thậm chí cần tiến hành sinh thiết phổi để chẩn đoán xác định viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở do *P. aeruginosa*. Tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) là các vi khuẩn cư trú phổ biến trong chất tiết đường hô hấp và

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

là các tác nhân gây bệnh không phải quá hiếm gặp gây viêm khí- phế quản ở các bệnh nhân thở máy. Viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở tạo hang/ hoại tử nhanh do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) hiếm gặp.

Xem xét điều trị: Viêm phổi bệnh viện (viêm phổi mắc phải từ bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở) được định nghĩa là một tình trạng viêm phổi mắc phải sau > 5 ngày nằm viện. Vì vậy, một viêm phổi bệnh viện "sớm" (xảy ra < 5 ngày nằm viện), có thể do phế cầu (*S. pneumoniae*) (bao gồm cả các chủng phế cầu kháng thuốc [DRSP]) hoặc *H. influenzae*, thực tế là một viêm phổi mắc phải từ cộng đồng được biểu hiện sớm sau khi bệnh nhân nhập viện. Các khuyến cáo điều trị theo kinh nghiệm (***trang 125***) bao phủ cả các tác nhân gây bệnh gây viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở "sớm" và "muộn". Điều trị bằng một thuốc kháng sinh (monotherapy) cũng có hiệu quả như điều trị kết hợp đối với các viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan với máy thở không do *P.aeruginosa* gây nên, song điều trị kết hợp bằng 2 thuốc được khuyến cáo đối với viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở đã được khẳng định là do *P. aeruginosa* gây nên. Nếu bị viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở với biểu hiện hoại tử/tạo hang nhanh do MSSA/MRSA, có thể điều trị cho bệnh nhân bằng vancomycin, quinupristin/dalfopristin hoặc linezolid (xem phần ***Tóm tắt các thông tin thuốc, Chương XI***). Sau 2 tuần điều trị kháng sinh thích hợp, các thâm nhiễm phổi không tiến triển/không thay đổi kèm với sốt và tăng bạch cầu thường do nguyên nhân không phải là nhiễm khuẩn gây nên, thay vì quy kết là do tình trạng nhiễm khuẩn tiếp diễn dai dẳng gây nên. Điều trị viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở do hít chất tiết vào cũng giống như điều trị đối với viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở do các vi khuẩn kị khí không phải là tác nhân gây bệnh thường gặp trong viêm phổi bệnh viện/ viêm phổi liên quan với máy thở.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng tim phổi nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN TIM MẠCH

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn (SBE) trên van tim bình thường

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Không có nguồn gốc rõ ràng hoặc từ răng miệng	Liên cầu Viridans *† Liên cầu nhóm B,C,G, *S.bovi* (Nồng độ ức chế tối thiểu [MIC] của penicillin < 0,12µg/mL)	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/ lần × 2 tuần*‡ ***kết hợp với*** Gentamicin 240mg hoặc 3 mg/kg (TM) mỗi 24 giờ × 2 tuần* ***hoặc*** **điều trị một thuốc bằng** Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/ lần × 4 tuần	Penicillin G 3 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/ lần × 2 tuần*‡ ***kết hợp với*** Gentamicin240mg hoặc 3mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần* ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần × 4 tuần	Amoxicillin§ 1g (uống) mỗi 8h/lần/ lần× 4 tuần ***hoặc*** Linezolid§ 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 4 tuần

* *Nếu có tình trạng kháng tương đối với penicillin (MIC= 0,12–0,5 µg/mL) hoặc nếu không có các biến chứng trong/ngoài tim tiến hành điều trị × 4 tuần.*

† *S. mitis (S. mitior), S. oralis, S. gordonii, S. parasanguis, S. sanguis, S. mutans, S. sobrinus, S. thermophilus, S. angiosus, S. milleri, S. intermedius, S. constellatus.*

‡ *Ở bệnh nhân dị ứng với penicillin, vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần× 2 tuần.*

§ *Ưu tiên điều trị đường TM. Điều trị bằng đường uống nếu không có đường vào TM hoặc nếu bệnh nhân không phải là một đối tượng cần phẫu thuật.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn trên van tim bình thường (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Không có nguồn gốc rõ ràng hoặc từ răng miệng	*Một biến thể của liên cầu phụ thuộc chất dinh dưỡng để phát triển (Nutritionally-variant streptococci [NVS]) hay streptocci* phụ thuộc vitamin B6 (pyridoxal) ‡	Như trên, song điều trị kéo dài × 6 tuần	Như trên, song điều trị kéo dài × 6 tuần	Như trên§, song điều trị kéo dài × 6 tuần
	Listeria monocytogenes	Ampicillin 2g (TM) mỗi 4h/lần ×4–6 tuần ***hoặc*** TMP-SMX 5mg/kg (TM) mỗi 6h/lần	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×4–6 tuần	Amoxicillin§1g (uống) mỗi 8h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Linezolid§ 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

<table>
<tr><td rowspan="2">Có khả năng có nguồn gốc từ đường tiêu hóa /tiết niệu- sinh dục (Điều trị khởi đầu đối với E.faecalis [VSE]; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là E. faecium [VRE], điều trị phù hợp</td><td>E. faecalis (VSE)†</td><td>Ampicillin 2 g (TM) mỗi 4h/ lần ×4–6 tuần
kết hợp với
Gentamicin 1mg/kg (TM) hoặc 80mg (TM) mỗi 8h/ lần × 4-6 tuần</td><td>Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần
kết hợp với
Gentamicin 240mg hoặc 3mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần</td><td>Amoxicillin§ 1g (uống) mỗi 8h/lần × 4–6 tuần
hoặc
Linezolid§ 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần</td></tr>
<tr><td>E. faecium (VRE) †</td><td colspan="2">Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/ lần × 4–6 tuần
hoặc
Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/ kg (TM) mỗi 8 giờ × 4–6 tuần</td><td>Linezolid § 600 mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần</td></tr>
<tr><td>Nguồn gốc từ đường tiêu hóa</td><td>S.(bovi) gallolyticum (Liên cầu nhóm D không phải cầu khuẩn ruột)</td><td colspan="3">Điều trị như đối với phân loại " không có nguồn gốc rõ ràng" (trang 70)</td></tr>
</table>

Từ viết tắt: VRE (Vancomycin-Resistant Enterococci): Cầu khuẩn ruột kháng Vancomycin; VSE (Vancomycin-Sensitive Enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin.

Thời gian điều trị phản ảnh tổng thời gian điều trị theo đường TM, thời gian điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnhmạch + thờigian điều trị theo đường uống.

† *Triệu chứng < 3 tháng → điều trị × tuần 4.*

Triệu chứng > 3 tháng → điều trị ×6 tuần.

‡ *NVS (Nutritionally Variant Streptococci) bao gồm: Abiotrophia defectivus, Granulicata adjacens/ elegans.*

§ *Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên chọn dùng . Điều trị đường uống nếu không có đường vào tĩnh mạch hoặc nếu bệnh nhân không phải là đối tượng cần được phẫu thuật.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn trên van tim bình thường (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn "cấy máu âm tính"*	Tác nhân gây bệnh không được biết (Abiotrophia, cầu khuẩn ruột)	Ampicillin/Sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần × 4 – 6 tuần ***kết hợp với*** Gentamicin[§] 240mg hoặc 3mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần	Quinolon[†](TM) mỗi 24 h/lần × 4-6 tuần	Quinolon [†§] (uống) mỗi 24h/lần × 4–6 tuần
	Hemophilus sp. *Actinobacillus actinomycetem-comitans* *Cardiobacterium hominis* *Eikenella corrodens* *Kingella kingae* (các vi sinh vật nhóm HACEK)	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/lần× 4–6 tuần ***hoặc*** Một cephalosporin thế hệ 3 bất kỳ (TM) × 4–6 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần	Ampicillin 2g (TM) mỗi 4h/lần × 4–6 tuần ***kết hợp với*** Gentamicin[§] 240mg hoặc 3 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc điều trị bằng một thuốc với*** Ampicillin/Sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Quinolon[†] (TM) mỗi 24h/lần × 4–6 tuần	Quinolon[†§] (uống) mỗi 24h/lần × 4–6 tuần
	Legionella Chlamydophilia *Chlamydia psittaci*	Doxycyclin** 200 mg (TM) mỗi 12 h/lần × 3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần × 3 tháng	Quinolon[†] (TM) mỗi 24h/lần × 3 tháng	Doxycyclin**[§]200mg (uống) mỗi 12h/lần× 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 tháng.
	Coxiella burnetii (Sốt Q)	Doxycyclin** 200 mg (TM/uống) mỗi12h/lần × 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 24 tháng ***kết hợp với*** Hydroxychloroquin 200 mg (uống) mỗi 8h/lần ×24 tháng		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn bán cấp do Brucella †	*Brucella melitensis, abortus, canis, suis*	Doxycyclin 200mg** (TM) mỗi 12 h/lần× 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12 h/lần × ≥6 tuần ***cộng với*** Rifampin 300 mg (uống) mỗi 8h/lần × ≥ 6 tuần ***cộng với*** Gentamicin §§ 3mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × ≥ 6 tuần

* *Các vi sinh vật phát triển chậm/khó phát triển có thể cần tới tăng CO_2 và thời gian nuôi cấy kéo dài.*

† *Levofloxacin 500mg hoặc Moxifloxacin 400mg.*

** *Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

§ *Điều trị đường TM được ưu tiên chọn dùng. Điều trị đường uống khi không có đường vào TM hoặc khi bệnh nhân không phải là đối tượng cần phẫu thuật.*

§§ *Có thể được cho với liều dùng 1 lần/ngày hoặc được cho thành các liều nhỏ mỗi 8h/lần.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn trên van tim bình thường

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng bệnh lý bán cấp có sốt ± triệu chứng/dấu hiệu thực thể khu trú ở một bệnh nhân có tiếng thổi ở tim. Thường không thấy có các biểu hiện ngoại biên khi được chẩn đoán/điều trị sớm.

Chẩn đoán: Có vi khuẩn trong máu liên tục/nuôi cấy (+) ở nhiều mẫu nuôi cấy (với tác nhân gây bệnh viêm nội tâm mạc) cộng với tổn thương sùi van khi siêu âm qua thành ngực/ siêu âm thực quản giúp chẩn đoán.

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn (không có nguồn gốc rõ ràng)

Xem xét chẩn đoán: Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là liên cầu viridans. Nguồn nhiễm khuẩn thường từ miệng, mặc dù các nhiễm khuẩn răng/khoang miệng thường không có biểu hiện rõ rệt trên lâm sàng.

Lưu ý: Chỉ có sùi van song không có kết quả cấy máu (+) hoặc các biểu hiện ngoại biên của viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn không đủ để chẩn đoán viêm nội tâm mạc. Sùi van trong viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn có thể tồn tại dai dẳng sau khi điều trị kháng sinh nhưng vô khuẩn.

Xem xét điều trị: Ở bệnh nhân dị ứng penicillin (phản ứng phản vệ), có thể sử dụng vancomycin đơn độc hoặc kết hợp với gentamicin . Theo dõi tốc độ lắng hồng cầu hàng tuần để đánh giá đáp ứng với điều trị kháng sinh. Không

cần tiến hành cấy máu nhắc lại nhiều lần trừ khi bệnh nhân sốt dai dẳng hoặc không thấy có đáp ứng lâm sàng. Liệu trình điều trị trong 2 tuần được chấp nhận đối với các viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do liên cầu viridans không có biến chứng. Điều trị viêm nội tâm mạch bán cấp nhiễm khuẩn do chủng liên cầu phụ thuộc chất dinh dưỡng để phát triển (nutritionally-variant streptococci[(NVS]) (liên cầu phụ thuộc vitamin B6/pyridoxal) cũng giống như đối với viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do liên cầu viridans.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch/mức độ nặng của suy tim.

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn (có khả năng có nguồn gốc từ đường tiêu hóa/tiết niệu-sinh dục)

Xem xét chẩn đoán: Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất từ nguồn gốc đường tiêu hóa/tiết niệu –sinh dục là Enterococci (đặc biệt là *E. faecalis*). Nếu là *S. bovis*, cần tìm kiếm nguồn gốc polyp, khối u đường tiêu hóa,. Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do Enterococci thường xẩy ra sau đặt dụng cụ y tế trên đường tiêu hóa/tiết niệu –sinh dục.

Lưu ý: Đau lưng vùng thấp là đặc trưng của viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do Enterococci/*S. bovis*, *S. bovis* được kết hợp với tình trạng tắc mạch hệ thần kinh trung ương, viêm tủy xương của đốt sống và các sùi van lớn.

Xem xét điều trị: Đối với các bệnh nhân dị ứng penicillin, sử dụng vancomycin kết hợp với gentamicin . Vancomycin dùng đơn độc là không thỏa đáng để điều trị viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do Enterococci (*E. faecalis*). Điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên van tim nhân tạo do Enterococci cũng giống như điều trị đối với viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn tại van tim bình thường do Enterococci. Điều trị viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do *S. bovis* giống như đối với viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do *S. viridans*.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch.

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn với "cấy máu âm tính" (các tác nhân gây bệnh có thể cấy được)

Xem xét chẩn đoán: Nuôi cấy vi khuẩn gây bệnh có thể cần tới môi trường đặc hiệu/tăng nồng độ CO_2 (chai cấy máu Castaneda) và thời gian nuôi cấy kéo dài (2–4 tuần). Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn "cấy máu âm tính" thật sự

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hiếm gặp và được đặc trưng bằng các dấu hiệu ngoại biên của viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn, tiếng thổi ở tim, sùi van tim (đánh giá bằng siêu âm tim qua thành ngực/siêu âm qua thực quản) và kết quả cấy máu âm tính.

Lưu ý: Hầu hết các trường hợp viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn "cấy máu âm tính" thực tế không phải là viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn cấy máu âm tính, mà là do vi khuẩn gây bệnh mọc chậm. Có thể không nhìn thấy các sùi van tim bằng siêu âm tim qua thực quản/qua thành ngực trong viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do sốt Q.

Xem xét điều trị: Theo dõi cải thiện lâm sàng bằng xét nghiệm tốc độ lắng hồng cầu hàng tuần và xét nghiệm này sẽ trở lại mức trước điều trị khi bệnh nhân được điều trị thỏa đáng. Siêu âm tim làm lại hàng tuần cho thấy giảm kích thước chỗ sùi van tim nếu điều trị có hiệu quả. Các sùi vô khuẩn có thể tiếp tục tồn tại sau khi điều trị kháng sinh.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch.

Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn "cấy máu âm tính"- với tác nhân gây bệnh không thể nuôi cấy được (các tác nhân gây bệnh được chẩn đoán bằng test huyết thanh học)

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng test huyết thanh học đặc hiệu. Các thuyên tác mạch lớn là bằng chứng gợi ý cho viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn cấy máu âm tính ở bệnh nhân có kết quả cấy máu âm tính song có các dấu hiệu của viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn, ví dụ: lách to/các biểu hiện ở ngoại biên của viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn.

Lưu ý: Không được chẩn đoán viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn cấy máu âm tính ở bệnh nhân chỉ có tiếng thổi ở tim mà không có các biểu hiện ngoại biên của viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn và kết quả cấy máu âm tính. Có thể không nhìn thấy các sùi van tim trên siêu âm tim qua thành ngực/qua thực quản trong viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do sốt Q. Chẩn đoán sốt Q mạn tính được đặt ra bằng cách chứng minh có tăng hiệu giá IgG (phase I) ≥1:1024 vào tháng thứ 6 sau khi bị sốt Q cấp tính.

Xem xét điều trị: Điều trị dựa trên vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu được phát hiện bằng test huyết thanh chẩn đoán.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch/mức độ nặng của suy tim.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn trên van tim bình thường (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Người bình thường khỏe mạnh *	Tụ cầu vàng (MRSA)	Daptomycin 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần×4–6 tuần ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 24h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Minocyclin100mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần
	Tụ cầu vàng (MSSA)	Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần × 4–6 tuần		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Cephalexin 1g (uống) mỗi 6h/lần × 4–6 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Người tiêm chích ma túy đường tĩnh mạch † (Điều trị như MRSA trước khi có kết quả cấy máu; sau khi có kết quả cấy máu điều trị phù hợp với tác nhân gây bệnh)	*S.aureus* (MRSA)	*Trước khi có kết quả cấy máu* Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ***kết hợp với*** Vancomycin 1g hoặc 15mg/kg (TM) mỗi 12h/ lần	*Sau khi có kết quả cấy máu:* Daptomycin 6mg/kg (TM) mỗi 24 giờ × 6 tuần ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/ lần× 6tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 6 tuần	*Sau khi có kết quả cấy máu:* Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/ lần ×4–6 tuần ***hoặc*** Minocyclin† 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần
	S. aureus (MSSA)	*Trước khi có kết quả cấy máu* Meropenem 1g (TM) mỗi 8/lần	*Sau khi có kết quả cấy máu:* Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Cefazolin 1g (TM) mỗi 8 giờ× 4–6 tuần ***hoặc*** Daptomycin 6mg/kg (TM) mỗi 24 giờ× 4–6 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg(TM) mỗi 12h/ lần × 4–6 tuần ***hoặc*** một carbapenem bất kỳ (TM) × 4–6 tuần	*Sau khi có kết quả cấy máu:* Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/ lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Cephalexin 1g (uống) mỗi 6h/lần × 4–6 tuần
	*P.aeruginosa** *S.marcesens* Trực khuẩn Gram âm kị khí	*Trước khi có kết quả cấy máu* Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 6h/lần	*Sau khi có kết quả cấy máu:* ***Một thuốc "A" ± Một thuốc "B"*** **Thuốc "A":** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 4–6 tuần **Thuốc "B"** : Amikacin500mg hoặc15 mg/kg(TM) mỗi 24h/lần ×4–6 tuần ***hoặc*** Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần × 4–6 tuần	None

Từ viết tắt: MRSA/MSSA =Methicillin-resistant/sensitive *S. aureus* – Tụ cầu kháng/nhạy methicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, thời gian điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống.

** Chỉ điều trị đường TM hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống.*

[1] Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn ở van ba lá do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) có thể điều trị đường TM/đường uống ×2 tuần nếu không có biến chứng trong tim hoặc hệ thần kinh trung ương. Thuyên tắc nhiễm khuẩn phổi là một biến chứng của viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn ở tim phải, Vd: ở van ba lá và bản thân dấu hiệu này không phải là một biến chứng ngoài tim của viêm nội tâm mạc cấp.

Viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn (ABE)

Xem xét chẩn đoán: Tiêu chuẩn chẩn đoán đối với viêm nội tâm mạc cấp do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MRSA/MSSA): có vi khuẩn trong máu liên tục/ cấy máu dương tính cao (cấy máu lặp lại cho kết quả 3/4 hoặc 4/4 mẫu cấy máu dương tính), sốt (thân nhiệt thường ≥39°C), không có tiếng thổi ở tim mới xuất hiện hoặc thay đổi, sùi van tim phát hiện được bằng siêu âm tim qua đường thực quản/xuyên thành ngực.

Lưu ý: Tiến hành làm siêu âm tim qua thành ngực để có được một dữ liệu cơ sở nhằm mục đích đánh giá biến chứng của viêm nội tâm mạc cấp như tình trạng phá hủy van, suy tim hoặc ápxe quanh van. Nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ tim mạch và bác sĩ truyền nhiễm. Ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc cấp do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) điều trị khởi đầu bằng vancomycin, tình trạng để kháng với deptomycin có thể xảy ra trong khi điều trị.

Xem xét điều trị: Điều trị trong vòng 4–6 tuần. Theo dõi hiệu giá kháng thể kháng acid teichoic hàng tuần đối với viêm nội tâm mạc cấp do tụ cầu vàng (*S. aureus)*, nếu điều trị hiệu quả hiệu giá này sẽ giảm xuống (cùng với tốc độ lắng hồng cầu). Nếu viêm nội tâm mạc cấp do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) không đáp ứng với điều trị kháng sinh thích hợp (tiếp tục có tình trạng cấy máu dương tính cao) hoặc nếu có ápxe cơ tim/quanh van song không thể dẫn lưu được, daptomycin "liều cao" 12 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần có thể có hiệu quả. Với các chủng tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) kháng lại với daptomycin, Quinupristin dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần có thể có hiệu quả.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch/mức độ nặng của tình trạng phá hủy van tim/suy tim.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn (ở người tiêm chích thuốc gây nghiện đường tĩnh mạch)

Xem xét chẩn đoán: Trên lâm sàng người tiêm chích đường tĩnh mạch bị nhiễm khuẩn do *S. aureus* thường có viêm nội tâm mạc cấp tương đối nhẹ, cho phép điều trị theo đường uống.

Lưu ý: Người tiêm chích đường tĩnh mạch có hở van động mạch chủ mới hoặc van ba lá cần được điều trị thuốc theo đường tĩnh mạch ± thay van tim.

Xem xét điều trị: Sau khi phân lập được tác nhân gây bệnh, có thể chuyển từ chế độ điều trị đường tĩnh mạch sang điều trị đường uống tới khi hoàn thành liệu trình điều trị.

Tiên lượng: Tiên lượng tốt hơn so với viêm nội tâm mạc cấp ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường nếu không bị biến chứng ápxe, hở van hoặc suy tim.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo (PVE)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Trước khi có kết quả cấy máu	Sau khi có kết quả cấy máu
Viêm nội tâm mạc sớm trên van tim nhân tạo (PVE) (< 60 ngày sau thay van tim nhân tạo)	Tụ cầu vàng (MSSA/MRSA) *S. epidermidis* (CoNS) Enterobacteriaceae	Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần ***kết hợp với*** Gentamicin 240mg hoặc 3 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần	*Tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA) / Enterobacteriaceae* Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 6tuần *Tụ cầu vàng nhạy /kháng với methicillin (MSSA/MRSA)*† Daptomycin 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần×6 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần × 6 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 6 tuần
	Các chủng Candida§	Micafungin 150mg hoặc 3 mg/kg (TM) mỗi 24 giờ	Các dạng bào chế của amphotericin với lipd 3–5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 6 tuần ***kết hợp với*** 5-FC 25mg/kg (uống) mỗi 6 giờ × 6 tuần

Viêm nội tâm mạc muộn trên van tim nhân tạo (> 60 ngày sau thay van tim nhân tạo)	*Viridans streptococci* *S. epidermidis* (CoNS)	Vancomycin 1g hoặc15mg/kg (TM) mỗi 12h/lần ***kết hợp với*** Gentamicin 240 mg hoặc 3 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần	*Liên cầu Viridans* Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/lần x 6 tuần ***kết hợp với*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 6 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x6 tuần ***kết hợp với*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 6 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x6 tuần ***kết hợp với*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x6 tuần *CoNS* Linezolid 600mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần x 6 tuần ***kết hợp với*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 8 giờ x 6 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 6 tuần ***kết hợp với*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 6 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA(methicillin–sensitive/resistant S. aureus): Tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin; MSSE/MRSE: methicillin – sensitive/resistant S.epidermidis – S.epidermidis nhạy/kháng methicillin. CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu không sinh men coagulase.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống.

† *Thuốc điều trị đối với tụ cầu vàng kháng methicillin(MRSA) cũng có hiệu quả đối với tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA).*

§ *Thường cần thay van để điều trị triệt để.*

§§ *Có thể được cho với phác đồ liều 1 lần/ngày hoặc cho với phác đồ liều chia nhỏ mỗi 8h/lần*

Biểu hiện lâm sàng: Sốt kéo dài và rét run sau khi thay van tim nhân tạo.

Chẩn đoán: Kết quả cấy máu dương tính cao (3/4 hoặc cả 4/4 mẫu máu cấy dương tính) với tác nhân gây bệnh gây viêm nội tâm mạc và không có các nguồn gây nhiễm khuẩn khác.

Viêm nội tâm mạc sớm trên van tim nhân tạo (< 60 ngày sau mổ thay van tim nhân tạo)

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu liên tục dương tính. Thân nhiệt thường ≤ 39°C .

Lưu ý: Tiến hành làm siêu âm tim qua thành ngực/qua thực quản để có được một dữ liệu cơ sở. Các lá van hai lá đóng sớm là một dấu hiệu sớm dự báo tình trạng hở van động mạch chủ sắp xảy ra.

Xem xét điều trị: Bệnh nhân có thể có cải thiện lâm sàng khi được điều trị nội khoa, song vẫn có thể cần thiết phải lấy bỏ van nhân tạo để điều trị triệt để.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch/mức độ nặng của suy tim.

Viêm nội tâm mạc muộn sau thay van tim nhân tạo (> 60 ngày sau thay van tim nhân tạo)

Lưu ý: Nuôi cấy van được lấy ra có thể âm tính, song nhuộm Gram âm van tim sẽ dương tính.

Xem xét điều trị: Về lâm sàng, viêm nội tâm mạc muộn sau thay van tim nhân tạo giống với viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn do liên cầu viridans. Bệnh nhân có thể có cải thiện về lâm sàng khi được điều trị nội khoa, song vẫn có thể cần thiết phải lấy bỏ van nhân tạo để điều trị triệt để.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ thuyên tắc mạch/mức độ nặng của suy tim.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng ngoài tim/Viêm cơ tim

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM ưu tiên
Viêm cơ tim do bệnh bạch hầu	*C.diphtheriae*	Điều trị như đối với bệnh bạch hầu (***xem trang 301***)
Virus	Coxsackie Influenza	Không điều trị đối với Coxsackie Như điều trị bệnh cúm
Viêm cơ tim do bệnh Lyme	*B. burgorferi*	Ceftriaxon 2 g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần
Viêm nội tâm mạc do lao	*M.tuberculosis*	Điều trị như đối với lao phổi (***xem trang 94***). Thêm một liều corticosteroids giảm dần liều × 4–8 tuần
Viêm mủ màng ngoài tim	*S.pneumoniae, S.aureus*	Điều trị như đối với ápxe phổi/ tràn mủ màng phổi (***xem trang 123***)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm màng ngoài tim do virus được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát cấp tính với sốt/đau ngực (trở nên tệ hơn khi bệnh nhân ngồi dậy) sau một nhiễm virus. Viêm màng ngoài tim do lao không được biểu hiện bằng tình trạng đau ngực, song có kèm với tĩnh mạch cổ nổi to, tiếng cọ màng ngoài tim (40%), mạch đảo (25%) và chụp Xquang phổi thấy có bóng tim to ± tràn dịch màng phổi bên trái. Viêm mủ màng ngoài tim được biểu hiện như một viêm màng ngoài tim cấp (bệnh nhân trong tình trạng bệnh lý nặng cần hồi sức). Phát sinh do lan rộng từ nhiễm khuẩn kế cận (Vd: viêm phổi) hoặc lan rộng theo đường máu (Vd: nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng). Viêm cơ tim do virus được biểu hiện bằng suy tim, loạn nhịp tim ± thuyên tắc mạch.

Xem xét chẩn đoán: Viêm màng ngoài tim/tràn dịch màng tim được biểu hiện bằng tim to với giảm tiếng tim ± ép tim cấp. Chẩn đoán bằng nuôi cấy dịch màng ngoài tim/sinh thiết màng ngoài tim tìm virus, vi khuẩn hoặc trực khuẩn lao (trực khuẩn kháng cồn-toan [AFB]). Chẩn đoán viêm cơ tim bằng lâm sàng ± sinh thiết cơ tim.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Xem xét các nguyên nhân gây tràn dịch màng ngoài tim khác (Vd: bệnh lý ác tính, nhất là nếu có tràn máu màng ngoài tim, hội chứng urê máu cao... vv). Nhịp tim nhanh không giải thích được bằng các nguyên nhân khác hẳn sẽ gợi ý viêm cơ tim cho đến khi chứng minh được nguyên nhân khác. Cần loại trừ các nguyên nhân gây viêm cơ tim khác không do virus gây nên và có thể điều trị được (Vd: bệnh sốt phát ban vùng núi đá [RMSF], bệnh Lyme, bạch hầu). Cần đặt nghi vấn bị bệnh Lyme ở tất cả các đối tượng không có bệnh tim song có phơi nhiễm với vùng dịch khi các đối tượng này có biểu hiện tình trạng block tim không giải thích được bằng nguyên nhân khác. Hiệu giá IgM với Lyme có thể âm tính ở giai đoạn sớm khi bệnh nhân có biểu hiện block tim.

Xem xét điều trị: Không có điều trị đặc hiệu đối với viêm cơ tim/viêm màng ngoài tim do virus. Viêm màng ngoài tim do lao được điều trị giống như đối với lao phổi ± phẫu thuật cắt bỏ màng ngoài tim. Viêm mủ màng tim được điều trị như đối với ápxe phổi kết hợp với phẫu thuật dẫn lưu mủ (mở cửa sổ màng ngoài tim). Tình trạng block tim trong bệnh Lyme thuyên giảm nhanh khi được điều trị, song có thể cần đặt máy tạo nhịp tim tạm thời tới khi tình trạng block tim của bệnh nhân hồi phục.

Tiên lượng: Đối với viêm màng ngoài tim do virus, tiên lượng tốt, song viêm cơ tim do virus có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Đối với viêm màng ngoài tim do lao, tiên lượng tốt nếu bệnh nhân được điều trị trước khi xảy ra tình trạng viêm màng ngoài tim co thắt/dính. Viêm mủ màng ngoài tim thường gây tử vong cho bệnh nhân nếu không được điều trị sớm bằng kháng sinh và phẫu thuật mở cửa sổ màng ngoài tim. Đối với tình trạng block tim/viêm cơ tim do bệnh Lyme, tiên lượng tốt nếu bệnh nhân được bắt đầu điều trị sớm khi nghi vấn chẩn đoán này.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm và các nhiễm trùng dây dẫn/ máy tạo nhịp

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm (loại đặt tạm thời)* <u>Do vi khuẩn</u> (Điều trị khởi đầu đối với (MSSA), nếu sau đó phân lập được (MRSA) điều trị một cách phù hợp)	Tụ cầu vàng (MSSA) Trực khuẩn Gram âm ái khí	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ** ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần **	Ceftizoxim 2g(TM) mỗi 8h/lần ** ***hoặc*** Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/ lần **	Quinolon ‡(uống) mỗi 24h/ lần **†
	Tụ cầu vàng (MRSA/ MSSA§)	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/ lần ** ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần ** ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12 giờ **		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/ lần**† ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12 giờ**†
Do Candida ¶ (Điều trị khởi đầu như đối với nhiễm trùng do C. albicans, nếu sau đó tác nhân gây bệnh phân lập được là Candida không phải albicans, điều trị một cách phù hợp)	*C. albicans*	Điều trị giống như đối với nhiễm Candida máu (***trang 271***)		
	Candida không phải albicans	Điều trị giống như đối với nhiễm Candida máu (***trang 271***)		
Các nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm (loại đặt bán vĩnh viễn Hickman/ Broviac/ Tessio)* <u>Do Vi khuẩn</u>	*S.aureus* (MRSA/ MSSA)	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/ lần ** ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần ** ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần **		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/ lần** † ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần **†

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant *S. aureus*): Tụ cầu nhạy/kháng methicillin.

† *Điều trị đường TM được ưu tiên chọn dùng. Điều trị đường uống nếu không có đường vào TM.*

‡ *Levofloxacin 500mg hoặc Moxifloxacin 400mg.*

* *Nếu lâm sàng có thể, cần rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm nếu catheter tĩnh mạch trung tâm bị nghi vấn là nguồn gốc gây nhiễm khuẩn máu ở bệnh nhân sepsis. Nếu có tình trạng vi khuẩn máu liên tục kéo dài cấy máu dương tính cao cần tiến hành làm siêu âm tim qua thành ngực/qua thực quản để loại trừ viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn.*

** *Điều trị × 2 tuần sau khi rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm nếu không có viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn.*

¶ *Đối với nhiễm nấm Candida máu không liên quan với catheter tĩnh mạch trung tâm,* ***(xem trang 271-272)***.

§ *Thuốc điều trị tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MRSA) cũng có hiệu quả điều trị đối với tụ cầu vàng kháng methicillin (MSSA).*

Nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm và các nhiễm trùng dây dẫn/ máy tạo nhịp (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
	S. epidermidis (CoNS)	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần** ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ** ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15mg/kg (TM) mỗi 12 giờ**		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần**†
Nhiễm trùng dâydẫn /máy tạo nhịp tim (Điều trị khởi đầu đối với tụ cầu vàng; nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là S. epidermidis, điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MSSA/MRSA)	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần†§ ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần †§ ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần †		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần†§* ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần†§*
	S. epidermidis (CoNS)	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần† ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần† ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15mg/kg (TM) mỗi 12h/lần †		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần†*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant *S. aureus*): Tụ cầu nhạy/kháng methicillin; MSSE/MRSE (methicillin-sensitive/resistant *S. epidermidis*): *S. epidermidis* nhạy/kháng methicillin. *CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu không sinh men coagulase.*

† *Điều trị đường TM được ưu tiên chọn dùng. Điều trị đường uống nếu không có đường vào TM.*

** *Điều trị × 2 tuần sau rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm nếu không bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.*

* *Điều trị × 2 tuần sau rút bỏ dây/máy tạo nhịp nếu không bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.*

§ *Đánh giá hiệu giá kháng thể acid teichoic sau 2 tuần. Nếu hiệu giá < 1/2 cần điều trị 2 tuần là đủ. Nếu hiệu giá > 1/2, cần loại trừ viêm nội tâm mạc và hoàn thành 4-6 tuần điều trị.*

Nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm và các nhiễm trùng dây dẫn/máy tạo nhịp (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm tắc TM nhiễm khuẩn (Septic thrombo-phlebitis) (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là MRSA, điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MSSA)	Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần × 2 tuần* ***hoặc*** Linezolid 600mg(TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần* ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần*	Ceftizoxim 2g(TM) mỗi 8h/lần×2 tuần* ***hoặc*** Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần × 2 tuần*	Linezolid 600mg (uống)mỗi 12h/lần ×2 tuần*† ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần × 2 tuần *† ***hoặc*** Cephalexin1g (uống) mỗi6h/lần × 2 tuần*†
	Tụ cầu vàng (MRSA)	Linezolid 600mg (TM)mỗi 12h/lần × 2 tuần* ***hoặc*** Vancomycin 1g hoặc 15mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần* ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần*		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần*† ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/ lần × 2 tuần*†

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA: methicillin-sensitive/resistant *S. aureus* – Tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Đánh giá hiệu giá kháng thể acid teichoic sau 2 tuần. Nếu hiệu giá < 1/2 cần điều trị 2 tuần là đủ. Nếu hiệu giá > 1/2, cần loại trừ viêm nội tâm mạc và hoàn thành 4-6 tuần điều trị.*

† Điều trị đường TM được ưu tiên chọn dùng. Điều trị đường uống nếu không có đường vào TM.

Nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm (loại đặt tạm thời)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiệt độ ≥39°C ± ban đỏ tại vị trí da truyền tĩnh mạch.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy bán định lượng vi khuẩn đầu catheter có ≥15 cụm khuẩn lạc (colonies) kết hợp với kết quả cấy máu mọc cùng tác nhân gây bệnh. Nếu không có lời giải thích khác cho tình trạng sốt và đường truyền tĩnh mạch đã được đặt ≥7 ngày, rút bỏ đường truyền tĩnh mạch và tiến hành nuôi cấy bán định lượng vi khuẩn đầu catheter. Viêm tắc TM mủ được biểu hiện bằng các cơn sốt chu kì/nhiễm khuẩn và có mủ tại vị trí đặt đường truyền tĩnh mạch ± có thể sờ thấy thừng tĩnh mạch.

Lưu ý: Nhiệt độ ≥39°C với nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch, trái ngược với viêm tĩnh mạch (phlebitis).

Xem xét điều trị: Rút bỏ đường truyền tĩnh mạch thường làm hết tình trạng nhiễm trùng, song điều trị kháng sinh trong 7 ngày thường được thực hiện sau khi đã rút bỏ đường truyền tĩnh mạch đối với nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm hoặc trong 2 tuần sau khi rút bỏ đường truyền TM đối với nhiễm trùng do tụ cầu vàng *(MSSA/MRSA)*. Điều trị kháng sinh chống nấm thường được cho 2 tuần sau khi rút bỏ đường truyền tĩnh mạch để điều trị nhiễm trùng huyết do Candida.

Tiên lượng: Tốt nếu đường truyền tĩnh mạch được rút bỏ trước khi xảy ra viêm nội tâm mạc/lan tràn ổ di bệnh nhiễm trùng.

Nhiễm trùng catheter tĩnh mạch trung tâm loại bán vĩnh viễn Hickman/Broviac

Biểu hiện lâm sàng: Sốt ± ban đỏ da tại vị trí truyền tĩnh mạch.

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu dương tính cộng với quét gallium thấy có bắt giữ

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

chất đánh dấu ở đầu catheter giúp chẩn đoán.

Lưu ý: Sử dụng kháng sinh sẽ làm bệnh nhân bớt sốt hơn song bệnh nhân thường sẽ không hết sốt nếu chưa rút bỏ đường truyền tĩnh mạch.

Xem xét điều trị: Thường cần rút bỏ đường truyền để điều trị triệt để. Rifampin 600mg (uống) mỗi 24 h/lần giờ có thể được phối hợp thêm vào phác đồ điều trị đường TM/đường uống nếu tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng (*S. aureus*).

Tiên lượng: Tốt đối với các vi sinh vật gây bệnh có độc lực thấp.

Các nhiễm trùng dây dẫn/máy tạo nhịp

Biểu hiện lâm sàng: Các mẫu cấy máu liên tục dương tính mà không có viêm nội tâm mạc ở một bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim.

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu dương tính cộng với quét gallium thấy có bắt giữ chất đánh dấu ở đầu dây dẫn/máy tạo nhịp giúp chẩn đoán. Cần phân biệt nhiễm khuẩn ở dây dẫn hay ở máy tạo nhịp bằng chụp CT/MRI ngực.

Lưu ý: Cấy máu dương tính trong nhiễm khuẩn dây dẫn thường gặp hơn so với nhiễm khuẩn tại buồng máy tạo nhịp. Cấy máu có thể âm tính đối với cả hai trường hợp nói trên, song nhiễm trùng buồng máy tạo nhịp thường gặp âm tính hơn.

Xem xét điều trị: Có thể thay mới riêng dây máy tạo nhịp nếu nhiễm trùng không ảnh hưởng đến máy tạo nhịp. Cần thay máy tạo nhịp mới nếu thiết bị này bị ảnh hưởng, dây dẫn nếu không bị tác động thường có thể để nguyên tại chỗ.

Tiên lượng: Tốt nếu dây dẫn/máy tạo nhịp được thay mới trước khi xảy ra các biến chứng nhiễm khuẩn huyết.

Viêm tắc tĩnh mạch nhiễm khuẩn (septic thrombophlebitis)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiệt độ ≥39°C với ban đỏ da tại chỗ và các dấu hiệu sepsis.

Xem xét chẩn đoán: Có thể sờ thấy thừng tĩnh mạch và mủ tại vị trí truyền khi rút bỏ đường truyền tĩnh mạch.

Lưu ý: Nghi vấn chẩn đoán này nếu có tình trạng có vi khuẩn trong máu tiếp diễn kéo dài và không có nguồn gốc khác gây nhiễm trùng ở một bệnh nhân có đường truyền tĩnh mạch ngoại biên.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Rút bỏ catheter tĩnh mạch. Thường cần mở TM bằng phẫu thuật để điều trị triệt để.

Tiên lượng: Tốt nếu catheter được rút bỏ sớm trước khi xảy ra các biến chứng nhiễm khuẩn huyết.

Các nhiễm trùng cầu nối mạch máu

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nhiễm trùng shunt/ cầu nối động – tĩnh mạch (Điều trị khởi đầu như đối với nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA; nếu sau đó phân lập được tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA, điều trị một cách phù hợp)	Tụ cầu vàng (MRSA)	Daptomycin*†§ 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ***kết hợp với*** Rifampin 300 mg (uống) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Linezolid†§ 600mg(TM) mỗi 12 h/lần ***kết hợp với*** Rifampin†§ 300mg (uống) mỗi 8h/lần	Vancomycin*†§ 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần ***kết hợp với*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Minocyclin †§100mg (TM) mỗi 12h/lần ***kết hợp với*** Rifampin†§ 300mg (uống) mỗi 8h/lần	Linezolid†§ 600mg (uống) mỗi 12h/lần ***kết hợp với*** Rifampin 300 mg (uống) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Minocyclin†§ 100mg (uống) mỗi 12h/lần ***cộng với*** Rifampin†§ 300mg (uống) mỗi 8h/lần
	Tụ cầu vàng (MSSA)	Nafcillin 3 g (TM) mỗi 12h/lần †	Vancomycin 1g hoặc 15 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần *†	Moxifloxacin 400 mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần*†§
	E.faecalis (VSE) Trực khuẩn Gram âm ái khí	Ampicillin 2 g (TM) mỗi 4h/lần*† ***kết hợp với*** Gentamicin 240mg hoặc 3 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần*†	Vancomycin1g hoặc 15mg/kg (TM) mỗi 24h/lần† ***kết hợp với*** Gentamicin 120mg ***hoặc*** 3mg/kg (TM) mỗi 24h/lần*†	
Nhiễm trùng cầu nối động mạch chủ	Tụ cầu vàng *(MSSA)* Trực khuẩn Gram âm ái khí *P.aeruginosa*	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần†** ***hoặc*** Cefepim 2 g (TM) mỗi 12h/lần †**	Piperacillin 4g (TM) mỗi 8 giờ† ***hoặc*** Moxifloxacin400mg (TM) mỗi 24h/lần†	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24 giờ† ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (uống) mỗi 24h/lần†

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MRSA/MSSA (methicillin-resistant/sensitive *S. aureus)*: Tụ cầu vàng kháng/nhạy methicillin; VSE (Vancomycin-sensitive enterococci): cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

** Theo liều duy trì cho bệnh nhân suy thận (CrCl < 10 mL/min) và kiểu điều trị thay thế thận .*

*** Tùy thuộc vào độ nhạy cảm của vi khuẩn với thuốc.*

† Nếu không có biểu hiện viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn, điều trị trong 2 tuần sau khi rút bỏ/thay mới cầu nối. Nếu cầu nối không thể rút bỏ/thay mới, điều trị trong vòng 6 tuần.

§ Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên chọn dùng. Điều trị theo đường uống nếu không có đường vào TM.

Nhiễm trùng cầu nối động tĩnh mạch

Biểu hiện lâm sàng: Sốt/có vi khuẩn trong máu liên tục song không có viêm nội tâm mạc ở một bệnh nhân có cầu nối động tĩnh mạch để lọc máu chu kỳ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng các mẫu cấy máu dương tính liên tục và quét gallium thấy có bắt giữ chất đánh dấu ở cầu nối động tĩnh mạch bị nhiễm trùng. Quét gallium sẽ giúp phát hiện được các nhiễm khuẩn sâu cầu nối động tĩnh mạch không phát hiện được bằng thăm khám lâm sàng.

Lưu ý: Kháng sinh sẽ giúp làm giảm nhiệt độ của bệnh nhân song thường bệnh nhân sẽ không hết sốt nếu không tiến hành thay cầu nối động tĩnh mạch.

Xem xét điều trị: Thường cần phải rút bỏ cầu nối để điều trị triệt để. Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) là một nguyên nhân hiếm gặp của nhiễm khuẩn cầu nối động tĩnh mạch; nếu có, cần điều trị bằng linezolid 600mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần tới khi rút bỏ/thay một cầu nối mới.

Tiên lượng: Tốt nếu cầu nối mới không trở nên bị nhiễm khuẩn ở cùng vị trí với cầu nối vừa được rút bỏ.

Nhiễm trùng cầu nối động mạch chủ

Biểu hiện lâm sàng: Các mẫu cấy máu dương tính dai dẳng song không có viêm nội tâm mạc ở một bệnh nhân có cầu nối động mạch chủ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy máu dương tính cộng với quét gallium thấy có bắt giữ chất đánh dấu ở cầu nối động mạch chủ bị nhiễm trùng hoặc bằng chụp CT/MRI bụng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Nhiễm khuẩn điển hình xảy ra tại vị trí cầu nối động mạch chủ.

Xem xét điều trị: Cần phải rút bỏ cầu nối để điều trị triệt để. Phẫu thuật càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán được khẳng định. Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) là một nguyên nhân hiếm gặp của nhiễm khuẩn cầu nối động mạch chủ; nếu có tình trạng này, điều trị bằng linezolid 600mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần tới khi rút bỏ/ thay cầu nối mới.

Tiên lượng: Tốt nếu cầu nối nhiễm khuẩn được rút bỏ trước khi xảy ra các biến chứng của nhiễm khuẩn huyết.

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Viêm thực quản

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nấm	*Candida albicans*	Fluconazol 200mg (TM hoặc uống) x 1 liều, sau đó 100mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần x 2- 3tuần	Micafungin 150mg (TM) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần ***hoặc*** Caspofungin 50mg (TM) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần ***hoặc*** Anidulafungin 100 mg (TM hoặc uống) x 1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần ***hoặc*** Amphotericin B deoxycholat 0,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần ***hoặc*** Itraconazol 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 ngày, sau đó 200mg (TM) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần.	Fluconazol 200mg (uống) x 1 liều, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần* ***hoặc*** Posaconazol 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 1 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** dung dịch Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần x 2-3 tuần.
Virus	HSV-1	Acyclovir 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x 3 tuần	Valacyclovir 500 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Famciclovir 500 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 tuần	
	CMV	Ganciclovir 5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 3 tuần	Valgaciclovir 900 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 tuần	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: HSV-1: Herpes simplex virus typ 1; CMV: Cytomegalovirus

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

**Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

Biểu hiện lâm sàng: Đau khi nuốt.

Chẩn đoán: Nhuộm/cấy tìm nấm/Herpes simplex virus (HSV)/CMV đối với bệnh phẩm sinh thiết.

Viêm thực quản do nấm (Candida)

Xem xét chẩn đoán: Hiếm gặp hoặc thậm chí không bao giờ xảy ra ở người bình thường. Thường gặp song không phải lúc nào cũng được kết hợp với nhiễm Candida ở miệng. Nếu bệnh nhân không phải là người nghiện rượu hoặc bị đái tháo đường và hiện không đang dùng kháng sinh, cần test tìm HIV.

Lưu ý: Điều trị thử được coi như một thử nghiệm chẩn đoán thích hợp. Cần đặt nghi vấn bị bệnh liên quan với CMV và tiến hành nội soi nếu bệnh nhân có những triệu chứng điển hình song không đáp ứng với điều trị chống nấm.

Xem xét điều trị: Ở người bình thường, điều trị cần kéo dài 1 tuần sau khi có cải thiện tình trạng lâm sàng. Bệnh nhân nhiễm HIV đáp ứng chậm hơn so với các đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường và có thể cần dùng liều cao hơn/điều trị kéo dài 2-3 tuần sau khi tình trạng lâm sàng đã thoái triển (***trang 552***) .

Tiên lượng: Liên quan với mức độ giảm miễn dịch của bệnh nhân.

Viêm thực quản do virus

Xem xét chẩn đoán: Hiếm gặp ở người bình thường. Có thể xảy ra ở người bị ức chế miễn dịch.

Lưu ý: Các loét thực quản do virus và không do virus trông tương tự nhau, cần sinh thiết để chẩn đoán virus gây bệnh đặc hiệu.

Xem xét điều trị: Ở người bình thường, điều trị kéo dài 2–3 tuần sau khi lâm sàng cải thiện. Bệnh nhân nhiễm HIV đáp ứng chậm hơn và có thể cần điều trị trong nhiều tuần sau khi biểu hiện lâm sàng đã thoái triển.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng (*H. pylori*)

Phác đồ 3 thuốc	Phác đồ 4 thuốc	Phác đồ nối tiếp
Thuốc ức chế bơm proton + amoxicillin 1g (uống) mỗi 12h/lần ***kết hợp với hoặc*** clarithromycin 500mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** tinidazol (hoặc metronidazol) 500mg (uống) mỗi 12h/lần; tất cả các phác đồ trên kéo dài 2 tuần	Thuốc ức chế bơm proton + metronidazol 500mg (uống) mỗi 12h/lần + doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần + bismuth subsalicylat 525mg (uống) mỗi 6h/lần; Tất cả các phác đồ trên kéo dài 2 tuần	**5 ngày**: Thuốc ức chế bơm proton + amoxicillin 1 g (uống) mỗi 12h/lần. **5 ngày tiếp theo**: Thuốc ức chế bơm proton ***kết hợp với hoặc*** clarithromycin 500mg (uống) mỗi 12/lần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24 giờ

Xem xét chẩn đoán: ***Test xâm lấn***: Test nhanh phát hiện urease, mô bệnh học, nuôi cấy. ***Test không xâm lấn***: Test ELISA huyết thanh, test urê hơi thở, test tìm kháng nguyên trong phân (kháng thể đơn dòng clọn).

Lưu ý: Test tìm *H. pylori* bị âm tính giả khi dùng kháng sinh, bismuth, thuốc ức chế bơm proton.

Xem xét điều trị: Xem phác đồ điều trị trong bảng trên. ***Thất bại điều trị***: thay thế amoxicillin bằng bismuth hoặc thay thế clarithromycin, metronidazol hoặc tinidazol bằng nitazoxanid 1g (uống) mỗi 12h/lần. Tất cả các phác đồ trên kéo dài trong 2 tuần. ***Phác đồ điều trị 1 tuần thường bị thất bại***.

Tests chứng tỏ đã điều trị khỏi tình trạng nhiễm *H.pylori*: Test urê trong hơi thở thực hiện 4–6 tuần sau điều trị. Test tìm kháng nguyên trong phân thực hiện 6–8 tuần sau điều trị. Ngừng dùng thuốc ức chế bơm proton 2 tuần trước khi tiến hành làm lại test.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thủng dạ dày

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Thủng dạ dày	Các vi khuẩn kị khí ở miệng	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần x 1-3 ngày	Bất kỳ beta-lactam nào (TM) x 1-3 ngày	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 1-3 ngày ***hoặc*** Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 1-3 ngày ***hoặc*** Quinolon* (uống) mỗi 24h/lần x 1-3 ngày

** Levofloxacin 500mg hoặc Moxifloxacin 400mg.*

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện cấp tính với sốt và viêm phúc mạc.

Xem xét chẩn đoán: Tiến hành chụp CT/MRI ổ bụng để phát hiện tình trạng thủng/ổ dịch đọng.

Lưu ý: Không cần dùng kháng sinh bao phủ *B. fragilis* đối với thủng dạ dày/thủng ruột non.

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn ngoại khoa về chỉ định phẫu thuật khâu chỗ thủng.

Tiên lượng: Tốt nếu bệnh nhân được phẫu thuật khâu chỗ thủng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ỉa chảy nhiễm khuẩn/Sốt thương hàn (thể ruột)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Ỉa chảy phân nước cấp tính	*E.coli* (ETEC,EHEC) Campylobacter *Yersinia salmonella* *Vibrio sp.*	Quinolon†(TM hoặc uống) ×5 ngày	Doxycyclin 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần ×5 ngày ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1 DS (uống) mỗi 12h/lần ×5 ngày

Ỉa chảy/ viêm đại tràng do *C.difficile.*	*Clostridium difficile*	**Ỉa chảy**[†§] ***Giai đoạn khởi đầu:*** Vancomycin 250mg (uống) mỗi 6h/lần × 7–10 ngày* (nếu không cải thiện sau 3 ngày, tăng liều lên 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×7 ngày)** ***Tái phát:*** Vancomycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×14 ngày** ***Tái diễn hay hồi quy:***[††] Vancomycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×1 tháng (***không được giảm liều vancomycin***). Nếu có một đợt tái phát mới, điều trị lại bằng Vancomycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần × 2 tháng. Nếu tiếp tục tái phát, điều trị lại bằng Vancomycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần × 3 tháng. Nếu liều không giảm dần và không có kèm viêm đại tràng, **có nghĩa chế độ trị liệu này không thất bại!** Nếu tình trạng ỉa chảy vẫn tiếp diễn, loại trừ chẩn đoán viêm đại tràng do *C. difficile* hoặc tìm kiếm chẩn đoán thay thế khác.	**Tiêu chảy** ***Giai đoạn đầu:*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Metronidazol 250mg (uống) mỗi 6h/lần × 7–10 ngày* ***Tái phát:*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×7–10 ngày ***Tái diễn:*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Rifaximin 400mg (uống) mỗi 8h/lần × 10 ngày ***hoặc*** Fidoxamicin 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 10 ngày

Từ viết tắt: ETEC (Enterotoxin of Escherichia Coli): *E. Coli* sinh độc tố ruột; EHEC (Entero Haemorrhagic Escherichia Coli): *E.Coli* gây chảy máu ruột.

* ***Thất bại điều trị thường gặp với phác đồ dùng Vancomycin 125 mg (uống) mỗi 6h/lần và với Metronidazol ở bất kỳ liều nào, (điều trị bằng Flagyl thường xuyên bị thất bại).***

** *Nếu không thấy có cải thiện sau dùng Vancomycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 3 ngày,* ***cần loại trừ viêm đại tràng bằng chụp CT bụng.*** *Nếu chụp cắt lớp vi tính bụng cho thấy có* ***viêm đại tràng,*** *cần điều trị như* ***viêm đại tràng*** *do C. difficile.*

† *Khi đang điều trị ỉa chảy hoặc viêm đại tràng do C. difficile,* ***ngừng dùng các kháng sinh có nguy cơ tiềm ẩn cao gây nhiễm khuẩn do C. difficile****, Vd:* ***clindamycin, ciprofloxacin, a-lactams*** *(ngoại trừ ceftriaxon). Các bệnh nhân đang được điều trị bằng levofloxacin hoặc moxifloxacin không nên điều trị đồng thời thuốc ức chế bơm proton. Cần hoặc ngừng dùng thuốc ức chế bơm proton hoặc chuyển sang dùng một thuốc chẹn H_2 trong khi đang điều trị bằng quinolon.*

†† ***Tránh "điều trị dự phòng" C. difficile.*** *Không điều trị các bệnh nhân* ***"có tiền sử nhiễm C. difficile."***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thay vào đó, tiến hành làm test PCR nhắc lại tìm C. difficile trong phân để khẳng định chẩn đoán. Chỉ điều trị ỉa chảy do C. difficile nếu test PCR dương tính đối với C. difficile.

§ ***Tránh dùng thuốc chống co thắt cơ trơn ruột cho bệnh nhân bị ỉa chảy do C. difficile**; sử dụng thuốc này có thể gây viêm đại tràng do C. difficile.*

§§ *Cắt bỏ đại tràng có thể cứu sống bệnh nhân trong viêm nặng toàn bộ đại tràng do C. difficile.*

Ỉa chảy nhiễm khuẩn/Sốt thương hàn (thể ruột) (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Ỉa chảy/viêm đại tràng do *C.difficile.* (tiếp)	*Clostridium difficile*	**Viêm đại tràng** ***Giai đoạn khởi đầu***: Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***cộng với*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24 giờ (đến khi viêm phúc mạc kết hợp được giải quyết) **Viêm toàn bộ đại tràng nặng**:§§ Metronidazol 500mg (TM/uống) mỗi 6–8h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***cộng với*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***kết hợp với*** Tigecyclin 200mg (TM) × 1 liều, sau đó 100 mg (TM) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh **Tái phát *hoặc* tái diễn**: Điều trị lại bằng Metronidazol 500mg (TM/uống) mỗi 6–8h/lần tới khi chữa khỏi bệnh	**Viêm đại tràng** ***Giai đoạn khởi đầu***: Metronidazol 250mg (uống) mỗi 6h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***cộng với*** Tigecyclin 200mg (TM) × 1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh **Tái phát *hoặc* tái diễn**: Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh
Viêm đại tràng do Cyto-megalovirus	CMV	Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần × 21 ngày; đối với HIV, ***Xem trang*** 548	

§ *Cắt bỏ đại tràng có thể cứu sống bệnh nhân trong viêm toàn bộ đại tràng nặng do C. difficile.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ỉa chảy nhiễm khuẩn/ Sốt thương hàn (thể ruột) (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Sốt thương hàn (enteric)	*Salmonella typhi/ paratyphi*	Quinolon†(TM hoặc uống) × 10–14 ngày ***hoặc*** TMP–SMX 5mg/kg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần× 10–14 ngày	Chloramphenicol 500mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần × 10–14 ngày ***hoặc*** Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM hoặc uống) × 10–14 ngày ***hoặc*** Azithromycin1g (uống) mỗi 24h/ lần × 5 ngày
Ỉa chảy phân nước mạn tính	*Giardia lamblia**	Tinidazol 2g (uống)× 1 liều ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12 giờ × 3 ngày ***hoặc*** Metronidazol 2g (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày	Albendazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần × 5 ngày ***hoặc*** Quinacrin 100mg (uống) mỗi 8h/ lần × 5 ngày
	Cryptosporidia*	Nitazoxanid 500mg (uống) 12h/lần× 5 ngày§	Paromomycin 500–750mg (uống) mỗi 8h/lần tới khi đáp ứng ***hoặc*** Azithromycin 600mg (uống) mỗi 24h/lần × 4 tuần
	Isospora* Cyclospora*	TMP–SMX viên nén hàm lượng 1 DS (uống) mỗi 12h/lần × 10 ngày‡	
Bệnh lỵ cấp tính	*Entamoeba histolytica*	<u>*Điều trị được ưu tiên lựa chọn*</u>: Metronidazol 750mg (uống) mỗi 8h/lần × 10 ngày, tiếp theo hoặc bằng Iodoquinol 650mg (uống) mỗi 8h/lần × 20 ngày hoặc Paromomycin 500mg (uống) mỗi 8h/lần × 7 ngày <u>*Điều trị thay thế*</u>: Tinidazol 1g (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày	
	Shigella	Quinolon† (TM hoặc uống) × 3 ngày	TMP–SMX viên nén hàm lượng 1 DS (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần × 3 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, thời gian điều trị theo đườnguống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

** Cũng có thể được biểu hiện như một ỉa chảy phân nước cấp tính.*

† Ciprofloxacin 400mg (TM) hoặc 500mg (uống) mỗi 12 giờ hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.

§ Có thể cần tới một thời gian điều trị dài hơn ở các bệnh nhân bị ức chế miễn dịch (điều trị tới khi khỏi hẳn).

Ỉa chảy phân nước cấp

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với ỉa chảy phân nước song không có máu/nhầy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân.

Lưu ý: Kháng sinh được khuyến cáo là các thuốc có hoạt tính đối với hầu hết các tác nhân gây bệnh vi khuẩn sinh độc tố ruột gây ỉa chảy nhưng không có hoạt tính đối với virus/ký sinh trùng. Thiếu hụt lactase tạm thời xảy ra đồng thời có thể kéo dài tình trạng ỉa chảy nếu bệnh nhân dùng các sản phẩm sữa trong khi đang bị ỉa chảy nhiễm khuẩn.

Xem xét điều trị: Tránh dùng norfloxacin và ciprofloxacin do nguy cơ kháng thuốc tiềm tàng. V. cholerae có thể được điều trị bằng một liều duy nhất của bất kỳ một quinolon hô hấp hoặc doxycyclin dùng theo đường uống.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt. Hầu hết các trường hợp sẽ khỏi nhờ điều trị hỗ trợ.

Viêm đại tràng/Ỉa chảy do *Clostridium difficile*

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy phân nước với thể tích lớn xảy ra tiếp theo phơi nhiễm với vật bị nhiễm bẩn *C. difficile*, tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn *C. difficile*, điều trị hóa chất chống ung thư gần đây hoặc điều trị một số loại kháng sinh (không phải với tất cả các kháng sinh). Hầu như có liên quan với sử dụng clindamycin, ciprofloxacin và β-lactam (ngoại trừ ceftriaxon) .

Xem xét chẩn đoán: Ỉa chảy phân nước với độc tố *C. difficile* trong phân dương tính. Chỉ cần xét nghiệm tìm độc tố *C. difficile* trong phân làm theo kỹ thuật PCR dương tính đủ độ nhạy/độ đặc hiệu để chẩn đoán (mục tiêu điều trị là kết thúc ỉa chảy, mà không phải là làm độc tố trong phân trở thành âm tính); ***Nếu độc tố trong phân âm tính, không cần làm lại test***. Nếu nghi vấn bị viêm đại tràng do

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

C. difficile ở bệnh nhân có *C. difficile* dương tính với sốt/tăng bạch cầu nổi trội/ đau bụng, cần khẳng định chẩn đoán bằng chụp cắt lớp vi tính bụng.

Lưu ý: Viêm đại tràng do *C. difficile* được gợi ý dựa vào có tình trạng tăng bạch cầu không thể giải thích được bằng một nguyên nhân khác, tăng tốc độ lắng hồng cầu, đau bụng và nhiệt độ thường > 39°C; Khẳng định chẩn đoán bằng chụp CT/MRI bụng. Các chủng *C. difficile* có độc lực cao có thể được biểu hiện bằng viêm đại tràng với nhiệt độ ≤39°C, tăng số lượng bạch cầu (thường rất cao, Vd: 25–50 x10^3/mm^3), song ít/không đau bụng; Khẳng định chẩn đoán bằng chụp CT/MRI bụng. Về phương diện hình ảnh học viêm đại tràng do *C. difficile* điển hình là một viêm toàn bộ đại tràng. Các trường hợp viêm từng đoạn đại tràng gợi ý các căn nguyên khác không phải do *C. difficile*, Vd: viêm đại tràng thiếu máu cục bộ. Xét nghiệm tìm độc tố của *C. difficile* có thể vẫn dương tính trong phân sau khi tình trạng ỉa chảy đã thoái triển; Ở các bệnh nhân đang được tiến hành nuôi dưỡng qua đường ruột, ỉa chảy nhiều khả năng do nuôi dưỡng qua đường ruột (tốc độ truyền quá cao/nồng độ thẩm thấu cao) thay vì do nhiễm khuẩn *C. difficile*. Ỉa chảy do norovirus có thể gần giống với ỉa chảy do *C.difficile* hoặc các vụ dịch đồng thời có thể xảy ra. Vancomycin có thể không hiệu quả trong điều trị viêm đại tràng do *C. difficile*.

Xem xét điều trị: Đối với ỉa chảy do *C. difficile*, vancomycin hoặc nitazoxanid dùng theo đường uống là điều trị được ưu tiên lựa chọn dùng; Flagyl thường thất bại. Rifaxamin và Fidaxomycin không có ưu điểm gì hơn so với vancomycin. Khi điều trị có hiệu quả, ỉa chảy do *C. difficile* bắt đầu cải thiện ≤ 3 ngày và thường thoái triển sau 5-7 ngày, mặc dù một số bệnh nhân cần tới 10 ngày điều trị. Nếu không thấy có cải thiện với vancomycin 250mg (uống) mỗi 6h/lần, tăng liều tới 500mg (uống) mỗi 6h/lần hoặc sử dụng nitazoxanid. ***Không điều trị các trường hợp ỉa chảy với test C. difficile âm tính bằng vancomycin hoặc metronidazol đường uống***. Đối với **viêm đại tràng do *C. difficile***, điều trị tới khi viêm đại tràng thoái triển hoàn toàn (theo dõi bằng xét nghiệm tốc độ máu lắng/ chụp CT bụng làm theo serie). Phối hợp thêm điều trị bao phủ cả trực khuẩn Gram âm ái khí đối với viêm phúc mạc vi thể/đại thể có tăng tốc độ máu lắng bằng ertapenem. Tigecyclin là điều trị bằng một thuốc duy nhất có hiệu quả cao đối với viêm đại tràng do *C. difficle* và thuốc cũng có tác dụng bao phủ đối với *B.fragilis* (để điều trị tình trạng viêm phúc mạc vi thể/đại thể kết hợp). ***Tránh dùng*** *thuốc ức chế nhu động ruột, ví dụ: loperamid để điều trị ỉa chảy do C. difficile vì thuốc có thể gây viêm đại tràng do C.difficile/ phình đại tràng nhiễm độc (toxic megacolon)*

Tiên lượng: Tiên lượng đối với ỉa chảy do *C. difficile* cực kỳ tốt. Tiên lượng viêm đại tràng do *C.difficile* có liên quan với độc lực của chủng vi khuẩn gây bệnh/và mức độ rộng của viêm đại tràng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt thương hàn thể ruột (*Salmonella typhi/Paratyphi*)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt cao (> 39°C) tăng dần thành hình bậc thang đi kèm với tình trạng nhịp tim chậm tương đối (song không có rét run) ở bệnh nhân bị ỉa chảy phân nước/táo bón, đau đầu, chán ăn, đau bụng, ho khan/đau họng, gan to căng mềm ± ban da mẩu hồng cánh sen (ở bụng). Tác động tâm thần gây bộ mặt vô cảm đặc trưng cho sốt thương hàn. Giảm tiểu cầu thường gợi ý chẩn đoán khác Vd: sốt rét hoặc đồng nhiễm virus như sốt Dengue.

Xem xét chẩn đoán: Hầu hết các ỉa chảy phân nước mắc phải từ cộng đồng không đi kèm với nhiệt độ > 39°C và nhịp tim chậm tương đối. Chẩn đoán được khẳng định bằng cách chứng minh có Salmonella trong máu, tủy xương, ở các ban da mẩu hồng cánh sen hoặc cấy phân. Cấy tủy xương là một phương pháp chẩn đoán tin cậy nhất/nhanh nhất. Số lượng bạch cầu thường thấp/giới hạn bình thường thấp. Tăng bạch cầu có thể gợi ý các chẩn đoán khác hoặc có biến chứng thủng ruột non và biến chứng này có thể xảy ra trong tuần thứ hai của sốt thương hàn.

Lưu ý: Ban da mẩu hồng cánh sen (Rose spots) chỉ có một vài đốm/khó quan sát và không được gặp ở tất cả các trường hợp. Sốt thương hàn thường được biểu hiện bằng táo bón, mà không phải là ỉa chảy. Tình trạng rét run nặng không phải là một dấu hiệu đặc trưng của sốt thương hàn, nếu thấy có tình trạng sốt rét run cần nghĩ đến chẩn đoán sốt rét.

Xem xét điều trị: Các cephalosporin thế hệ 2, aztreonam và aminoglycosid không có hiệu quả điều trị. Do các chủng Salmonella gây sốt thương hàn thể ruột là các vi sinh vật nội tế bào, điều trị đủ 2 tuần để tối đa hóa tỉ lệ chữa khỏi bệnh/ giảm thiểu tối đa tình trạng tái phát. Điều trị các đợt tái phát bằng các kháng sinh được gợi ý × 2–3 tuần. Bài xuất Salmonella vào phân thường kéo dài < 3 tháng. Bài xuất tiếp diễn liên tục vi khuẩn > 3 tháng gợi ý tình trạng người lành mang vi khuẩn- cần loại trừ sỏi gan mật/tiết niệu.

Tiên lượng: Tiên lượng tốt nếu được điều trị sớm. Tiên lượng tồi nếu điều trị muộn/thủng ruột non.

Ỉa chảy phân nước mạn tính

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy phân nước song không có máu/chất nhầy kéo dài > 1 tháng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật/bào nang trong mẫu bệnh phẩm phân. Thường cần tiến hành lấy và phân tích nhiều

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

mẫu bệnh phẩm phân tươi hàng ngày để chẩn đoán nhất là đối với ký sinh trùng đơn bào.

Lưu ý: Tình trạng thiếu hụt lactase tạm thời xẩy ra đồng thời có thể làm kéo dài la chảy nếu bệnh nhân tiếp tục sử dụng các chế phẩm sữa trong khi bị ỉa chảy nhiễm khuẩn.

Xem xét điều trị: Cryptosporidia và Isospora đang được ghi nhận là ngày càng gia tăng trong la chảy cấp/mạn tính ở đối tượng là người khỏe mạnh.

Tiên lượng: Cực tốt ở các bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt. Các bệnh nhân không được điều trị có thể xuất hiện tình trạng giảm hấp thu.

Do Giardia lamblia

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp/bán cấp tình trạng la chảy, đau quặn bụng, chướng bụng, đầy hơi. Giai đoạn ủ bệnh kéo dài 1–2 tuần. Tình trạng giảm hấp thu có thể xẩy ra ở các trường hợp mạn tính. Không có tăng bạch cầu ưa acid.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có thể tư dưỡng (trophozoites) hoặc bào nang (cysts) trong phân/test phát hiện kháng nguyên. Nếu xét nghiệm phân và test phát hiện kháng nguyên âm tính mà vẫn nghi vấn có tình trạng nhiễm kí sinh trùng Giardia, tiến hành "string test"/hút dịch và sinh thiết tá tràng (duodenal aspirate and biopsy) tìm kí sinh trùng.

Lưu ý: Ký sinh trùng đơn bào được bài tiết vào phân từng lúc. Thường cần tiến hành xét nghiệm nhiều mẫu phân để chẩn đoán. Bệnh nhân thường có kèm với tình trạng không dung nạp tạm thời với lactose.

Xem xét điều trị: Nitazoxanid là điều trị có hiệu quả. Tình trạng la chảy có thể kéo dài nếu bệnh nhân sử dụng các sản phẩm sữa (hoặc các sản phẩm chứa lactose) sau khi điều trị/đã chữa khỏi nhiễm ký sinh trùng. Có thể cần lặp lại liệu trình điều trị .

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của tình trạng giảm hấp thu và tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân.

Do Cryptosporidia

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp/bán cấp tính tình trạng la chảy. Thường xẩy ra ở bệnh nhân nhiễm HIV với số lượng tế bào $CD_4 < 200$. Nhiễm Cryptosporidia đường mật chỉ được gặp ở người nhiễm HIV; có thể được biểu hiện như viêm túi mật không có sỏi (acalculous cholecystitis) hoặc viêm đường mật xơ hóa (sclerosing cholangitis) với đau ở vùng hạ sườn phải, sốt, tăng nồng độ phosphatase kiềm, song nồng độ bilirubin bình thường.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trong phân/bệnh phẩm sinh thiết ruột. Tình trạng bệnh lý giống bệnh tả ở đối tượng là người khỏe mạnh. Gây ỉa chảy mạn phân nước ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

Lưu ý: Ký sinh trùng này có kích thước nhỏ hơn so với Cyclospora. Thành của noãn nang mịn (không bị nhăn nheo) khi được nhuộm kỹ thuật kháng acid (acid fast Staining).

Xem xét điều trị: Điều trị bằng nitazoxanid có hiệu quả.

Tiên lượng: Liên quan với bội phụ dịch có thỏa đáng hay không/tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Do Cyclospora

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp/bán cấp tình trạng ỉa chảy. Giai đoạn ủ bệnh kéo dài 1–14 ngày.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trong phân/mẫu bệnh phẩm sinh thiết ruột. Về lâm sàng không thể phân biệt được với ỉa chảy do Cryptosporidia (ỉa chảy phân nước từng lúc không có máu hoặc nhầy). Mệt mỏi/sút cân thường gặp.

Lưu ý: Các noãn nang chỉ được thấy trong phân và xác định tốt nhất bằng phương pháp nhuộm kháng acid được sửa đổi của Kinyoun. Các giọt mỡ kháng acid có màu hồng khi được nhuộm bằng phương pháp nhuộm kháng toan. Các noãn nang có "thành nhăn nheo" đặc trưng cho Cyclospora, song không gặp đối với Cryptosporidia. Các noãn nang bào có hình dáng tương tự song có thể tích to gấp đôi so với thể tích của Cryptosporidia (~ 10µm so với 5µm).

Xem xét điều trị: Điều trị bằng Nitazoxanid có hiệu quả.

Tiên lượng: Liên quan với bội phụ dịch có thỏa đáng hay không/tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Bệnh lỵ cấp tính

Do Entamoeba histolytica

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp/bán cấp với ỉa chảy phân máu/nhầy. Bạch cầu/hồng cầu trong phân do amip xâm lấn niêm mạc. *E. histolytica* cũng có thể gây ỉa chảy mạn tính. Ổ loét đại tràng thứ phát do *E. histolytica* mạn tính có dạng tròn và có thể hình thành các ápxe "hình khuy áo".

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật/thể tư dưỡng (trophozoites) của ký sinh trùng trong phân/bệnh phẩm sinh thiết ruột. Huyết thanh học âm tính với lỵ amíp, song dương tính với các thể ngoài ruột của amip. Cần làm test để phân biệt giữa *E. histolytica* (gây bệnh lỵ amip cấp tính) với E không gây bệnh (non-pathogen E) ở người mang không thể hiện bệnh. Khi nội soi đại tràng Sigma, các ổ loét do *E. histolytica* tròn xen kẽ với niêm mạc bình thường giữa các ổ loét và có thể hình thành các ápxe "hình khuy áo". Trái lại, các ổ loét do Shigella có dạng đường thẳng, bờ nham nhở và không có niêm mạc bình thường đan xen giữa các ổ loét. Lỵ chảy máu do *E.histolytica* bán cấp hơn so với Shigella.

Lưu ý: Thủng ruột/ápxe ruột có thể là biến chứng của viêm đại tràng do amip. Cần loại trừ các nguyên nhân nhiễm khuẩn gây ỉa chảy phân máu và nhầy trước khi chẩn đoán/điều trị các bệnh ruột do viêm. Tiến hành nuôi cấy phân nhiều lần để tìm tác nhân gây bệnh là vi khuẩn/ký sinh trùng. Không được nhầm *E. histolytica* trong mẫu bệnh phẩm phân với *E. hartmanni*, một đơn bào không gây bệnh có hình dạng rất giống nhưng có kích thước nhỏ hơn.

Xem xét điều trị: Người mang bào tử *E. histolytica* cần được điều trị, song metronidazol không có hiệu quả đối với bào tử. Các kháng sinh được khuyến cáo giúp điều trị *E.histolytica* ở ruột và gan. Sử dụng paromomycin 500mg (uống) mỗi 8h/lần × 7 ngày để điều trị các thể bào tử không triệu chứng.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm. Tiên lượng có liên quan với mức độ nặng của lỵ amip/ loét ruột do amip/nhiễm amip ngoài ruột.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Do Shigella

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với ỉa chảy phân máu/nhầy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh được vi sinh vật trong mẫu bệnh phẩm phân. Các ổ loét do Shigella ở đại tràng có dạng thẳng, bờ nham nhở và hiếm khi dẫn tới thủng ruột.

Xem xét điều trị: Bệnh lỵ do Shigella có tính cấp tính/bùng phát hơn so với lỵ do amip. Shigella không có tình trạng người lành mang vi khuẩn, khác với Entamoeba.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm. Mức độ nặng của bệnh có liên quan với các chủng *Shigella* gây bệnh: *S. dysenteriae* (nặng nhất) > *S. flexneri* > *S. boydii/S. sonnei* (nhẹ nhất).

Viêm túi mật

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Người có sức khỏe nền bình thường	*E. coli* Klebsiella *E.faecalis* (VSE)	Meropenem1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Tigecyclin 100mg (TM) × 1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/ lần*	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần* ± Ampicillin 1g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Quinolon‡ (TM)*	Quinolon‡ (uống)*
Viêm túi mật khí thũng † (emphyse-matous cholecystitis)	*Clostridium perfringens* *E. coli*	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ¶ ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần¶	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần¶ ***hoặc*** Ticarcillin/acid clavulanic 3,1g (TM) mỗi 6h/lần¶	Clindamycin 300 mg (uống) mỗi 8h/lần

Từ viết tắt: VSE (Vancomycin-sensitive enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, thời gian điều trị đường uống hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

† *Chỉ điều trị đường TM hoặc chuyển từ điều trị đường TM sang đường uống.*

‡ *Ciprofloxacin 400 mg (TM) hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400 mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.*

* *Nếu không cắt bỏ túi mật, điều trị × 5–7 ngày. Nếu tiến hành cắt túi mật, điều trị × 3–4 ngày sau mổ.*

¶ *Điều trị × 4–7 ngày sau cắt túi mật.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm túi mật

Biểu hiện lâm sàng: Đau vùng hạ sườn phải, sốt thường ≤39°C, dấu hiệu Murphy dương tính, không có dấu hiệu gõ đau trên xương sườn dưới bên phải.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng siêu âm vùng hạ sườn phải /scan HIDA dương tính.

Lưu ý: Không cần dùng thuốc bao phủ đối với *B. fragilis.*

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn ngoại khoa về khả năng cắt túi mật.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng tim – phổi của bệnh nhân.

Viêm túi mật khí thũng (Emphysematous Cholecystitis)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện lâm sàng như viêm túi mật. Thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường.

Xem xét chẩn đoán: Khí ở vùng hạ sườn phải/ trong túi mật trên phim chụp bụng tư thế nằm ngửa.

Lưu ý: Cần tiến hành mổ cắt túi mật ngay.

Xem xét điều trị: Quá trình hậu phẫu thường khó /kéo dài.

Tiên lượng: Phụ thuộc vào phẫu thuật cắt túi mật sớm hay muộn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm đường mật

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Người có sức khỏe nền bình thường	*E. coli* Klebsiella *E. faecalis* (VSE)	Meropenem 1g(TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Tigecyclin 200mg(TM) x 1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g(TM) mỗi 6h/ lần*	Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Cefoperazon 2g (TM) mỗi 12 giờ/lần* ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8 giờ/lần	Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần*

Từ viết tắt: VSE (Vancomycin-sensitive enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, thời gian điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Điều trị đến khi bệnh lý nền được giải quyết (thường 5–7 ngày).*

Biểu hiện lâm sàng: Đau vùng hạ sườn phải, sốt >39°C, dấu hiệu Murphy dương tính, dấu hiệu gõ đau trên xương sườn dưới bên phải.

Xem xét chẩn đoán: Ống mật chủ bị tắc nghẽn trên hình ảnh siêu âm/chụp CT/MRI ổ bụng.

Lưu ý: Tam chứng Charcot (sốt, đau mạn sườn phải vàng da) chỉ được biểu hiện ở 50% các trường hợp.

Xem xét điều trị: Cần hội chẩn ngoại khoa về chỉ định phẫu thuật giải phóng tình trạng tắc nghẽn đường mật. Tiếp tục dùng kháng sinh 4–7 ngày sau khi đã phẫu thuật giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường mật.

Tiên lượng: Có liên quan với chỉ định phẫu thuật làm giảm tình trạng tắc nghẽn đường mật sớm hay muộn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thủng /Ápxe thành túi mật

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Thủng/ ápxe thành túi mật	*E. coli* Klebsiella *E.faecalis (VSE)*	Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Tigecyclin 100mg (TM) × 1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/ lần* ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần*	Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/ lần* ***hoặc*** Cefoperazon 2g (TM) mỗi 12h/ lần* ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/ lần	Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần*

Từ viết tắt: VSE (Vancomycin-sensitive enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

** Điều trị đến khi bệnh lý nền được giải quyết (thường 1–2 tuần).*

Biểu hiện lâm sàng: Đau vùng mạng sườn phải, sốt ≤39°C, dấu hiệu Murphy dương tính, dấu hiệu gõ đau trên xương sườn dưới bên phải.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI ổ bụng. Viêm phúc mạc mật thường gặp.

Lưu ý: Có thể thấy có tình trạng viêm phúc mạc do vi khuẩn.

Xem xét điều trị: Nên tham khảo ý kiến ngoại khoa về chỉ định cắt bỏ túi mật. Tiến triển hậu phẫu thường khó khăn và kéo dài.

Tiên lượng: Phụ thuộc vào phẫu thuật cắt bỏ túi mật/ mổ khâu chỗ thủng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tụy cấp

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm tụy thể phù nề	Không có	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Viêm tụy hoại tử/chảy máu	Trực khuẩn Gram âm ái khí *B.fragilis*	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần*	Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Ampicillin/sulbactam 1,5g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Ticarcillin/clavulanat 3,1g (TM) mỗi 6h/lần*	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần* ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần* ***hoặc đơn trị liệu bằng*** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Điều trị tới khi giải quyết được bệnh lý nền (thường 1-2 tuần).*

Viêm tụy phù nề

Biểu hiện lâm sàng: Đau bụng dữ dội với sốt ≤39°C ± tụt huyết áp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên tăng nồng độ amylase và lipase huyết thanh với nồng độ methemalbumin bình thường. Có thể do thuốc gây nên (Vd: do steroids) .

Lưu ý: Tăng đơn độc nồng độ amylase máu không đủ để chẩn đoán viêm tụy cấp.

Xem xét điều trị: Không cần đặt ống thông dạ dày. Bồi phụ dịch tích cực cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Tốt khi được bồi phụ dịch thỏa đáng.

Viêm tụy xuất huyết/hoại tử

Biểu hiện lâm sàng: Đau bụng dữ dội với sốt ≤39°C ± tụt huyết áp. Dấu hiệu Grey-Turner/Cullen được gặp ở một số bệnh nhân.

Xem xét chẩn đoán: Tăng nhẹ nồng độ amylase và lipase huyết thanh với nồng độ methemalbumin tăng cao.

Lưu ý: Với tăng nồng độ lipase, nồng độ amylase có mối tương quan nghịch với mức độ nặng của bệnh.

Xem xét điều trị: Nên tham khảo ý kiến ngoại khoa cho chỉ định rửa ổ bụng như một điều trị hỗ trợ cho điều trị kháng sinh. Albumin huyết thanh/dextran được ưu tiên sử dụng để bù thể tích.

Tiên lượng: Tối ở các bệnh nhân có giảm nồng độ canxi máu hoặc có tình trạng sốc.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe tụy/Nang giả tụy nhiễm trùng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nang giả tụy nhiễm trùng/ Ápxe tụy	Trực khuẩn Gram âm ái khí *B. fragilis*	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/ lần*	Ampicillin/ sulbactam 1,5g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Ticarcillin/ clavulanat 3,1g (TM) mỗi 6h/ lần* ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần	Moxifloxacin400mg (uống) mỗi 24h/ lần* ***hoặc điều trị kết hợp với*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần* ***kết hợp với*** Quinolon† (uống)*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

† Ciprofloxacin 500mg mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg mỗi 24h/lần.

** Điều trị tới khi giải quyết được bệnh lý nguyên nhân.*

Biểu hiện lâm sàng: Xảy ra sau một viêm tụy cấp hoặc phát triển trong một nang giả tụy. Nang giả tụy nhiễm khuẩn có triệu chứng tương tự một ápxe. Nhiệt độ thường ≥39°C.

Xem xét chẩn đoán: Chụp CT/MRI ổ bụng chứng minh có ápxe tụy.

Lưu ý: Thường không thấy có các dấu hiệu phúc mạc.

Tiên lượng: Liên quan với kích thước/mức độ lan rộng của ổ ápxe và dẫn lưu ápxe có thỏa đáng hay không.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe gan

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Ápxe gan	Trực khuẩn Gram âm hiếu khí Cầu khuẩn ruột (VSE) *B. fragilis*	Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Tigecyclin100mg (TM) × 1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần*	Quinolon †(TM)* ***kết hợp với hoặc*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần* Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Sulbactam/ ampicillin 3g (TM) mỗi 6h/lần	Amoxicillin/ acid clavulanic 875/125mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần* ***hoặc điều trị kết hợp với*** Quinolon†(uống)* ***kết hợp với hoặc*** Metronidazol 500mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Clindamycin 300 mg (uống) mỗi 8h/ lần*
	E. histolitica	***Xem trang 433***		

Từ viết tắt: VSE (Vancomycin-sensitive enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM,thời gian điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống.

** Điều trị đến khi hết hẳn ổ ápxe hoặc ổ ápxe không còn được giảm kích thướcqua các lần chụp cắt lớp vi tính theo serie.*

† Ciprofloxacin 400 mg (TM) hoặc 500mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, đau hạ sườn phải, dấu hiệu Murphy âm tính và dấu hiệu gõ đau hạ sườn phải âm tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên hình ảnh phim chụp CT/MRI gan và

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hút dịch ápxe. Chụp cắt lớp vi tính cho thấy có nhiều tổn thương trong gan. Nguồn gốc thường là từ đại tràng (viêm túi thừa hoặc ápxe túi thừa với nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn sinh mủ từ khoảng cửa) hoặc nhiễm khuẩn ngược dòng từ túi mật (viêm túi mật hoặc ápxe thành túi mật).

Lưu ý: Các ápxe do vi khuẩn thường có nhiều ổ và tác động tới nhiều thùy của gan. Ápxe do amip thường chỉ có một ổ và tác động tới thùy gan phải.

Xem xét điều trị: Vết rách/chấn thương gan thường đòi hỏi ~ 2 tuần điều trị kháng sinh.

Tiên lượng: Tốt nếu bệnh nhân được điều trị sớm.

Nhiễm trùng Candida xâm lấn nội tạng (hepatosplenic candidiasis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nhiễm trùng Candida gan –lách	*Candida albicans*	Fluconazol 800mg (TM) × 1 liều, sau đó 400 mg (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần ***hoặc*** Micafungin 100mg (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần	Ambisome (L-Amb) (***trang 843***) (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần ***hoặc*** Amphotericin B 0,7mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần	Fluconazol 800mg (uống) × 1 liều, sau đó 400mg (uống) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần* ***hoặc*** Itraconazol dạng dung dịch 200mg (uống) mỗi12h/lần × 2–4 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

Biểu hiện lâm sàng: Các cơn sốt với nhiệt độ đỉnh cao mới xuất hiện sau 2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

kèm với đau hạ sườn phải /đau hạ sườn trái ở bệnh nhân giảm bạch cầu không sốt.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI ổ bụng cho thấy các tổn thương dạng khối trong gan/lách.

Lưu ý: Không được bỏ qua tình trạng sưng đau vùng hạ sườn phải và tăng phosphatase kiềm ở bệnh nhân ung thư có giảm bạch cầu hạt, như một bằng chứng để chẩn đoán.

Xem xét điều trị: Điều trị tới khi tổn thương gan/lách thoái triển hoàn toàn. Nên xem xét tìnhtrạng này như một thể bệnh nhiễm trùng Candida lan tràn hay xâm lấn phủ tạng.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ/thời gian bị giảm bạch cầu hạt .

Bệnh viêm gan u hạt (BCG)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị đường TM ưu tiên
Viêm gan do BCG	*Bacille Calmette-Guérin* (BCG)	INH 300mg (uống) mỗi 24h/lần × 6 tháng + rifampin 600mg (uống) mỗi 24h/lần × 6 tháng

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, rét run, chán ăn, sút cân, gan to ± đau vùng hạ sườn phải nhiều ngày tới nhiều tuần sau truyền BCG vào trong túi mật để điều trị ung thư túi mật.

Xem xét chẩn đoán: Tăng phosphatase kiềm nhiều hơn tăng SGOT/SGPT. Sinh thiết gan âm tính với trực khuẩn kháng cồn-toan (AFB)/dương tính với bệnh lý tạo u hạt.

Lưu ý: Loại trừ các nguyên nhân gây gan to khác.

Xem xét điều trị: INH kết hợp với rifampin × 6 tháng có thể điều trị khỏi cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị sớm.

Bệnh do xoắn khuẩn leptospira (Leptospirosis)

Biểu hiện lâm sàng : Sau ủ bệnh 1-2 tuần, khởi phát đột ngột tình trạng sốt, không rét run, đau đầu dữ dội, xung huyết kết mạc, hội chứng kích thích màng não, ho khan, đau cơ nghiêm trọng (đau cơ nhị đầu/đau khi nắn bóp cơ), kèm

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hoặc không kèm với đau bụng. Pha đầu (leptospira trong máu) kéo dài 4-9 ngày; Pha hai (pha miễn dịch) kéo dài 6-12 ngày. Thường thấy có tăng bạch cầu song không có giảm tiểu cầu. Có tác động tới gan (tăng men gan/ tăng bilirubin máu) và thận (tăng ure máu, protein niệu (+), tiểu nhiều, nước tiểu vô khuẩn hay đái ra mủ). Viêm màng não giai đoạn sớm→ có dấu hiệu viêm màng não cấp do vi khuẩn với dịch não tủy (+) với xoắn khuẩn leptospira. Viêm màng não muộn→ viêm màng não vô khuẩn với dịch não tủy (-) với xoắn khuẩn leptospira. Tình trạng nôn tiến triển, chảy máu cam vàng da/gan lách to chỉ gặp trong hội chứng Weil (nhiễm trùng do xoắn khuẩn leptospira thể vàng da). Đau cơ trầm trọng với tổn thương gan và lách là các bằng chứng gợi ý cho nhiễm trùng xoắn khuẩn leptospira.

Xem xét chẩn đoán: Gần đây có phơi nhiễm do nghề nghiệp hoặc tiếp xúc với nước nhiễm bẩn (chứa nước tiểu chuột). Quan sát thấy xoắn khuẩn Leptospira trong nước tiểu (sau 2 tuần) khi soi bệnh phẩm nước tiểu trên kính hiển vi nền đen. Cấy máu dương tính ở giai đoạn sớm (âm tính ở giai đoạn muộn); cấy nước tiểu dương tính ở giai đoạn muộn. Xoắn khuẩn Leptospira chết nhanh trong môi trường nước tiểu acid (cần cho thêm chất dịch muối đệm trước khi nuôi cấy). Chẩn đoán bằng nuôi cấy máu/nước tiểu hoặc tăng hiệu giá IgM khi làm theo test ngưng kết vi thể (microscopic agglutination test [MAT]) (sau 1 tuần). Điều trị kháng sinh có thể làm hiệu giá kháng thể huyết thanh không tăng, tăng ít hoặc tăng muộn.

Lưu ý: Triệu chứng khá giống cúm (đau đầu, đau họng, đau cơ), bệnh nhân có thể nhớ chính xác giờ khởi phát bệnh. Không giống cúm ở điểm không có rét run và biểu hiện xung huyết kết mạc. Hình ảnh chụp Xquang ngực âm tính khi bị cúm (giai đoạn sớm), song hình ảnh Xquang ngực thường dương tính trong nhiễm trùng do leptospira. Cần chẩn đoán phân biệt với viêm gan virus (thân nhiệt < 39°C, không có xung huyết đỏ kết mạc, giảm bạch cầu, tăng cao transaminase, không có tác động tới thận). Chẩn đoán phân biệt với viêm gan do Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus , Herpes-simplex virus bằng có các tế bào bạch cầu không điển hình (không có trong nhiễm trùng do xoắn khuẩn leptospira) và chẩn đoán huyết thanh đặc hiệu. Giống như viêm màng não vô khuẩn (do virus), dịch não tủy trong nhiễm trùng do leptospira có nồng độ glucose bình thường, số lượng tế bào bạch cầu < 500/vi trường có độ phóng đại lớn [hpf]). Đây là một bệnh lý nhiễm trùng duy nhất có nồng độ bilirubin trong dịch não tủy > nồng độ bilirubin huyết thanh.

Xem xét điều trị: Penicillin hoặc doxycyclin (± phản ứng Jarisch-Herxheimer)

Tiên lượng: Rất tốt nếu điều trị sớm, tỷ lệ tử vong 5-40% trong hội chứng Weil và ở người già.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm gan do virus

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị
Cấp tính	HAV (không có điều trị), HBV (xem xét sử dụng thuốc chống virus nhóm nucleoside đối với suy gan cấp do HBV), HCV (xem xét sử dụng pegylated-Interferon kèm với hoặc không kèm với ribavirin nếu không thấy có sự thanh thải của virus sau 12-16 tuần), HDV (không có điều trị), HEV (xem xét sử dụng ribavirin để điều trị thể viêm gan nặng).	
Mạn tính	HBV*	*Điều trị được ưu tiên lựa chọn*: Tenofovir 300mg (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Entecavir 0,5 mg (uống) mỗi 24h/lần × ≥ 12 tháng *Đối với các chủng virus kháng với lamivudin* sử dụng ***hoặc*** Entecavir 1,0 mg mỗi 24h/lần ***hoặc*** Pegylated interferon alfa-2a 180µg (tiêm dưới da)/ hàng tuần *Không kèm với* ribavirin ×12 tháng *Điều trị thay thế*: Telbivudin 600mg (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Adefovir 10mg (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Lamivudin 100mg (uống) × ≥ 12 tháng
	HCV	**Genotype 1** ***(bao gồm cả 1a và 1b)*** *Điều trị được ưu tiên lựa chọn (hiệu quả tương tự nhau)*: Ledipasvir 90mg/sofosbuvir 400mg (Harvoni) (uống) mỗi 24h/lần x 12 tuần Paritaprevir 150mg/ritonavir 100mg/ombitasvir 25mg (uống) mỗi 24h/lần + dasabuvir 250mg (Viekira Pak) (uống) mỗi 12h/lần + ribavirin[1,2] x hàng tuần[3] Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + simeprevir[4] 150mg (Olysio) (uống) mỗi 24h/lần ± ribavirin[1] × hàng tuần [3] **Genotype 2** *Điều trị được ưu tiên lựa chọn*: Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + ribavirin[1] x 12 tuần (16 tuần khi có xơ gan). **Genotype 3** *Các điều trị được ưu tiên lựa chọn*: Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + ribavirin[1] x 24 tuần *Điều trị thay thế*: Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + pegylated IFN alfa-2a/2b[5] ribavirin[1] x 12 tuần **Genotype 4** *Điều trị được ưu tiên lựa chọn (hiệu quả tương tự nhau)*: Ledipasvir 90mg/sofosbuvir 400mg (Harvoni) (uống) mỗi 24h/lần x 12 tuần Paritaprevir 150mg/ ritonavir 100mg/ ombitasvir 25mg (Viekira Pak minus dasabuvir) (uống) mỗi 24h/lần + ribavirin[1] x 12 tuần. Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + ribavirin[1] x 24 tuần *Điều trị thay thế*: Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + pegylated IFN alfa-2a/2b[5] + ribavirin[1] x 12 tuần, Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + simeprevir 150mg (Olysio) (uống) mỗi 24h/lần ± ribavirin[1] x 12 tuần. **Genotype 5** *Điều trị được ưu tiên lựa chọn*: Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + pegylated IFN alfa-2a/2b[5] + ribavirin[1] x 12 tuần. *Điều trị thay thế*: Pegylated IFN alfa-2a/2b[5] + ribavirin[1] × 48 tuần. **Genotype 6** *Điều trị được ưu tiên lựa chọn*: Ledipasvir 90mg/sofosbuvir 400mg (Harvoni) (uống) mỗi 24h/lần x 12 tuần *Điều trị thay thế*: Sofosbuvir 400mg (Sovaldi) (uống) mỗi 24h/lần + pegylated IFN alfa-2a/2b[5] + ribavirin [1] x 12 tuần
	HDV	Điều trị kéo dài bằng pegylated Interferon alfa-2a song không cần phối hợp với ribavirin như đối với điều viêm gan B mạn tính ***(xem ở trên)***
	HEV	Ribavirin (uống) 600-1200 mg/ngày × 12 tuần hoặc pegylated interferon tiêm hàng tuần × 12 tuần +/- ribavir

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: HAV (Hepatitis A virus): Virus gây viêm gan A; HBV (Hepatitis B virus): Virus gây viêm gan B; HCV (Hepatitis C virus): Virus gây viêm gan C; HDV (Hepatitis D virus): Virus gây viêm gan D; HEV (Hepatitis E virus): Virus gây viêm gan E.

** HBeAg(+) kết hợp với ALT > 2 lần giá trị bình thường và DNA của HBV > 20.000 IU/mL hoặc tiêu chuẩn thay thế là tình trạng nhiễm HBV mạn tính với tình trạng viêm vừa/nặng hoặc có tình trạng xơ hóa có ý nghĩa trên sinh thiết. Đáp ứng điều trị cấp một (Primary therapeutic response) (giảm < 2 log) trong nồng độ DNA của HBV sau ≥ 6 tháng điều trị . Các thất bại điều trị cần được điều trị bằng phác đồ điều trị thay thế hoặc điều trị thêm thuốc.*

[1] Ribavirin cần được dùng với liều như sau:

Trọng lượng < 75kg: Ribavirin 1000mg (uống) hàng ngày chia nhỏ thành 2 liều (400mg vào buổi sáng, 600mg vào buổi chiều tối).

Trọng lượng > 75kg: Ribavirin 1200mg (uống) hàng ngày chia nhỏ thành 2 liều (600mg mỗi 12h/lần)

[2] Đối với Genotype Ib, ribavirin chỉ được chỉ định ở người bị xơ gan.

[3] Điều trị 12 tuần khi không bị xơ gan; điều trị 24 tuần khi bị xơ gan.

[4] Simperevir có thể không có hiệu quả ở các bệnh nhân bị nhiễm HCV thuộc genotype 1a Q80K polymorphism

[5] Nên dùng Pegylated IFN alfa-2a với liều 180µg (tiêm dưới da) 1 tuần/lần. Nên dùng Pegylated IFN alfa-2b với liều 1,5 µg/kg (tiêm dưới da) tuần/lần. Cả hai loại pegylated IFN alfa đã được phê chuẩn cho điều trị genotype 1.

Phỏng theo: *American Association for the Study of Liver Disease and Infectious Disease Society of America . Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C .http://www .hcvguidelines .org, 2014.*

Koff R.S. Hepatitis Essentials. Jones & Bartlett, Sudbury, MA; 2011.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm gan cấp do virus

Biểu hiện lâm sàng: Không có triệu chứng hoặc chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, hội chứng giống bệnh huyết thanh (serum-sickness like syndrome), ± vàng da, nước tiểu sẫm màu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa vào sự hiện diện của IgM kháng HAV trong trường hợp do virus viêm gan A (HAV) hoặc HBsAg và IgM kháng HBc trong trường hợp do virus vêm gan B (HBV); hoặc anti HCV và RNA của HCV trong trường hợp do virus viêm gan C (HCV); hoặc HBsAg, anti-HDV và RNA của HDV trong trường hợp do virus viêm gan D (HDV); hoặc anti-HEV và RNA của HEV trong trường hợp do virus viêm gan E anti-HAV hoặc HBsAg, với tăng rõ rệt aminotransferases huyết thanh (ALT > 400). Phosphatase kiềm trong huyết thanh bình thường/tăng nhẹ; nồng độ albumin máu bình thường hoặc bị giảm nhẹ; INR bình thường hoặc tăng lên nhẹ.

Lưu ý: Cần loại trừ các tác nhân gây viêm gan khác (Vd: Epstein-Barr virus [EBV], Cytomegalovirus [CMV], Herpes-simplex virus [HSV],v.v...) và tổn thương gan do thuốc nếu test huyết thanh học chẩn đoán các virus viêm gan (HAV, HBV, HCV, HDV,và HEV) âm tính.

Xem xét điều trị: Đối với các bệnh nhân xuất hiện bệnh não gan và/hoặc INR kéo dài (suy gan cấp) cho bệnh nhân nhập viện vào các trung tâm có thể tiến hành ghép gan cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Viêm gan A thường tự khỏi; Viêm gan B, C, D và hãn hữu là viêm gan E có thể tiến triển thành viêm gan mạn/xơ gan/ung thư biểu mô tế bào gan.

Viêm gan do Epstein-Barr virus (EBV)/Cytomegalovirus (CMV)

Biểu hiện lâm sàng: Tương tự như viêm gan cấp do virus kết hợp với hạch cổ sau hai bên và mệt mỏi.

Xem xét chẩn đoán: Viêm gan do EBV là một phần của bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn và có thể là dấu hiệu biểu hiện bệnh ở người lớn. Viêm gan do CMV cũng có thể được biểu hiện như một bệnh nhiễm trùng "tăng bạch cầu đơn nhân" ở các đối tượng là người bình thường. Ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, viêm gan có thể là biểu hiện tiên phát của nhiễm khuẩn do CMV. Có thể chẩn đoán viêm gan do EBV/CMV bằng huyết thanh học chẩn đoán (test mono spot dương tính, hiệu giá IgM đối với EBV VCA tăng cao, hiệu giá IgM đối với CMV tăng cao, phát hiện được kháng nguyên CMV ở giai đoạn sớm (qua kỹ thuật nuôi cấy tế bào đơn [shell vial cultures technique]) hoặc kỹ thuật khuếch đại phân tử (molecular amplification technique).

Lưu ý: Ở các đối tượng là người bình thường và đối tượng bị suy giảm miễn dịch bị tăng aminotransferase (ALT/AST) không giải thích được căn nguyên, xem xét khả năng bị viêm gan do CMV và chỉ định tiến hành làm các xét nghiệm thích hợp.

Điều trị: Không có điều trị hữu hiệu nào đối với viêm gan do EBV; Viêm gan do CMV ở người bình thường có thể được điều trị bằng Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần × 12 ngày.

Tiên lượng: Ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường viêm gan do EBV và CMV thường tự khỏi. Ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, tiên lượng của viêm gan do CMV có liên quan với mức độ ức chế miễn dịch và quyết định điều trị sớm hay muộn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm gan virus mạn

Biểu hiện lâm sàng: Thường không có triệu chứng với tăng aminotransferase huyết thanh dai dẳng hoặc từng lúc song ở một số bệnh nhân aminotransferase vẫn bình thường. Một số bệnh nhân được biểu hiện bằng các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh gan mạn.

Xem xét chẩn đoán: Viêm gan B mạn được chẩn đoán dựa trên sự có mặt của HBsAg và HBV DNA. Viêm gan C mạn tính được chẩn đoán bằng xét nghiệm anti-HCV và HCV RNA dương tính. Giá trị điểm cắt báo hiệu (signal cutoff [SCO] >1,0= nhiễm HCV; SCO <1,0=test (+) giả. Hầu hết các nhiễm HCV có SCO >5-10. Viêm gan D mạn tính được chẩn đoán bằng xét nghiệm HBsAg và HDV RNA test dương tính. Viêm gan E mạn tính được chẩn đoán dựa trên sự có mặt của anti-

HEV và HEV RNA. Có thể sử dụng sinh thiết gan để phân độ tình trạng viêm và đánh giá giai đoạn xơ hóa.

Lưu ý: Viêm gan tự miễn có thể được biểu hiện như một viêm gan cấp hoặc mạn tính song có tăng nồng độ IgG, tăng ANAs và kháng thể kháng cơ trơn (+). Đối với cả HCV và HBV, cần loại trừ đồng nhiễm khuẩn HIV.

Xem xét điều trị: Trong viêm gan B mạn tính (***xem trang 174***) cần điều trị tới khi không còn phát hiện được HBV DNA nữa, nồng độ ALT trở lại mức bình thường và đối với các bệnh nhân có HbeA (+) khi xảy ra tình trạng chuyển dạng huyết thanh HBeAg (HBeAg seroconversion) (sau đó tiếp tục điều trị thêm 6–12 tháng). Đối với viêm gan C mạn tính, điều trị được dựa trên genotype của virus (***Xem trang 174***)

Tiên lượng: Có thanh thải bền vững đối với HCV RNA (được đánh giá 24 tuần sau khi ngừng điều trị) cho biết kết quả chữa khỏi ở 99% các bệnh nhân viêm gan C mạn tính. Có thanh thải bền vững đối với HBV DNA cho biết là có cải thiện tiên lượng ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính.

Đồng nhiễm HIV với viêm gan B mạn tính:

Các khuyến cáo điều trị cho các bệnh nhân bị đồng nhiễm HIV tùy thuộc vào trạng thái nhiễm HIV của bệnh nhân

Trạng thái nhiễm HIV	Điều trị viêm gan B được đề xuất
Không cần hoặc có thể cần chỉ định HAART trong thời gian tới.	Peginterferon *hoặc* adefovir
Cần điều trị cả HAART và virus viêm gan B	Tenofovir *kết hợp với* emtricabin *hoặc* tenofovir *kết hợp với* lamivudin
HAART được bắt đầu mà không cần điều trị HBV	Peginterferon *hoặc* adefovir
HAART được bắt đầu bằng lamivudin; HBV kháng lamivudin	Phối hợp thêm tenofovir *và* tiếp tục dùng lamivudin
HAART được bắt đầu mà không dùng lamivudin	Tenofovir cộng với emtricabin hoặc tenofovir và lamivudin

Từ viết tắt: HAART (Highly active antiretroviral therapy): Điều trị kháng retrovirus hiệu quả cao

***Phỏng theo**: Koff R.S. Hepatitis Essentials. Jones & Bartlett, Sudbury, MA; 2011.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phúc mạc/ápxe trong ổ bụng *hoặc* vùng khung chậu

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm phúc mạc nhẹ/ vừa	Entero-bacteriaceae *B. fragilis*	Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần ¥ ***hoặc*** Cefoxitin 2g (TM) mỗi 6h/ lần ¥ ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần¥	Ampicillin/sulbactam 1,5g (TM) mỗi 6h/lần¥ ***hoặc*** Ceftazidim/avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần ***cộng với*** Metronidazol 500mg (TM) mỗi 8h/lần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần¥ ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic 875/125mg (uống) mỗi 12h/lần¥ ***hoặc điều trị kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần¥

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phúc mạc nặng[‡]	Entero-bacteriaceae *B. fragilis*	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần [¥] ***hoặc*** Ceftazidim/ avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần ***cộng với*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần [¥] ***hoặc*** Tigecyclin 200mg(TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần [¥] ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần [¥]	Ampicillin/sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần[¥] ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8 giờ/lần ***hoặc điều trị kết hợp với*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần [¥] ***cộng với hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần [¥] ***hoặc*** Levofloxacin 500 mg (TM) mỗi 24h/lần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần[¥] ***hoặc*** Amoxicillin/acid clavulanic 875/125mg (uống) mỗi 12h/lần [¥]
	Entero-bacteriaceae kháng carbapenem (CRE)	Ceftazidim/avibactam 2,5 g (TM) mỗi 8h/lần [¥] ***cộng với*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24 h/lần [¥]		

Từ viết tắt: CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae): Enterobacteriaceae kháng carbapenem

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian theo đường TM, thời gian điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

[¥] *Số ngày điều trị như được chỉ dẫn bằng lâm sàng hoặc trong 5-7 ngày sau khi đã tiết hành phẫu thuật sửa chữa tổn thương nền trong ổ bụng.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phúc mạc/ápxe trong ổ bụng hoặc vùng khung chậu (tiếp)

Viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn (SBP) ‡	Entero-bacteriaceae Phế cầu *(S.pneumoniae) (gặp ở trẻ em)*	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/ lầnx 1–2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) × 1–2 tuần	Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lầnx 1–2 tuần ***hoặc*** Bất kỳ aminoglycosid nào (TM) mỗi 24h/lần × 1–2tuần	Quinolon ¶ (uống) × 1–2 tuần ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic 875/125 mg (uống)
Viêm phúc mạc mạn tính do lao	*M. tuberculosis*	Không áp dụng		Điều trị giống như điều trị lao phổi (***trang 122***)
Viêm phúc mạc liên quan với lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD) ‡	*S. epidermidis* (CoNS) *S. aureus* (MSSA) *Enterobacteria-ceae* Trực khuẩn Gram âm không lên men (Non-fermentative GNBs)	*Trước khi có kết quả nuôi cấy* Vancomycin 1g (TM) liều khởi đầu* ***kết hợp với*** Gentamicin 5mg/kg hoặc 240mg (TM) liều khởi đầu*	*Sau khi có kết quả nuôi cấy:* *MSSA/Enterobacteriaceae* Meropenem 1g (TM) liều khởi đầu* *MRSA* Vancomycin 1 g (TM) liều khởi đầu* ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM hoặc uống)	

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant *S. aureus):* Tụ cầu nhạy/kháng methicillin; CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae): Enterobacteriaceae kháng carbapenem; CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu với coagulase âm tính; CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis): Lọc màng bụng liên tục ngoại trú .

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

‡ *Chỉ điều trị đường TM hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống.*

¶ *Tiếp theo bằng liều duy trì ×2 tuần sau khi có kết quả nuôi cấy. Với liều duy trì, sử dụng liều suy thận (CrCl < 10 mL/phút) và liều dùng cho lọc máu sau phúc mạc (**xem phần Tóm tắt thông tin thuốc**).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phúc mạc/ápxe trong ổ bụng/vùng khung chậu (viêm ruột thừa/viêm túi thừa/viêm tắc tĩnh mạch vùng khung chậu nhiễm khuẩn huyết)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt thành đỉnh với đau bụng cấp và các dấu hiệu kích thích phúc mạc. Trong viêm túi thừa, đau khu trú trên các đoạn đại tràng bị tác động. Viêm ruột thừa ± thủng được biểu hiện bằng đau hạ sườn phải/cảm ứng phúc mạc hoặc sờ được khối ở bụng. Ápxe quanh túi thừa biểu hiện giống như ápxe trong ổ bụng/ápxe trong khung chậu, rất thường gặp ở vùng bụng phần dưới bên trái. Viêm tắc tĩnh mạch vùng khung chậu nhiễm khuẩn huyết (septic pelvic thrombophlebitis [SPT]) được biểu hiện bằng sốt cao dao động không đáp ứng với điều trị kháng sinh xảy ra sau đẻ/ sau phẫu thuật vùng khung chậu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI vùng bụng/ khung chậu.

Lưu ý: Gõ vang ở vùng gan gợi ý thủng tạng. Viêm phúc mạc/ápxe vùng khung chậu được biểu hiện giống như viêm phúc mạc/ápxe trong ổ bụng, song thường không thấy có các dấu hiệu kích thích phúc mạc.

Xem xét điều trị: Các bệnh nhân bị viêm đại tràng thiếu máu cục bộ/ bệnh đại tràng do viêm cần được điều trị giống như viêm phúc mạc, tùy theo mức độ nặng của bệnh. Cần hội chẩn chuyên khoa ngoại về chỉ định xử trí/rửa ổ bụng hoặc dẫn lưu ápxe. Trong viêm tắc tĩnh mạch vùng khung chậu nhiễm khuẩn huyết, sốt giảm nhanh khi phối hợp thêm heparin với kháng sinh.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ và khoảng thời gian phúc mạc bị vi khuẩn tác động và việc rửa ổ bụng được tiến hành nhanh chóng/thích hợp tới mức độ nào. Tiên lượng đối với viêm tắc tĩnh mạch vùng tiêu khung nhiễm khuẩn huyết tương đối tốt nếu bệnh nhân được điều trị sớm và các cục máu đông chỉ hạn chế ở các tĩnh mạch vùng khung chậu.

Viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn (Spontaneous Bacterial Peritonitis [SBP])

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp hoặc bán cấp với sốt ± đau bụng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy máu dương tính với tác nhân gây viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn. Đối với các bệnh nhân bị đau bụng, cổ trướng và kết quả chụp CT/MRI âm tính, chọc dịch cổ trướng với > 500 bạch cầu và > 100 bạch cầu đa nhân trung tính sẽ dự đoán kết quả cấy dịch cổ trướng sẽ dương tính và giúp chẩn đoán viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn. Thường thấy có rối loạn chức năng lách ở một mức nào đó và điều này khiến cho bệnh nhân có nguy cơ bị

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

nhiễm khuẩn do vi sinh vật có vỏ bao (encapsulated organisms).

Lưu ý: Không được bỏ sót nguồn nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa gây viêm phúc mạc (Vd: viêm ruột thừa, viêm túi thừa); tiến hành chụp CT/MRI ổ bụng.

Xem xét điều trị: *B. fragilis*/vi khuẩn kị khí không phải là tác nhân gây bệnh thường gặp trong viêm phúc mạc do vi khuẩn và điều trị bao phủ đối với *B. fragilis* không thực sự cần thiết.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rối loạn chức năng gan/lách.

Viêm phúc mạc mạn tính do lao (*Mycobacterium tuberculosis*)

Biểu hiện lâm sàng: Đau bụng với sốt, sút cân, cổ trướng kéo dài quá 1–3 tháng

Xem xét chẩn đoán: Dấu hiệu "bụng bàn cờ" khi sờ nắn bụng. Chẩn đoán bằng tìm thấy trực khuẩn kháng cồn trên bệnh phẩm sinh thiết/nuôi cấy phúc mạc.

Lưu ý: Phim Xquang phổi bình thường ở ~ 70%. Có gia tăng tần suất gặp ở các bệnh nhân bị xơ gan do rượu.

Xem xét điều trị: Được điều trị giống như lao phổi.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phúc mạc liên quan với lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD Associated Peritonitis)

Biểu hiện lâm sàng: Đau bụng ± sốt ở một bệnh nhân được lọc màng bụng liên tục ngoại trú (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis [CAPD]).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/nuôi cấy và có tăng số lượng bạch cầu trong dịch cổ trướng. Dịch cổ trướng có bạch cầu lympho chiếm ưu thế có thể gợi ý căn nguyên lao hoặc nấm. Khác với viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn (SBP), không có tiêu chuẩn chẩn đoán đặc hiệu đối với dịch cổ trướng trong viêm phúc mạc liên quan với lọc màng bụng liên tục ngoại trú.

Lưu ý: Thường không thấy có tình trạng sốt.

Xem xét điều trị: Điều trị bằng kháng sinh toàn thân ± kháng sinh trong dịch lọc màng bụng.

Tiên lượng: Tốt nếu bệnh nhân được điều trị sớm và rút bỏ catheter lọc màng bụng.

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU-SINH DỤC

Hội chứng đái khó – đái mủ (hội chứng niệu đạo cấp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM	Điều trị đường uống
Hội chứng niệu đạo cấp	*S. saprophyticus* *C.trachomatis* *E. coli* (<10^5 khuẩn lạc/mL)	Không áp dụng	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×10 ngày ***hoặc*** Quinolon (uống)* × 7 ngày

* *Ciprofloxacin 500 mg mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg mỗi 24h/lần.*

Biểu hiện lâm sàng: Đái khó, đái dắt, đái gấp hay không nhịn tiểu được, khó chịu vùng bụng dưới, sốt < 39°C.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên các triệu chứng viêm bàng quang với đái mủ song cấy nước tiểu không mọc hoặc nồng độ *E. coli* thấp (≤10^3 khuẩn lạc/mL). Bằng chứng nhiễm khuẩn do *S.saprophyticus* là pH nước tiểu kiềm và có hồng cầu trong nước tiểu.

Lưu ý: Gần giống với tình trạng viêm bàng quang "cấy nước tiểu âm tính".

Xem xét điều trị: *S. saprophyticus* nhạy với hầu hết các kháng sinh được dùng để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bàng quang (xem Atlas màu đối với tiêu bản nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị
Vi khuẩn	Enterobacteriaceae *E. faecalis* (VSE) *S. agalactiae* (liên cầu nhóm B) *S. saprophyticus*	Amoxicillin 500 mg (uống) x mỗi 12h/lần x 3 ngày ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1SS (uống) x mỗi 12h/lần x 3 ngày ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x 3 ngày ***hoặc*** Nitrofurantoin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày
	Trực khuẩn Gram âm đa kháng thuốc kháng sinh (MDR GNBs)	Fosfomycin 3 g (uống) mỗi 24h/lần x3 ngày
Nấm	*C.albicans* †	Fluconazol 200mg (uống)x 1 liều, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 4 ngày
	Các chủng Candida phân lập được kháng Fluconazol ‡ hoặc bệnh nấm không đáp ứng với điều trị bằng Fluconazol	Amphotericin B 0,3 mg/kg (TM)x 1 liều

Từ viết tắt: VSE (Vancomycin-sensitive enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin; MDR GNBs (Multidrug resistant Gram negative bacillus): trực khuẩn Gram âm kháng lại với nhiều thuốc kháng sinh.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

† *Viêm bàng quang do C. albicans* ***(xem trang 185)***

‡ *Tình trạng kháng fluconazol* ***(xem trang 185)***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bàng quang do vi khuẩn (Bacterial cystitis)

Biểu hiện lâm sàng: Đái khó, đái rắt, đái gấp hoặc khi nhịn tiểu được, khó chịu vùng bụng dưới, sốt < 39°C.

Xem xét chẩn đoán: Đái mủ kết hợp với có vi khuẩn trong nước tiểu (bacteriuria).

Lưu ý: Các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (Vd: người dùng steroid dài ngày, bệnh nhân ĐTĐ, bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, xơ gan, đa u tủy xương) có thể cần điều trị 3–5 ngày. Một liều amoxicillin hoặc TMP–SMX duy nhất có thể đủ trong viêm bàng quang cấp không biến chứng ở đối tượng là người bình thường.

Xem xét điều trị: Pyridium 200mg (uống) mỗi 8h/lần sau bữa ăn × 24–48 giờ rất hữu ích để làm giảm đái khó (cần thông báo cho bệnh nhân là nước tiểu của họ sẽ chuyển sang mầu da cam) .

Tiên lượng: Cực kỳ tốt ở các đối tượng là người bình thường.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bàng quang do Candida (*Candida cystitis*)

Xem xét chẩn đoán: Đái mủ rõ rệt, nitrat niệu âm tính ± hồng cầu niệu. Khác biệt nếu không phải là viêm bàng quang do *Candida albicans*.

Lưu ý: Không thấy có đáp ứng với điều trị hoặc xuất hiện "bóng nấm" trong hệ thống ống góp thận gợi ý nhiễm nấm Candida thận.

Xem xét điều trị: Nếu điều trị bằng fluconazol thất bại, sử dụng amphotericin. Đối với bệnh nhân suy thận mạn/lọc máu mạn có tình trạng Candida niệu (candiduria), sử dụng amphotericin B deoxycholat để rửa bàng quang (như đối với tình trạng Candida đường tiết niệu liên quan với đặt catheter bàng quang, xem ở dưới). Rút bỏ các ống thông hoặc các thiết bị đặt tại đường tiết niệu và sửa chữa các bất thường giải phẫu là điều quan trọng để bảo đảm điều trị thành công.

Tiên lượng: Các bệnh nhân bị suy giảm chức năng miễn dịch bảo vệ, có bất thường hệ thống ống góp thận, có các nang thận, bị bệnh thận hoặc sỏi thận dễ có khuynh hướng bị nhiễm khuẩn niệu tái phát/ sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu (urosepsis).

Có vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAB)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị
Có vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAB)†*	*E. coli* *E.faecalis* (VSE)	Nitrofurantoin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày ***hoặc*** Amoxicillin 500 mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày
	E.faecium (VRE)	Nitrofurantoin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần× 3 ngày ***hoặc*** Fosfomycin 3g (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày ††
	Klebsiella kháng với nhiều thuốc kháng sinh †† Acinetobacter kháng với nhiều thuốc kháng sinh †† *P. aeruginosa* kháng với nhiều thuốc kháng sinh††	Nitrofurantoin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày†† ***hoặc*** Fosfomycin 3g (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày †† ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 3 ngày ††§ ***hoặc*** Doripenem 1 g (TM) mỗi 8h/lần× 3 ngày††§

Từ viết tắt: VSE/VRE (Vancomycin-sensitive/resistant enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy/kháng Vancomycin; MDR (multidrug resistant) : Tình trạng kháng với nhiều thuốc kháng sinh hay tình trạng đa kháng thuốc; CAB (Catheter Associated Bacteriuria) : Có vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu.

* *Rút bỏ/thay mới catheter Foley trước khi bắt đầu điều trị kháng sinh.*

† *Không cần điều trị đối với tình trạng có vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAB) ở các đối tượng là người có chức năng miễn dịch bình thường ; Điều trị chặn trước (pre-emptive therapy) được gợi ý áp dụng cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch, Vd: bệnh nhân xơ gan, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, đái tháo đường, đa u tủy xương, dùng steroid, dùng thuốc ức chế miễn dịch và các đối tượng bị suy thận.*

†† *Các liệu trình điều trị kéo dài hơn có thể cần thiết cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Nếu thấy tình trạng đái mủ giảm đi rõ rệt sau 2 ngày điều trị, kết thúc liệu trình sau 3 ngày điều trị. Nếu không thấy có đáp ứng nói trên, tiếp tục điều trị trong 7 ngày .*

§ *Chỉ khi không thể điều trị được bằng đường uống .*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm nấm Candida niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAC)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị
Nhiễm nấm Candida niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAC) †*	*C. albicans*	Fluconazol 200mg (uống)× 1 liều, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần
	C.albicans kháng Fluconazol /các chủng Candida không phải albicans	Amphotericin B 0,3–0,6 mg/kg mỗi 24h/lần ×1–7 ngày ***hoặc*** Flucytosin 25 mg/kg x 4 lần/ngày (uống) ×7–10 ngày ***hoặc*** Rửa bàng quang với Amphotericin B (*Rửa liên tục*: 50mg trong 1000mL nước vô khuẩn trong vòng 24h ×1–2 ngày; *Rửa ngắt quãng*: 50mg trong 200–300mL nước vô khuẩn mỗi 6-8h/lần ×1–2 ngày)§§

Từ viết tắt : CAC (Catheter Associated Candiduria): Nhiễm nấm Candida niệu liên quan với đặt ống thông tiểu

* *Rút bỏ/thay mới catheter Foley trước khi bắt đầu điều trị kháng sinh.*

† *Không cần điều trị đối với tình trạng nhiễm nấm niệu liên quan với đặt ống thông tiểu (CAC) ở các đối tượng là người có chức năng miễn dịch bình thường; Điều trị chặn trước (pre-emptive therapy) được gợi ý áp dụng cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch, Vd: bệnh nhân xơ gan, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, đái tháo đường, đa u tủy xương, dùng steroid, dùng thuốc ức chế miễn dịch và các đối tượng bị suy thận.*

§§ *Hiệu quả hạn chế.*

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh nhân đang đặt ống thông trong đường tiết niệu (Catheter Foley) có tình trạng vi khuẩn niệu (bacteriuria) và đái mủ; không có triệu chứng lâm sàng .

Xem xét chẩn đoán: Đái mủ kết hợp với có vi khuẩn niệu/nấm Candida niệu (Candiduria). Bệnh nhân thường không sốt hoặc thân nhiệt < 38°C.

Lưu ý: Có tình trạng vi khuẩn niệu/nấm Candida niệu thường biểu hiện tình trạng vi sinh vật cư trú, mà không phải là nhiễm trùng. Tình trạng Candida niệu kéo dài dai dẳng sau khi rửa bàng quang bằng amphotericin B deoxycholat gợi ý bệnh nhiễm nấm Candida thận.

Xem xét điều trị: Tránh điều trị tình trạng có vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu cho các đối tượng là người bình thường không có bệnh lý/bất thường

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

đường tiết niệu- sinh dục. Các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (Vd: người ĐTĐ, lupus ban đỏ hệ thống, dùng steroid dài ngày, đa u tủy xương, xơ gan) có thể cần điều trị trong thời gian lưu ống thông tiểu. Nếu không làm sạch được vi khuẩn/ nấm Candida niệu bằng điều trị kháng sinh thích hợp, thay ống thông tiểu. Đối với bệnh nhân bị suy thận mạn/lọc máu chu kỳ có tình trạng nhiễm nấm Candida niệu, sử dụng amphotericin B deoxycholat để rửa bàng quang. Hiệu quả của điều trị nhiễm nấm Candida niệu liên quan với dặt ống thông tiểu còn hạn chế và tình trạng tái phát thường xẩy ra trừ khi ống thông tiểu được thay mới hoặc (thường được ưu tiên lựa chọn) là rút bỏ ống thông tiểu.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt ở đối tượng là người khỏe mạnh. Không điều trị đối với tình trạng có vi khuẩn niệu/ nhiễm nấm Candida niệu ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch có thể gây nhiễm trùng lan lên (Vd: viêm thận-bể thận) hoặc nhiễm khuẩn huyết/ nhiễm nấm huyết.

Viêm mào tinh hoàn

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cấp tính *Nam giới trẻ tuổi*	*C. trachomatis*	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/ lầnx 4 ngày	Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lầnx 7 ngày	Doxycyclin200mg(uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 7 ngày* ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lầnx 10 ngày ***hoặc*** Ofloxacin 300mg (uống) mỗi 12h/ lầnx 10 ngày
Nam giới có tuổi	*P. aeruginosa*	Cefepim 2 g (TM) mỗi 8h/lần x10 ngày ***hoặc*** Meropenem1g (TM) mỗi 8h/lần x10 ngày	Ciprofloxacin 400 mg (TM) mỗi 8h/ lầnx 10 ngày ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/ lần x 10 ngày	Ciprofloxacin 750 mg (uống) mỗi 12h/ lần x 10 ngày
Mạn tính	*M.tuberculosis* *Blastomyces dermatiditis*	Điều trị như đối với lao phổi (***xem trang 94***) hoặc bệnh nấm Blastomyces phổi (***xem trang 437***)		

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

** Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

Viêm mào tinh hoàn cấp (*Chlamydia trachomatis/Pseudomonas aeruginosa*)

Biểu hiện lâm sàng: Đau cấp tính một bên tinh hoàn ± sốt.

Xem xét chẩn đoán: Siêu âm để loại trừ xoắn tinh hoàn hoặc khối u tinh hoàn.

Lưu ý: Loại trừ xoắn tinh hoàn bằng hình ảnh siêu âm và triệu chứng sốt (không sốt trong xoắn tinh hoàn).

Xem xét điều trị: Các nam giới trẻ tuổi đáp ứng với điều trị chậm trên 1 tuần. Các nam giới có tuổi đáp ứng với điều trị pseudomonas trong vòng 72 giờ.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt ở nam giới trẻ. Liên quan với tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân là người có tuổi.

Viêm mào tinh hoàn mạn (*Mycobacterium tuberculosis/Blastomyces dermatiditis*)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm mạn tính tinh hoàn - mào tinh hoàn (epididymo-orchitis) với các hạt nhỏ ở mào tinh.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phát hiện được trực khuẩn kháng cồn-toan (AFB) từ bệnh phẩm sinh thiết/nuôi cấy từ bệnh phẩm mào tinh hoàn bị viêm. Viêm mào tinh hoàn do trực khuẩn lao luôn kết hợp với lao thận. Viêm mào tinh hoàn do Blastomyces là một biểu hiện của nhiễm trùng nấm toàn thân.

Lưu ý: Viêm mạch (Vd: viêm nhiều động mạch nút) và u lympho có thể có biểu hiện tương tự.

Xem xét điều trị: Được điều trị giống như đối với lao/nhiễm trùng do nấm Blastomyces.

Tiên lượng: Tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bể thận cấp tính (xem Atlas màu đối với tiêu bản nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm thận - bể thận cấp tính (Điều trị khởi đầu được dựa trên kết quả nhuộm Gram nước tiểu; Xem thêm phần ***Các xem xét điều trị***, ở dưới)	Entero-bacteriaceae	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Aztreonam 2 g (TM) mỗi 8h/lần× 2 tuần ***hoặc*** Gentamicin 240mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần× 2 tuần ***hoặc*** Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần
	Enterococcus faecalis (VSE) [5]	Ampicillin 1g (TM) mỗi 4h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Quinolon† (TM) x 2 tuần	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần× 2 tuần
	Enterococcus faecium (VRE)	Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Quinupristin/ dalfopristin 7,5 mg/ kg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200 mg (TM) mỗi 12 giờ/ lần× 3 ngày, sau đó 100 mg mỗi 12h/lần x 2 tuần	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12h/lần× 2 tuần*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	Trực khuẩn Gram âm kháng nhiều thuốc kháng sinh (MDR GNB)	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ceftolozan/ tazobactam 1,5g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	
	Enterobacteriaceae kháng carbapenem (CRE)	Ceftazidim/ avibactam 2,5 g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	Tigecyclin 200mg (TM) × 1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần** ***hoặc*** Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	

Từ viết tắt: VSE/VRE (Vancomycin-sensitive/resistant enterococci) : Cầu khuẩn ruột nhạy/kháng Vancomycin. MDR GNB (Multidrug resistant Gram Negative Bacillus): Trực khuẩn Gram âm kháng nhiều thuốc kháng sinh; CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae): Enterobacteriaceae kháng lại carbapenem.

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

** Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

*** Phụ thuộc vào nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc (MICs), có thể cần tới các liều cao hơn Liều nạp: 400mg (TM) × 1 liều, sau đó dùng liều duy trì: 200mg (TM) mỗi 24h/lần.*

[§] Điều trị E. faecalis kháng vancomycin như đối với cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bể thận mạn tính/Lao thận

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm thận- bể thận mạn	Enterobacteriaceae.	*Điều tr đường TM* Không áp dụng	Quinolon† (uống)x 4–6 tuần ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1 DS (uống) mỗi 12h/lần x 4–6 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x cho đủ tổng thời gian điều trị là 4–6 tuần	
Lao thận	*M. tuberculosis*	*Điều trị đường TM* Không áp dụng	Được điều trị giống như lao phổi (***trang 122***)	

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

† *Ciprofloxacin XR 1000mg (uống) mỗi 24h/lần hoặc Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500 mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bể thận cấp tính do vi khuẩn (*Enterobacteriaceae, E. faecalis/faecium*)

Biểu hiện lâm sàng: Căng đau hố thắt lưng một bên có sốt ≥39°C.

Xem xét chẩn đoán: Có vi khuẩn niệu kết hợp với đái mủ và đau hố thắt lưng một bên, nhiệt độ ≥39°C. Có vi khuẩn trong máu thường đi kèm với viêm thận - bể thận cấp. Tiến hành cấy máu và cấy nước tiểu.

Lưu ý: Thân nhiệt giảm đi trong vòng 72 giờ dù bệnh nhân được điều trị hoặc không được điều trị kháng sinh. Nếu nhiệt độ không giảm sau 72 giờ điều trị

kháng sinh, cần nghi vấn ápxe thận/ápxe quanh thận.

Xem xét điều trị: Điều trị khởi đầu được dựa trên kết quả nhuộm Gram nước tiểu: Nếu thấy trực khuẩn Gram âm, điều trị như nhiễm khuẩn do Enterobacteriaceae. Nếu thấy cầu khuẩn Gram dương thành chuỗi (cầu khuẩn ruột), điều trị như *E. faecalis*; nếu Enterococcus sau đó được phân lập là *E.faecium*, điều trị một cách phù hợp. Viêm bể thận cấp thường được điều trị khởi đầu trong 1–3 ngày theo đường tĩnh mạch, sau đó chuyển sang đường uống cho đủ liệu trình 4 tuần dùng kháng sinh để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ tiến triển thành viêm bể thận mạn tính. Tiến hành chụp CT/MRI ở các bệnh nhân tiếp tục sốt dai dẳng sau điều trị kháng sinh 72 giờ để loại trừ sỏi thận, tắc nghẽn, ápxe hoặc viêm bể thận u vàng (xanthomatous pyelonephritis).

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu đợt bệnh đầu tiên được điều trị thỏa đáng bằng kháng sinh trong 4 tuần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm bể thận mạn tính do vi khuẩn (Enterobacteriaceae)

Biểu hiện lâm sàng: Tiền sử trước đó bị viêm thận - bể thận cấp với cùng các triệu chứng như viêm thận - bể thận cấp ngoại trừ triệu chứng căng đau hố thắt lưng và sốt nhẹ hơn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng chụp CT/MRI cho thấy có các thay đổi của viêm thận-bể thận mạn kết hợp với có vi khuẩn trong nước tiểu (bacteriuria)/đái mủ. Cấy nước tiểu có thể âm tính từng lúc trước khi điều trị. Viêm thận bể thận mạn là một tổn thương bệnh lý ở cả hai bên thận song được biểu hiện trên lâm sàng ở một bên thận.

Lưu ý: Cấy nước tiểu có thể dương tính từng lúc sau điều trị; cần xét nghiệm nhắc lại hàng tuần× 4 lần để khẳng định nước tiểu vẫn tiếp tục cho kết quả nuôi cấy âm tính.

Xem xét điều trị: Điều trị × 4–6 tuần. Cấp máu cho mạch tủy thận kém/ các biến dạng giải phẫu thận khiến khó loại bỏ được vi khuẩn gây bệnh hoàn toàn.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rộng của tổn thương thận.

Lao thận (*Mycobacterium tuberculosis*)

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương thành khối của thận với các bất thường niệu quản (dày hẹp lòng niệu quản hoặc xoắn niệu quản) đái máu vi thể /đái mủ vô khuẩn. Không đau trừ khi bị biến chứng tắc nghẽn niệu quản.

Xem xét chẩn đoán: Kết hợp bất thường đường tiết niệu trên/dưới ± đái máu vi thể/ pH nước tiểu ≤5.5. Chẩn đoán bằng cấy tìm lao từ nước tiểu. Sử dụng kỹ thuật PCR tìm trực khuẩn lao trong nước tiểu là một xét nghiệm đặc hiệu song không thật nhạy.

Lưu ý: Phim chụp Xquang ngực bình thường ở 50% các trường hợp, song hầu hết bệnh nhân có phản ứng bì với tuberculin (phản ứng Mantoux) dương tính. Loại trừ các nguyên nhân nhiễm khuẩn/viêm khác gây đái mủ vô khuẩn (Vd: Trichomonas, viêm thận kẽ).

Xem xét điều trị: Điều trị như đối với lao phổi.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị trước khi xảy ra tắc nghẽn niệu quản/phá hủy nhu mô thận.

Ápxe thận (trong thận/quanh thận)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Vùng vỏ thận (Điều trị khởi đầu với MSSA; nếu sau đó phân lập được tác nhân gây bệnh là MRSA điều trị một cách phù hợp)	Tụ cầu vàng *(S.aureus)*	*MSSA*: Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần* ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần*	*MSSA* Meropenem1g (TM) mỗi 8h/ lần* ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần*	*MSSA/MRSA* Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần*
		MRSA: Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần*	*MRSA* Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần*	
Vùng tủy thận	Entero-bac-teriaceae	Quinolon (TM)†*	TMP–SMX 2,5mg/kg (TM) mỗi 6h/lần*	Quinolon (uống)†*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (Methicillin-sensitive/resistant S. aureus): Tụ cầu nhạy/kháng methicillin

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

* *Điều trị tới khi ổ ápxe thận thoái triển hoàn toàn hoặc không còn giảm kích thước trên CT/MRI.*

† Levofloxacin 500 mg (TM/uống) mỗi 24h/lần.

Biểu hiện lâm sàng: Tương tự như viêm thận bể thận song sốt vẫn tiếp tục tăng cao sau khi dùng kháng sinh 72 giờ.

Xem xét chẩn đoán: Tiến hành chụp CT/MRI để chẩn đoán ápxe quanh thận/trong nhu mô thận và để loại trừ tổn thương dạng khối. Ápxe vỏ thận thường thứ phát do lan theo đường máu/đường kế cận tới thận. Ápxe tủy thận thường do lan rộng của nhiễm trùng trong nhu mô thận.

Lưu ý: Cấy nước tiểu có thể âm tính trong ápxe vùng vỏ thận.

Xem xét điều trị: Hầu hết các ápxe lớn cần được dẫn lưu. Nhiều ổ ápxe nhỏ được điều trị nội khoa. Cần hội chẩn bác sĩ chuyên khoa tiết niệu.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rối loạn chức năng thận nền.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm/ápxe tuyến tiền liệt

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Viêm /ápxe tuyến tiền liệt cấp	Entero-bacteriaceae	Quinolon* (TM)× 2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/ lần ×2 tuần	TMP–SMX 2,5mg/ kg (TM) mỗi 6h/ lần × 2 tuần ***hoặc*** Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần× 2 tuần	Quinolon* (uống) × 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/ lần × 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 24h/lần × 11 ngày ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1SS (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần
Viêm tuyến tiền liệt mạn	Entero-bacteriaceae -	Điều trị đường TM không được áp dụng	Quinolon* (uống)× 1–3 tháng ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 24h/lần × 1–3 tháng ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1 DS (uống) mỗi 12h/lần× 1–3 tháng	
	Trực khuẩn Gram âm kháng lại nhiều thuốc kháng sinh (MDR GNB)		Fosfomycin 3g (uống) mỗi 48h/lần× 30 ngày ± Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 24h/lần × 1–3 tháng	

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

* *Ciprofloxacin XR 1000 mg (uống) mỗi 24h/lần hoặc Ciprofloxacin 400 mg (TM) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm/Ápxe tuyến tiền liệt cấp

Biểu hiện lâm sàng: Viêm tuyến tiền liệt cấp được biểu hiện như một tình trạng bệnh lý sốt cấp tính ở nam giới với đái khó và khám không thấy căng đau hố thắt lưng. Ápxe tuyến tiền liệt được biểu hiện bằng những cơn sốt kiểu nhiễm khuẩn huyết song không có dấu hiệu khu trú.

Xem xét chẩn đoán: Viêm tuyến tiền liệt cấp được chẩn đoán bằng tình trạng có vi khuẩn niệu, đái mủ cộng với có các sợi nhầy (mucus threads) trong nước tiểu và khám tuyến tiền liệt thấy căng đau nhẹ và được gặp chủ yếu ở nam giới trẻ tuổi. Cấy nước tiểu dương tính do nước tiểu bị nhiễm bẩn khi đi qua tuyến tiền liệt bị nhiễm khuẩn. Ápxe tuyến tiền liệt được chẩn đoán bằng siêu âm qua trực tràng hoặc chụp CT/MRI tuyến tiền liệt.

Lưu ý: Không được bỏ sót viêm tuyến tiền liệt cấp ở nam giới có tình trạng vi khuẩn niệu (bacteriuria) song không có dấu hiệu khu trú hoặc ápxe tuyến tiền liệt ở các bệnh nhân có tiền sử bị viêm tuyến tiền liệt.

Xem xét điều trị: Điều trị viêm tuyến tiền liệt cấp đủ 2 tuần để làm giảm nguy cơ tiến triển thành viêm tuyến tiền liệt mạn tính. Ápxe tuyến tiền liệt được điều trị giống như viêm tuyến tiền liệt cấp kết hợp với dẫn lưu ngoại khoa.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị sớm bằng liệu trình kháng sinh đủ thời gian (kết hợp với dẫn lưu đối với ápxe tuyến tiền liệt).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính (Enterobacteriaceae/trực khuẩn Gram âm đa kháng thuốc)

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng tiết niệu mơ hồ (khó tiểu nhẹ ± đau thắt lưng), tiền sử bị viêm tuyến tiền liệt cấp, không sốt hoặc sốt nhẹ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên có tình trạng vi khuẩn niệu kết hợp với đái mủ với các sợi nhầy trong nước tiểu (mucus threads) ± khám thấy tuyến tiền liệt căng đau nhẹ. Cấy nước tiểu/tinh dịch/ dịch thu được khi khám và ấn nặn tuyến tiền liệt đều dương tính

Lưu ý: Nguyên nhân thường gặp nhất gây điều trị thất bại là thời gian điều trị không thỏa đáng. Viêm tuyến tiền liệt mạn tính với vôi hóa tuyến tiền liệt (siêu âm qua trực tràng) sẽ không khỏi hoàn toàn khi dùng kháng sinh; Cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo (transurethral resection of prostate [TURP]) kèm lấy bỏ tất cả các mảng vôi hóa là phương pháp điều trị triệt để.

Xem xét điều trị: Ở bệnh nhân dị ứng sulfa, có thể sử dụng TMP đơn độc thay

thế cho TMP–SMX .

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị × 1–3 tháng. Ápxe tuyến tiền liệt là một biến chứng hiếm gặp song nghiêm trọng (có thể gây tình trạng sepsis do nhiễm khuẩn niệu).

Sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu (Urosepsis) (xem Atlas màu đối với tiêu bản nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Mắc phải ở cộng đồng (Điều trị khởi đầu được dựa trên kết quả nhuộm Gram nước tiểu)	Entero-bacteriaceae (ESBL [–])	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 7 ngày* ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần ×7 ngày*	Amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần ×7 ngày* ***hoặc*** Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần ×7 ngày*	Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần ×7 ngày* ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1SS (uống) mỗi 12h/lần ×7 ngày*
	Entero-bacteriaceae (ESBL [+])	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 7 ngày*	Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần×7 ngày*	Fosfomycin 3g (uống) trong 3 ngày × 7 ngày*
	E.faecalis (VSE) Liên cầu nhóm B	Ampicillin 2g (TM) mỗi 4h/lần ×7ngày *	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×7 ngày*	Amoxicillin 1g(uống) mỗi 8h/lần ×7 ngày* ***hoặc*** Levofloxacin 500 mg (uống) mỗi 24h/lần ×7 ngày*
(Không nhuộm Gram nước tiểu)	*Entero-bacteriaceae* *E. faecalis (VSE)* Liên cầu nhóm B	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×7 ngày*	Piperacillin/ tazobactam 3,375 mg (TM) mỗi 6h/lần ×7 ngày*	Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần ×7 ngày*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: ESBL (Extended spectrum – βlactamase): Enzym ESBL hay enzym β lactamase phổ mở rộng; VSE (Vancomycin sensitive enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

* Có thể cần thời gian điều trị kéo dài hơn nếu có tình trạng bất thường tiết niệu/thận.

Sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu (Urosepsis) (xem Atlas màu đối với tiêu bản nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Liên quan với thủ thuật tiết niệu (Điều trị khởi đầu đối với *P.aeruginosa*... Nếu sau đó phân lập được tác nhân gây bệnh không phải là *Pseudomonas aeruginosa*, điều trị phù hợp)	*P. aeruginosa* Enterobacter Klebsiella Serratia	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x7 ngày ***hoặc*** Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 8h/lần x 7 ngày ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/lần x7 ngày ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần x7 ngày	Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x7 ngày ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/lần x7 ngày ***hoặc*** Aztreonam 2 g (TM) mỗi 8h/lần x7 ngày ***hoặc*** Amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần x7 ngày ***hoặc*** Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 8h/lần x7 ngày	Ciprofloxacin 750 mg (uống) mỗi 12h/lần x7 ngày ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (uống) mỗi 24h/lần x 7 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	Trực khuẩn Gram âm kháng lại nhiều thuốc kháng sinh	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ceftolozan/tazobactam 1,5g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	Colistin 5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	
	Entero-bacteriaceae kháng carbapenem (CRE)	Ceftazidim/avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 200mg (TM) × 1 liều sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần *	Colistin 5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần	

Từ viết tắt: CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae): Enterobacteriaceae kháng carbapenem.

***Ghi chú**: Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Phụ thuộc vào nồng độ ức chế tối thiểu (MICs), có thể cần dùng liều cao hơn. Liều nạp: 400 mg (TM) × 1 liều, sau đó liều duy trì: 200 mg (TM) mỗi 24h/lần*

Sepsis do nhiễm khuẩn đường tiết niệu mắc phải từ cộng đồng (Community-Acquired Urosepsis)

Biểu hiện lâm sàng: Sepsis từ nguồn gốc đường tiết niệu.

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu và nước tiểu dương tính với cùng tác nhân gây bệnh đường tiết niệu. Nếu bệnh nhân không bị ĐTĐ, lupus ban đỏ hệ thống, xơ gan, đa u tủy xương, dùng steroid, có bệnh thận hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu từ trước đó, tiến hành chụp CT/MRI niệu-sinh dục để loại trừ ápxe/tắc nghẽn. Ápxe tuyến tiền liệt hiếm khi là nguyên nhân gây sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Cấy nước tiểu thấy có kết hợp vi khuẩn Gram dương/âm gợi ý mẫu bệnh phẩm bị nhiễm bẩn hoặc có rò bàng quang- ruột.

Xem xét điều trị: Điều trị theo kinh nghiệm dựa trên kết quả nhuộm Gram nước tiểu. Nếu nhuộm Gram nước tiểu cho thấy có mủ niệu và cầu khuẩn Gram dương, điều trị như đối với cầu khuẩn ruột nhóm D (*E. faecalis*- cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]). Nếu thấy có trực khuẩn Gram âm, điều trị như đối với Enterobacteriaceae. Tụ cầu vàng/Phế cầu không phải là tác nhân gây bệnh đường tiết niệu.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của tình trạng bệnh lý nền gây sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu (Urosepsis) sau thủ thuật đường tiết niệu

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng sepsis xẩy ra trong vòng 24 giờ sau khi tiến hành thủ thuật trên đường tiết niệu-sinh dục.

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu và nước tiểu dương tính với cùng tác nhân gây bệnh đường tiết niệu. Sử dụng kết quả cấy nước tiểu trước thủ thuật để nhận diện vi sinh vật gây bệnh đường tiết niệu và để hướng dẫn điều trị.

Lưu ý: Nếu không phải *P. aeruginosa* trong nước tiểu/máu, chuyển sang dùng TMP–SMX trong khi chờ kết quả xét đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn.

Xem xét điều trị: Điều trị bằng một thuốc theo kinh nghiệm đối với *P. aeruginosa* sẽ bao phủ được hầu hết các vi khuẩn gây bệnh khác trên đường tiết niệu.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của tình trạng bệnh lý nền gây sepsis do nhiễm khuẩn niệu và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh lý viêm vùng khung chậu (Pelvic Inflammatory Disease[PID]), Viêm vòi tử cung (Salpingitis), Ápxe phần phụ (Tuboovarian Abscess), Viêm nội mạc tử cung (Endometritis)/ Viêm nội mạc-cơ tử cung (Endomyometritis), nhiễm khuẩn huyết sau nạo phá thai (Septic Abortion)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Bệnh nhân nằm viện †	*B. fragilis* Entero-bacteriaceae Lậu cầu (*N.gonorrhoeae*) *C. trachomatis* *C. sordelli*§ (nhiễm khuẩn sau phá thai)	**Đơn trị liệu bằng** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc điều trị kết hợp với*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần×11 ngày ***kết hợp với hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần ×3–10 ngày ***hoặc*** Cefoxitin 2g (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cefotetan 2g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần **Điều trị kết hợp thay thế:** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần ×11 ngày ***cộng với*** Ampicillin/sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Quinolon‡ (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***cộng với*** Metronidazol 1 g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần		**Đơn trị liệu bằng** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần
Bệnh nhân ngoại trú (chỉ bị bệnh lý viêm vùng khung chậu nhẹ)	Lậu cầu (*N.gonorrhoeae*) *C. trachomatis* *B. fragilis* Enterobacteriaceae	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần** ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

† *Chỉ điều trị bằng đường TM hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống đối với viêm vòi tử cung (salpingitis), ápxe phần phụ (tuboovarian abscess), viêm nội mạc tử cung (endometritis), viêm nội mạc- cơ tử cung (endomyometritis), nhiễm khuẩn huyết sau nạo phá thai hoặc bị bệnh lý viêm vùng khung chậu (PID) nặng .*

‡ *Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần hoặc Ofloxacin 400mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần.*

" *Tình trạng lậu cầu kháng với quinolon xuất hiện gần đây đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận trong/sau điều trị.*

§ *Điều trị kháng sinh đối với nhiễm khuẩn huyết sau phá thai tương tự như điều trị viêm vòi tử cung, viêm nội mạc tử cung cộng với nạo buồng tử cung lấy hết các thành phần bên trong tử cung.*

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh lý viêm vùng khung chậu (PID)/viêm vòi tử cung được biểu hiện bằng dấu hiệu căng đau khi thăm khám phụ khoa /lay động cổ tử cung, đau vùng bụng dưới và sốt. Viêm nội mạc tử cung/ viêm nội mạc-cơ tử cung được biểu hiện bằng căng đau tử cung khi khám ± ra khí hư/sốt. Viêm nội mạc-cơ tử cung (Endomyometritis) là nhiễm khuẩn sau đẻ thường gặp nhất.

Xem xét chẩn đoán: Đau bụng dưới một bên ở một bệnh nhân nữ không có nguyên nhân trong khung chậu nào khác, gợi ý bệnh lý viêm vùng khung chậu/ viêm vòi tử cung.

Lưu ý: Tiến hành chụp CT/MRI bụng/khung chậu để khẳng định chẩn đoán và để loại trừ các bệnh lý khác hoặc ápxe vòi tử cung- buồng trứng.

Xem xét điều trị: Ápxe phần phụ thường cần được dẫn lưu/lấy bỏ khối ápxe ± cắt toàn bộ tử cung qua đường bụng/ và cắt bỏ cả hai bên vòi tử cung-buồng trứng, kết hợp với kháng sinh (***trang 113***) × 1–2 tuần sau khi dẫn lưu/loại bỏ khối ápxe. Nhiễm khuẩn huyết sau phá thai được điều trị như đối với viêm nội mạc tử cung/viêm nội mạc-cơ tử cung kết hợp với nạo hút buồng tử cung.

Tiên lượng: Liên quan với sự kịp thời điều trị/dẫn lưu thỏa đáng nếu có ápxe vòi tử cung-buồng trứng. Các biến chứng muộn của bệnh lý viêm vùng khung chậu/viêm vòi tử cung bao gồm sẹo hẹp vòi tử cung/ vô sinh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC BỆNH LÂY THEO ĐƯỜNG TÌNH DỤC

Viêm niệu đạo/viêm cổ tử cung

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tiêm bắp	Điều trị đường uống
Do lậu cầu	*N.gonorrhoeae*	Ceftriaxon 250mg (tiêm bắp) × 1 liều ***kết hợp với hoặc*** Azithromycin 1–2g (uống) × 1 liều ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × nhiều ngày	Cefixim 400 mg (uống) × 1 liều† ***hoặc*** Cefpodoxim 400 mg (uống) × 1 liều† ***hoặc*** Azithromycin 2g (uống) × 1 liều†
Không do lậu cầu	*C.trachomatis* *U.urealyticum* *M.genitalium*	Không áp dụng	Doxycyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần× 7 ngày‡ ***hoặc*** Quinolon (uống) × 7 ngày *† ***hoặc*** Azithromycin 1 g (uống) × 1 liều ***hoặc*** Erythromycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần × 7 ngày
	Trichomonas vaginalis	Không áp dụng	Tinidazol 2g (uống) ×1 liều ***hoặc*** Metronidazol 2 g (uống) × 1 liều

** Levofloxacin 500mg mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400mg mỗi 24h/lần hoặc Ofloxacin 300mg mỗi 12h/lần.*

† Gia tăng đề kháng với các phác đồ điều trị theo đường uống cần cân nhắc điều trị thay thế (điều trị bước hai) và làm các xét nghiệm để xác nhận đã điều trị tiệt căn là điều cơ bản.

‡ Doxycyclin có thể được dùng với liều 200mg (uống) mỗi 24h/lần × 7 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm niệu đạo/viêm cổ tử cung do lậu cầu (do *Neisseria gonorrhoeae*)

Biểu hiện lâm sàng: Mủ quy đầu/xuất tiết dịch cổ tử cung với cảm giác rát bỏng khi đi tiểu/đái khó-đái đau 3–5 ngày sau khi phơi nhiễm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán nhanh ở nam bằng nhuộm Gram dịch tiết niệu đạo cho thấy có các song cầu Gram âm. Nuôi cấy dịch niệu đạo cũng cho kết quả dương tính. Ở nữ giới, chẩn đoán đòi hỏi phải định danh được vi sinh vật bằng nuôi cấy hoặc bằng mẫu dò DNA vi khuẩn (DNA probe), mà không phải là nhuộm Gram. Chẩn đoán nhanh ở nam/nữ bằng mẫu dò DNA. Tiến hành nuôi cấy dịch ngoáy họng/hậu môn tìm lậu cầu (*N. gonorrhoeae)*. Đồng nhiễm khuẩn (co-infections) thường gặp, cần tiến hành làm huyết thanh học chẩn đoán giang mai (test VDRL) và nhiễm HIV.

Lưu ý: Nhuộm Gram dịch tiết cổ tử cung thấy các song cầu Gram âm không đủ để chẩn đoán *N.gonorrhoeae*; phải khẳng định bằng nuôi cấy vi khuẩn hoặc test khuyếch đại acid nucleic (nucleic acid amplification). Nhiễm khuẩn do *N. gonorrhoeae* không có triệu chứng ở 10% nam giới và ở 70% nữ giới.

Xem xét điều trị: Không đáp ứng với điều trị gợi ý tái nhiễm khuẩn hoặc tái phát. Điều trị cả nhiễm khuẩn hầu họng/trực tràng do lậu cầu bằng ceftriaxon. Đồng nhiễm với các tác nhân gây viêm niệu đạo không phải lậu cầu thường gặp, vì vậy nên phối hợp thêm azithromycin uống. Do có gia tăng tình trạng đề kháng, xem xét dùng azithromycin 2g trong liệu pháp kép ở bệnh nhân bị nhiễm khuẩn do lậu cầu.

Tiên lượng: Tốt ngay cả khi nhiễm khuẩn lan tỏa.

Viêm niệu đạo/viêm cổ tử cung không do lậu cầu (Chlamydia/Ureaplasma/ Mycoplasma)

Biểu hiện lâm sàng: Mủ quy đầu/xuất tiết dịch cổ tử cung ± đái khó- đái đau ~ 1 tuần sau khi phơi nhiễm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng test khuếch đại acid nucleic (NAAT) với Chlamydia /test khuếch đại acid nuclei Ureaplasmahoặc Mycoplasma làm trên chất xuất tiết niệu đạo/cổ tử cung dương tính. Cần đánh giá dịch xuất tiết niệu đạo/cổ tử cung để loại trừ nhiễm *N. gonorrhoeae*. Đồng nhiễm thường gặp; tiến hành làm huyết thanh học chẩn đoán giang mai và HIV.

Lưu ý: Các nhiễm khuẩn do *C. trachomatis* không có biểu hiện triệu chứng ở 25% các trường hợp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Không thấy đáp ứng với điều trị bằng doxycyclin gợi ý tái nhiễm khuẩn hoặc nhiễm khuẩn do Trichomonas/Ureaplasma/Mycoplasma. Không thấy đáp ứng với điều trị bằng azithromycin gợi ý nhiễm Trichomonas hoặc nhiễm khuẩn do Mycoplasma đề kháng thuốc (cần xem xét điều trị bằng quinolon).

Tiên lượng: Sẹo hẹp ống dẫn trứng/vô sinh ở các đối tượng bị nhiễm khuẩn mạn tính.

Viêm niệu đạo/cổ tử cung do Trichomonas (*Trichomonas vaginalis*)

Biểu hiện lâm sàng: Dịch tiết âm đạo (khí hư), ngứa và có bọt.

Xem xét chẩn đoán: Tìm Trichomonas bằng cách soi tươi khí hư (wet mount) / nuôi cấy trong môi trường đặc biệt.

Lưu ý: Dấu hiệu "cổ tử cung hình quả dâu tây" kinh điển không thường gặp.

Xem xét điều trị: Sử dụng phác đồ kéo dài 1tuần nếu phác đồ dùng một liều duy nhất thất bại. Hiện tại, tình trạng kháng thuốc được ghi nhận như một nguyên nhân chính gây thất bại điều trị.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu cả bạn tình của bệnh nhân cũng được điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm âm đạo (Vaginitis/Vaginosis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị theo đường uống
Viêm âm đạo do vi khuẩn	Tập khuẩn (*Gardnerella vaginalis*, Mobiluncus, Prevotella, *M. hominis*... vv)	Tinidazol 1g (uống) × 5 ngày ***hoặc*** 2 g (uống) × 2 ngày ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 12h/lần × 7 ngày
Viêm âm đạo/ viêm bao quy đầu do Candida	Candida	Fluconazol 150 mg (uống) × 1 liều†

†Các đối tượng không đáp ứng với điều trị cần được điều trị bằng Fluconazol 200mg (uống) × 1liều sau đó 100 mg (uống) mỗi 24h/lần × 1tuần.

Viêm âm đạo do vi khuẩn (Bacterial Vaginosis/Vaginitis)

Biểu hiện lâm sàng: Dịch tiết âm đạo không ngứa với mùi "tanh".

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng các "clue cells" trên soi tươi phết lam kính dịch tiết âm đạo ("Clue cells" là các tế bào biểu mô âm đạo có các vi khuẩn kết dính trên bề mặt của chúng khiến bờ của các tế bào này bị biến đổi. Các tế bào biểu mô dường như bị rắc đầy các coccobacilli). pH âm đạo ≥ 4,5.

Lưu ý: Mùi "tanh" từ phiếu đồ dịch tiết âm đạo càng nồng thêm khi nhỏ thêm dung dịch KOH 10%. (test "Whiff" dương tính). Test Whiff có thể dương tính ở tới 70% các bệnh nhân bị viêm âm đạo do vi khuẩn. (Test này được thực hiện bằng cách nhỏ một giọt KOH 10% vào banh mỏ vịt khi khám âm đạo hoặc trộn dịch tiết âm đạo với một giọt KOH trên tiêu bản phiếu đồ soi kính hiển vi. KOH do có tính chất kiềm, gây phóng thích các amines bốc hơi từ dịch tiết âm đạo. Các amin này là các sản phẩm chuyển hóa kị khí của vi khuẩn).

Xem xét điều trị: Thay thế cho điều trị đường uống, kem bôi âm đạo clindamycin 2% ×7 ngày (tránh dùng cho phụ nữ đang mang thai) hoặc metronidazole dạng gel 0,075% bôi trong âm đạo mỗi 12h/lần × 5 ngày có thể được áp dụng.

Tiên lượng: Các biến chứng bao gồm vỡ ối sớm, đẻ non, tăng nguy cơ bị bệnh lý viêm nhiễm vùng khung chậu. Tình trạng tái phát rất hay gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm âm đạo/quy đầu do Candida

Biểu hiện lâm sàng: Các mảng trắng, ngứa trong âm đạo/ban đỏ ở quy đầu dương vật.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/nuôi cấy mảng mầu trắng.

Lưu ý: Cần loại trừ nhiễm Trichomonas, do bệnh cảnh này cũng được biểu hiện bằng tình trạng ngứa ở nữ.

Xem xét điều trị: Các viêm âm đạo không biến chứng (các đợt nhiễm trùng nhẹ tản phát ở đối tượng là người khỏe mạnh) hoàn toàn đáp ứng tốt với điều trị một liều duy nhất. Các viêm âm đạo có biến chứng (tình trạng viêm nặng, tái diễn hoặc ở bệnh nhân đái tháo đường khó kiểm soát bệnh) thường cần điều trị ≥7 ngày (điều trị tại chỗ hàng ngày hoặc 2 liều Fluconazole 150 mg cách nhau 72 giờ). Các nhiễm khuẩn Candida không phải albicans đáp ứng kém với azoles. Acid boric bôi tại chỗ (600 mg/ngày trong một viên nang gelatin ×14 ngày) thường có hiệu quả trong bệnh cảnh này.

Tiên lượng: Tốt với điều trị đường toàn thân. Bệnh nhân ĐTĐ/nam giới chưa được cắt bao quy đầu có thể cần điều trị kéo dài ngày.

Mụn nước ở bộ phận sinh dục (Herpes sinh dục) (HSV-2/HSV-1)

Phân loại	Điều trị theo đường uống
Điều trị khởi đầu	Acyclovir 200mg (uống)× 5 lần/ ngày ×10 ngày ***hoặc*** Famciclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần × 7–10 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 1g (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày
Điều trị ngắt quãng/ điều trị các đợt tái phát (có < 6 đợt/ năm)	Acyclovir 200mg (uống) × 5 lần/ngày × 5 ngày hoặc Valacyclovir (*ở người bình thường*: 500mg (uống) mỗi 24h/lần × 5 ngày; *ở người HIV dương tính*: 1g (uống) mỗi 12h/lần × 7–10 ngày)** ***hoặc*** Famciclovir (*ở người bình thường*: 125mg (uống) mỗi 12h/lần × 5 ngày hoặc 1g (uống) mỗi 12h/lần × 1 ngày*; *ở người HIV dương tính*: 500 mg (uống) mỗi 12h/ lần × 7 ngày)
Điều trị ức chế mạn tính (có >6 đợt/năm)	Acyclovir 400mg (uống) mỗi 12h/lần × 1 năm ***hoặc*** Valacyclovir (*ở người bình thường*: 1g (uống) mỗi 24h/lần × 1 năm; *ở người HIV dương tính*: 500mg (uống) mỗi 12h/lần × 1 năm) ***hoặc*** Famciclovir 250mg (uống) mỗi 12h/lần × 1 năm

** Điều trị ban đầu cho bệnh nhân được bắt đầu ngay khi đợt bệnh tái phát xảy ra.*

*** Điều trị trong thời gian ngắn bằng Valaciclovir 500mg mỗi 12h/lần × 3 ngày hoặc Acyclovir 800mg mỗi 8h/lần × 2 ngày cũng có hiệu quả.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Các mụn nước/các ổ loét gây đau ở bộ phận sinh dục với sưng đau hạch vùng hai bên ± sốt nhẹ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên biểu hiện lâm sàng có thể bị sai lạc.

Lưu ý: 70% herpes sinh dục mới mắc do HSV-1 gây nên. Tăng hiệu giá IgG đối với HSV-2 chứng tỏ phơi nhiễm trong quá khứ, mà không phải là nhiễm trùng cấp. Hiệu giá IgM đối với HSV-2 có thể âm tính.

Xem xét điều trị: Nếu có Herpes trực tràng xảy ra đồng thời, tăng liều acyclovir lên 800mg (uống) mỗi 8h/lần × 7 ngày. Đối với herpes sinh dục tái diễn, dùng acyclovir hoặc valacyclovir (liều dùng giống như trong điều trị nhiễm trùng tiên phát) trong 7 ngày với mỗi đợt tái phát. Các đợt tái phát của HSV-2 gây đau ít hơn đợt nhiễm trùng tiên phát và sưng hạch bẹn ít nổi trội/ ít gây đau hơn.

Tiên lượng: HSV-2 có xu hướng tái phát, nhất là trong năm đầu tiên. Tái phát HSV-1 ít gặp hơn.

Các vết loét ở bộ phận sinh dục (Genital Ulcers)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tiêm bắp	Điều trị theo đường uống
Giang mai tiên phát	*Treponema pallidum*	Benzathin penicillin 2,4 triệu đơn vị (Tiêm bắp) × 1 liều	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Azithromycin 2g (uống) ×1 liều**
Bệnh hạ cam (Chancroid)	*Hemophilus ducreyi*	Ceftriaxon 250mg (Tiêm bắp) x 1 liều ***hoặc*** bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào 250-500mg (Tiêm bắp) x 1 liều	Azithromycin 1g (uống) × 1 liều ***hoặc*** Quinolon* (uống) × 3 ngày ***hoặc*** Erythromycin base 500mg (uống) mỗi 8h/lần × 7 ngày

** Ciprofloxacin 500 mg mỗi 12h/lần hoặc Levofl oxacin 500 mg hoặc Moxifloxacin 400 mg mỗi 24h/lần.*

*** Có tình trạng gia tăng kháng thuốc (bệnh nhân cần được theo dõi cẩn thận).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh giang mai tiên phát (Treponema pallidum)

Biểu hiện lâm sàng: Các loét không đau, cứng (vết săng) với nổi hạch bẹn hai bên không đau. Các vết săng do giang mai thường gồ cao, đáy sạch và cứng, nhưng không có ăn sâu ở dưới đáy ổ loét .

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phát hiện được các xoắn khuẩn khi soi dịch tiết từ ổ loét dưới kính hiển vi nền đen. Tăng hiệu giá kháng thể IgM , IgG chống xoắn khuẩn treponema (non-treponemal tests, Vd: như VDRL/RPR) xuất hiện sau 1 tuần. (*Ghi chú*: dùng non-treponemal tests để "sàng lọc" một cách nhanh chóng các trường hợp nghi ngờ giang mai (để phát hiện các kháng thể IgM , IgG chống vi khuẩn treponema): VDRL [Venereal Disease Research Laboratory], RPR [Rapid Plasma Reagin],TRUST.[Toluidine Red Unheated Serum Test] và USR [Unheated Serum Reagin]).

Lưu ý: Hiệu giá của các tests non-treponemal (VDRL/RPR) giảm chậm trong vòng 1 năm; Không thấy hiệu giá này giảm xuống gợi ý điều trị thất bại hoặc có kèm HIV. Ngay cả sau khi điều trị có hiệu quả, một số bệnh nhân vẫn có kết quả test VDRL/RPR dương tính suốt đời (serofast).

Xem xét điều trị: Penicillin đường tiêm là kháng sinh được ưu tiên chọn dùng

đối với tất cả các giai đoạn của giang mai. Nếu điều trị thất bại và hiệu giá VDRL/ RPR không giảm đi, tiến hành làm test huyết thanh học HIV.

Tiên lượng: Tốt nếu bệnh nhân được điều trị sớm.

Bệnh hạ cam (Chancroid) (*Hemophilus ducreyi*)

Biểu hiện lâm sàng: Những vết loét gây đau, ăn sâu ở đáy, nham nhở + hạch bẹn sưng to một bên và đau.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên tìm thấy vi khuẩn hình que tụ thành chuỗi (streptobacilli) tạo thành hình ảnh "bày cá" trên tiêu bản phiến đồ nhuộm Gram dịch tiết lấy từ vết loét/nuôi cấy mọc *H. ducreyi*/ kỹthuật PCR khuếch đại acid nucleic vi khuẩn (NAAT) .

Lưu ý: Đồng nhiễm thường gặp; cần tiến hành làm xét nghiệm chẩn đoán huyết thanh học giang mai và HIV.

Xem xét điều trị: Ở bệnh nhân HIV, phác đồ dùng nhiều liều hoặc azithromycin được ưu tiên chọn dùng cho bệnh nhân. Tình trạng vi khuẩn kháng lại erythromycin/ciprofloxacin cũng đã được báo cáo.

Tiên lượng: Tốt nếu bệnh nhân được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hạch bẹn mưng mủ

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM	Điều trị đường uống
U hạt lympho do bệnh hoa liễu hay Bệnh hột xoài (LGV)	*Chlamydia trachomatis* (typ huyết thanh L_{1-3})	Không áp dụng	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x3 tuần ***hoặc*** Erythromycin base 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 3 tuần
U hạt vùng bẹn (granuloma inguinale) hay bệnh Donovanosis	Klebsiella (Calymmato-bacterium) granulomatis	Không áp dụng	Azithromycin 1g hàng tuần tới khi chữa khỏi bệnh. Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Erythromycin 500mg (uống) mỗi 6h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** TMP–SMX loại viên nén hàm lượng 1 DS mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh.

Từ viết tắt: Lymphogranuloma venereum (LGV): Viêm hạch bạch huyết hoa liễu hay bệnh hột soài.

U hạt lympho do bệnh hoa liễu hay bệnh hột soài (Lymphogranuloma venereum [LGV] (do *Chlamydia trachomatis*)

Biểu hiện lâm sàng: Hạch bẹn sưng to một bên ± chảy dịch/ tạo các đường rò.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng hiệu giá kháng thể đối với *Chlamydia trachomatis* thuộc typ huyết thanh L1-3 rất cao. Không được tiến hành sinh thiết hạch bẹn (thường không liền được sẹo sau sinh thiết và có thể hình thành đường rò). Có thể biểu hiện như một tình trạng sốt không rõ căn nguyên.

Lưu ý: Dát đỏ khởi đầu có thể không quan sát được trên lâm sàng. Sinh thiết cho thấy hình ảnh u hạt; có thể bị nhầm với bệnh Crohn quanh hậu môn.

Xem xét điều trị: U hạt lympho do bệnh hoa liễu vùng hậu môn có thể cần kéo dài thêm thời gian điều trị.

Tiên lượng: Các tổn thương xơ hóa quanh hậu môn/vùng khung chậu không thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

U hạt vùng bẹn (granuloma inguinale) (do Klebsiella [Calymmatobacterium] granulomatis) hay bệnh Donovanosis

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh lý giả hạch to (Pseudolymphadenopathy) với các loét không đau ở vùng bẹn .

Xem xét chẩn đoán: Thấy các thể Donovan (hình ảnh "hạt lúa mạch trương phồng sau ngâm nước" ["puffed-wheat"]) trên tiêu bản sinh thiết mô.

Lưu ý: Không có hạch bẹn sưng to thật sự và trái ngược với nhiễm trùng do u hạt lympho do bệnh hoa liễu.

Xem xét điều trị: Doxycyclin hoặc azithromycin là điều trị được ưu tiên chọn dùng cho bệnh nhân. Điều trị liên tục tới khi tổn thương lành sẹo.

Tiên lượng: Tốt nếu bệnh nhân được điều trị sớm.

Các mụn cóc quanh hậu môn/sinh dục (Condylomata acuminata)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị
Các mụn cóc sinh dục/ quanh hậu môn	Human papilloma virus (HPV)	Podophyllin 10–25% trong cồn benzoin hoặc podofilox hoặc imiquimod (bệnh nhân tự bôi) hoặc phẫu thuật/ loại bỏ bằng laser /áp lạnh bằng nitơ lỏng hoặc gel orcidofovir (1%) QHS × 5 ngày cách mỗi tuần trong 6 đợt điều trị hoặc acid trichloracetic (TCA)/acid bichloracetic (BCA) hoặc interferon trong tổn thương. Sinecatechins (thuốc mỡ 15%) mỗi 8h/lần × 4 tháng.

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương mụn cóc đơn độc/nhiều ± da đổi màu, mà không có hạch bẹn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng. Các mụn cơm sinh dục thường do papiloma virus người (HPV) thuộc các typ 6, 11 gây ra. Các mụn cóc hậu môn – sinh dục do papiloma virus người (HPV) typ 16,18,31,33,35 gây ra và các loại khác có liên quan với ung thư cổ tử cung. Phụ nữ bị mụn cóc sinh dục – hậu môn cần làm phiếu đồ dịch tiết cổ tử cung nhiều lần để phát hiện tình trạng loạn sản/ác tính cổ tử cung.

Lưu ý: Hầu hết các nhiễm khuẩn do papiloma virus người (HPV) không có biểu hiện triệu chứng.

Xem xét điều trị: Cidofovir điều trị/ngừng sự tiến triển của HPV trong 50% các trường hợp.

Tiên lượng: Tùy thuộc typ huyết thanh của HPV có nguy cơ gây ung thư (HPV typ 16, 18, 31, 33, 35). Hiện tại trên thị trường đã có vaccin phòng bệnh (mà không phải để điều trị bệnh).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giang mai (Syphilis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường Tĩnh mạch/ Tiêm bắp	Điều trị theo đường uống
Giang mai giai đoạn 1, 2 hoặc tiềm ẩn sớm (thời gian < 1 năm)	*Treponema pallidum*	Benzathin penicillin 2,4 triệu đơn vị (Tiêm bắp) × 1 liều	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Azithromycin 2g (uống) × 1 liều*
Tiềm ẩn muộn (thời gian >1 năm) hoặc giang mai giai đoạn ba	*Treponema pallidum*	Benzathin penicillin 2,4 triệu đơn vị (Tiêm bắp) hàng tuần × 3 tuần	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 4 tuần
Giang mai thần kinh (Neurosyphilis)	*Treponema pallidum*	Penicillin G 3–4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 giờ hoặc truyền liên tục × 10 –14 ngày ***hoặc*** *Điều trị thay thế:* Procain penicillin 2,4 triệu đơn vị (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần × 10–14 ngày cộng với probenecid 500mg (uống) mỗi 6h/lần × 10–14 ngày ***hoặc*** Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/lần × 10–14 ngày	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 4 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 4 tuần

** Có tình trạng gia tăng đề kháng thuốc (Bệnh nhân cần được theo dõi cẩn thận).*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường tiêm bắp hoặc thời gian điều trị theo đường uống. Tất cả các giai đoạn của giang mai ở bệnh nhân HIV thường đáp ứng với các phác đồ điều trị được khuyến cáo để điều trị cho đối tượng là người bình thường. Giang mai xảy ra ở phụ nữ mang thai cần được điều trị phù hợp với giai đoạn của giang mai. Các bệnh nhân có thai là người dị ứng với penicillin cần được giải mẫn cảm và điều trị bằng penicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giang mai giai đoạn 1 (*Treponema pallidum*)

Biểu hiện lâm sàng: Một (hoặc nhiều) ổ loét không đau, cứng (vết săng) với hạch bẹn sưng to không đau cả hai bên.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa vào tìm xoắn khuẩn trên soi kính hiển vi nền tối hoặc xét nghiệm định lượng kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) đối với dịch tiết của ổ loét. Test phản ứng gián tiếp với xoắn khuẩn (VDRL/RPR) hoặc test trực tiếp với xoắn khuẩn (TPPA, các loại khác) dương tính sau 1 tuần. Các bệnh nhân có tăng ít hiệu giá kháng thể VDRL/RPR và test trực tiếp với xoắn khuẩn âm tính có thể là do có phản ứng sinh học dương tính giả (BFP [biological faulse positive]) như được gặp trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Lưu ý: Hiệu giá VDRL/RPR giảm xuống chậm trong vòng 1 năm. Không thấy giảm hiệu giá này gợi ý điều trị thất bại.

Xem xét điều trị: Penicillin tiêm là kháng sinh được ưu tiên chọn dùng cho tất cả các giai đoạn của giang mai; nếu điều trị thất bại và hiệu giá VDRL/RPR không giảm đi, tiến hành xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán HIV. Một số bệnh nhân được điều trị hiệu quả vẫn có test VDRL/RPR dương tính ở hiệu giá thấp Vd 1:4 (serofast) trong nhiều năm.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giang mai giai đoạn 2 (*Treponema pallidum*)

Biểu hiện lâm sàng: Chấm, mụn nhỏ, sẩn bong vảy, không ngứa, không đau, phát ban đối xứng ở mặt/thân mình có thể lan đến bàn tay/bàn chân. Thường đi kèm với hạch toàn thân. Điển hình xuất hiện 4–10 tuần sau vết săng giai đoạn 1, mặc dù các giai đoạn bệnh có thể chồng lấp nhau. Rụng tóc, các mụn cóc quanh hậu môn-sinh dục (condyloma lata), các mảng trên niêm mạc, viêm mống mắt/viêm màng bồ đào có thể được gặp. Tác động trên thận được biểu hiện từ tình trạng protein niệu nhẹ tới hội chứng thận hư. Nếu không điều trị, tình trạng lui bệnh tự nhiên xảy ra sau 3–12 tuần.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng các dấu hiệu lâm sàng và test VDRL/RPR cho hiệu giá cao (≥1:64). Sau điều trị, hiệu giá RPR/VDRL thường giảm xuống 4 lần trong vòng < 6 tháng.

Lưu ý: Nếu chỉ huyết thanh không hòa loãng được test, hiện tượng prozone có thể làm cho test VDRL/RPR bị âm tính giả. (***Hiệu ứng Hook " hook effect" hay hiện tượng prozone*** là một kết quả âm tính xảy ra với một số test miễn dịch do

nồng độ của chất phân tích đặc biệt tăng qua cao).

Xem xét điều trị: Penicillin tiêm là kháng sinh được ưu tiên chọn dùng cho tất cả các giai đoạn của giang mai.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị sớm.

Giang mai tiềm ẩn (*Treponema pallidum*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh nhân không có triệu chứng với tăng hiệu giá test non-treponemal và test treponemal phản ứng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng test huyết thanh học dương tính ± tiền sử trước đó, song không có các dấu hiệu/triệu chứng giang mai. Giang mai không triệu chứng xuất hiện < 1 năm trong quá trình bệnh được gọi là giang mai tiềm ẩn "sớm"; Giang mai không triệu chứng > 1 năm /không rõ thời gian được gọi là bệnh giang mai tiềm ẩn "muộn". Bệnh giang mai giai đoạn 2 có thể tái phát lên đến 25% số bệnh nhân bị bệnh giang mai tiềm ẩn sớm nhưng tái phát hiếm gặp ở bệnh nhân giang mai tiềm ẩn muộn. Khám bệnh nhân để phát hiện giang mai thần kinh.

Lưu ý: Test trực tiếp với xoắn khuẩn (Treponemal tests [FTA-ABS, MHA-TP, TPPA...]) thường vẫn dương tính suốt đời bệnh nhân, ngay cả sau khi điều trị thỏa đáng.

Xem xét điều trị: Penicillin tiêm là kháng sinh được ưu tiên chọn dùng đối với tất cả các giai đoạn của giang mai. Làm lại hiệu giá VDRL/RPR tại các thời điểm 6, 12 và 24 tháng; Có đáp ứng với điều trị được xác định là khi có giảm hiệu giá RPR/VDRL xuống 4 lần (hoàn loãng 2 ống).

Tiên lượng: Cực kỳ tốt ngay cả khi được điều trị muộn.

Giang mai giai đoạn 3 (*Treponema pallidum*)

Biểu hiện lâm sàng: Có thể được biểu hiện bằng viêm động mạch chủ, giang mai thần kinh, viêm mống mắt hoặc tổn thương da dạng u hạt (gummata) 5–30 năm sau nhiễm khuẩn khởi đầu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng tiền sử giang mai kết hợp với test huyết thanh học dương tính với các dấu hiệu/triệu chứng của bệnh giang mai muộn.

Lưu ý: Điều trị các dấu hiệu thực thể của giang mai thần kinh phát hiện được khi khám lâm sàng hoặc chọc dịch não tủy, ngay cả khi VDRL/RPR không phản ứng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Penicillin tiêm là kháng sinh được ưu tiên chọn dùng đối với tất cả các giai đoạn của giang mai.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ của tổn thương cơ quan đích.

Giang mai thần kinh (*Treponema pallidum*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh nhân thường không có triệu chứng, song có thể có các triệu chứng về thị giác/thính giác, bất thường thần kinh sọ, bệnh tabet tủy sống - tổn thương các rễ thần kinh sau và cột sau của tủy sống, liệt nhẹ, rối loạn tâm thần hoặc các dấu hiệu viêm màng não hoặc sa sút trí tuệ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng gia tăng hiệu giá VDRL trong dịch não tủy; Không cần tiến hành đánh giá hiệu giá kháng thể trong dịch não tủy bằng test hấp thu kháng thể xoắn khuẩn huỳnh quang (Fluorescent treponemal antibody absorption test [FTA-ABS]). Chẩn đoán được khẳng định nếu dịch não tủy có tăng tế bào (> 5 bạch cầu /trên một quang trường có độ phóng đại lớn [hpf]) hoặc tăng nồng độ protein (> 50 mg/dL) và test VDRL dương tính.

Lưu ý: Các bất thường dịch não tủy tiếp diễn dai dẳng gợi ý điều trị thất bại. Test VDRL dịch não tủy (có độ nhạy 60%) có thể âm tính trong giang mai thần kinh.

Xem xét điều trị: Penicillin tiêm là kháng sinh được ưu tiên chọn dùng đối với tất cả các giai đoạn của giang mai. Các bất thường dịch não tủy phải thuyên giảm trong vòng 6 tháng và trở về bình thường sau 2 năm, chọc lại dịch não tủy 6 tháng sau điều trị. Tỷ lệ thất bại với điều trị bằng ceftriaxon là 20%.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ của tổn thương cơ quan đích.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN XƯƠNG VÀ KHỚP

Viêm khớp nhiễm khuẩn/Viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cấp tính (Điều trị ban đầu dựa trên kết quả nhuộm Gram dịch khớp. Nếu thấy cầu khuẩn Gram dương thành cụm, điều trị khởi đầu đối với tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA); Nếu sau đó vi khuẩn gây bệnh phân lập được là tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA), điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MSSA)	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần ×3 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 3 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần ×3 tuần	Nafcillin 2g(TM) mỗi 4h/lần × 3 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 3 tuần ***hoặc*** Ertapenem1g (TM) mỗi 24h/lần ×3 tuần	Cephalexin1g (uống) mỗi 6h/lần ×3tuần ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần × 3 tuần ***hoặc*** Quinolon* (uống) mỗi 24h/lần × 3 tuần
	Tụ cầu vàng (MRSA)	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần × 3tuần ***hoặc*** Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×3tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần × 3tuần		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần ×3tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 3tuần
	Liên cầu nhóm A,B,C,G	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 3 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần ×3 tuần	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần ×3 tuần ***hoặc*** Quinolon* (TM) mỗi 24h/lần ×3 tuần	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần ×3 tuần ***hoặc*** Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×3 tuần ***hoặc*** Quinolon* mỗi 24h/lần ×3 tuần

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant *S. aureus*): Tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin.

* Moxifloxacin 400mg (TM/uống) mỗi 24h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM/uống) mỗi 24 h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm khớp nhiễm khuẩn/Viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cấp tính (tiếp)	Entero-bacteriaceae	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần x3 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x3 tuần	Aztreonam 2 g (TM) mỗi 8h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp* (TM) x3 tuần	Quinolon hô hấp* (uống) x3 tuần
	P.aeruginosa	Meropenem1g (TM) mỗi 8h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 8h/lần x 3 tuần	Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần x 3tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần x3 tuần	Ciprofloxacin 750 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (uống) mỗi 24h/lần x 3 tuần
	N. gonorrhoeae (PSNG/PPNG)	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần* ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Levofloxacin 500mg mỗi 24h/lầnx2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x2 tuần	Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24 giờ x 2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần x2 tuần
	Brucella	Streptomycin 1g (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần x 3 tuần ***cộng với*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 tuần	Gentamicin 5mg/kg (TM) mỗi 24h/lầnx 3 tuần ***cộng với*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 tuần	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x liệu trình 3 tuần† ***kết hợp với*** Rifampin 600mg (uống) mỗi 24h/lần x 3 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	Salmonella	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/lần x2–3 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp* (TM) x2–3 tuần	Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2–3 tuần ***hoặc*** TMP–SMX 2,5 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần x2–3 tuần	Quinolon hô hấp* (uống) x 2–3 tuần ***hoặc*** TMP–SMX viên nén hàm lượng 1 DS (uống) mỗi 12h/lần x2–3 tuần

Từ viết tắt: PSNG (Penicillin sensitive N. gonorrhoeae): Lậu cầu ngạy với penicillin; PPGN (Penicillinase producing N. gonorrhoeae): Lậu cầu sinh men penicillinase.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

* Moxifloxacin 400mg (TM/uống) mỗi 24h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM/uống) mỗi 24 h/lần.

Viêm khớp nhiễm khuẩn/Viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Thứ phát do vết thương động vật cắn	*Pasteurella multocida* *Streptobacillus moniliformis* *Eikinella corrodens*	Piperacillin/tazo-bactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần x2 tuần ***hoặc*** Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần x2 tuần ***hoặc*** Ticarcillin/ clavulanat 3,1g (TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x2tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần x3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần x11 ngày	Amoxicillin/ aicd clavulanic 875/ 125mg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/ lần x3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x11 ngày † ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần x2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm khớp do nấm	*Coccidioides immitis*	Không áp dụng	Itraconazol dạng dung dịch 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×12 tháng hoặc tới khi chữa khỏi nấm** ***hoặc*** Fluconazol 800mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi nấm**
	Sporothrix schenckii	Không áp dụng	Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi nấm**
Viêm khớp do lao	*M. tuberculosis*	Không áp dụng	Điều trị giống như đối với lao phổi (***trang 122***) ngoại trừ cần điều trị kéo dài 6–9 tháng

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Moxifloxacin 400 mg (TM/uống) mỗi 24h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM/uống) mỗi 24h/lần.*

† Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.

‡ Ciprofloxacin 400mg (TM) hoặc 500mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.

*** Itraconazol dạng dung dịch được hấp thu tốt hơn so với dạng viên nang.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm khớp nhiễm khuẩn/Viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn cấp tính

Biểu hiện lâm sàng: Đau khớp cấp kèm với sốt. Khớp nhiễm trùng mất khả năng chịu được tải trọng. Viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn được biểu hiện bằng đau khi khớp cử động, song bệnh nhân vẫn có thể mang được vật nặng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trong dịch khớp khi nhuộm hoặc nuôi cấy. Trong viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn (thường gặp nhất ở khớp gối), đau trên chỗ gấp khớp (mặc dù khớp có thể chịu được tải trọng) và xét nghiệm dịch khớp âm tính với viêm khớp nhiễm khuẩn. Ngoại trừ đối với nhiễm khuẩn do *N. gonorrhoeae*, ít gặp viêm nhiều khớp do tác nhân gây bệnh là vi khuẩn. Viêm nhiều khớp sau nhiễm khuẩn (Post-infectious polyarthritis) thường có nguồn gốc do virus, rất thường gặp do parvovirus B19, rubella hoặc virus viêm gan B (HBV).

Lưu ý: Viêm khớp phản ứng có thể xảy ra sau khi bị nhiễm khuẩn do *C. jejuni*, Salmonella, Shigella, Yersinia, *N. gonorrheae C. trachomatis hoặc C. difficile*. Nuôi cấy dịch khớp âm tính. Viêm khớp phản ứng thường không đối xứng và có tính chất viêm một khớp/viêm một vài khớp.

Xem xét điều trị: Xem các tác nhân gây bệnh đặc hiệu, ở dưới. Điều trị viêm bao hoạt dịch nhiễm khuẩn giống như điều trị viêm khớp nhiễm khuẩn.

Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) (MSSA/MRSA)

Xem xét chẩn đoán: Khớp nóng và đau, mất khả năng chịu được tải trọng. Chẩn đoán dựa vào tăng tế bào trong dịch khớp và nuôi cấy dương tính với vi khuẩn gây viêm khớp. Xét nghiệm dịch khớp để loại trừ bệnh gout (các tinh thể lưỡng chiết hai đầu) và bệnh giả Gout (có các tinh thể calcipyrophosphat). Tình trạng này có thể xảy ra trong bệnh cảnh viêm nội tâm mạc với thuyên tắc huyết khối nhiễm khuẩn tới khớp. Các biểu hiện khác của viêm nội tâm mạc thường được thấy rõ.

Lưu ý: Cần loại trừ các nguyên nhân gây viêm khớp không do nhiễm trùng khác (Vd: bệnh sarcoidose, bệnh Whipple, EhlersDanlos, v.v...), các tình trạng này thường nhẹ hơn, song có thể gần giống với viêm khớp nhiễm khuẩn. Trong viêm khớp phản ứng tiếp theo viêm niệu đạo (do *C.trachomatis, Ureaplasma urealyticum, N. gonorrhoeae*) hoặc ỉa chảy (do Shigella, Campylobacter, Yersinia, Salmonella), nuôi cấy dịch khớp sẽ âm tính và số lượng bạch cầu trong dịch khớp thường <10.000/mm^3 với nồng độ acid lactic và glucose trong dịch khớp bình thường. Không được bỏ sót viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trong viêm khớp nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) biểu hiện viêm một khớp/một vài khớp mà không có nguồn rõ ràng.

Xem xét điều trị: Đối với viêm khớp nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), vancomycin thấm rất kém vào dịch khớp, vì vậy nên sử dụng linezolid thay thế. Bất động khớp bị nhiễm khuẩn trong khi điều trị mang lại lợi ích. Tiêm kháng sinh trực tiếp vào bao hoạt dịch không mang lại lợi ích gì vượt trội hơn so với dùng kháng sinh theo đường TM hoặc uống.

Tiên lượng: Điều trị càng sớm càng tốt để làm giảm tới mức thấp nhất tình trạng tổn hại khớp. Có thể cần hút dịch khớp nhiều lần/dẫn lưu mở để bảo tồn chức năng khớp.

Liên cầu nhóm A, B, C, G

Xem xét chẩn đoán: Thường gây viêm ở một khớp. Thường không phải do thuyên tắc cục huyết khối nhiễm khuẩn từ viêm nội tâm mạc gây nên.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tổn thương khớp và sự nhanh chóng bắt đầu điều trị kháng sinh cho bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterobacteriaceae

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng phân lập được trực khuẩn Gram âm từ dịch khớp.

Lưu ý:Viêm khớp nhiễm khuẩn ở một khớp " không thường gặp" (Vd: khớp ức đòn, khớp cùng) cần đặt nghi vấn bệnh nhân là đối tượng tiêm chích ma túy đường TM tới khi chứng minh được một nguyên nhân khác.

Xem xét điều trị: Chọc hút dịch khớp là điều cơ bản đối với trường hợp nghi vấn viêm khớp nhiễm khuẩn đối với khớp háng và có thể cần thiết đối với các khớp khác. Cần hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Nhỏ kháng sinh tại chỗ vào dịch khớp không chứng minh là có hiệu quả vượt trội.

Tiên lượng: Liên quan tới mức độ phá hủy khớp và điều trị kháng sinh sớm hay muộn cho bệnh nhân.

Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa)

Xem xét chẩn đoán: Viêm khớp nhiễm khuẩn/ viêm tủy xương do *P. aeruginosa* có thể xảy ra sau vết thương do vật nhọn nhiễm nước bẩn đâm xuyên (Vd: chọc đinh vào gót chân qua giày). Biểu hiện ở khớp ức – đòn hoặc cùng - chậu thường gặp ở người tiêm chích ma túy đường TM.

Lưu ý: Cần đặt nghi vấn bệnh nhân là đối tượng sử dụng ma túy đường tĩnh mạch khi viêm khớp nhiễm khuẩn do *P. aeruginosa* xảy ra ở đối tượng không có tiền sử chấn thương.

Xem xét điều trị: Nếu ciprofloxacin được sử dụng, điều trị với liều 750mg (mà không phải là liều 500 mg) đối với viêm khớp nhiễm khuẩn/viêm tủy xương do *P. aeruginosa*.

Tiên lượng: Liên quan tới mức độ phá hủy khớp và điều trị kháng sinh sớm hay muộn cho bệnh nhân.

Lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae)

Xem xét chẩn đoán: Viêm khớp do lậu cầu có thể được biểu hiện như tình trạng viêm khớp xảy ra ở một khớp hoặc nhiều khớp có thể bị tác động như một phần thuộc bệnh cảnh hội chứng viêm khớp – viêm da do lậu (*gonococcal arthritis-dermatitis syndrome*)- một tình trạng nhiễm khuẩn lan tỏa do lậu cầu. Có vi khuẩn trong máu với cấy máu dương tính xảy ra sớm trong giai đoạn phát

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ban trong khi đó nuôi cấy dịch khớp âm tính. Tác động khớp xẩy ra với các dấu hiệu điển hình của viêm khớp nhiễm khuẩn và nuôi cấy dịch khớp dương tính với *N. gonorrhoeae,* song ở giai đoạn này cấy máu âm tính. Viêm bao gân cấp tính (acute tenosynovitis) thường là một bằng chứng gợi ý viêm khớp nhiễm khuẩn do lậu .

Lưu ý: Spectinomycin không có hiệu quả điều trị đối với lậu ở họng (pharyngeal gonorrhea).

Xem xét điều trị: Hội chứng viêm da –viêm khớp do lậu gây ra bởi các chủng *N .gonorrhoeae* rất nhạy cảm với kháng sinh. Cephalosporins cũng giúp loại trừ được giang mai trong giai đoạn ủ bệnh.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt đối với hội chứng viêm khớp – viêm da. Tồi, đối với tình trạng viêm khớp chỉ ở một khớp.

Brucella sp.

Xem xét chẩn đoán: Thường có bằng chứng của nhiễm Brucella ở một nơi nào đó (viêm màng não, viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn, viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn). Chẩn đoán bằng nuôi cấy máu hoặc dịch khớp.

Lưu ý: Brucella có tác động ưu tiên đối với xương/khớp (Vd: đốt sống, khớp cùng-chậu). Cần đặt nghi vấn chẩn đoán ở các bệnh nhân có biểu hiện bất thường với đau bụng-lưng. Có thể được biểu hiện như một tình trạng sốt không rõ căn nguyên.

Xem xét điều trị: Một số bệnh nhân có thể cần điều trị kháng sinh kéo dài 6 tuần.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm khuẩn và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Salmonella sp.

Xem xét chẩn đoán: Xẩy ra trong ở bệnh nhân bị bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh lý hemoglobin. Chẩn đoán bằng nuôi cấy máu/dịch khớp.

Lưu ý: *S. aureus*, mà không phải là Salmonella, là nguyên nhân thường gặp nhất của viêm khớp nhiễm khuẩn trong bệnh hồng cầu hình liềm.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm khuẩn và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm khớp nhiễm khuẩn thứ phát sau vết thương động vật cắn

Biểu hiện lâm sàng: Vết thương do động vật cắn đâm xuyên vào khoang khớp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng phết lam kính/ nuôi cấy dịch khớp/cấy máu tìm vi khuẩn.

Lưu ý: Có thể xuất hiện tình trạng di ổ nhiễm khuẩn từ vi khuẩn trong máu.

Xem xét điều trị: Điều trị trong ít nhất 2 tuần bằng điều trị kết hợp đường TM/ uống.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm khuẩn và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Viêm khớp nhiễm khuẩn mạn tính

Biểu hiện lâm sàng: Đau khớp bán cấp/mạn tính với giảm tầm vận động khớp song ít hoặc không có sốt. Có thể chịu được tải trọng trên khớp tổn thương.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng phết lam kính/nuôi cấy dịch khớp/sinh thiết màng hoạt dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nấm Coccidioides immitis

Xem xét chẩn đoán: Để chẩn đoán phải thấy vi sinh vật mọc từ bệnh phẩm màng hoạt dịch hoặc dịch khớp.

Lưu ý: Dịch khớp giống như trong lao khớp (tăng tế bào lympho, nồng độ glucose thấp, tăng nồng độ protein trong dịch khớp).

Xem xét điều trị: Điều trị theo đường uống được ưu tiên chọn dùng. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh tương tự như khi dùng phác đồ điều trị bằng amphotericin. Bệnh nhân HIV cần điều trị ức chế nấm kéo dài suốt đời.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm trùng và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Nấm Sporothrix schenckii

Xem xét chẩn đoán: Thường là nhiễm khuẩn một khớp thứ phát do cấy truyền trực tiếp vi sinh vật vào khớp/chấn thương.

Lưu ý: Viêm nhiều khớp gợi ý tình trạng nhiễm trùng lan tỏa.

Xem xét điều trị: SSKI (Saturated Solution of Potassium Iodide) hữu ích đối với biểu hiện da và bạch mạch do nhiễm nấm *Sporothrix schenckii* song không tác dụng trong trường hợp nhiễm trùng nấm tác động tới xương/khớp. (lymphocutaneous sporotrichosis là tình trạng nhiễm trùng nấm sporothrix gây các hạt ở da thành mủ và các mụn mủ này tiến triển ra xung quanh/ mạch bạch huyết).

Tiên lượng: Cực kỳ tốt đối với nhiễm trùng khu trú (Vd: Lymphocutaneous sporotrichosis). Trong nhiễm trùng lan tỏa, tiên lượng liên quan với yếu tố chức năng miễn dịch của bệnh nhân.

Mycobacterium tuberculosis (Lao)

Xem xét chẩn đoán: Bằng chứng giúp chẩn đoán là viêm bao gân bán cấp/ mạn tính trên khớp bị tác động. Khác với các thể viêm khớp nhiễm khuẩn khác, trong đó tình trạng nhiễm khuẩn khớp thường do vi khuẩn lan truyền theo đường máu, viêm khớp do lao có thể biến chứng viêm tủy xương kế cận do lao. Các dấu hiệu khi xét nghiệm dịch khớp bao gồm tăng tế bào lympho, nồng độ glucose thấp và tăng protein trong dịch khớp.

Lưu ý: Cần gửi bệnh phẩm sinh thiết màng hoạt dịch để làm phiến đồ/nuôi cấy tìm trực khuẩn kháng cồn-toan cho các trường hợp viêm một khớp mạn tính không rõ căn nguyên.

Xem xét điều trị: Viêm khớp do lao thường cần được điều trị 6-9 tháng.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm khuẩn và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Lyme*/ Viêm khớp do bệnh Lyme

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Bệnh Lyme	*Borrelia burgdorferi*	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần ×4 tuần	Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 11 ngày† ***hoặc*** Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần
Viêm khớp do bệnh Lyme		Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 4 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần ×4 tuần	Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x 4 tuần	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 4 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12h/lần ×4 tuần

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

* ***Xem trang 46*** *để biết về bệnh Lyme thần kinh do nhiễm xoắn khuẩn Borrelia (Lyme neuroborreliosis) và* ***trang 142*** *để biết về viêm cơ tim do bệnh Lyme.*

† *Điều trị bằng doxycyclin x 10 ngày cũng có hiệu quả như điều trị trong 2 tuần.*

‡ *Đối với các bệnh nhân người lớn không dung nạp với Amoxicillin, Doxycyclin và Cefuroxim axetil, Azithromycin (500 mg uống mỗi ngày trong 7–10 ngày), Clarithromycin (500 mg uống x 2 lần/ngày trong 14–21 ngày, nếu bệnh nhân không phải là phụ nữ đang mang thai) hoặc Erythromycin (500 mg uống x 4 lần/ngày trong 14–21 ngày) có thể cho bệnh nhân dùng ngay. Liều dùng được khuyến cáo đối với các thuốc này cho trẻ em sẽ như sau: Azithromycin 10 mg/kg/ngày (liều tối đa là 500mg mỗi ngày); Clarithromycin, 7,5 mg/kg x2 lần/ngày (liều tối đa là 500mg cho một liều); và Erythromycin, 12,5 mg/kg 4 lần/ngày (liều tối đa là 500mg cho một liều).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Lyme

Biểu hiện lâm sàng: Được biểu hiện cấp tính với tình trạng bệnh tại chỗ hoặc lan tỏa sau khi bị ve nhiễm *Borrelia spirochete* cắn. Hồng ban di chuyển (Erythema migrans) (tổn thương hình khuyên với trung tâm sạch) xảy ra ở ~ 75% các trường hợp trong vòng 2 tuần sau khi bị ve đốt và có thể đi kèm với sốt, đau đầu, đau khớp/đau cơ, hội chứng kích thích màng não. Các biểu hiện cấp tính khác có thể gặp bao gồm viêm màng não vô khuẩn, liệt dây VII ngoại biên của Bell, bệnh thần kinh ngoại biên, viêm gan nhẹ, viêm cơ tim với block tim hoặc viêm khớp. Bệnh mạn tính có thể được biểu hiện bằng viêm khớp, bệnh thần kinh ngoại biên, viêm màng não - não hoặc tình trạng viêm da-teo da mạn tính đầu chi (acrodermatitis chronica atrophicans) (thường xảy ra > 10 năm sau nhiễm khuẩn). (acrodermatitis chronica atrophicans là một biểu hiện bệnh lý da của các vùng chi được coi như một biểu hiện muộn của bệnh Lyme nhất là khi bệnh không được phát hiện và điều trị và tình trạng này được đặc trưng bằng thương tổn đỏ da [erythematous] và phù nề và các tổn thương này có xu hướng trở nên teo da khiến vùng da này có biểu hiện như tờ bìa nhăn nheo).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng kết hợp với tăng hiệu giá IgM với bệnh Lyme (IFA/ELISA). Nếu hiệu giá IgM với bệnh Lyme làm theo kỹ thuật ELISA ở mức ranh giới hoặc bị nghi vấn là kết qủa dương tính giả, tiến hành định lượng IgM theo phương pháp Western blot để khẳng định chẩn đoán. Hiệu giá IgM âm tính giả trrong giai đoạn sớm của bệnh thường gặp. Phản ứng chéo IgM thường gặp với Epstein-Barr virus và Cytomegalovirus. Sau khi loại trừ nhiễm trùng do EBV/CMV, lại nhắc lại test phát hiện IgM với bệnh Lyme và IgG bằng kỹ thuật ELISA/immunoblot sau đó 4 tuần (hiệu giá IgM dương tính giả đảo lại thành âm tính). Hiệu giá IgM có thể cần tới 4–6 tuần mới tăng cao sau khi bị ve đốt. Loại ve Ixodes là các vector truyền bệnh chính, các động vật gặm nhấm nhỏ là vật trung gian truyền bệnh chính. Ở Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp xảy ra ven biển Đông Bắc, thượng Trung Tây, California và phía Tây Nevada.

Lưu ý: Không phải lúc nào cũng nhìn thấy ban da và vết ve đốt thường không gây đau và bị bỏ qua không được phát hiện (ve thường tự rơi khỏi vết đốt sau 1 -2 ngày hút máu). Không được bỏ sót chẩn đoán bệnh Lyme ở các bệnh nhân sống ở những vùng có ve Ixodes mang tính dịch lưu hành địa phương thình lình xuất hiện tình trạng block tim không có căn nguyên giải thích được.

Xem xét điều trị: *B. burgdorferi* có độ nhạy cao với tất cả các beta-lactams. Đối với liệt Bell hoặc bệnh Lyme thần kinh, Minocyclin (100 mg uống mỗi 12h/lần × 2 tuần) có thể được ưa dùng hơn Doxycyclin. Tỷ lệ thất bại cao hơn khi điều trị bằng macrolid. Các triệu chứng có thể tiếp diễn từ 1 năm trở lên sau khi đã điều

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trị thỏa đáng. Không có lý do gì để cần phải điều trị nhắc lại khi các triệu chứng tồn tại dai dẳng.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt ở các đối tượng là người bình thường.

Viêm khớp do bệnh Lyme

Biểu hiện lâm sàng: Viêm khớp cấp do bệnh Lyme được biểu hiện bằng đau khớp, giảm tầm vận động của khớp, giảm khả năng chịu tải trọng trên khớp bị tác động, song ít hoặc không có sốt. Viêm khớp mạn do bệnh Lyme giống như viêm khớp dạng thấp.

Xem xét chẩn đoán: Bệnh thường tác động tới trẻ em và ở các khớp lớn chịu tải trọng (Vd: khớp gối). Viêm khớp cấp do bệnh Lyme được chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng kết hợp với tăng hiệu giá IgM với bệnh Lyme. Viêm khớp mạn do bệnh Lyme được gợi ý dựa trên biểu hiện giống viêm khớp dạng thấp với yếu tố dạng thấp và kháng thể kháng nhân (ANA) âm tính và hiệu giá IgG với bệnh Lyme dương tính và PCR dịch khớp dương tính với bệnh Lyme.

Lưu ý: Khớp viêm cấp do bệnh Lyme đỏ song không nóng, trái ngược với viêm khớp nhiễm khuẩn. Trong viêm khớp mạn do bệnh Lyme, hiệu giá IgG với bệnh Lyme âm tính là thông số cơ bản giúp loại trừ viêm khớp mạn tính do bệnh Lyme, song một gia tăng hiệu giá IgG với bệnh Lyme chỉ dẫn có tiếp xúc trong quá khứ với *B. burgdorferi* mà không đủ để chẩn đoán viêm khớp do bệnh Lyme. Dịch khớp trong bệnh Lyme mạn tính thường cho kết quả nuôi cấy âm tính, song cho kết quả dương tính khi làm test PCR, tuy nhiên làm test PCR dịch khớp, không giúp phân biệt được giữa một nhiễm khuẩn hoạt động với nhiễm khuẩn trước đó.

Xem xét điều trị: Hiệu giá IgG Lyme vẫn tăng cao trong suốt cuộc đời bệnh nhân và không giảm đi khi điều trị. Các triệu chứng khớp thường tiếp diễn trong nhiều tháng/nhiều năm sau điều trị kháng sinh có hiệu quả do tình trạng viêm khớp tự miễn, điều trị bằng thuốc kháng viêm, mà không cần dùng nhắc lại các liệu trình kháng sinh. Điều trị bằng đường uống cũng có hiệu quả như điều trị đường tĩnh mạch.

Tiên lượng: Tốt ở các đối tượng là người bình thường. Viêm khớp mạn/không đáp ứng với điều trị có thể gặp ở những bệnh nhân thuộc nhóm HLA typ DRW 2/4.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Khớp nhân tạo bị nhiễm trùng (Infected joint prosthesis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Tụ cầu (Staphylococcal) (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là MRSA/ CoNS, điều trị phù hợp)	*S. epidermidis* (CoNS)	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12 giờ *	Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/ lần*† ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/ lần *†	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/ lần *
	S.aureus (MSSA)	Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần* ***hoặc*** Cefazolin1g (TM) mỗi 8h/ lần* ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/ lần*†	Meropenem1g (TM) mỗi 8h/ lần* ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần*	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Cephalexin 1g (uống) mỗi 6h/ lần*
	S.aureus (MRSA)	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/ lần* ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/ lần* ***hoặc*** Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/ kg (TM) mỗi 8h/lần*		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/ lần* ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần *

Từ viết tắt: MRSA/MSSA: methicillin-resistant/sensitive *S. aureus*: Tụ cầu vàng kháng hoặc nhạy methicillin; MSSE/MRSE: methicillin sensitive/resistant *S. epidermidis* - *S. epidermidis* nhạy hoặc kháng methicillin; CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu với coagulase âm tính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Điều trị thêm 1 tuần sau khi thay khớp nhân tạo mới.*

† Chỉ khi chủng MSSE còn nhạy với thuốc.

Biểu hiện lâm sàng: Đau ở vùng khớp nhân tạo với khớp lỏng/mất ổn định ± sốt nhẹ.

Xem xét chẩn đoán: Khớp nhân tạo bị nhiễm khuẩn được gợi ý dựa trên dấu hiệu khớp nhân tạo lỏng lẻo/có vùng sáng liền kề với khớp nhân tạo trên phim thẳng ± cấy máu dương tính. Chẩn đoán được khẳng định bằng chụp xạ hình xương. Sử dụng thủ thuật hút dịch khớp để phân lập vi sinh vật gây bệnh.

Lưu ý: Tăng tốc độ lắng hồng cầu với lỏng khớp nhân tạo gợi ý nhiễm khuẩn khớp giả. Tình trạng lỏng khớp cơ giới song không do nhiễm khuẩn là điều thường gặp sau khi tiến hành thay khớp giả nhiều năm, song các bệnh nhân này có tốc độ lắng hồng cầu bình thường.

Xem xét điều trị: Thường cần phải tháo bỏ khớp nhân tạo bị nhiễm khuẩn để điều trị triệt để. Thay một khớp nhân tại mới có thể được thực hiện vào bất kỳ lúc nào sau khi đã tháo bỏ khớp giả bị nhiễm khuẩn. Để dự phòng nhiễm khuẩn đối với khớp nhân tạo mới được thay, cắt lọc rộng và triệt để các vật liệu của khớp nhân tạo cũ bị nhiễm khuẩn rất quan trọng. Nếu không thể mới được khớp nhân tạo đã bị nhiễm khuẩn, có thể sử dụng điều trị ức chế nhiễm khuẩn suốt đời của bệnh nhân bằng kháng sinh đường uống (Vd: minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần). TMP–SMX 5 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần có thể có hiệu quả để ức chế lâu dài /điều trị tiệt căn trong thay thế toàn bộ khớp háng (điều trị × 6 tháng) hoặc thay toàn bộ khớp gối (điều trị ×9 tháng) do các chủng MSSA/ MSSE còn nhạy với thuốc; Phối hợp thêm rifampin 300mg (uống) mỗi 12h/lần có thể hữu ích.

Tiên lượng: Có liên quan với cắt lọc thỏa đáng các chất liệu khớp nhân tạo bị nhiễm khuẩn sau khi đã lấy bỏ khớp giả.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075